



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN MARET
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 4

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan 5

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 6

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 17

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 17

3.3.2 Rawat Inap 19

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) 27

3.3.4 High Care Unit (HCU) 28

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 29

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 31

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 32

3.4.1 Instalasi Farmasi 32

3.4.2 Laboratorium 51

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran 56

3.4.4 Radiologi 62

3.4.5 Gizi 67

3.4.6 CSSD - Laundry 78

3.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan 86

3.5.1 SDM 86

3.5.2 IPSRS 88

3.5.3 Security 92

3.5.4 Parkir 101

3.5.5 Humas Marketing 102

3.5.6 Penjaminan 106

3.5.7 PIPP – MOD - MPP 107

3.5.8 *Cleaning Service* 115

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum 116

3.6 Komite dan Tim 118

3.6.1 Komite Mutu 118

3.6.2 Komite PPI 170

3.6.3 Tim PKRS 185

3.6.4 Tim Prognas 186

3.6.5 Tim PPRA 227

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT 232

3.7 Permasalahan Rumah Sakit 235

3.8 Profil SDM 250

Bab IV Kesimpulan dan Saran 254

Bab V Penutup 255

Lampiran 257

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Maret Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



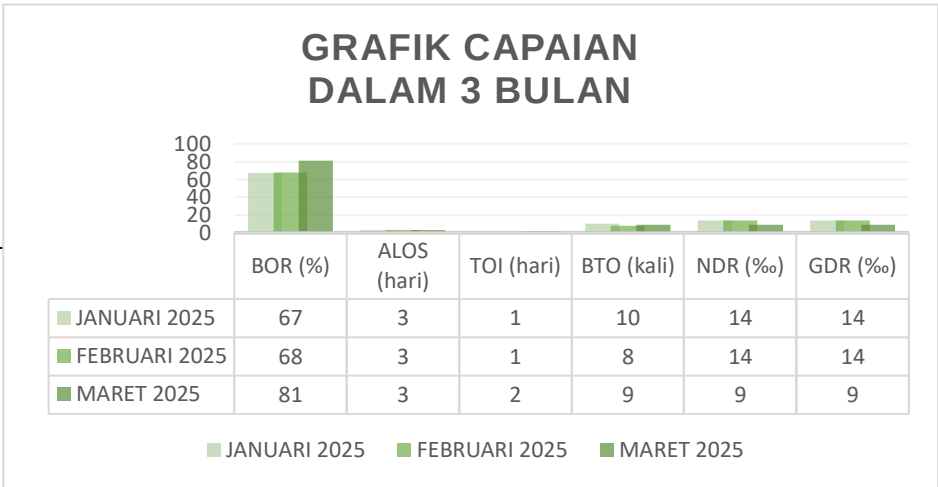
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

NO	INDIKATOR	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	BOR	67	68	81
2	ALOS	3	3	3
3	TOI	1	1	2
4	BTO	10	8	9

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



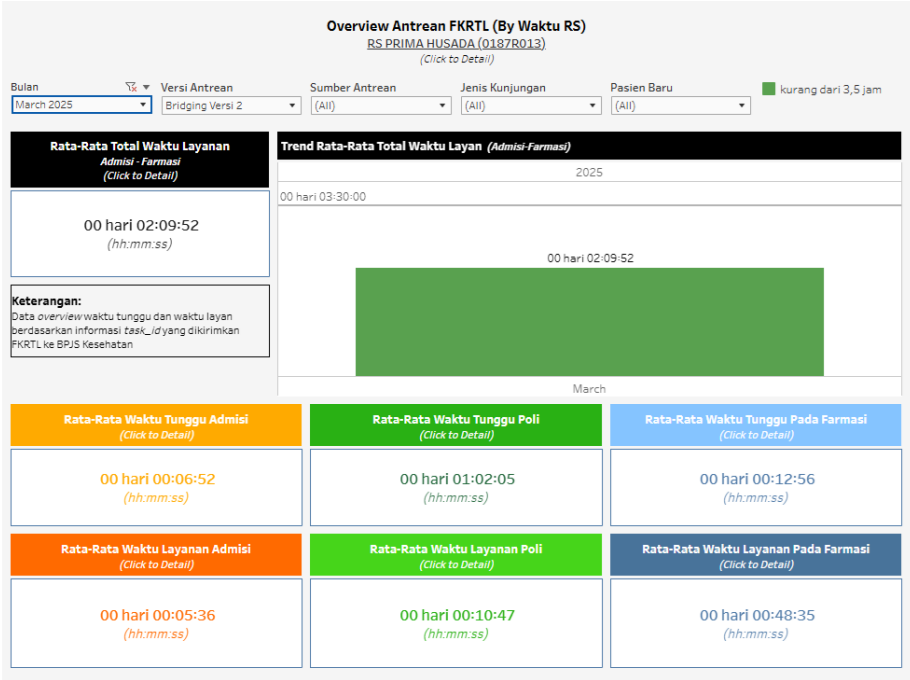
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil perhitungan statistik rumah sakit pada Bulan Maret Tahun 2025, kinerja RSPHM didapatkan hasil nilai indicator :

- 1. BOR sebesar 81% (standar : 60-85%) sesuai standar.
- 2. LOS sebesar 3 hari sesuai dengan standard RSPHM terkait SE dari PT.DPM khusus pasien BPJS (standar pasien umum : 6-12 hari)
- 3. TOI sebesar 2 hari (standar : 1-3 hari)
- 4. BTO sebesar 9 kali (standar : 4-5 kali)

BOR Bulan Maret Tahun 2025 di bandingkan dengan Bulan Februari Tahun 2025 mengalami kenaikan. BOR tersebut menjadi bukti bahwa penggunaan tempat tidur di Bulan Maret sudah standar. Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan tempat tidur sudah efisien dari segi ekonomi menghasilkan pemasukan bagi rumah sakit

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN		BULAN 2025		
			Januari	Februari	Maret
	Waktu Rata-Rata	Rata-Rata Tahun 2024			
1	Total Waktu Layanan	2:12:37	02:07:27	01:59:21	02:09:52
2	Waktu Tunggu Admisi	0:11:52	00:07:37	00:04:57	00:06:52
3	Waktu Layanan Admisi	0:07:49	00:05:49	00:04:58	00:05:36
4	Waktu Tunggu Poli	1:03:51	01:06:01	01:05:56	01:02:05
5	Waktu Layanan Poli	0:14:56	00:09:41	00:10:08	00:10:47
6	Waktu Tunggu Farmasi	0:14:47	00:11:17	00:09:31	00:12:56
7	Waktu Layanan Farmasi	0:54:42	00:44:57	00:38:06	00:48:35

Analisis :
Pada bulan ini jika dibandingkan rata-rata tahun 2024 maka bulan ini masih lebih baik dilihat dari waktu total layanan. Namun terjadi peningkatan dari bulan sebelumnya.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	JENIS	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	45,98%	46,43%	47.64%
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	96,72%	95.11%	94.28%

Analisis :
Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan (>30%) dan (>90%)

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabit

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Bimbingan Doa pada pasien IRNA	Bulan maret 2025 Sudah berjalan rutin 3x seminggu	Berjalan dengan baik dan respon pasien baik
2	IRNA	Senam hamil	Sudah berjalan akan tetapi bulan maret 2025 di istirahatkan karena tidak ada tempat	-
		Foto bayi	Sudah berjalan	Fasilitas dari unit sendiri
		ERM rawat inap	Sudah berjalan dengan mengambil sampel 30 pasien, koordinasi dengan programmer untuk yang eror dan yang kurang	Banyak kendala ttd tidak bisa, masih banyak yang eror,pengkajian kurang lengkap
3	IRJA	Poli Eksekutif	Sudah berjalan mulai dari 2024 untuk bulan maret 2025 ada 25 pasien,19 pasien di dominasi oleh pasien obgyn	Pasien anak menurun karena pasien anak yang ke poli Sakura hanya pasien yang mencari dr Dicky bukan karena tertarik akan layanannya. Pasien dewasa (IPD dan Neuro) tidak tertarik pada poli Sakura

				karena merasa sudah cukup dengan poli regular dengan jaminan BPJS
4	IGD	Edukasi mengenai kriteria kegawatan menurut BPJS	Membuat video edukasi, sudah terpasang poster di IGD tentang penyakit yang tidak tercover BPJS Kesehatan	Sudah terpasang di IGD
BIDANG PENUNJANG				
1	Depo Farmasi	1. Website Primantara	1. Presentasi MOCKUP oleh Programmer PT sudah dilakukan pada tanggal 23-09-2024 2. Presentasi MOCKUP oleh Vendor pada tanggal 20-12-2024, notulen sudah masuk ke PT, menunggu ACC	Permintaan di hold menunggu kenaikan pasien PRIMANTARA. Monitoring dan Evaluasi.
		2. Jasa pengantaran obat	1. Pendataan pasien masih menggunakan google spreadsheet dan kitir manual, belum ada fitur yang bridging dengan SIMRS sebagai penanda resep bahwa obat dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap. 2. Promo Lifetime diskon 50% untuk pengguna baru berjalan mulai Bulan Desember 2024. 3. Subsidi promo untuk obat tertinggal menggunakan pengantaran gratis.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet dan perubahan alur pembayaran di Kasir.
		3. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	1. TTD elektronik untuk pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. 2. TTD elektronik untuk pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien pulang rawat inap masih belum bisa dan tahap	Dalam antrian programmer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.

			koordinasi dengan programmer.	
		4. KPO elektronik (e-KPO)	1. Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. Pengajuan ke progamer untuk dibuatkan fitur e-KPO yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien. 2. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS. 3. Jumlah KPO tertinggal : 408.	Dalam antrian programmer.
		6. Pengadaan LAF sesuai dengan pedoman dasar dispensing sediaan steril.	1. Koordinasi dengan Kains Farmasi untuk melakukan pengajuan proposal ke PT terkait pemindahan ruang LAF, yaitu rencana diajukan di Lantai Maternitas (ex IKO Covid). 2. Proposal pengajuan sudah diterima PT → ACC	Dalam proses renovasi sebagai persiapan AKRE pada akhir Tahun 2026.
		7. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	1. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga TTK kurang (jika ada staf yang sakit). 2. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. 3. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. 4. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	Monitoring dan Evaluasi
		8. Resep Manual IGD	1. Permintaan obat menggunakan resep manual di IGD. 2. Resep akan diarsipkan oleh	Berjalan awal Tahun 2025. Hasil SO membaik, yaitu +5.439.289, dari +25.820.296

			Petugas Farmasi dan dilakukan double crosscheck, jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan. 3. Perubahan alur untuk meminimalisir selisih SO.	
2	Gudang Farmasi	Scan Barcode	1. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT. 2. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04-10-2024. 3. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer 4. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia 5. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer	Rencana trial menunggu Programmer PT
		Perluasan Gudang Farmasi	1. Mengajukan perluasan Gudang Farmasi di Lantai 2, karena pallet buffer sudah tidak cukup. 2. Penurunan buffer dari lantai 2 menggunakan katrol yang tidak terpakai di Laundry.	Sudah berjalan
		Perbaikan mutasi barang	1. Sudah dilakukan koordinasi dengan petugas IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO. 2. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. 3. Fitur minta barang	Monitoring dan Evaluasi. Supervisi Kabid.

			floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. 4. Sistem stok IKO sudah dikunci. 5. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. 6. Membuat alur dan kesepakatan terkait penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. Menggunakan tabel penggunaan isonest. 7. Admin IKO	
3	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	1. Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses tahap akhir, target pada Bulan Juni 2025. 2. Melakukan pendataan fitur yang dibutuhkan pada SIMRS, lalu diserahkan kepada Programmer PT.	Kurang sinkron antara fitur perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis. Permasalahan E-RM dan layanan Poli yang belum masuk E-RM sudah disampaikan kepada Programmer PT sekaligus flow chart.
		2. Penggunaan ERM Rawat Inap	1. Kolaborasi dengan Programmer PT. 2. Melakukan trial pada awal Bulan Maret 2025.	Follow up. Monitoring dan Evaluasi.
		3. Kirim ke Satu Sehat untuk Pasien Rawat Jalan (Baik ERM ataupun Non ERM)	Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : 1. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. 2. Bayi baru lahir yang	Monitoring dan Evaluasi.

			belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. 3. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap. TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	
		4. Dokumentasi DRM lama.	1. Melakukan scaning form kedalam SIMRS. 2. Tarikan data bisa diambil pada rekap kunjungan di SIMRS. 3. Menunggu programmer membuat fitur scanning.	Koordinasi dengan Programmer. Pengajuan ke PT.
		5.Retensi DRM	1. Data DRM yang akan diretensi menunggu Programmer PT sebelum dilakukan pemilahan dan pemusnahan DRM. 2. Pemusnahan terakhir dilakukan pada Tahun 2018.	Follow up Programmer PT.
		6. Rekap Data Laporan Dinkes	1. Data yang dibutuhkan tidak semua bisa ditarik oleh system. 2. Pengajuan fitur ke Programmer PT. 3. RM membuat Google Spreadsheet untuk diisi oleh unit-unit terkait setiap harinya. 4. Tujuannya untuk memudahkan Karu RM dalam pelaporan RL ke Dinkes tepat waktu.	Dalam Proses.
4	Pendaftaran	1. Anjungan Pasien Mandiri.	1. Melakukan studi	Dalam proses dan diajukan ke

			banding atau mencari informasi terkait penggunaan APM di RS lain. 2. Membuat flowchart dan diajukan ke Programmer PT.	Program Kerja Tahun 2025.
		2. Penetapan petugas jaga.	1. Melakukan penetapan PJ disetiap divisi, Pendaftaran Central, CSO dan Pendaftaran IGD dengan personil tetap, dengan tujuan supaya petugas menguasai permasalahan dan fokus pelayanan, memudahkan telusur dan perbaikan jika ada komplain dan masalah.	PJ Pendaftaran Central : Tyas PJ Pendaftaran IGD : Riri Pendaftaran CSO : Shinta Bella
		3. Pendaftaran pasien	1. Reservasi pasien umum dan asuransi melalui web, disertai pembayaran melalui VA. 2. Kolaborasi dengan IT dan SIMRS.	Proses mengerjakan TOR
4	Radiologi	1. Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil JPEG dapat diakses.	Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer.
		2. Menambah jam pelayanan supaya pelayanan maksimal.	Melakukan close recruitmen untuk mengisi jam kosong pada siang hari.	Surat pemberitahuan kebutuhan Sp.Rad sudah diterima oleh Ketua Kolegium.
		3. Respon Time Radiologi	Kolaborasi dengan perawat untuk melakukan pencatatan di Google Spreadsheet secara real time.	Mulai dijalankan awal Tahun 2024.
5	Laboratorium	1. Pengadaan LIS.	1. Hardware sudah terpasang di Laboratorium. 2. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	Dalam antrian programmer.
		2. Stok Opname BDRS	BDRS berjalan mulai 29 November 2024.	SO akan dilakukan Pada hari Sabtu, 22 Maret 2025.
		3. Penambahan fitur	1. Penambahan fitur upload hasil laboratorium rujukan dari luar RS.	Dalam antrian Programmer PT.

			2. Penambahan fitur centang otomatis hasil pemeriksaan yang abnormal, batas atas dan batas bawah sudah dicatat dan diajukan ke Programmer PT.	
6	Gizi	1. Pengaktifan Poli Gizi di Rawat Jalan.	1. Kolaborasi dengan Humas&Marketing. 2. Kolaborasi dengan pelayanan antar obat (PRIMANTARA), free MCU Gizi.	Monitoring dan evaluasi setiap bulan.
		2. Prima Healthy Meal.	Sudah pengajuan TOR ke PT.	Menunggu ACC.
		3. Daftar Menu Makanan Penunggu VIP.	Book Menu sudah proses dikerjakan oleh PKRS.	Dalam proses.
		4. Registrasi alat makan	1. Kolaborasi dengan penyaji untuk melakukan pencatatan keluar masuknya sendok di Google Spreadsheet. 2. Perbaikan alur saat mengambil peralatan makan di ruangan, jika ditemukan sendok hilang maka dicatat di Google Spreadsheet dan dioperkan ke perawat ruangan untuk ditagihkan ke saat pasien KRS. 3. Dilakukan stok opname setiap bulan untuk menghitung peralatan makan. 4. Membuat SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS.	Registrasi alat makan sudah berjalan sejak Bulan Januari 2024 Proses dibuatkan SPO kehilangan alat makan, penggantian biaya dilakukan di Kasir, jika tidak tertagihkan maka tanggungjawab unit bersama.
		5. Pemesanan diit melalui SIMRS	1. Memastikan proses pemesanan diet lebih efisien dan mengurangi kesalahan pemesanan diet dari DPJP ke perawat, perawat ke ahli gizi. 2. Ahli gizi mengkonfirmasi diet di SIM-RS jika ada	Monitoring dan evaluasi.

			penambahan diet/ganti diet saat selesai visitasi di ruangan. 3. Proses cetak label langsung efisien tanpa harus mengetik ulang dan tidak menulis manual di label. 4. Koordinasi dengan bagian SIM-RS supaya segera di realisasikan ke unit.	
		6. QC sesuai sistem HACCP	1. Pelatihan HACCP dilakukan oleh seluruh Ahli Gizi. 2. Memastikan proses quality control makanan sesuai standar. 3. Memastikan 7 prinsip HACCP. 4. Koordinasi dengan SDM jika ada informasi terkait pelatihan tersebut.	Menunggu jadwal pelatihan.
7	Dapur	Perbaiki menu makanan dan plating.	1. Sudah dilakukan supervisi oleh Direktur Utama PT DPM pada hari Senin, 18 November 2024. 2. Kebijakan penggunaan alat makan dan SPO plating sudah dibuatkan sebagai pedoman penyaji dalam melakukan pekerjaan.	Monitoring dan Evaluasi. Revisi tampilan sedang diproses oleh PKRS (Eriko).
		Menu makanan buka puasa senin-kamis.	Program PT berjalan mulai tanggal 09 Desember 2024. Yang sudah disiapkan : 1. Daftar siklus menu makanan. 2. SPO pemesanan makanan buka puasa (+). 3. Link google form untuk pemesanan (+). 4. Kebijakan pemesanan makanan H-1 maksimal pukul 13.00 WIB.	Monitoring dan Evaluasi.
8	Pantry	Food Waste	Perbaiki pencatatan sisa makanan berdasarkan menu makanan untuk mengetahui makanan yang kurang diminati.	Dimulai awal Bulan Maret 2025.

7	CSSD	1. Mengajukan mesin sterilikator (steam plasma).	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi instrument bedah syaraf.
		2. Perbaiki serah terima menggunakan digital form.	Sudah berjalan di Bulan Juli.	1. Kolom tidak terisi lengkap. 2. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabisid.
		3. Perbaiki jam kerja	Pelayanan mulai pukul 06.30-21.00 WIB, jika ada alat yang akan disetor diatas jam pelayanan maka dilakukan pre-cleaning di unit masing-masing.	Berjalan per Bulan Desember 2024. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabisid.
8	Laundry	1. Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg.	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama.
		2. Membuat digital form untuk permintaan linen.	1. Rencana permintaan sehari 2 kali oleh unit sesuai dengan kebutuhan. 2. Belum terealisasi.	Dalam proses.
		3. Pengadaan Bedcover untuk pasien VIP dan LINEN IKO.	Rencana diajukan ulang dengan melampirkan keluhan pasien VIP, kerusakan linen IKO.	Dalam Proses.
		4. Perbaiki jam kerja	Pelayanan ada 3 shift, shift malam dimulai pukul 22.00-04.00 WIB tanpa jam istirahat, dan memenuhi stok di unit.	Berjalan per Bulan Desember 2024.
9	Lain-lain	Rapat Bulanan masing-masing Unit dengan Kabisid.	Dilakukan per Bulan November 2024. Supervisi pemahaman pelaksana tentang pedoman pelayanan, pengorganisasian, dan pelayanan sesuai dengan akreditasi. Pelaksanaan : 1. Tanya Jawab 2. Role Play	1. Pendaftaran Hari : Rabu, 16-04-2025. Waktu : 13.00 WIB sd selesai. Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom). 2. Farmasi Hari : Rabu, 23-04-2025. Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir

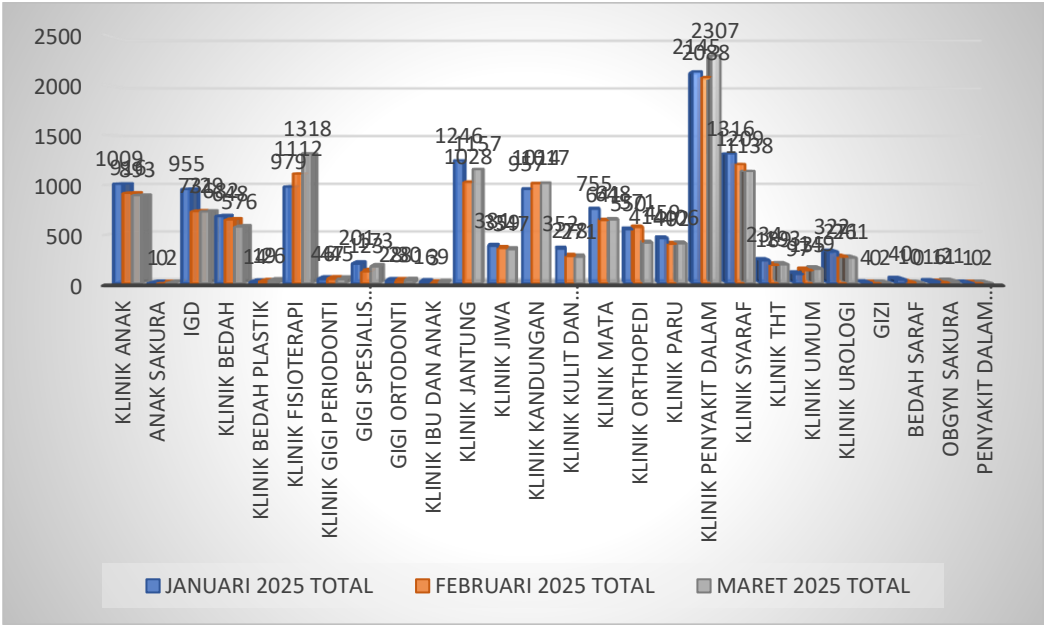
				menggunakan Zoom) 3. Gizi Hari : Selasa, 22-04-2025 Waktu : 11.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 4. Laboratorium Hari : Selasa, 15-04-2025 Waktu : 14.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 5. Radiologi Hari : Selasa, 22-04-2025 Waktu : 14.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 6. CSSD dan Laundry Hari : Kamis, 17-04-2025 Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Laundry (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 7. Rapat All Karu Penunjang Hari : Senin, 28-03-2025 Waktu : 15.00 WIB sd selesai Tempat : Ruang Direktur RS
--	--	--	--	---

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	JANUARI 2025			FEBRUARI 2025			MARET 2025		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	49	960	1009	49	867	916	42	851	893
2	Anak sakura	1	0	1	0	0	0	0	2	2
3	IGD	355	600	955	228	503	731	227	502	729
4	Klinik Bedah	58	624	682	47	601	648	28	548	576
5	Klinik Bedah Plastik	2	12	14	1	18	19	2	24	26
6	Klinik Fisioterapi	5	974	979	5	117	1112	1	1317	1318
7	Klinik Gigi Periodonti	6	40	46	9	38	47	7	38	45
8	Gigi spesialis pedodontis	20	181	201	18	105	123	17	156	173
9	Gigi Ortodonti	3	25	28	5	23	28	7	23	30
10	Klinik Ibu dan Anak	0	16	16	0	3	3	0	9	9
11	Klinik Jantung	37	1209	1246	25	1003	1028	23	1134	1157
12	Klinik Jiwa	9	372	381	8	351	359	12	335	347
13	Klinik Kandungan	108	849	957	116	898	1014	80	937	1017
14	Klinik Kulit dan Kelamin	45	307	352	27	251	278	20	251	271
15	Klinik Mata	42	713	755	47	594	641	46	602	648
16	Klinik Orthopedi	35	515	550	21	550	571	14	400	414
17	Klinik Paru	15	444	459	8	394	402	4	402	406
18	Klinik Penyakit Dalam	60	2085	2145	54	2034	2088	35	2272	2307
19	Klinik Syaraf	39	1277	1316	35	1174	1209	34	1104	1138
20	Klinik THT	56	178	234	38	151	189	36	157	193
21	Klinik Umum	69	28	97	122	13	135	125	24	149
22	Klinik Urologi	36	286	322	32	239	271	18	243	261
23	Gizi	3	1	4	0	0	0	1	1	2
24	Bedah Saraf	2	38	40	3	7	10	0	0	0
25	Obgyn Sakura	4	12	16	2	9	11	4	17	21
26	Penyakit dalam sakura	0	1	1	0	0	0	1	1	2
Total		988	12107	13095	900	10933	11833	784	11354	12138



Analisis :

1. Kunjungan di bulan maret meningkat dari bulan sebelumnya, sebanyak 2,5% dari bulan february 2025. Analisanya meskipun DPJP banyak yang cuti dan aktif 28 hari pasien

meningkat di sebabkan oleh seringnya pertemuan dengan FKTP sehingga banyaknya rujukan dari FKTP.

2. Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 2307 pasien. Kunjungan tersebut meningkat dari bulan sebelumnya sebanyak 219 pasien,
3. Kunjungan poli bedah saraf sangat menurun 100% dari bulan sebelumnya, karena dokter bedah saraf cuti panjang selama 3 bulan
4. Untuk poli pedodonti anak untuk bulan februari sempat menurun disebabkan banyaknya pendingan sehingga dokter membatasi pasien akan tetapi untuk bulan maret 2025 pasien meningkat 50 pasien
5. Kunjungan poli eksekutif adalah bulan maret meningkat 56% dari bulan februari 2025 disebabkan banyaknya kolaborasi baik dari pendaftaran dan rawat inap untuk menginformasikan tentang poli sakura

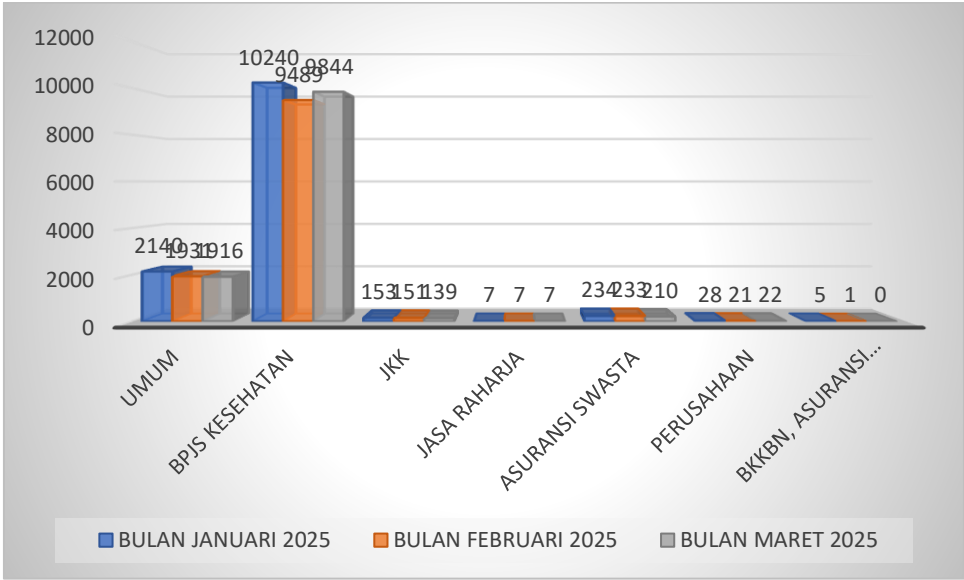
Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli sakura
2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum, asuransi tentang pelayanan poli sakura
3. Menambah jam HFIS untuk poli pedodonti sehingga akan menambah jumlah pasien
4. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
5. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
6. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
7. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
8. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.
9. Sosialisasi pada komunitas pasien geriatri maupu prolanis klinis MS, bahwa dokter gigi ortodonti (perawat gigi) dan poli sakura
10. Sosialisasi pada perusahaan dan stakeholder bahwa ada poli sakura yang menyediakan layanan one stop service
11. Mengajukan pelayanan baru otho, bedah, uro dan kulit di Poli Sakura

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN JANUARI 2025	%	BULAN FEBRUARI 2025	%	BULAN MARET 2025	%
1	Umum	2140	16,72%	1931	16,32%	1916	15,8%
2	BPJS Kesehatan	10240	79.99%	9489	80,19%	9844	81,1%
3	JKK	153	1,20%	151	1,28%	139	1,1%
4	Jasa raharja	7	0,05%	7	0,06%	7	0,1%
5	Asuransi swasta	234	1,83%	233	1,97%	210	1,7%
6	Perusahaan	28	2,05%	21	0,18%	22	0,2%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	5	0%	1	0,01%	0	
	Total	12802	100%	11833	100%	12138	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :
Kunjungan pasien bulan Maret 2025 berdasarkan cara pembayaran menurun 2,5% dari bulan februari 2025 . Kunjungan terbanyak adalah pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan sebesar 81,1%. Kunjungan bpjs meningkat di bandingkan bulan februari 2025 dikarenakan banyaknya kunjungan karena dokter spesialis akhir bulan banyak yang cuti jadi kunjunganya di maksimalkan pertengahan bulan maret 2025

Kunjungan terendah berdasarkan cara pembayaran kunjungan asuransi pemerintah dengan 0,% tidak ada kunjungan

Rencana Tindak Lanjut :
Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional.

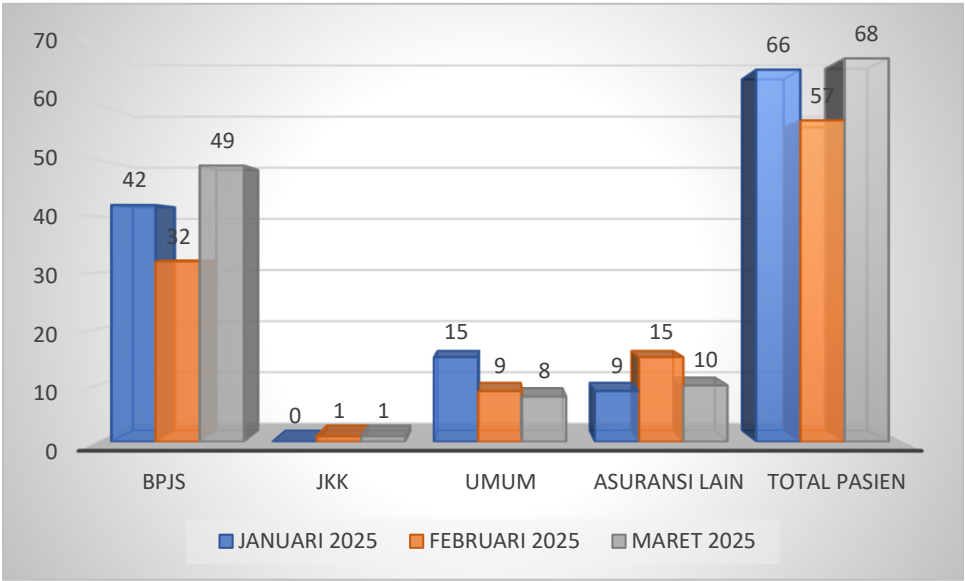
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari – Maret 2025)

NO	HAL	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	42	32	49	↑ 34,69%
2	JKK	0	1	1	0%
3	Umum	15	9	8	↓ 11,11%
4	Asuransi Lain	9	15	10	↓ 33,33%
Total Pasien		66	57	68	↑ 19.2%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Januari – Maret 2025)



3.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANS I	
1	Maret 2025	49	8	1	10	68
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret meningkat 34,69% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan dari di IGD banyak yang naik kelas	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan maret mengalami penurunan 11,11% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan dari di IGD juga menurun dan lodingan juga menurun	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret pasien tetap dengan bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret mengalami penurunan 33,33% dari bulan sebelumnya	Total pasien bulan maret 2025 mengalami peningkatan 19,2% (11 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran 2. Rencana penambahan VVIP 1 TT 3. Memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP 4. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap 5. Bekerjasama dengan marketing untuk meningkatkan pasien pasien asuransi terutama peusahaan perusahaan yang baru				

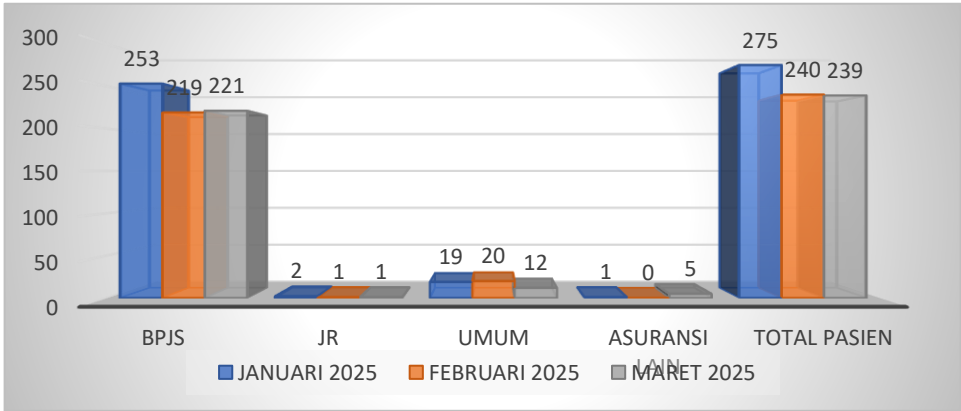
		6. Meningkatkan pelayanan yang lebih ekstra kepada pasien
		7. Mempromosikan ruangan vip/vvip lewat sosial media

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar
(Januari - Maret 2025)

NO	HAL	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	253	219	221	↑ 1%
2	JR	2	1	1	0%
3	Umum	19	20	12	↓ 67%
4	Asuransi Lain	1	0	5	↑ 100%
Total Pasien		275	240	239	0,5%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Januari - Maret 2025)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN MARET 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JR	ASURANSI	

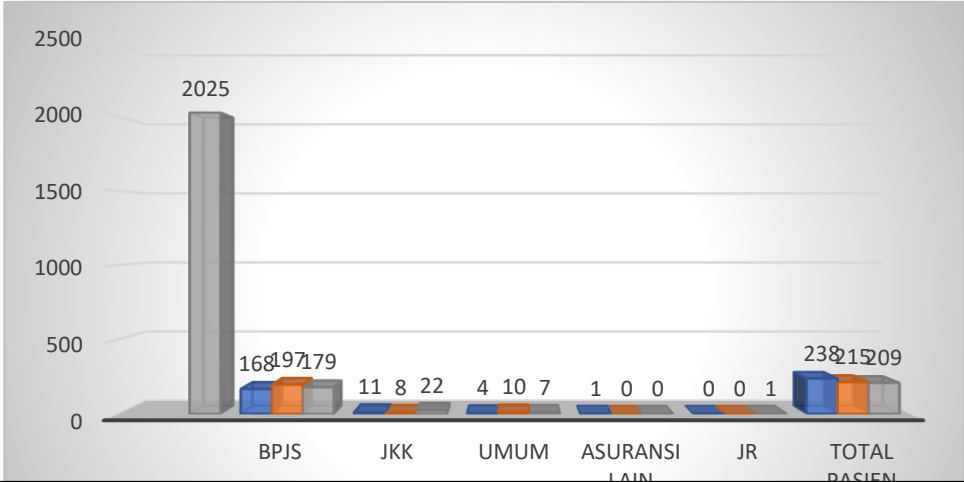
1	Analisis	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 1% dari bulan februari 2025	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil,untuk bulan maret 2025 mengalami penurunan 67% dari bulan sebelumnya	Pasien JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami stagnan dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 100% dari bulan sebelumnya	Total keseluruhan bulan maret mengalami penurunan 0,5% dari bulan februari 2025 (1 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulanya 2. Memperbaiki setiap fasilitas yang ada di unit jika ada yang rusak 3. Promosi ruangan anak lewat media sosial ,tiktok dan IG 4. Program taman anak-anak harus di terealisasikan di irna anak untuk tahun ini 5. Berkoordinasi dengan Marketing untuk kunjungan ke TK atau paud tentang pelayanan gigi anak baru				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari - Maret 2025)

NO	HAL	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	168	197	179	↓ 9,13%
2	JKK	11	8	22	↑ 175%
3	Umum	4	10	7	↓ 30%
4	Asuransi Lain	1	0	0	↓ 100%
5	JR	0	0	1	↑ 100%
Total Pasien		238	215	209	↓ 2,79%

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari - Maret 2025)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN MARET	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Maret 2025	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret mengalami penurunan 9,13% dari bulan sebelumnya disebabkan banyaknya kunjungan kelas 2 menurun di dari IGD dan lodingan poli	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret mengalami penurunan 30% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK 3 dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk kunjungan bulan maret mengalami peningkatan 175% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan rujukan dari perusahaan meningkat	Pasien JR/Asuransi dalam 3 bulan terakhir tidak ada akan tetapi bulan maret 2025 ada 1 pasien	Total pasien di lantai 2,3,dan 4 mengala mi penuruna n 2,79% (6 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Pemberian edukasi yang baik 7. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD				

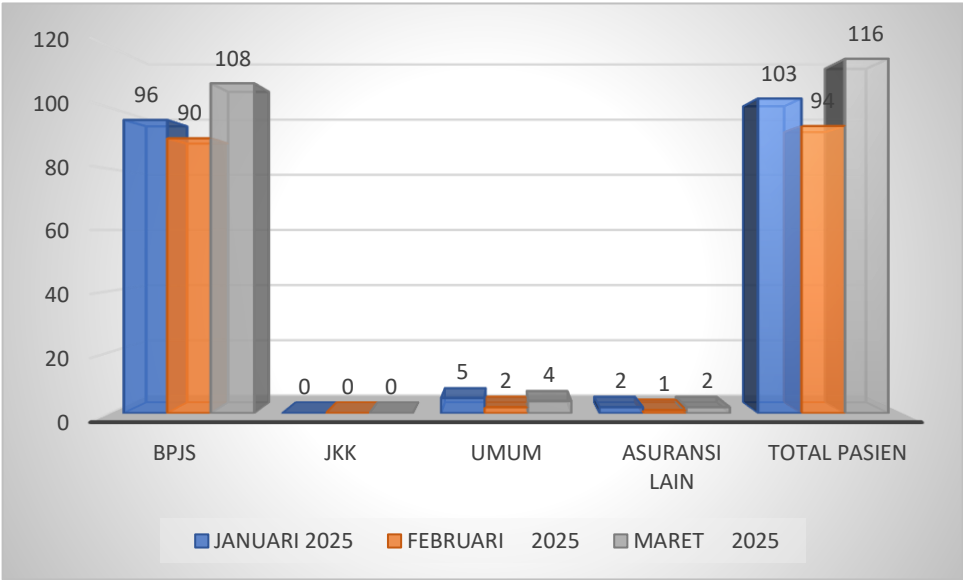
3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari - Maret 2025)

NO	HAL	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	96	90	108	↑16,6%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	5	2	4	↑50%
4	Asuransi Lain	2	1	2	↑50%
Total Pasien		103	94	116	↑18,9%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar

(Januari - Maret 2025)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

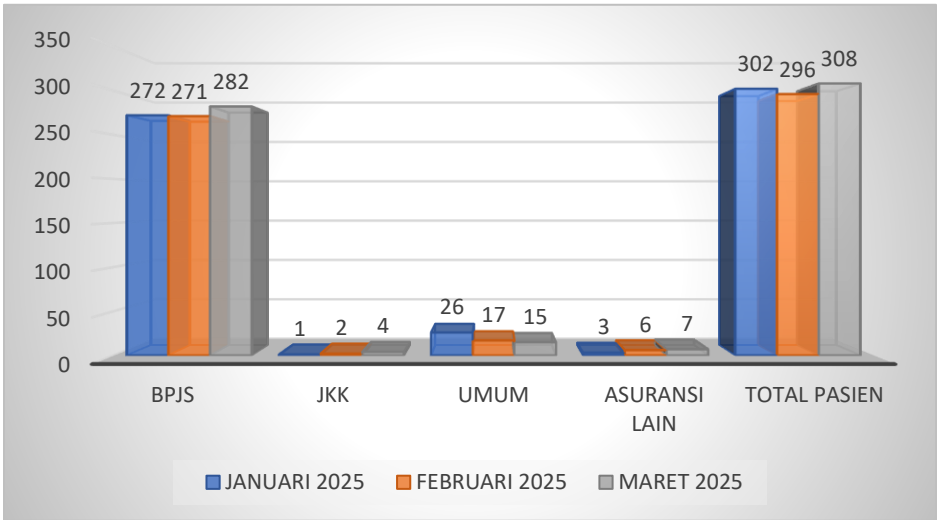
NO.	BULAN MARET	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret meningkat 16,6% dari bulan sebelumnya	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret mengalami peningkatan 50% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien di lantai 5C	Pasien Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 50% dari bulan sebelumnya	Pada bulan maret 2025 total pasien mengalami peningkatan 18,9% dari bulan sebelumnya
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkoordinasi dengan marketing untuk selalu koordinasi dengan faskes tentang pelayanan pasien TB di rumah sakit prima husada				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari - Maret 2025)

NO	PENJAMIN	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	272	271	282	↑ 3,9%
2	JKK	1	2	4	↑ 100%
3	Umum	26	17	15	↓ 13,3%
4	Asuransi Lain	3	6	7	↑ 14,28%
Total Pasien		302	296	308	↑ 3,89%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari - Maret 2025)



3.1.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN MARET	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 3,9% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan di IGD sudah stabil	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum mengalami penurunan bulan maret 2025 mengalami penurunan 13,3% di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 100% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan mengalami peningkatan untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 14,4%di bandingkan bulan sebelumnya	Total semua pasien mengalami peningkatan pasien 3,89 % dari bulan sebelumnya
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD				

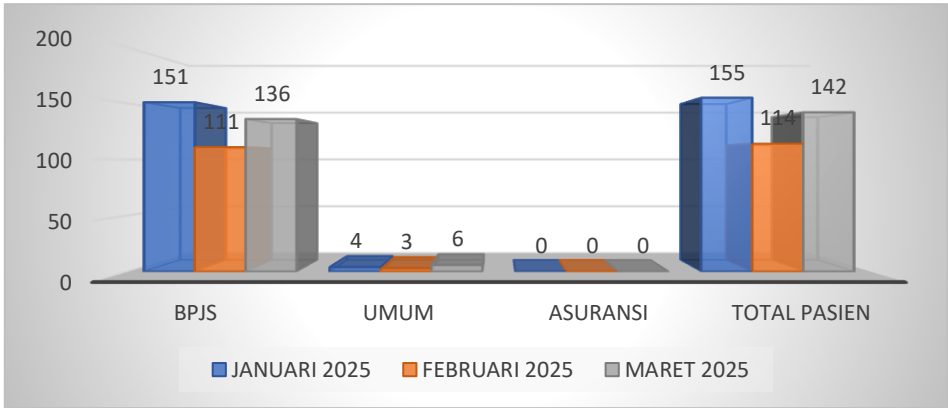
3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari – Maret 2025)

NO	HAL	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	151	111	136	↑ 18,3%
2	Umum	4	3	6	↑ 50%
3	Asuransi	0	0	0	0%
Total Pasien		155	114	142	↑ 19,71%

3.1.1.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar

(Januari - Maret 2025)



3.1.1.5.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO	BULAN MARET	RAWAT INAP			KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian maret 2025	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 18,3% dari bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 50% dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan maret 2025 tidak ada pasien	Total pasien bulan maret 2025 mengalami peningkatan 19,71%
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan bekerja sama dengan humas marketing terutama untuk kunjungan ke bidan bidan praktek yang mempunyai BPJS	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,bekerjasama dengan humas marketing untuk posting di ig tentang pelayanan di maternitas	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,dan mengadakan corporate gatreing dengan perusahaan setiap 1 tahun sekali	

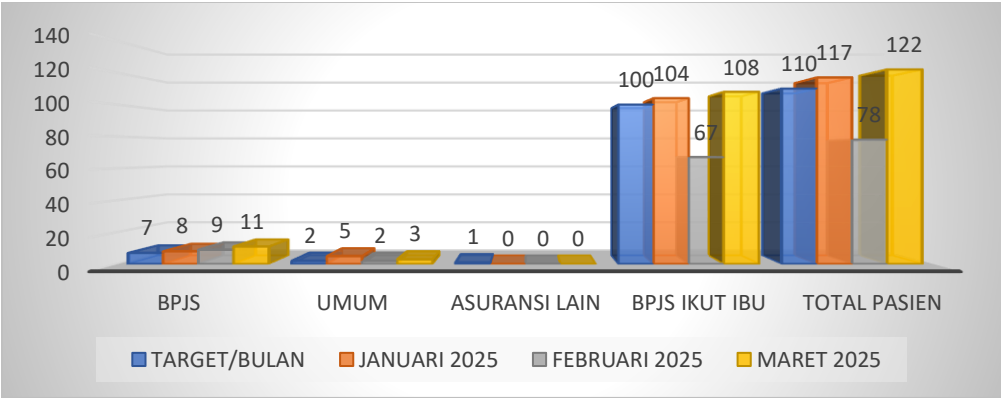
3.1.1.6 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari – Maret 2025)

NO	HAL	TARGET/BULAN	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	PERSENTASE TERHADAP
----	-----	--------------	--------------	---------------	------------	---------------------

						BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	8	9	11	↑ 22,2%
2	Umum	2	5	2	3	↑ 33,3%
3	Asuransi Lain	1	0	0	0	0%
4	BPJS IKUT IBU	100	104	67	108	↑ 61,2%
Total Pasien		110	117	78	122	↑ 56,4%

3.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari – Maret 2025)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

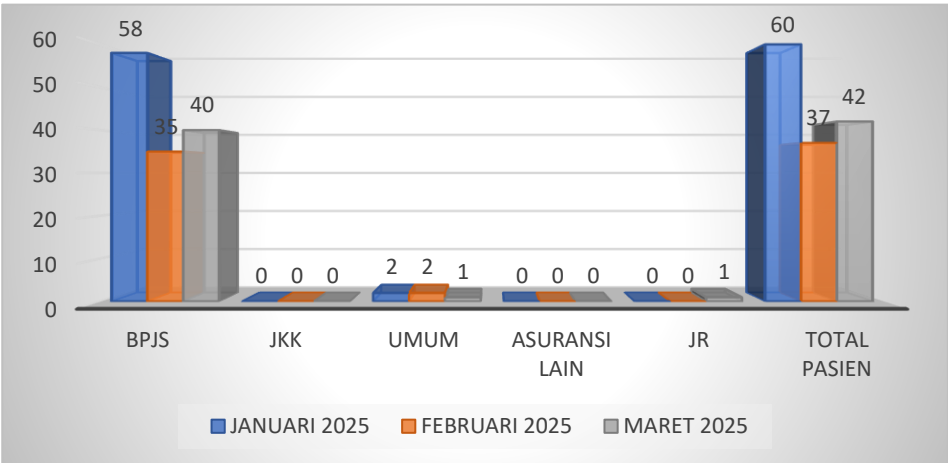
NO.	BULAN	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	Total Pasien
1	Maret 2025	11	3	0	108	122
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan maret 2025 meningkat 22,5% di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 33,3% dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 tidak ada pasien sama sekali	Pasien BPJS ikut ibu dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 61,2% dibandingkan bulan sebelumnya	Total pasien dalam bulan maret 2025 mengalami peningkatan 56,4% di bandingkan bulan sebelumnya
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, dan berkoordinasi dengan marketing untuk menginformasikan ke bidan bidan jejaring	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing, membuat program pelayanan baru seperti pijat bayi sehingga menarik banyak pasien	Meningkatkan pelayanan dan koordinasi dengan bagian marketing untuk meningkatkan pasien asuransi	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing,membuat program foto bayi dari unit neo

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)
3.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari - Maret 2025)

NO	PENJAMIN	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN
----	----------	--------------	---------------	------------	---------------------------

					SEBELUMNYA
1	BPJS	58	35	40	↑ 14,28%
2	JKK	0	0	0	tetap
3	Umum	2	2	1	↓ 50%
4	Asuransi Lain	0	0	0	tetap
5	JR	0	0	1	↑ 100%
Total Pasien		60	37	42	↑ 23,52%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Januari - Maret 2025)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN MARET	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 14,28% dibandingka n bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 jumlah kunjungan menurun 100% dengan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien 0	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 ada 1 pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien belum stabil untuk bulan maret total pasien meningkat 23,52% diabndingkan bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

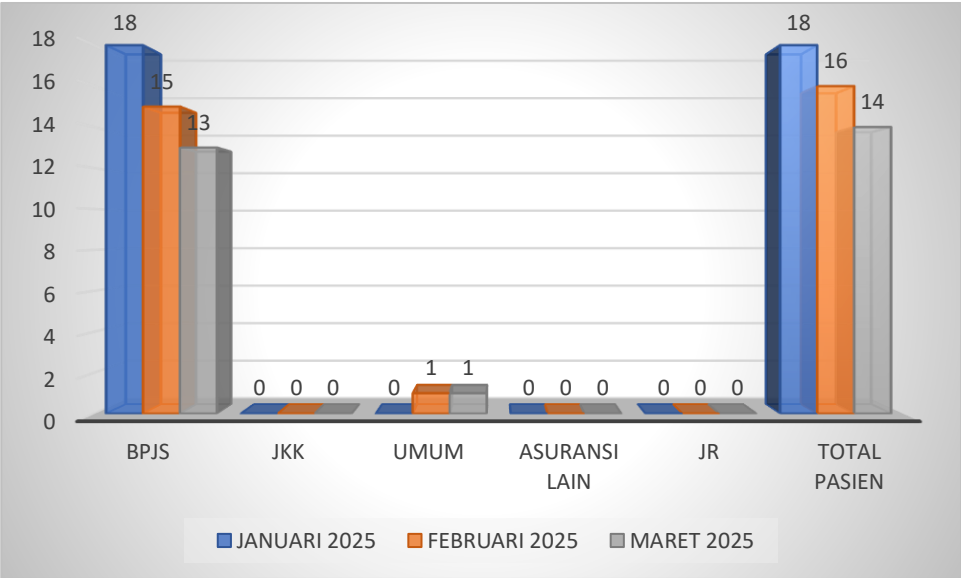
3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Januari - Maret 2025)

NO	HAL	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	18	15	13	↓13,33%

2	JKK	0	0	0	tetap
3	Umum	0	1	1	tetap
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	0	0	0	0%
Total Pasien		18	16	14	↓ 12,5%

3.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Januari - Maret 2025)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN MARET	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan, untuk bulan maret 2025 mengalami penurunan 13,33% di bandingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami stagnan dari bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum ada pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien bulan maret 2025 mengalami penurunan 12,25%
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit				

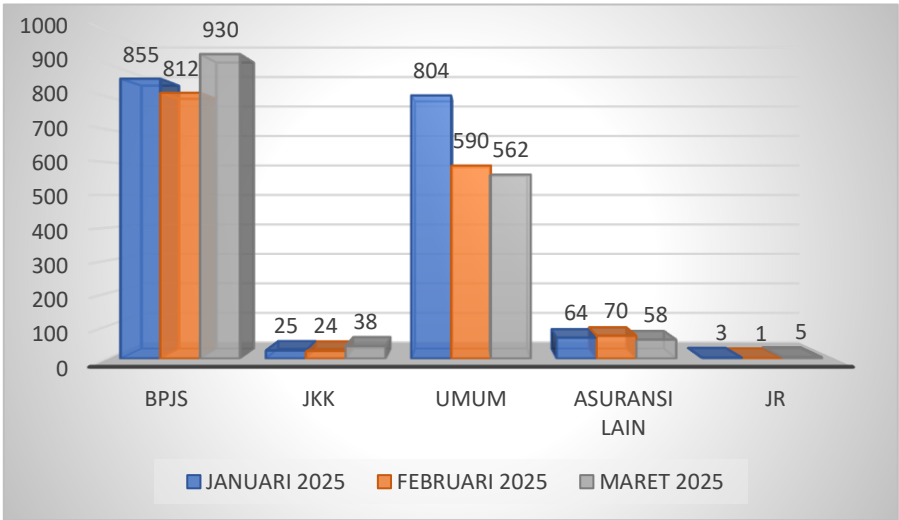
		4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat	
--	--	--	--

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.2.3 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari – Maret 2025)

NO	HAL	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	855	812	930	Type equation h ↑ 12,6%
2	JKK	25	24	38	↑ 36,8%
3	Umum	804	590	562	Type equation h ↓ 4,7%
4	Asuransi Lain	64	70	58	↓ 17%
5	JR	3	1	5	Type equation h ↑ 80%
Total Pasien		1751	1497	1593	↑ 6,0%

3.1.2.4 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Januari – Maret 2025)



3.1.3.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN MARET 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 12,6% dari bulan sebelumnya di sebabkan oleh	K Kunjungan pasien dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan maret 2025 mengalami 4,7% dari bulan sebelumnya disebabkan	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 36,8% dari bulan sebelumnya	Kunjungan pasien dengan jaminan JR dan asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami penurunan 11,2% dari bulan sebelumnya	ToTotal Kunjungan pasien IGD semua jaminan bulan maret 2025 mengalami peningkatan 6,0% dari bulan sebelumnya

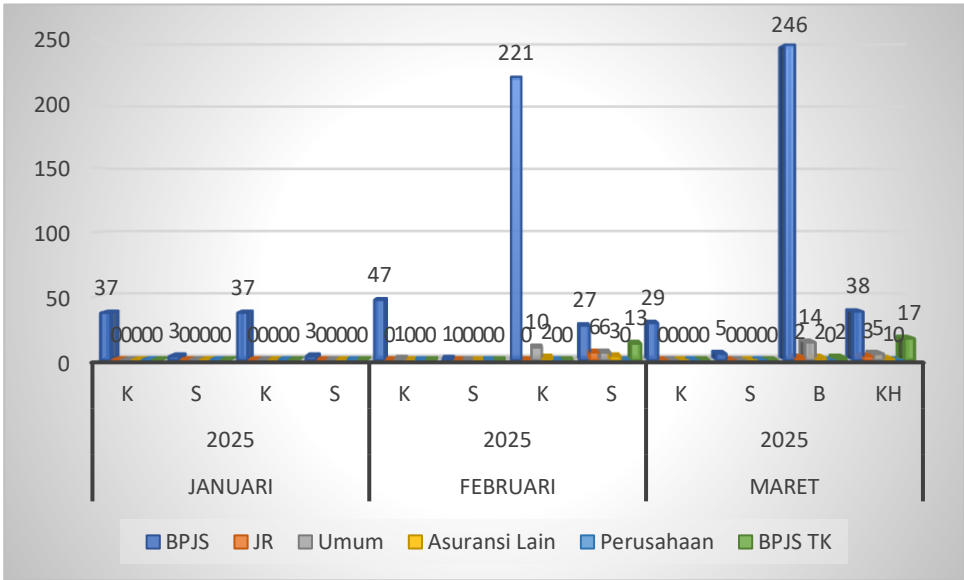
		pahaminya peraturan BPJS dan kains IGD sudah berganti dengan perbaikan alur	kunjungan di IGD mayoritas BPJS			
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD dengan memperbaiki pelayanan dan mengurangi komplain serta bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.2.5 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Januari – Maret 2025)

NO	HAL	JANUARI 2025				FEBRUARI 2025				MARET 2025				MARET 2025
		k	s	k	s	k	s	k	s	k	s	b	kh	
1	BPJS	37	3	37	3	47	1	221	27	29	5	246	38	Penurunan 0,5%
2	JR	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	3	
3	Umum	0	0	0	0	1	0	10	6	0	0	14	5	
4	Asuransi Lain	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	1	
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	BPJS TK	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	2	17	
	Total Pasien	337				366				364				364

3.1.2.6 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Januari – Maret 2025)



3.1.4.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN MARET	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	PERUSAHAAN	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir pasien operasi yang menggunakan BPJS meningkat untuk bulan maret 2025 meningkat 6,9% dari bulan sebelumnya	Pasien BPJS TK dalam 3 bulan operasi menggunakan bpjs TK meningkat untuk bulan maret 2025 31,5% di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien Umum operasi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami peningkatan 10,5 % dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien perusahaan dalam 3 bulan terakhir stagnan tidak ada operasi selama 3 bulan terakhir	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan maret 2025 mengalami penurunan 27,2 % di bandingkan bulan sebelumnya	Total pasien untuk bulan maret 2025 menurun 0,5%
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan mengurangi pasien IDO sehingga pasien puas dengan pelayanan operasi di prima husada 2. Berkoordinasi dengan bagian marketing untuk ekspos ruangan IKO yang sudah di ganti vinyl 3. Mengikuti pelatihan yang terbaru sehingga menunjang pelayanan yang terbaik di IKO 4. Berkoordinasi dengan humas marketing,terutama kunjungan ke perusahaan-perusahaan dan psc untuk mengirim ke prima husada malang 5. mengirimkan pelatihan asisten bedah saraf 6. Memberikan edukasi yang bagus untuk pasien pasien operasi					

3.2 Kinerja Bidang Penunjang

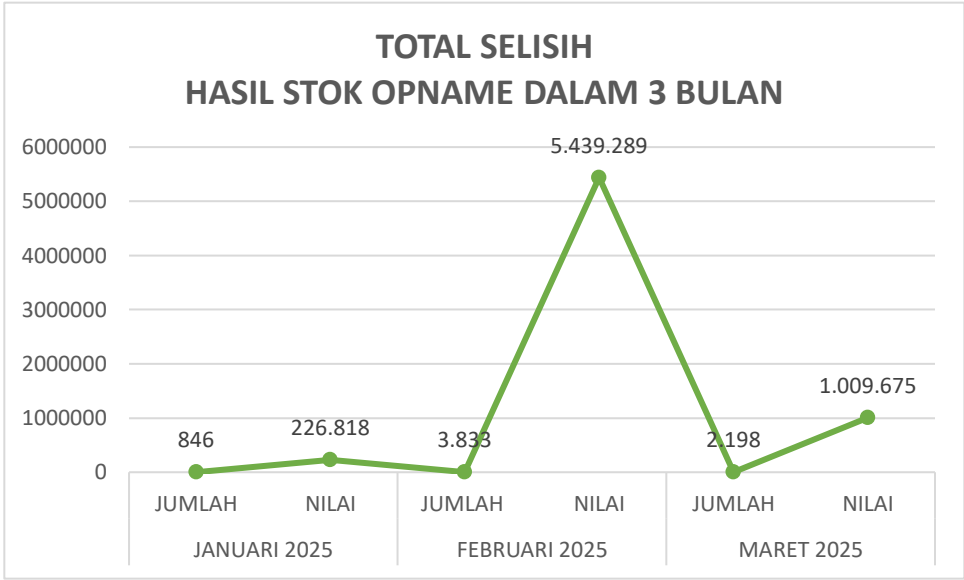
3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Januari – Maret 2025

UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH PERSEDIAAN					
		JANUARI 2025		FEBRUARI 2025		MARET 2025	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	FISIK	987.821	1.975.733.953	915.745	1.761.987.563	1.035.559	1.873.594.700
	SISTEM	987.822	1.975.808.953	915.745	1.761.987.563	1.035.558	1.874.036.506
	SELISIH	1	-75.000	0	0	1	+34.860
DEPO FARMASI	FISIK	154.951	485.480.619	157.013	480.400.038	163.384	504.874.177
	SISTEM	154.207	485.122.849	153.182	474.904.947	161.212	505.093.452
	SELISIH	745	+357.772	3.832	+5.495.099	2.173	-219.275
IKO	FISIK	2.031	81.909.892	1.905	89.600.086	1.891	91.545.201
	SISTEM	1.929	81.965.847	1.904	89.655.896	1.867	90.351.111

	SELISIH	102	-55.954	1	-55.810	24	+1.194.090
GUDANG RETURE	FISIK	0	0	0	0	0	0
	SISTEM	0	0	0	0	0	0
	SELISIH	0	0	0	0	0	0
TOTAL SELISIH		846	+226.818	3.833	+5.439.289	2.198	+1.009.675

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Januari – Maret 2025



3.2.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

Hasil stok opname pada Bulan Maret 2025 sudah mendekati target (+1.009.675), analisisnya sebagai berikut :		
NO	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
GUDANG FARMASI Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname belum mencapai target (0), yaitu sebesar + Rp 34.860. Analisa :		
1.	Kesalahan pengadaan PT dalam input master sediaan farmasi F04613 Fluconazole tab 150 mg – nulab Rak Obat Oral Generik satuan. Seharusnya 1 box isi 10 tab, sebelumnya terinput 1 box isi 30 tab menyebabkan adanya selisih stock 100 tab.	Koordinasi dengan Pengadaan PT untuk merubah master barang.
2.	F02895 Alkohol 95% dilakukan release pada sistem tetapi barang tidak di ambil oleh unit.	Perbaiki sistem serah terima BMHP : 3. Cetak SPB unit. 4. Serah terima barang BMHP dengan unit. 5. Release barang disistem sesuai yang diambil.
3.	Adanya rak sejenis menyebabkan kendala pada open periode SO pada bulan maret 2025.	Koordinasi dengan progamer.
4.	Adanya rak sistem yang tidak digunakan lagi (rak salep, rak tablet paten).	Penghapusan master rak oleh programmer.
5.	Dilakukan random cek pada seluruh rak sudah sesuai antara fisik dan system. Kartu Stok Berjalan.	Supervisi secara berkala.
DEPO FARMASI Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar - Rp 219.275, hal ini disebabkan karena :		
1.	Selisih lebih pada F02985 Vaseline album – Brataco karena termasuk barang untuk racikan salep dan penggunaannya sesuai peresepan dokter (timbangan mg) sedangkan master barang 1 klg = 1000 gr sehingga inputan resep di simrs 1 gr tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk racikan 1 mg.	Koordinasi dengan Pengadaan PT dan progamer master barang isi satuan 10.000 agar saat peresepan stok di simrs tidak cepat habis dan sesuai pemakaian mg.
2.	F04319 Mess No 20 - Aesculap secara sistem ada	Koordinasi dengan progamer untuk

	tetapi fisik barang tidak tersedia di depo farmasi.	menghapus master barang.
3.	Terdapat selisih kurang 90 vial F00558 obat suntik KB - Harsen, di depo tidak terdapat stock, sedangkan di sistem terdapat 90 vial, setelah di telusur obat tersebut ada di poli obgyn sehingga jumlah fisik tidak terhitung	Membuat Berita Acara Penyesuaian SO Sediaan Farmasi. Kains farmasi koordinasi dengan bidan poli obgyn perbaikan semua stok hibah yang ada disistem dikembalikan ke depo farmasi.
4.	F00791 vaksin hexaxim 0.5 ml - sanofi selisih kurang 1 vial karena DPJP salah input e-resep tanggal 12/03/2025 dimana resep dan inputan penjualan vaksin infanrix hexa 0.5 ml - gsk sebanyak 1 vial namun vaksin yang diambil tidak sesuai yaitu vaksin hexaxim 0.5 ml – sanofi sebanyak 1 vial.	Membuat Berita Acara Penyesuaian SO Sediaan Farmasi. Revisi penjualan resep by. Ny. Apip tanggal 12/03/2025 sesuai yang terpakai.
5.	Permintaan obat menggunakan resep manual di IGD.	Resep akan diarsipkan oleh Petugas Farmasi dan dilakukan double crosscheck, jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan. Perubahan alur untuk meminimalisir selisih SO.
6.	Inputan nama barang sama namun beda pabrik atau beda ukuran sehingga perawat sering tertukar saat input resep dan barang yang diambil, seperti: - F01419 Guedel airway 90 mm/no. 3 – hospitech = -1 - F01411 Guedel airway 100 mm/no. 4 – hospitech = +1 - F01642 Masker nebulizer set anak – onemed = +1 - F01643 Masker nebulizer set dewasa – onemed = -1 - F01691 Oxyflow bayi neonate (nasal oxygen cannul xs) – hospitech = +1 - F01694 Oxyflow pediatric (nasal oxygen cannul s) – hospitech = -1 - F01969 Spalk 15 x 5 cm (te-15) = +2 - F01970 Spalk 20 x 5 cm (te-20) = -2 - F00048 Asam mefenamat tab 500 mg - hexpharm jaya = +50 - F00047 Asam mefenamat tab 500 mg – mersi = -71 - F03280 Cefazolin sodium inj 1 g - ogb dexta = -28 - F00150 Cefazolin sodium inj 1 g - ogb mahakam = +28 - F04640 Cefotaxime inj 1 g - hexpharm jaya = +50 - F00157 Cefotaxime inj 1 g – mepro = -48 - F00199 Citicoline inj 500 mg/4ml - hexpharm jaya = +3 - F04516 Citicoline inj 500mg/4ml – mersi = -3 - F00490 Metronidazole inf 5% 100 ml - hexpharm jaya = -6 - F04633 Metronidazole inf 5% 100 ml – mersi = +1	Perbaikan prosedur menghabiskan stok lama dan mengingatkan petugas agar penyiapan barang sesuai yang diinput penjualan.
7.	Peralihan distribusi obat dari UDD ke ODD menyebabkan selisih lebih, yaitu 6. Retur ODD yang belum diturunkan ke depo farmasi tapi sudah dilakukan input retur.	Perbaikan prosedur retur barang tidak bertujuan: secara sistem proses retur barang tidak bertujuan wajib ada validasi dari keuangan PT. Kains membuat Berita Acara Obat Tidak bertujuan → Input penerimaan farmasi lainnya → di approve oleh PT → menambah stok di depo.

	7. Proses retur yang tidak optimal dari rawat inap (perawat tidak input retur disistem). 8. Obat di retur ke depo farmasi tanpa etiket sehingga farmasi kesulitan tracking obat tidak beretiket.	Retur barang bertujuan ke depo farmasi wajib sesuai di hari yang sama dengan inputan retur penjualan sebelum pasien KRS.
8.	Kartu stok belum berjalan.	Supervisi secara berkala.
FLOORSTOK IKO Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar + Rp1.194.090, hal ini disebabkan karena :		
1.	Jadwal operasi sering berbenturan dengan waktu perhitungan stok floorstock.	Menghitung barang yang sudah tidak terpakai untuk operasi dan memastikan barang yang di gunakan sebelumnya sudah terinput.
2.	Inputan nama barang sama namun beda pabrik atau beda ukuran sehingga perawat sering tertukar saat input resep dan barang yang diambil, seperti : - F01383 Foley cath 3 way no 22 – rusch = -1 - F01384 Foley cath 3 way no 24 – rusch = +1 - F00967 Benang t-vio 2-0 v10 – triton = -1 - F00969 Benang t-vio 2/0 v66 – triton = +1 - F00962 Benang t-silk 4-0 s78 – triton = +1 - F00971 Benang t-vio 4-0 v2 – triton = -1 - F00964 Benang t-vio 0 v12 – triton = -1 - F00966 Benang t-vio 1 v16 – triton = +1 - F01653 Mess no. 15 - b braun = +1 - F01654 Mess no. 20 - b braun = -1	Perbaikan prosedur menghabiskan stok lama dan mengingatkan petugas agar penyiapan barang sesuai yang diinput penjualan.
GUDANG RETUR Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname sudah sesuai dengan target (0).		
1.	Tidak terdapat rak Gudang Retur.	Sentralisasi master barang PT. DPM dan mengajukan gudang retur kembali dimunculkan.

3.2.1.4 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Januari – Maret 2025)

No	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tanggal Expired	No Batch	Jumlah Fisik Baik (BULAN)			Total Harga	Laporan Penjualan 1 Tahun Terakhir
							Januari	Februari	Maret		
1	F01348	Ett cuff no 4.5 - work	Pcs	36.500	30/03/2025	200321	12	12	12	483.000	1
2	F00320	Fludis inf 100 ml - bernofarm	Flash	165.000	30/03/2025	EID19350	17	7	6	1.155.000	14
3	F01495	Jarum 18 g x 1½" (precision glide) - bd	Pcs	1.500	30/03/2025	0098540	93	53	32	48.000	359
4	F03261	Koni e caps 400 - konimex	Caps	4.000	30/04/2025	23ADI	202	202	79	316.000	55
5	F00687	S-omevell inj 40 mg - novell	Vial	143.000	30/04/2025	250138	2	1	1	143.000	3
6	F00963	Benang t-vio 0 v11 - triton	Pcs	93.500	30/05/2025	220507OM	64	59	49	4.581.500	64
7	F00173	Cendo lyteers mds - cendo	Pcs	3.850	30/05/2025	SS60512	100	100	40	154.000	865
8	F01393	Foley cath no 8 -	Pcs	61.765	30/05/2025	20F28	5	4	4	247.060	23

		rusch									
9	F00385	Inviclot inj 5000 iu 5 ml - fahrenheit	Vial	66.000	30/05/2025	3HB578	10	10	8	528.000	2
10	F00546	Nutrisi lactogen lactose free 400 g - Nestle	Kaleng	116.036	30/05/2025	L33120346AB	1	1	1	116.036	2
11	F00939	Benang t-lene 5-0 I17 - triton	Pcs	80.000	30/06/2025	200601AC	1	1	1	80.000	100
12	F00455	Lovenox 60 mg/06 ml - sanofi	Amp	120.000	30/06/2025	4HS495FB	37	19	15	1.800.000	267
13	F00550	Nuvison tab - guardian	Tab	5.800	30/06/2025	2306083	650	626	424	2.459.200	1.304
14	F00796	Vaksin influenza - flubio - biofarma	Vial	121.032	30/06/2025	3020124	0	0	3	363.096	22
15	F00276	Epexol syr 120 ml - sanbe	Btl	18.200	30/07/2025	DG9786	24	24	8	145.600	28
16	F00542	Ntg inj 1 mg/ml - ferron	Vial	65.000	30/07/2025	BN4832412A	17	16	16	1.040.000	31
17	F00580	Osetamivir caps 75 mg (hibah dinkes) - indofarma	Caps	10.010	30/07/2025	210V2062	1.100	1.100	1.100	11.011.000	0
18	F03256	Frixitas tab 1 mg - novell	Tab	3.848	30/07/2025	23F297	94	94	38	146.224	161
19	F00500	Mikaject inj 250 mg/2 ml - mahakam	Vial	80.750	30/07/2025	A232131B	68	42	25	1.912.500	389
20	F00517	Neostigmine inj 05 mg/ml - ethica	Amp	10.901	30/07/2025	E23H0142A	17	15	15	163.515	2
21	F00030	Aminophylline inj 24 mg/ml - phapros	Amp	4.000	30/08/2025	66307030-1	49	36	34	132.000	227
22	F00307	Ferriprox tab 500 mg - apotex inc	Tab	35.100	30/08/2025	ry1625	194	194	194	6.809.400	0
23	F00603	Perossal 2x6 - dipa pharmala b	Pcs	231.000	30/08/2025	22HA14780	17	16	16	3.696.005	59
24	F00228	Cotrimoxazole syr 240 mg/5 ml - mersi	Btl	2.773	30/09/2025	A21797	89	82	76	210.748	244
25	F01337	Dj stent 6 fr close end - medika	Pcs	280.000	30/09/2025	76122032	14	14	14	3.920.000	17
26	F00607	Phenobarbital tab 30 mg - kimia farma	Tab	200	30/09/2025	I31729N	0	0	100	20.000	0
Total										41.680.884	

3.2.1.5 Analisis Obat Near ED < 6 bulan (Bulan Januari - Maret 2025)

Analisis	Tindak Lanjut
Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan Maret - September 2025 karena obat dan alkes slow moving: 1. Ett cuff no 4.5 - work, dimasukkan ke dalam trakea untuk memastikan tidak tertutupnya trakea sebagai saluran pernapasan dan udara pernapasan dapat masuk kedalam paru-paru. Faktur pembelian terakhir tanggal 19/07/2024 dari distributor sejumlah 8 pcs, penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 2. Fludis inf 100 ml - bernofarm, pengobatan infeksi non-sistemik oleh jamur candida pada vagina, tenggorokan, dan mulut. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/08/2021 dari distributor sejumlah 15 flash. 3. Jarum 18 g x 1½" (precision glide) - bd, digunakan untuk menggantikan needle/ jarum bawaan spuit, untuk menyuntik pasien. Penggunaan death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 28/08/2021 dari distributor sejumlah 600 pcs. 4. Koni e caps 400 - konimex digunakan untuk suplemen memelihara kesehatan kulit. Penggunaan slow moving, faktur pembelian terakhir tanggal 31/10/2023 dari distributor sejumlah 90 kapsul. 5. S-omevell inj 40 mg - Novell, di gunakan untuk gerd, helicobacter pylori eradication, gastric ulcer, Zollinger-ellison syndrome. Faktur pembelian terakhir tanggal 31/08/2024 dari RS Prima Husada Sukorejo sejumlah 2 vial. 6. Benang t-vio 0 v11 - triton, digunakan untuk operasi. Penggunaan alkes death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 31/07/2023 dari distributor sejumlah 12 pcs. 7. Cendo lyteers mds – cendo untuk melumasi dan menyejukkan pada mata kering akibat kekurangan sekresi mata atau teiritasi kondisi lingkungan, ketidaknyamanan karena penggunaan hard contact lens, gangguan penglihatan karena kelebihan lender pada mata. Penggunaan slow moving, faktur pembelian terakhir tanggal 25/06/2024 dari distributor sejumlah 200 pcs. 8. Foley cath no 8 - rusch, dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Faktur pembelian terakhir tanggal 09/12/2021 dari distributor sejumlah 30 pcs. 9. Inviclot inj 5000 iu 5 ml - Fahrenheit, digunakan untuk antikoagulan. Penggunaan obat death moving faktur pembelian terakhir tanggal 23/09/2023 dari distributor sejumlah 10 vial. 10. Nutrisi lactogen lactose free 400 g - Nestle merupakan susu formula bayi yang tidak mengandung laktosa dan digunakan pada bayi usia 0-12 bulan yang mengalami intoleransi terhadap laktosa dan diare. Faktur pembelian terakhir tanggal 18/04/2024 dari distributor sejumlah 3 kaleng. 11. Benang t-lene 5-0 I17 – triton, digunakan untuk operasi. Penyimpanan di IKO tidak FEFO sehingga ditemukan barang near ED, faktur pembelian terakhir tanggal 28/09/2021 dari distributor sejumlah 24 pcs. 12. Lovenox 60 mg/06 ml - Sanofi, digunakan sebagai antikoagulan. Faktur pembelian terakhir tanggal 19/12/2024 dari distributor sejumlah 30 amp, penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. 13. Nuvision tab - guardian, digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk memelihara kesehatan mata. Faktur pembelian terakhir tanggal 23/10/2023 dari distributor sejumlah 1980 tab.	1. Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ alkes yang near ed. 2. Koordinasi dengan karu untuk menggunakan alkes yang near ed. 3. Koordinasi dengan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. 4. Koordinasi dengan DPJP obat yang <i>death moving</i> di <i>stop order</i> dan dikeluarkan dari Formularium RS. 5. Sediaan farmasi near ED akan dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS akan diberikan ke PHS untuk lainnya akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan.

14. Vaksin influenza - flubio – biofarma, digunakan untuk melindungi tubuh dari penyakit akibat virus influenza. Faktur pembelian terakhir tanggal 20/03/2025 dari distributor sejumlah 4 vial, penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.
15. Epexol syr 120 ml - sanbe, sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya untuk eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik serta asma bronkial. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 20/09/2023 dari distributor sejumlah 15 botol.
16. Ntg inj 1 mg/ml - ferron, indikasi untuk mengontrol hipertensi dengan cepat selama pembedahan jantung, Menurunkan tekanan darah dan menjaga hipotensi yang terkontrol selama prosedur pembedahan, Mengontrol iskemia miokard selama dan setelah pembedahan, Gagal jantung kongestif yang tidak responsif karena infark miokard akut, Angina tidak stabil yang sulit disembuhkan dengan beta blocker dan nitrat sublingual. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 25/06/2024 dari distributor sejumlah 10 amp.
17. Oseltamivir caps 75 mg (hibah dinkes) – indofarma, untuk mengatasi infeksi virus influenza tipe A atau B. Penggunaan obat death moving. Penerimaan obat dari dinas kesehatan tanggal 06/08/2021 sejumlah 700 tablet untuk pengobatan covid-19.
18. Frixitas tab 1 mg – novell, untuk mengatasi kegelisahan berlebihan dan agoraphobia. Faktur pembelian terakhir tanggal 11/11/2021 dari distributor sejumlah 120 tablet. Penggunaan obat death moving peresepan terakhir tanggal 24/07/2024.
19. Mikaject inj 250 mg/2 ml – Mahakam sebagai antibiotik. Faktur pembelian terakhir tanggal 03/01/2025 dari distributor sejumlah 40 vial, penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor.
20. Neostigmine inj 05 mg/ml – ethica untuk meringankan gejala myasthenia gravis, pengobatan ileus paralitik, retensi urin pasca operasi. Faktur pembelian terakhir tanggal 28/11/2024 dari distributor sejumlah 10 ampul. Penggunaan obat slow moving tapi termasuk obat emergency.
21. Aminophylline inj 24 mg/ml – phapros, untuk mengatasi serangan asma bronkial. Pembelian terakhir tanggal 27/11/2024 dari RS Prima Husada Sukorejo sejumlah 30 ampul. Penggunaan obat slow moving tapi termasuk obat emergency.
22. Ferriprox tab 500 mg - apotex inc untuk terapi kelebihan Fe (zat besi) pada pasien talasemia mayor. Faktur pembelian terakhir tanggal 21/02/2021 dari distributor sejumlah 300 tablet. Penggunaan obat death moving karena obat tidak bisa di klaim obat kronis di FKRTL.
23. Perossal 2x6 - dipa pharmlab merupakan material sintetik pengganti tulang yang resorbable, digunakan untuk pengisian atau rekonstruksi tulang pada tulang yang rusak. Faktur pembelian terakhir tanggal 15/01/2025 dari distributor sejumlah 12 pcs, penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor.
24. Cotrimoxazole syr 240 mg/5 ml – mersi untuk infeksi saluran nafas, kulit, saluran kemih dan kelain, gastrointestinal, infeksi THT. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/12/2024 dari distributor sejumlah 30 botol.

25. Dj stent 6 fr close end – medika dimasukkan ke dalam ureter untuk mencegah atau menangani penyumbatan aliran urine dari ginjal. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/11/2024 dari distributor sejumlah 5 pcs.	
26. Phenobarbital tab 30 mg - kimia farma, digunakan untuk mengobati atau mencegah kejang. Peresepan terakhir tanggal 01/04/2023 penggunaan obat jadi death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 16/02/2024 dari distributor sejumlah 100 tab.	

3.2.1.6 Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

No Risk	Divisi	Spesialis terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	Komit e medik	Dokter/ Dokter spesialis	Pasien	Klini s	Kesalahan input e-resep	Kontrol dan supervisi	9	Ekstri m	Kemungkin an besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	SPO penulisan dan input resep serta supervisi	Meninjau ulang setiap tahun terkait kompetensi dokter
2	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klini s	Kesalahan penyiapan obat	Kontrol dan supervisi	14	Ekstri m	Kemungkin an besar	Turun	Kontrol dan supervisi serta pelatihan berkelanjutan	3 bulan - 6 bulan	6	SPO alur pelayanan resep rawat jalan dan resep pulang pasien rawat inap. Jumlah TTK/ apoteker terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga. Terdapat diklat dan motivasi kerja	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

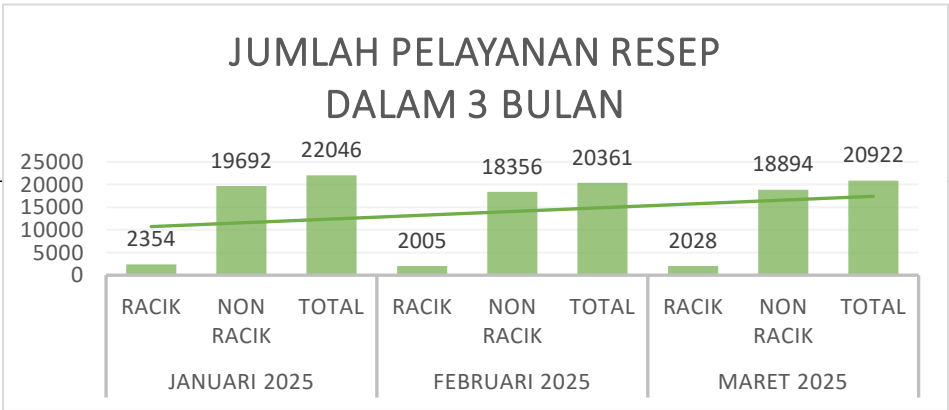
3	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan penulisan pada etiket obat	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
4	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Obat tidak dilengkapi <i>expired date/ beyond use date</i>	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
5	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan identifikasi pasien	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
6	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan pemberian obat pada pasien	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	SPO telaah obat, SPO verifikasi pemberian obat rawat inap. Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

7	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	3	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
8	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	Kontrol dan supervisi	3	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
9	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden reaksi alergi obat	Kontrol dan supervisi	11	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
10	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kesalahan dosis obat	Kontrol dan supervisi	8	Ekstrem	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

3.2.1.7 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Januari - Maret 2025

UNIT	JUMLAH RESEP					
	JANUARI 2025		FEBRUARI 2025		MARET 2025	
	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
IRNA	216	8639	195	8229	220	8506
IRJA	2005	7929	1726	7389	1686	7529
IKO	0	899	0	794	0	919
IGD	133	2225	84	1944	122	1940
TOTAL	2354	19692	2005	18356	2028	18894
JUMLAH RESEP OBAT	22.046		20.361		20.922	

3.2.1.8 Grafik Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Januari - Maret 2025



Analisis :

Secara keseluruhan total resep pada Bulan Maret 2025 mengalami peningkatan namun tidak signifikan, hal ini sebanding dengan peningkatan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap.

Peningkatan yang tidak signifikan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1. Jumlah pasien baru tidak banyak.
- 2. Target PRB rawat jalan juga tetap berjalan, dimana pasien rujuk balik ke FKTP dikarenakan pasien sudah stabil dan retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien.
- 3. Kenaikan pasien rawat inap tidak signifikan, karena terdapat penurunan jumlah pasien rawat inap di akhir bulan (cuti bersama).

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
- 2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
- 3. Mengajukan fitur cek hasil laboratorium dalam batas waktu 6 bulan dari IRNA dan IRJA untuk memudahkan pemberian obat sesuai dengan retriaksi yang ditentukan.
- 4. Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver.
- 5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru dan obat tertinggal.
- 6. Perubahan alur distribusi obat, petugas melebur menjadi satu. Penambahan petugas shift malam supaya tidak terjadi lembur menyelesaikan obat rawat jalan.
- 7. Penambahan admin IKO untuk focus pada mutase barang di Floorstok IKO.

3.2.1.9 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari - Maret 2025

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025	
1.	Pengkajian Resep	100%	99.42%	99.17%	99.14%	Jumlah pengkajian resep, yaitu Januari 2025 = 22.046 Februari 2025 = 20.361 Maret 2025 = 20.922 Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep, yaitu Januari 2025 = 128 Februari 2025 = 168 Maret 2025 = 180
2.	Dispensing sediaan steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di Ruang Pencampuran Obat Steril (LAF).
3.	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan dalam RM.
4.	Kejadian Efek Samping Obat	0	0	1	0	Tidak ditemukan pelaporan efek samping obat pada Bulan Maret 2025.
5.	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep obat yang ditandatangani oleh penerima obat.
6.	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di Lembar Edukasi (pasien rawat inap) dan tanda-tangan penerima obat di resep (pasien rawat jalan).
7.	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8.	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	99.92%	Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar. Dilakukan pada hari Kamis, 27-03-2025 dengan dr Adhya Aji, Sp.PD.

9.	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh Apoteker di RM.
10.	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape.
11.	Obat tidak bertuan	0	0	365	20	Ditemukan retur obat tidak bertuan sehingga dilakukan retur ke Gudang Retur dan sudah dilakukan penerimaan farmasi lain di SIMRS.
12.	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	50	34	29	Obat tertinggal dikirimkan menggunakan PRIMANTARA, untuk pasien yang tidak merespon obatnya dilakukan return.
13.	Penempelan label obat rawat inap	100%	100%	100%	100%	Tidak ada laporan penempelan label obat rawat inap yang tidak ada dan tidak ada laporan IKP kejadian kesalahan penulisan etiket obat.

3.2.1.10 **Tabel Analisa dan Tindakanlanjut Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada pada Bulan Januari - Maret 2025**

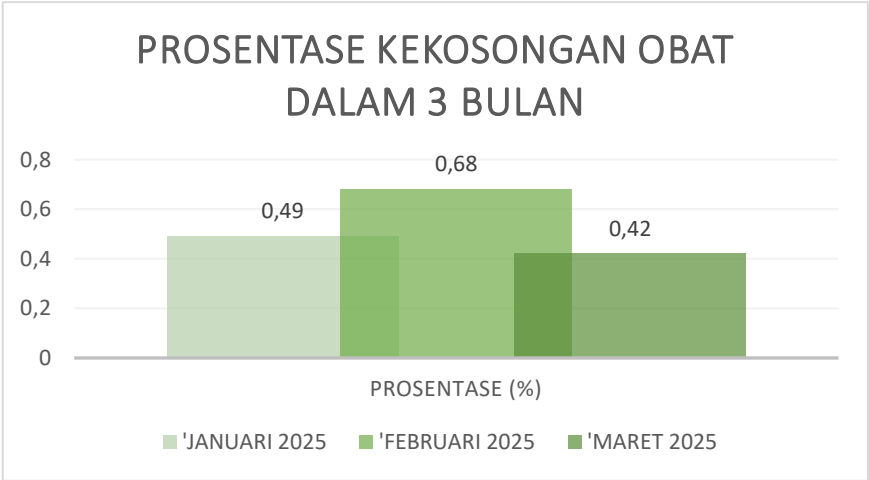
Kinerja	Analisa	Tindakanlanjut
Pengkajian Resep	Penulisan resep yang lengkap bulan Maret 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Februari 2025, dengan prosesntase resep yang tidak lengkap yaitu : bulan Februari 2025 sebanyak 99.17% dan bulan Maret 2025 sebanyak 99.14%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep : 1. Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS 2. Dari segi telaah farmasetik : masih ditemukan dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi. 3. Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh apoteker.	1. Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke IFRS. 2. Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual). 3. Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.
Kejadian Efek Samping Obat	1. Hasil monitoring pelaporan MESO bulan Januari 2025 tidak ditemukan terjadinya efek samping obat. 2. Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.	1. Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan. 2. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x

		24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien. 3. Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO). 4. Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO. 5. Menganalisa laporan ESO. 6. Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO). 7. Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
Edukasi Obat Pada Pasien dan Keluarga	1. Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi. 2. Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.	Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
Pelayanan Informasi Obat (PIO)	PPA dapat megakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di nurse station atau di poli.	Map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape sudah tersedia di unit pelayanan
Obat Tidak Bertuan	1. Retur obat tidak bertuan dikarenakan proses retur yang tidak optimal dari rawat inap dan rawat jalan (perawat tidak input retur disistem). 2. Obat di retur ke depo farmasi tanpa etiket sehingga farmasi kesulitan tracking obat tidak beretiket.	1. Obat tidak layak dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan. 2. Obat layak di retur ke gudang retur farmasi dengan berita acara obat/ alkes tidak bertuan yang sudah di tandatangani oleh Direktur RS, kemudian keuangan PT memberikan persetujuan akhir dan dilakukan Penerimaan Farmasi Lain di SIMRS. 3. Pembuatan fitur khusus untuk obat tidak bertuan dan pengembangan fitur approval berjenjang. 4. Peningkatan akurasi manajemen stok obat.
Obat Tertinggal Yang Tidak Diambil Pasien	Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien bulan Maret 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Februari 2025, dengan total resep yang di retur yaitu bulan Februari 2025 sebanyak 34 dan bulan Maret 2025 sebanyak 29. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam dan keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama.	Terdapat program pengantaran obat gratis melalui Primantara sehingga mengurangi jumlah obat tertinggal.

1.2.1.11 Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Januari - Maret 2025

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
JANUARI 2025					
1.	1/1/2025-31/1/2025	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
2.	1/1/2025-31/1/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3.	1/1/2025-31/1/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4.	1/1/2025-31/1/2025	Spironolakton tab 25 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
5.	1/1/2025-31/1/2025	Spironolakton tab 100 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
6.	4/1/2025-15/1/2025	Gliquidone tab 30 mg	Antidiabetes	PT. Anugrah Argon Medica	Substitusi dengan golongan Antidiabetes Oral lain
Total prosentase Januari 2025 = 0.49%					
FEBRUARI 2025					
1.	1/2/2025-28/2/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2.	1/2/2025-28/2/2025	Spironolakton tab 100 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Substitusi ke Spironolakton tab 25 mg
3.	1/2/2025-28/2/2025	Orezinc syr 60 ml	Obat untuk diare	PT. Antar Mitra Sembada	Zincpro syr 60 ml
4.	1/2/2025-28/2/2025	Quetvell tab 200 mg	Anti psikosis	PT. Antar Mitra Sembada	Soroquin tab 200 m
5.	1/2/2025-28/2/2025	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
6.	1/2/2025-28/2/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
7.	1/2/2025-28/2/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
8.	1/2/2025-28/2/2025	Gliquidone tab 30 mg	Antidiabetes	PT. Anugrah Argon Medica	Substitusi dengan golongan Antidiabetes Oral lain
Total Prosentase Februari 2025 = 0.68%					
MARET 2025					
1	1/3/2025-31/3/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/3/2025-31/3/2025	Quetvell tab 200 mg	Anti psikosis	PT. Antar Mitra Sembada	Soroquin tab 200 mg
3	1/3/2025-31/3/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
4	1/3/2025-31/3/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
5	1/3/2025-31/3/2025	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
Total prosentase Maret 2025 = 0.42%					

1.2.1.12 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari - Maret 2025



Analisis :

- 1. Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan masih sering terjadi kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator seperti Haloperidol tab 5 mg – Yarindo, Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg, dan Itraconazole caps 100 mg sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- 2. RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- 2. Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- 3. Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- 4. RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- 5. Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

1.2.1.13 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan Maret 2025

No	Kegiatan	Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan	Jumlah	Alasan	Keterangan
1.	Pemusnahan	Phenobarbital tab 30 mg	200 tablet	Obat expired date 02/2025, no batch B30325N	Pemusnahan obat dilakukan tanggal 05 Maret 2025. Tempat dilakukan pemusnahan : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
2.	BMHP/Alat Kesehatan Rusak (Substandar)	Harum Pen (Couter Pencil) - Medmax	Semua stok yang tersedia	1. Jika dipakai mengeluarkan bau tak sedap (asumsi dpjp dari cat birunya) 2. Jika dipakai coagulasi lewat alat harus menggunakan bagian ujung (tapi	Form keluhan alat kesehatan substandard dari IGD dilaporkan tanggal 01/02/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT. DPM namun belum ada tindak lanjut penggantian produk

				mengeluarkan percikan api), jika menggunakan bagian tengah tidak bisa 3. Risiko menimbulkan luka bakar pada pasien	
3.	Recall	-	-	-	Tidak ada recall

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan Maret 2025

NO	MONITORING DAN EVALUASI	HASIL	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP	Perencanaan dilakukan dengan metode konsumsi dan pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dengan pembelian, repacking dan donasi/ hibah Evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP digudang farmasi menggunakan sistem ROP dan Non ROP farmasi di SIMRS, dikarenakan sistem ROP belum mendeteksi penjualan obat slow moving namun tetap harus disediakan jadi petugas mendata obat menipis secara manual kemudian diinput Non ROP farmasi	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP menggunakan sistem ROP di gudang farmasi.
2.	Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ke distributor	Tersedia PKS dengan distributor; Semua pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, termasuk obat vaksin harus menjamin garansi keaslian yakni : a. Sediaan farmasi - No.Ijin Edar dari BPOM b. Alkes - No.Ijin Edar dari Dirjen Binfar dan CoA c. BMHP - No ijin edar dari Binfar d. B3 - MSDS; Kunjungan ke distributor; Surat Pesanan obat, alkes, dan BMHP di tandatangan oleh APJ	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP
3.	Pemantauan suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin	Form monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin sudah tersedia namun petugas masih tidak rutin mengisi.	Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo dan gudang farmasi oleh apoteker setiap hari
4.	Supervisi box emergency, trolley emergency, kit emergency, box HPP dan Eklamsi	Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali. Bedah box triwulan 1 pada bulan januari 2025 sudah dilakukan. Berikut temuan obat yang mendekati ED 6 bulan dan diganti dengan ED jauh yaitu : - Box emergency poli lantai 1 : penggantian obat near Ed dexamethason injeksi (ed : 8/25 → 6/26), valisanbe injeksi (ed 8/25 → 7/26) - Box emergency poli treadmill : manitol infus (5/25 → 6/26), na phenytoin injeksi (ed 7/25 → 9/27), dexamethason injeksi (ed : 8/25 → 6/26) - Box emergency poli lantai 2 : tidak ada obat ED < 6 bulan - Trolley emergency IGD : dobutamin injeksi (7/25 → 9/27, infus gelafusal (ec 5/25 → 3/27), manitol infus (5/25 → 1/26), na phenytoin injeksi (ed 7/25 → 7/26)	Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut : a. Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari. b. Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka. c. Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali

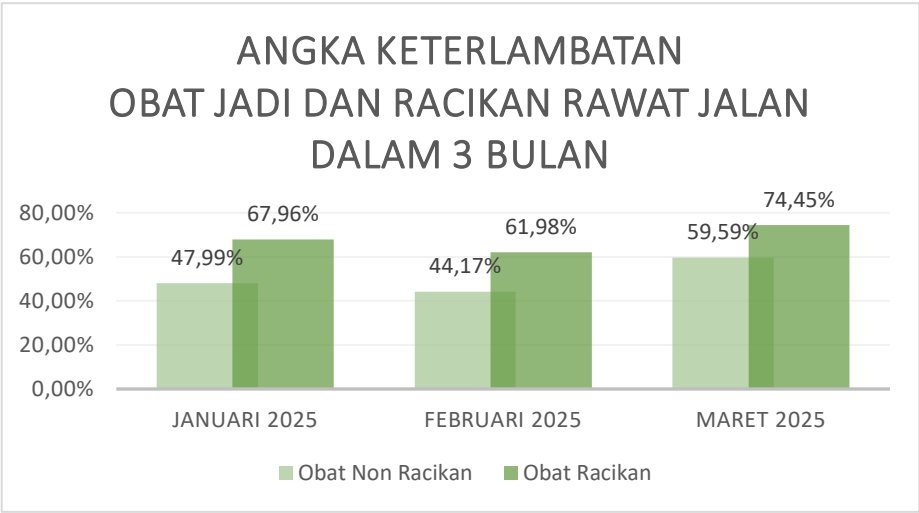
		- Box emergency infant Ponak IGD : gelafusal infus (ed 5/25 → 3/27) - Box HPP - Eklamsi tidak ada obat near ED - Kit emergency IGD : infusion set dewasa (ED 6/25 → 10/29), dexamethason injeksi (ED 5/25 → 5/26) - Box emergency ambulance 1 : amiodarone inj (ED 5/25 → 6/26), dexamethasone inj (ED 6/25 → 6/26), miniaspi (ED 5/25 → 3/27), phinev inj (ED 7/25 → 7/27), cairan NS 0.9 500 ml (ED 6/25 → 10/26) - Box emergency ambulance 2 : cairan NS 0.9% 500 ml (ED 6/25 → 10/26), infusion set dewasa (ED 5/25 → 10/29), iv canul 20 (ED 6/25 → 6/29), iv canul 22 (ED 6/25 → 6/28) - Box HPP-Eklamsi set IKO : As. Tranexamat (3/26 → 10/26), Misoprostol (11/25 → 3/26), Kondom (3/26 → 12/26), Cairan WFI (5/26 → 9/26), Calcii gluconas (4/26 → 3/27), MgSO4 20 % (6/25 → 9/26), MgSO4 40% (5/25 → 11/26), Jarum no. 23 (8/26 → 11/27) - Box emergency infant dan trolley emergency IKO: tidak ada obat ED < 6 bulan - Box emergency 2C : Amiodarone (9/25 → 6/26) dexametasone (5/25 → 6/26), Dopamine (9/25 → 9/26), valisanbe (3/25 → 6/26), Infus D5% (7/25 → 11/26) Infus gelafusal (6/25 → 4/27) - Box emergency ICU Ventilator : Dexametasone (5/25 → 6/26), Norepinephrine (6/25 → 4/26). Box emergency ICU : Amiodarone (11/25 → 5/26), Dopamine (9/25 → 9/26), Phenytoine (7/25 → 9/27), Infus D5% (7/25 → 11/26) - Box emergency HCU : Amiodarone (8/25 → 6/26), Dopamine (9/25 → 9/26), Infus D5% (7/25 → 11/26), Spuit 1cc (8/25 → 5/29) - Box emergency 3C : Amiodarone (8/25 → 6/26), Dopamine (9/25 → 2/26), furosemide (9/25 → 6/26), infus D5% (7/25 → 11/26), Iv cannula no. 20 (10/25 → 6/26) - Box emergency 3A : Amiodarone (9/25 → 6/26), Dexametasone (8/25 → 6/26), Dobutamine (8/25 → 11/27), Furosemide (9/25 → 6/26), Na phenytoin (7/25 → 9/27), Dopamine (9/25 → 2/26), Infus D5% (9/25 → 11/26), Clopidogrel (12/25 → 10/26) - Box emergency 4A : Dobutamin (10/25 → 11/27), Dopamine (11/25 → 9/26), Dexametasone (6/25 → 6/26), Furosemide (9/25 → 6/26), Manitol (9/25 → 6/26) - Box emergency Maternitas : tidak ada obat ED < 6 bulan - Trolley emergency Maternitas : Spuit 3 cc (10/25 → 6/29), Blood set (8/25 → 7/29), Spuit 20 cc (7/25 → 10/29), Oxyflow dewasa (10/25 → 11/29) - Box emergency PICU : ISDN (5/25 → 8/26), Ephineprine (10/25 → 8/26), Dexametasone (8/25 → 6/26), suction cath no. 8 (10/25 → 2/28) - Box emergency 5C : Infus D5 (9/25 → 11/26), infus gelafusal (9/25 → 4/27), amiodarone (11/25 → 6/26), clopidogrel (11/25 → 10/26), dexamethasone (10/25 → 6/26), dopamin (4/26 → 9/26), ephineprine (8/25 → 7/27), na. phenytoin (7/25 → 9/27), furosemide (9/25 →	untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan.
--	--	--	--

		6/26), atropine sulfate (11/26 → 4/27), manitol (1/26 → 6/26) - Box emergency 6A : Infus D5% (7/25 → 11/26), Manitol (5/25 → 1/26), Dexametasone (6/25 → 6/26) - Box emergency 7A : Dexametasone (6/25 → 6/26), atropin sulfate (11/25 → 4/27), Infus D5% (8/25 → 11/26) - Box emergency 8A : ephinephrine (8/25 → 7/27), spuit 10 cc terumo (10/25 → 6/29), spuit 3 cc terumo (10/25 → 6/29) - Radiologi : Amiodaron (8/25 → 6/26), Aspilet (11/25 → 8/26), Atropin (11/26 → 4/27), Clopidogrel (2/26 → 10/26), Dexametason (10/25 → 6/26), Dopamine (9/25 → 9/26), Furosemide (9/25 → 6/26), Infus D5% (9/25 → 11/26), Manitol (1/26 → 6/26), Na phehytoin inj (1/26 → 9/27), Valisanbe Inj (12/25 → 6/26), IV cannula no. 22 (1/26 → 1/29)	
5.	Kartu stok obat	Kepatuhan penulisan kartu stok 70% di depo farmasi, petugas masih merapel pengeluaran kartu stok dan belum menulis sisa stok. Kepatuhan penulisan kartu stok 100% di gudang farmasi.	a) Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok b) Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.
6	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun di ruangan terpisah dan didalam lemari B3 tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan.	Monitoring dan evaluasi terhadap penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)
7	Penyimpanan produk steril di unit	Masih ditemukan poli melakukan penyimpanan NS 0.9% 500 ml sisa untuk rawat luka dan digunakan kembali besok hari (1x24 jam) sehingga melewati batas BUD.	Supervisi secara berkala dan edukasi ke perawat BUD produk steril tidak boleh lebih dari 3 jam
8	Pelaksanaan double check untuk pemberian obat high alert	Bulan februari 2025 terjadi perubahan sistem dari distribusi UDD (<i>Unit Dose Dispensing</i>) ke ODD (<i>One Daily Dose</i>) dimana double check obat high alert dengan mengisi daftar tilik serah terima obat farmasi - rawat inap sudah ditiadakan. Serah terima obat menggunakan lembar serah terima obat pasien, resep dan daftar pemberian obat (DPO) antar farmasi dan perawat. Double check dilakukan oleh farmasi sebelum distribusi obat. Tidak ditemukan kejadian IKP.	Supervisi berkala

3.2.1.15 Tabel Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Januari - Maret 2025

INDIKATOR	BULAN		
	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
Penyiapan Obat Jadi Rawat Jalan > 30 menit	47.99%	44.17%	59.59%
Penyiapan Obat Racikan > 60 menit	67.96%	61.98%	74.45%

3.2.1.16 Grafik Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Januari - Maret 2025



Analisis :
Waktu tunggu obat rawat jalan pada Bulan Maret 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Februari 2025. Namun prosentasi tersebut masih jauh dari target (0%) dikarenakan libur tanggal merah dan poli tutup sehingga menyebabkan penumpukan kunjungan pasien pada saat hari aktif, kunjungan pasien yang tidak dibatasi sehingga terjadi penumpukan resep di jam-jam tertentu.

Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam klik obat selesai maupun ambil obat, sehingga petugas farmasi diharapkan *real time* dalam pelaksanaannya.
- 2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait alur pemberian obat kepada pasien, bahwa harus dihindari terjadi penumpukan obat yang telah siap diberikan.
- 3. Terdapat program pengantaran obat melalui Primantara sehingga mengurangi antrian pasien menunggu obat.
- 4. Petugas input dibagi menjadi resep kronis dan resep non kronis oleh TTK, resep iter dan PRB oleh Apoteker.

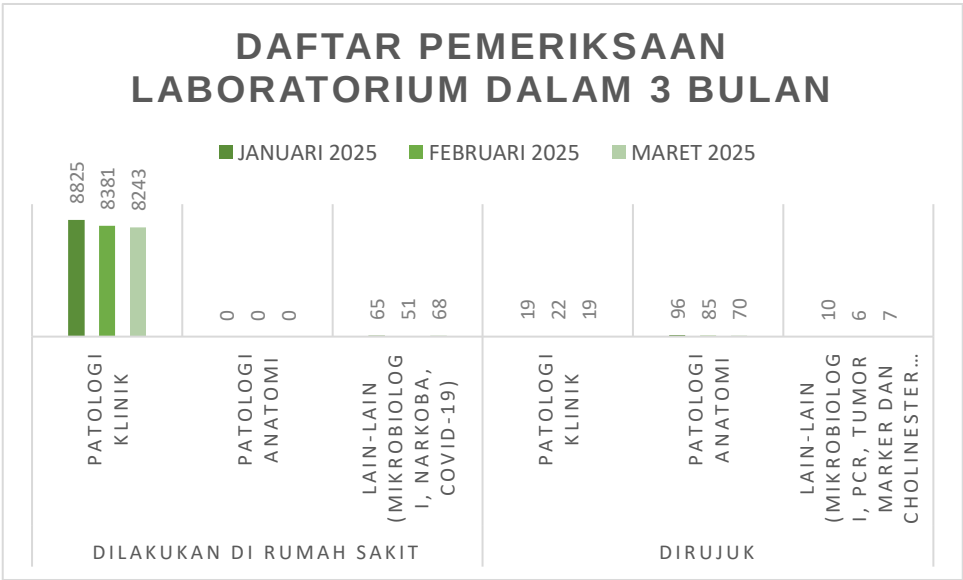
1.2.2 **Laboratorium**

1.2.2.11Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar Januari - Maret 2025

No	Jenis Pemeriksaan	Bulan		
		Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025
Dilakukan di Rumah Sakit				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	4910	4940	4789
	Hematologi	2825	2520	2583
	Serologi dan Molekuler	666	533	508
	Urine	415	383	355
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	9	5	8
Total		8825	8381	8243
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	0	0	0
	Pemeriksaan Histopatologi	0	0	0
Total		0	0	0
3.	Lain-lain			
	Bakteriologi/Mikrobiologi	50	37	30
	Narkoba	8	11	35
	Covid-19	7	3	3
Total		65	51	68

Dilakukan di Luar Rumah Sakit (Dirujuk)				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	0	1	2
	Hematologi	4	7	0
	Serologi dan Molekuler	15	14	16
	Urine	0	0	1
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	0	0	0
Total		19	22	19
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	8	10	14
	Pemeriksaan Histopatologi	88	75	56
Total		96	85	70
3.	Lain-lain			
	Bakteriologi/Mikrobiologi	9	6	7
	PCR	0	0	0
	Tumor Marker	1	0	0
	Cholinesterase	0	0	0
Total		10	6	7

1.2.2.12 Grafik Pemeriksaan Didalam Rumah Sakit Bulan Januari - Maret 2025



Analisis :

- Permintaan pemeriksaan laboratorium pada Bulan Maret 2025 mengalami penurunan, yaitu sebesar 8243 pemeriksaan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh penurunan jumlah kunjungan laboratorium, salah satunya adalah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan juga mengalami penurunan.
- Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, yaitu :
 - Patologi Anatomi = 251 sampel
 - Patologi Klinik = 60 sampel
 - Lain-lain = 23 sampel
- Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi pada dalam 3 bulan terakhir mencapai 251 pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit belum memiliki Laboratorium Patologi Anatomi, ditunjang dengan meningkatnya jumlah tindakan excise yang membutuhkan pemeriksaan penunjang (PA) untuk kebutuhan klaim.
- Hasil pemeriksaan PA masih mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan karena adanya tindakan potong ulang dari hasil yang mengarah atau curiga keganasan dan cuti bersama lebaran pada akhir Bulan Maret 2025.
- Masih ditemukan pemeriksaan patologi klinik pada Bulan Maret 2025 sebesar 19

pemeriksaan, yaitu antara lain pemeriksaan Resikulosit, D Dimer, ANA Test, Serum Iron, TIBC, Gamma GT, Hbe Ag, Ig G/M Anti Dengue, NS One Dengue, IgM CMV, Anti HCV, TPHA, IgM Toxoplasma, IgM Rubella dan ASTO. Rumah Sakit tidak melakukan pengadaan alat dan reagen karena permintaan hanya sedikit.

6. Ada pemeriksaan yang dirujuk ke RSSA (selain Panglima Sudirman) karena tutup lebaran, hal ini menyebabkan adanya perbedaan harga yang signifikan.

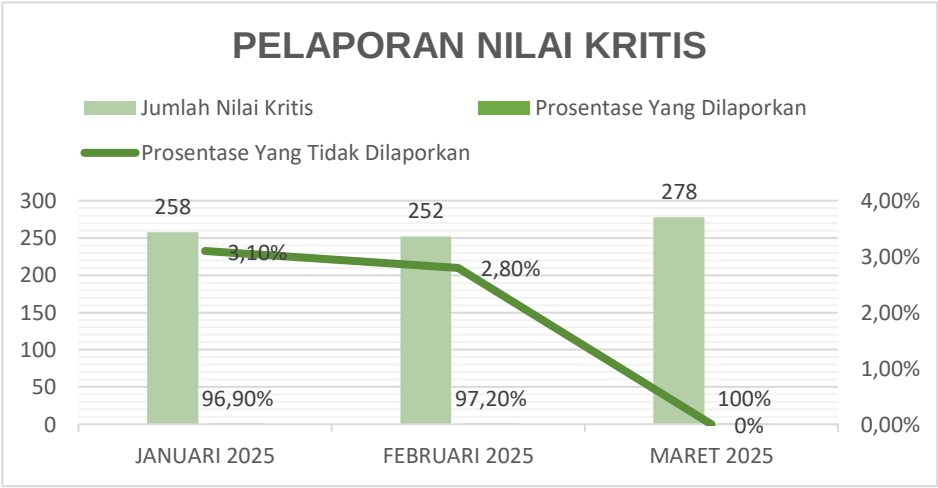
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
- 2. Perbaikan serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.
- 3. Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok dan dilakukan SO.
- 4. Follow up pengadaan reagen yang lama kosong.
- 5. Mengajukan pengadaan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang.
- 6. Membuat kesepakatan batas akhir bacaan hasil PA dan follow up secara berkala kepada Dokter Penanggungjawab Patologi Anatomi.
- 7. Mengajukan review tarif pemeriksaan laboratorium kepada Kepala Keuangan PT.

1.2.2.13 Pelaporan Nilai Kritis

NO	BULAN	JUMLAH NILAI KRITIS	PROSENTASE YANG DILAPORKAN	PROSENTASE YANG TIDAK DILAPORKAN
1.	Januari 2025	258	96,9%	3,1%
2.	Februari 2025	252	97,2%	2,8%
3.	Maret 2025	278	100%	0

1.2.2.14 Grafik Pelaporan Nilai Kritis



Analisis :

- 1. Pelaporan nilai kritis pada Bulan Maret 2025 sudah mencapai 100%.
- 2. Petugas sudah disiplin dalam melakukan dokumentasi pelaporan nilai kritis.
- 3. Tidak ada complain yang masuk karena keterlambatan pelaporan nilai kritis ke unit.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Supervisi berkala dilakukan oleh Karu dan Kabid Penunjang Medis
- 2. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan dan Kabid Pelayanan Medis terkait pelaporan complain DPJP terhadap keterlambatan pelaporan nilai kritis.
- 3. Kolaborasi dengan SDM terkait kedisiplinan petugas dalam melakukan pekerjaan.
- 4. Pertahankan kinerja yang sudah baik.

4.1.1.5 Tabel Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan Januari - Maret 2025

No	Nama pasien	No RM	Tanggal Pengambilan sampel	Unit Asal	Sampel yang diterima
Bulan Januari 2025					
1.	Durasid	205115	02/01/2025	IGD	DL Clothing
2.	Mori	224882	01/01/2025	IGD	DL Clothing
3.	Ervan W	161868	01/01/2025	IRNA 4A	SE Rusak
4.	Christian	161417	08/01/2025	IGD	DL Clothing
5.	By Ny Nuri	225528	13/01/2025	Neonatologi	Sampel Kurang
6.	Eritri	208429	13/01/2025	IRNA 6A	DL Clothing
7.	Olga S	149217	17/01/2025	IGD	DL Clothing
8.	Setiani	213248	22/01/2025	ICU	Lisis
9.	Atim	064323	22/01/2023	IRNA 6A	DL Clothing
Bulan Februari 2025					
Tidak ada					
Bulan Maret 2025					
Tidak ada					

Analisis :

Pada Bulan Maret 2025 tidak ditemukan sampel rusak, sudah ada sosialisasi oleh Kabid Keperawatan saat Rapat Unit Bulanan saat melakukan sampling darah, kebutuhan dan prosedur penyimpanan sampai dengan pengiriman sampel ke laboratorium.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Monitoring dan Evaluasi.
2. Memberikan pemahaman bahwa pengambilan sampel sesuai dengan batas garis indicator.
3. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan terkait training prosedur pengambilan darah, penyimpanan dan pengiriman sampel.
4. Supervisi ED reagen.

4.1.1.6 Tabel Pelayanan BDRS Bulan Januari - Maret 2025

Bulan	Permintaan Labu Darah				Total	Return Labu Darah				Total
	A	B	O	AB		A	B	O	AB	
Januari 2025	24	1	31	25	81	-	3	-	9	12
Februari 2025	17	6	20	18	61	2	-	-	-	2
Maret 2025	33	17	40	25	115	3	7	-	12	22

4.1.1.7 Tabel Hasil Incompatible pada Crossmatch pada Bulan Januari – Maret 2025

No	Nama Pasien	Jumlah pasien dan permintaan labu darah Incompatible				Total Permintaan Labu darah
		A	AB	O	B	
Bulan Januari 2025						
1.	Ayu Rahmalia	√				1 Labu
2.	Dursaid				√	2 Labu
3.	Pi'i			√		2 Labu
Bulan Februari 2025						
1.	Sukarno			√		1 Labu
2.	Luke Kurnia			√		3 Labu
Bulan Maret 2025						
1.	Nur Mujiati	√				2 Labu

Analisis :

1. Permintaan labu darah Pada Bulan Maret 2025 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan kasus dengan diagnosis kebutuhan labu darah meningkat, dan semua permintaan terpakai, tidak ada return dari unit.
2. Masih ditemukan return labu darah ke PMI sebanyak 22 kantong darah.
3. Masih ditemukan hasil incompatible pada crossmatch pada Bulan Maret 2025 sebanyak 1 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Mengurangi stok maksimum labu darah dengan permintaan jarang.
2. Mengirimkan analis untuk magang di PMI selama 2 minggu secara bergantian, biaya free.
3. Melakukan penertiban penulisan kartu stok labu darah secara real time, pelaksanaan SO dilakukan setiap akhir bulan.
4. Sampel darah dikirim ke UTD terdekat, karena UTD yang bisa mengeluarkan surat keterangan hasil crossmatch incompatible ke DPJP.

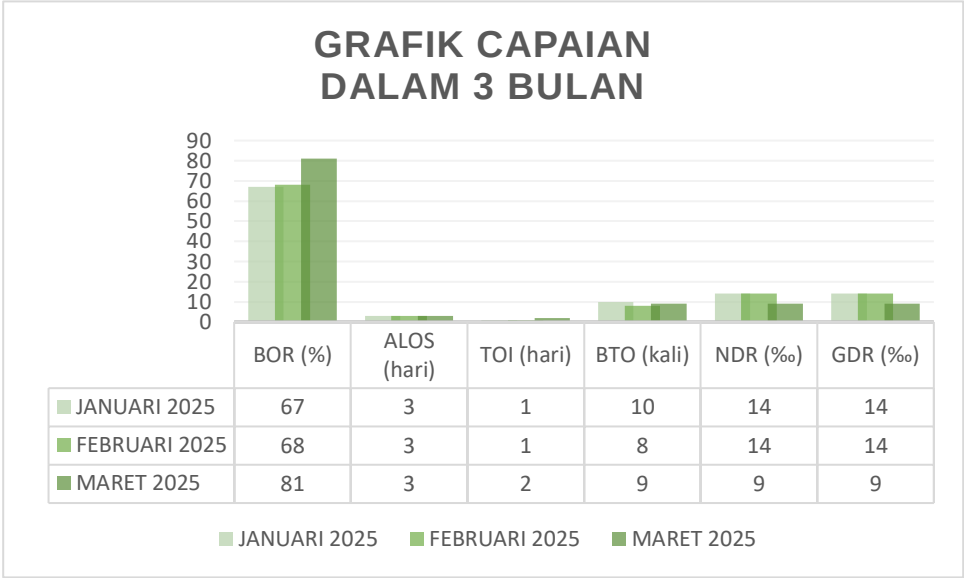
3.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

3.1.1.1 Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Januari – Maret 2025

Indikator	Rumus	Data	Standar Depkes	Bulan	Unit												Total
					2C	3A	3C	4Ab	5C	6A	7A	8A	MTS	NICU	HCU	ICU	
BOR (Bed Occupancy Rate) “Prosesntase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu”	$(\Sigma HP / (\Sigma TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60-80 %	Januari 2025	62	57	71	50	53	68	65	53	70	32	27	42	67%
				Februari 2025	72	68	80	62	57	78	82	68	65	24	29	30	68%
				Maret 2025	68	57	61	83	60	62	71	65	66	31	24	17	81%
ALOS (Average Length of Stay) “Rata-rata lama rawat seorang pasien”	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	Jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6-9 hari	Januari 2025	4	3	3	3	4	4	4	1	3	3	2	2	3hari
				Februari 2025	4	2	3	3	3	4	3	3	3	2	0	2	3 hari
				Maret 2025	4	3	3	3	4	3	3	1	3	3	2	2	3hari
TOI (Turn Over Interval) “Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati”	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1-3 hari	Januari 2025	2	2	1	2	2	1	1	2	1	4	3	2	1hari
				Februari 2025	1	1	1	1	2	1	1	1	1	5	3	4	1 hari
				Maret 2025	1	1	1	0	2	1	1	1	1	4	4	5	2hari
BTO (Bed Turn Over) “Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode”	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	Jumlah pasien, Jumlah TT	4-5 kali (dalam hitungan bulan)	Januari 2025	8	8	10	8	7	9	9	8	12	6	8	8	10kali
				Februari 2025	7	8	8	8	7	8	8	8	8	4	7	5	8kali
				Maret 2025	8	9	9	11	8	9	10	8	12	6	7	5	9kali
NDR (Net	$(\sum Px \text{ Mati } > 48 \text{ jm}) /$	Jumlah	<25 ‰	Januari	0	0	0	16	29	0	10	11	0	0	0	179	14‰

Death Rate) “Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$\sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\text{‰}$	pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar		2025													
				Februari 2025	0	0	0	8	10	0	21	11	0	12	133	235	14‰
				Maret 2025	0	0	0	7	0	9	9	21	0	16	77	91	9‰
GDR (Gross Death Rate) “Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\text{‰}$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	Januari 2025	0	0	0	16	29	0	10	11	0	0	0	179	14‰
				Februari 2025	0	0	0	8	10	0	21	11	0	12	133	235	14‰
				Maret 2025	0	0	0	7	0	9	9	21	0	16	77	91	9‰

3.1.1.2 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Januari – Maret 2025



Analisis :

Berdasarkan hasil perhitungan statistik rumah sakit pada Bulan Maret Tahun 2025, kinerja RSPHM didapatkan hasil nilai indikator :

1. BOR sebesar 81% (standar : 60-85%) sesuai standar.
2. LOS sebesar 3 hari sesuai dengan standard RSPHM terkait SE dari PT.DPM khusus pasien BPJS (standar pasien umum : 6-12 hari)
3. TOI sebesar 2 hari (standar : 1-3 hari)
4. BTO sebesar 9 kali (standar : 4-5 kali)

BOR Bulan Maret Tahun 2025 di bandingkan dengan Bulan Februari Tahun 2025 mengalami kenaikan. BOR tersebut menjadi bukti bahwa penggunaan tempat tidur di Bulan Maret sudah standar. Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan tempat tidur sudah efisien dari segi ekonomi menghasilkan pemasukan bagi rumah sakit.

Masalah :

Indikator LOS dan BTO belum memenuhi standar, terkait LOS yang belum memenuhi standar (standard lama belum berubah tidak sesuai peraturan baru). Standard saat ini sesuai dengan ketentuan BPJS yang mengacu juga pada PPK-CP masing-masing kasus/penyakit. Hal ini menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang baik serta adanya kendali mutu dan kendali biaya sehingga lama perawatan pasien lebih cepat.

Sedangkan BTO standar tersebut digunakan untuk satu tahun penuh, angka 9 mencerminkan bahwa 1 tempat tidur bisa digunakan 9 kali perawatan dalam sebulan.

Rencana Tindak Lanjut :

Meningkatkan kualitas pelayanan di rawat inap dan menjalankan sasaran keselamatan pasien agar mutu pelayanan tetap sesuai standar

3.1.1.3 Tabel Diagnosa Terbanyak Bulan Maret 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	462
2.	I51.9	Decomp Cordis/Heart Disease, unspecified	371
3.	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	315
4.	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	312
5.	M17.9	Gonarthrosis, unspecified	254
6.	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	218
7.	I69.3	Sequelae of cerebral infarction	216
8.	J47	Bronchiectasis	206
9.	G63.2	Diabetic polyneuropathy (E10-E14 with common fourth character .4)	178
10.	K04.1	Necrosis of pulp	171

3.1.1.4 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan Maret 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	A01.0	Typhoid Fever (TF)	232
2.	P24.9	Neonatus Cukup Bulan	109
3.	A90	Dengue Fever	63
4.	I63.9	Cerebro Vaskuler Accident Infark	44
5.	E14.9	Diabetes Mellitus Hyperglukemia	36
6.	O63.0	Gravida+Kala 1 Fase Aktif	36
7.	O34.2	Gravida+Bekas Section Caesaria	35
8.	O42.0	KETUBAN PECAH DINI	21
9.	J18.9	PNEUMONIA	20
10.	J18.0	BRONCHO PNEUMONIA	19

Analisis :

1. Diagnosa terbanyak di Rawat Jalan adalah DM tanpa komplikasi sebesar 462 kasus, sedangkan diagnose terbanyak di Rawat Inap adalah Typhoid Fever sebesar 232 kasus.
2. Tarikan data diagnose rawat inap diambil dari hasil analisa pada resume medis saat pasien pulang, yaitu pada diagnose utama yang ditulis oleh DPJP. Sedangkan tarikan data diagnose rawat jalan diambil dari SIMRS.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan analisa pada resume medis saat pasien pulang berdasarkan diagnose sekunder.

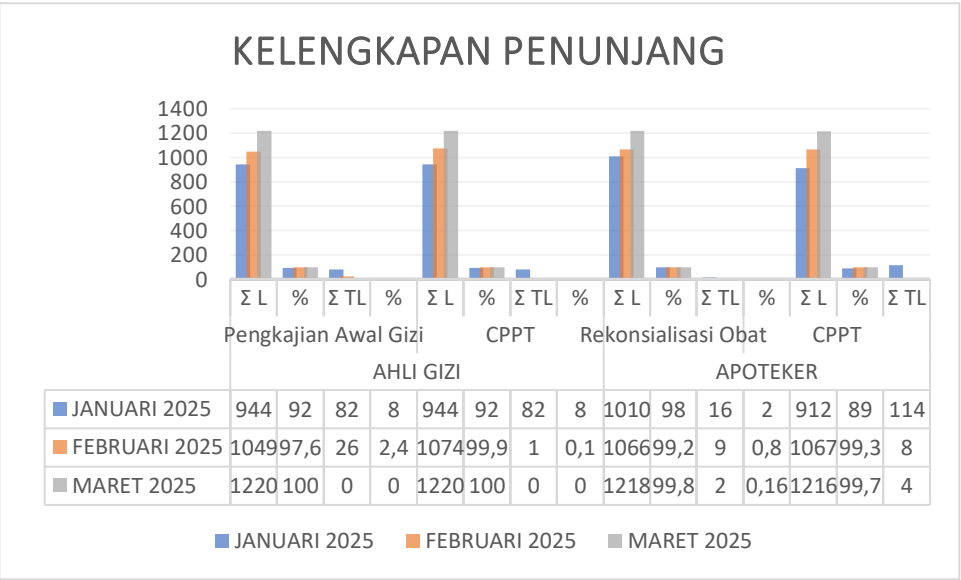
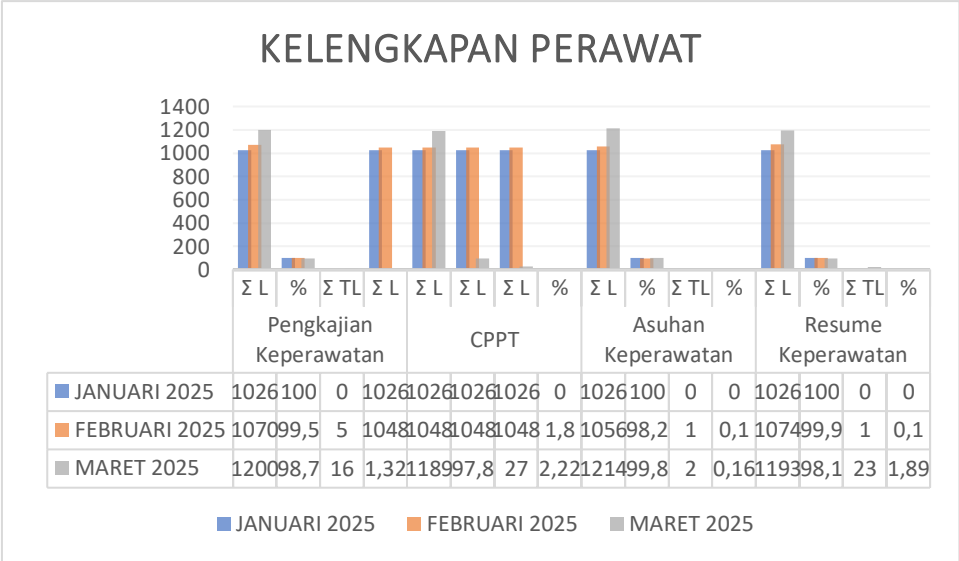
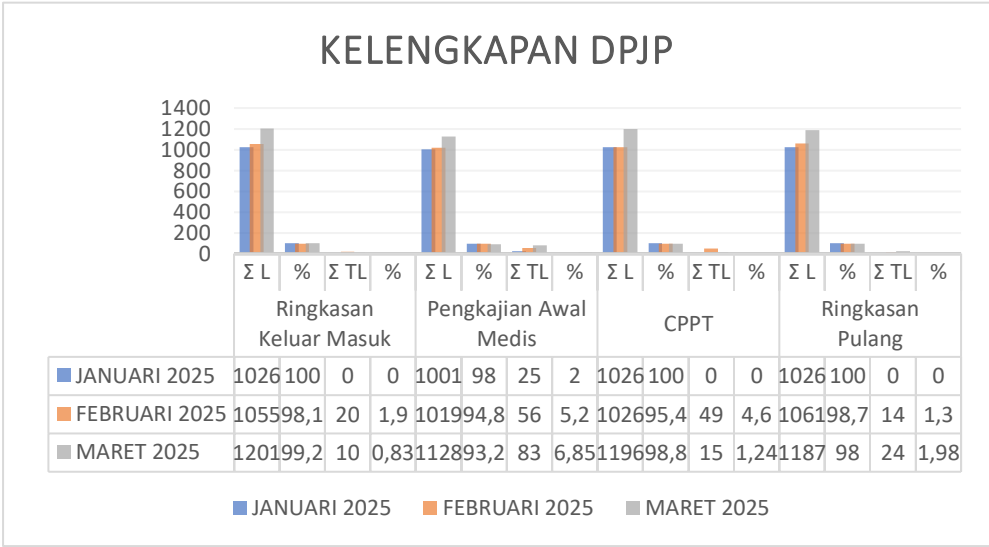
3.1.1.5 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Januari - Maret 2025

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1026	100	0	0	1001	98	25	2	1026	100	0	0	1026	100	0	0
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	Σ L	Σ L	Σ L	Σ L	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1026	100	0	1026	1026	1026	1026	0	1026	100	0	0	1026	100	0	0
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Februari	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
Maret	1220	100	0	0	1220	100	0	0	1218	99.84	2	0.16	1216	99.67	4	0.33

3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Januari – Maret Tahun 2025



Analisis :

- 1. Kelengkapan DRM rawat inap DPJP dan Perawat mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena perubahan alur analisa rekam medis, perawat melakukan setor terlebih dahulu ke petugas rekam medis sehingga data yang didapatkan valid.
- 2. Kelengkapan DRM penunjang mengalami peningkatan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Membuat raport ketidaklengkapan dan kolaborasi dengan Kabid Keperawatan.

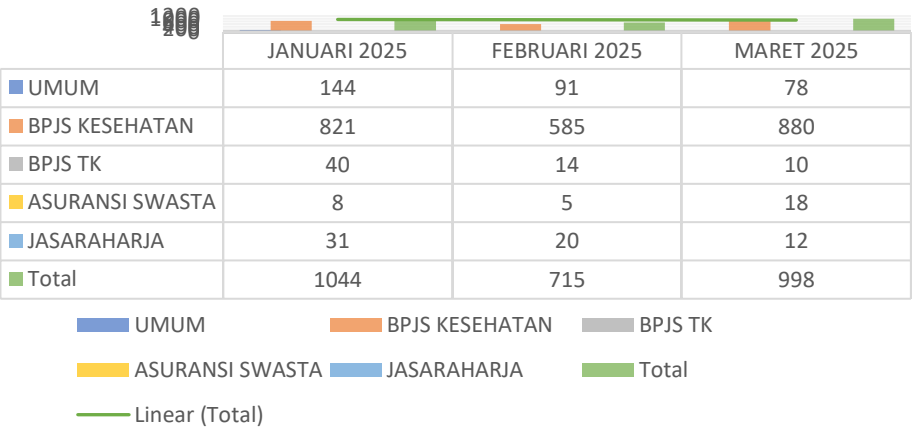
4.2.4 Radiologi

4.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Januari - Maret 2025

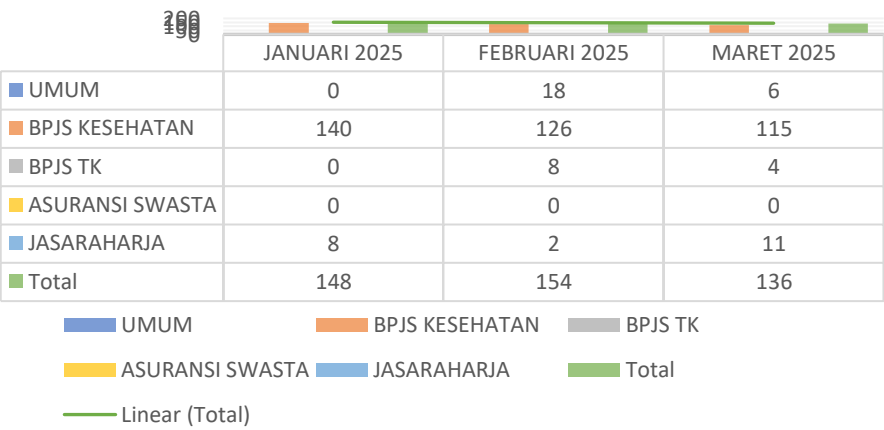
NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1.	RADIODIAGNOSTIK	UMUM	144	91	78
		BPJS KESEHATAN	821	585	880
		BPJS TK	40	14	10
		ASURANSI SWASTA	8	5	18
		JASARAHARJA	31	20	12
	TOTAL		1044	715	998
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	0	18	6
		BPJS KESEHATAN	140	126	115
		BPJS TK	0	8	4
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	8	2	11
	TOTAL		148	154	136
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0	0	0
		BPJS KESEHATAN	7	2	8
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		7	2	8
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	36	39	23
		BPJS KESEHATAN	200	303	188
		BPJS TK	0	0	4
		ASURANSI SWASTA	16	24	11
		JASARAHARJA	0	0	4
	TOTAL		252	366	230
TOTAL KESELURUHAN			1451	1237	1372

4.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Jnauari - Maret 2025

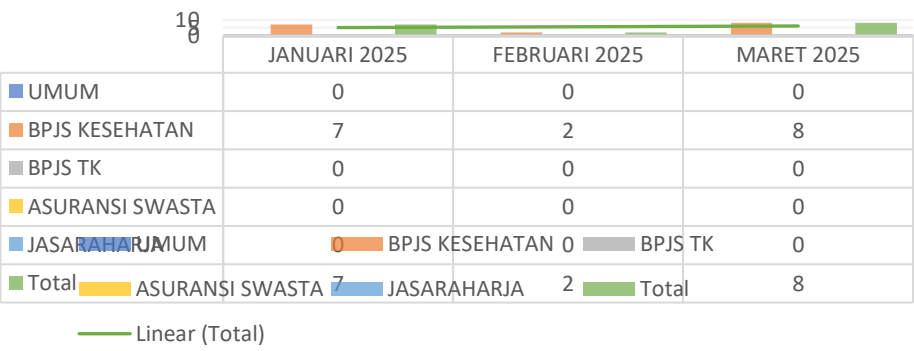
PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK



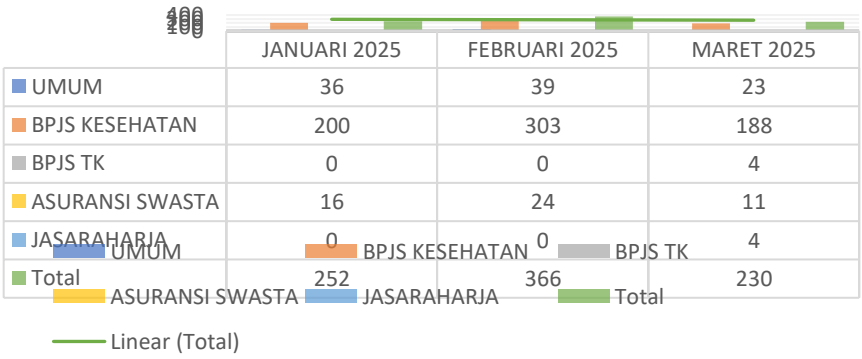
PEMERIKSAAN CT SCAN TANPA KONTRAS

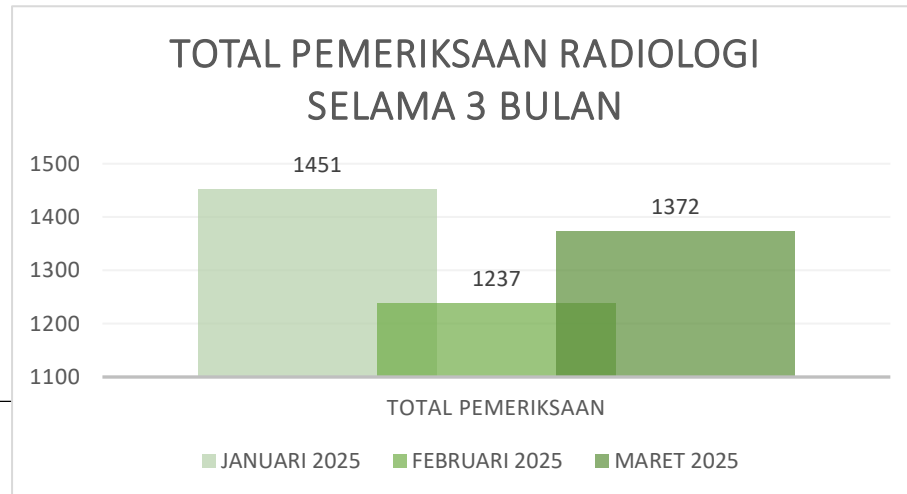


PEMERIKSAAN CT SCAN DENGAN KONTRAS



USG TANPA KONTRAS





Analisis :

1. Pelayanan pemeriksaan selama Bulan Maret 2025 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.

Pada Bulan Maret 2025 pemeriksaan terbanyak, yaitu :

- a. Radiodiagnostik : 998
- b. USG Tanpa Kontras : 230
- c. CT Scan Tanpa Kontras : 136

2. Produktivitas pemeriksaan radiodiagnostik mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya tambahan pasien MCU haji dan MCU Perusahaan/mandiri.
3. Jumlah total pemeriksaan selama Bulan Maret 2025 adalah sebanyak 1372 pemeriksaan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - 1) Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - 2) Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
3. Melakukan review tarif tindakan yang dibutuhkan DPJP atau bisa dilakukan di RS, namun belum ada di Billing. Contoh : Baby Gram.
4. Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT.

4.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Bulan Januari - Maret 2025

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Januari 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	0	0	0	0
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Februari 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Dahniyar Afandi (227465)	Kongestif Pulmonum	Pneumonia	1
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Maret 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	By Ny Zaimatus (227984)	Normal	Pneumonia	2
2.		Kasti (073280)	Normal	Infark Akut	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Agus Wahyu (114824)	Spondylosis	Compresi Fractura	1

Analisis :

Pada Bulan Maret terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak ditulis secara lengkap pada surat permintaan radiologi.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.

4.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

NO	PEMERIKSAAN	RATA-RATA WAKTU (menit)			
		dr Agung, Sp.Rad (K)		dr Yudho, Sp.Rad	
		SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN
1.	Ro Thorax PA/AP	3	25-60	3	1440
2.	Ro Vertebrae	3	25-60	4	1440
3.	Ro Abdomen	3	25-60	10	1440
4.	Ro Extremitas	4	25-420	2	1440
5.	Ro Skull	3	25-60	2	1440
6.	USG Abdomen	8	3	8	3
7.	CT Scan Non Kontras	5	30-1440	-	-
8.	CT Scan Dengan Kontras	15	30-1440	-	-
9.	Radiologi CITO	-	-	-	-

Analisa :

1. Rata-rata pemeriksaan radiologi adalah 3 menit dengan rata-rata hasil pembacaan radiologi 25 menit untuk dr Agung, Sp.Rad (K), hal ini disebabkan karena hasil rontgen dapat

dikonsultasikan via pesan whatsapp. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam).

2. Rata-rata pembacaan radiologi oleh dr Yudho, Sp.Rad adalah 1440menit/24 jam, tidak sesuai dengan target standar RS. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian jobdesk konsulan, dr Yudho, Sp.Rad tidak berkenan dikonsuli via pesan whatsapp dan dibacakan saat praktik keesokan harinya.
3. Pembacaan elektif dilakukan oleh dr Yudho, Sp.Rad saat praktik. (Semua foto Vertebrae, Ekstremitas, Abdomen, dan Skull).
4. Tidak terdapat pemeriksaan CITO dan kasus kritis selama Bulan Maret 2025.
5. Semua pemeriksaan CT Scan dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad (K).
6. Terdapat kekosongan jam pelayanan radiologi pada siang hari.
7. Pembacaan hasil pemeriksaan radiologi oleh dr Agung, Sp.Rad, diatas target standar RS yakni 420-1440 menit dikarenakan hasil jadi diatas pukul 00.00 WIB dan DPJP meminta dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menemui kedua DPJP Radiologi untuk menambah jam praktik.
2. Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kolegium Radiografer bahwa RS membutuhkan tambahan DS Radiologi untuk mengisi jadwal praktik siang hari, sudah diterima oleh dr Agung, Sp.Rad.
3. Melakukan supervise pencatatan respon time pada Google Spreadsheet.
4. Membuat perjanjian dengan Kains Radiologi (dr Agung, Sp.Rad (K)) selama belum terpenuhi dokter untuk merespon konsulan secara cepat.

4.2.4.5 Tabel Angka Komplain DPJP Terhadap Keterlambatan Hasil Pembacaan Radiologi pada Bulan Februari 2025

NO	NAMA PASIEN	NAMA DPJP	PEMERIKSAAN	WAKTU	
				SELESAI PERIKSA	SELESAI HASIL
1.	-	-	-	-	-

Analisis :

Pada Bulan Maret tidak ada komplain DPJP dan Dokter Umum karena keterlambatan hasil pembacaan radiologi.

Hal ini disebabkan, selain waktu tunggu cito tidak melebihi standar, bisa disebabkan ketidakpahaman petugas pelayanan dalam melaporkan complain sehingga tidak terdokumentasikan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :

Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.

4.2.4.6 Tabel PMI dan PME di Radiologi

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pemantapan Mutu Internal (PMI)			
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.	1. Respons time pelayanan radiologi terukur dan sesuai standar. 2. Pengendalian kegagalan foto dan meminimalkan pengulangan. 3. Mengendalikan penggunaan BMHP radiologi.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf)	
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.	
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
1.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	1. Peralatan radiologi dalam kondisi siap pakai. 2. Standarisasi pelayanan radiologi rujukan.
2.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
3.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFFK (Balai Pengaman Fasilitas .Kesehatan)	
4.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.	
5.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
6.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku	

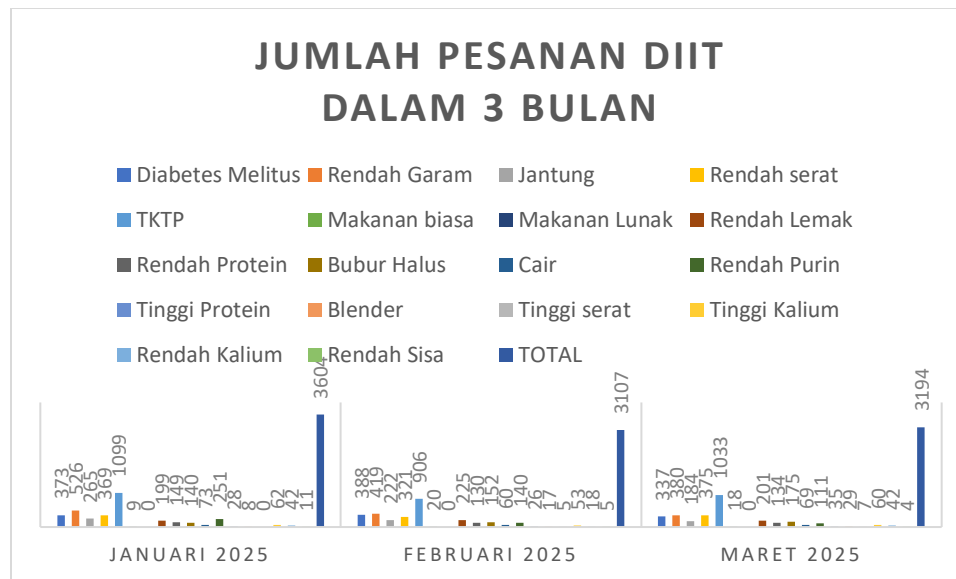
2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Desember 2024 – Februari 2025

NO	NAMA DIIT	BULAN			PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	
1.	Diabetes Melitus	373	388	337	87
2.	Rendah Garam	526	419	380	90
3.	Jantung	265	222	184	82
4.	Rendah serat	369	321	375	116
5.	TKTP	1099	906	1033	114
6.	Makanan biasa	9	20	18	90
7.	Makanan Lunak	0	0	0	0
8.	Rendah Lemak	199	225	201	89
9.	Rendah Protein	149	130	134	103
10.	Bubur Halus	140	152	175	115
11.	Cair	73	60	69	115

12.	Rendah Purin	251	140	111	79
13.	Tinggi Protein	28	26	35	134
14.	Blender	8	17	29	170
15.	Tinggi serat	0	5	7	71
16.	Tinggi Kalium	62	53	60	113
17.	Rendah Kalium	42	18	42	233
18.	Rendah Sisa	11	5	4	80
TOTAL		3604	3107	3194	102

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Januari - Maret 2025



Analisis :

1. Jumlah pemberian diit pasien rawat inap pada Bulan Maret mengalami peningkatan, hal ini berbanding lurus dengan kenaikan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit.
2. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemesanan diit terbanyak selama Bulan Maret 2025 adalah TKTP sebanyak 1033, berbanding lurus dengan diagnose terbanyak di rawat inap yaitu Thypoid Fever dengan kebutuhan diit TKTP.
3. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

Rencana Tindak Lanjut :

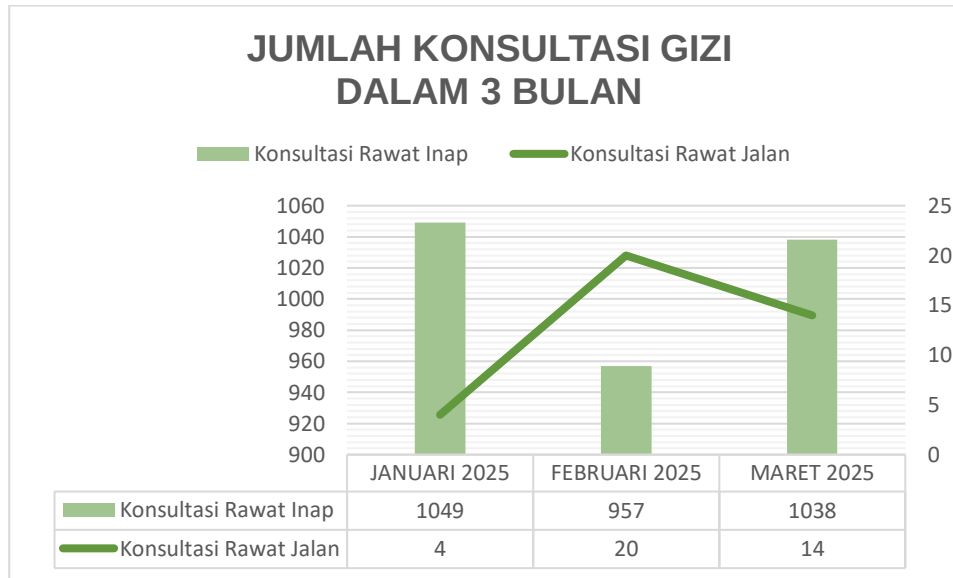
1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.
3. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward.
4. Melakukan perbaikan menu makanan dan plating sesuai dengan kelas pasien.
5. Kolaborasi dengan PKRS untuk membuat leaflet menu makanan dan diupload di Sosial Media.

- Perbaikan pencatatan food waste dipisahkan setiap menu makanan untuk mengetahui menu makanan mana yang tidak diminati.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi Januari – Maret 2025

No	Indikasi	Jumlah Pasien		
		Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025
1.	Konsultasi Rawat Inap	1049	957	1038
2.	Konsultasi Rawat Jalan	4	20	14

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi



Analisis :

- Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada Bulan Maret 2025 meningkat mengikuti jumlah pasien yang rawat inap.
- Jumlah konsultasi gizi rawat jalan pada Bulan Maret 2025 mengalami penurunan hal ini disebabkan pasien dan keluarga menunda datang dikarenakan liburan lebaran.
- Tidak semua DPJP memberikan rujukan ke Poli Gizi, rujukan diterima dari Poli Jantung dan Poli IPD saja ketika pasien bertanya terkait pantangan makan saat control ke Poli Spesialis.

Rencana Tindak Lanjut :

- Merancang pengembangan pelayanan MCU Konsultasi Gizi dengan perusahaan.
- Koordinasi dengan Humas Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan.
- Koordinasi dengan Kabid Pelayanan agar DPJP merujuk pasien ke Poli Gizi.

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Januari – Maret 2025

No	Jenis Komplain	Nama Pasien	Analisis	Rencana Tindak Lanjut	Total
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	An Yuan (B3C-4 IRNA 3C Anak)	1. Siklus menu yang berlaku di RS Prima Husada Malang adalah siklus menu 10 hari+1 hari	Melakukan analisis asupan makan pasien selama rawat inap untuk melihat daya terima pasien tersebut terhadap menu yang disajikan	1
		Isi Komplain : Menu yang didapat tidak bervariasi dibandingkan dengan terakhir kali pasien rawat inap (siklus menu berulang)	2. Pasien MRS pada hari dimana siklus menu yang sama dengan hari MRS sebelumnya.		

2.4.5.6 Tabel Rekap Food Waste (Sisa Makanan) bulan Maret 2025

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)	Keterangan
			Maret 2025	
1.	Karbohidrat	Nasi	241,1	67% dari sisa makan berasal dari karbohidrat.
		Nasi Tim	374	
		Total	615,1	
2.	Snack	Roti Kukus	0	Menu yang kurang diminati : 1. Bubur Sagu 2. Puding
		Setup Pisang	0	
		Kacang Hijau	0	
		Kue Hongkong	0	
		Terang Bulan	0	
		Bubur Sagu	0.8	
		Kue Lumpur	0	
		Puding	0.4	
		Donat	0	
		Tahu Fantasi	0	
		Sagu Mutiara	0	
		Total	1.2	
1.	Menu 1			Menu 5 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	5,7	
		Rolade Ayam	3,9	
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,2	
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel,	2,2	

		Oyong, Kemangi)		sebanyak 41.1 kg.
		Ayam Kecap	5,1	
		Tahu Bumbu Tomat	1,5	
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,2	
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)	2,4	
		Tempe Goreng	1,7	
	Tambahan VIP	Perkedel	0	
Total			22,9	
2.	Menu 2			
	Pagi	Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	7,8	
		Tahu Rempah (Remet)	3,1	
		Abon	0	
	Tambahan VIP	Telur Rebus	0	
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)	5,7	
		Ayam Wijen	3,3	
		Bakwan Jagung	1,9	
	Tambahan VIP	Telur Gulung	0	
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	4,7	
		Tempe Goreng	2,4	
	Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar	0,4	
Total			29,3	
3.	Menu 3			
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	3,7	
		Tahu Krispy	2,7	
		Abon	0	
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,6	
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	4,7	
		Rolade Ayam	4	
		Tahu Goreng	1,3	
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,5	
	Sore	Oseng (Jamur Kuping, Wortel, Bakso, Kacang Polong)	3,7	
		Ayam Bombay	3,9	
		Tempe Orek	1,6	
	Tambahan VIP	Telur Dadar	0,3	
Total			26,4	
4.	Menu 4			
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	4,1	
		Tahu Nugget	3,8	
		Abon	0	

	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar	0
	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	4,3
		Ayam Kecap	6,5
		Jamur Krispy	2,7
	Tambahan VIP	Tahu Bacem	0
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	4,2
		Telur Rebus	2,8
		Tempe Goreng	3,2
	Tambahan VIP	Keripik Kentang	0,2
	Total		31,8
5.	Menu 5		
	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	5,3
		Opor Tahu	3,8
		Oper Telur	3,5
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,2
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	6,4
		Ayam Bombay	6,3
		Bakwan Jagung	4,5
	Tambahan VIP	Tahu Krispy	0
	Sore	Sup Merah (Bakso, Ayam Dadu, Polong, Wortel)	6,9
		Tempe Goreng	4,2
		Telur Dadar	0
	Total		41,1
6.	Menu 6		
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	2,9
		Orak Arik (Wortel, Kubis, Daun Bawang, Telur)	3,6
		Tempe Goreng	4,1
	Tambahan VIP	Ayam Goreng	1,6
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	6,2
		Ayam Laos	5,4
		Tahu Bumbu Tomat	2,8
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,1
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)	3
		Tahu Krispy	1,8
	Tambahan VIP	Perkedel	0,2
	Total		31,7
7.	Menu 7		
	Pagi	Cah Sawi (Sawi Putih, Wortel Serut, Ayam Dadu)	4,9
		Telur Ceplok Bumbu Kuning	2,1

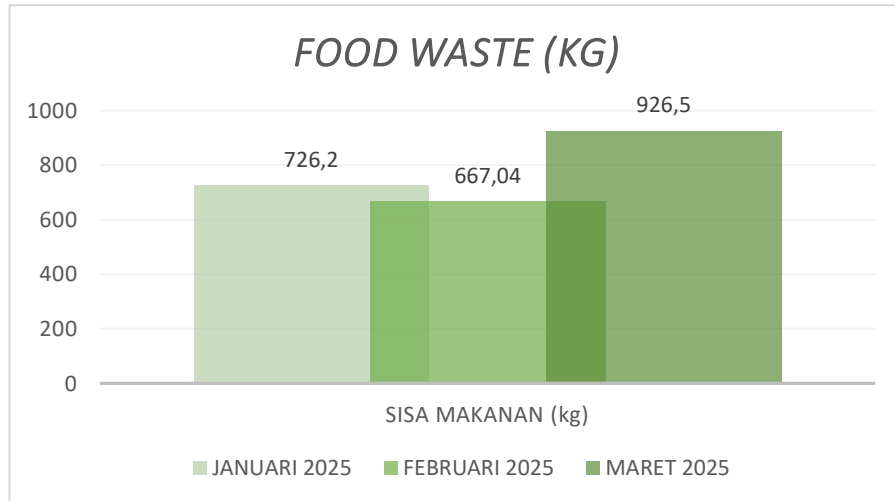
		Abon	0,5
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,1
	Siang	Sup (Wortel Dadu, Jamur Es, Polong, Bakso)	4,4
		Ayam Ungkep	4,1
		Perkedel	1,3
	Tambahan VIP	Jamur Krispy	0,2
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	5,5
		Tempe Goreng	4,2
	Tambahan VIP	Telur Dadar	0,1
Total			27,3
8.	Menu 8		
	Pagi	Sayur Bobor (Manisah, Sawi Hijau)	4,6
		Tahu Nugget	3,7
		Abon	0
	Tambahan VIP	Ayam Fillet Tepung	0,4
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Jagung, Manisah)	4,4
		Ayam Bakar	6,5
		Tahu Goreng	3,3
	Tambahan VIP	Nugget Ayam	0
	Sore	Semur (Ayam Fillet, Soun, Daun Bawang, Tomat)	4,7
		Botok Tahu	3,7
		Abon	0
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,7
Total			32
9.	Menu 9		
	Pagi	Tumis (Bakso, Wortel, Buncis)	4,8
		Tahu Rempah	4,6
		Abon	0
	Tambahan VIP	Telur Dadar	0,5
	Siang	Sup (Bihun, Wortel, Pokcoy)	6,1
		Ayam Kemangi	7,2
		Tahu Krispi	2,7
	Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar	0
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	4,9
		Telur Rebus	2,2
		Tempe Goreng	2,3
	Tambahan VIP	Keripik Kentang	0,3
Total			35,6
10.	Menu 10		
	Pagi	Sup (Wortel, Bakso, Sawi Putih)	4,5
		Telur Ceplok	3,3

		Abon	0	
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0.9	
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Wortel, Jagung, Manisah)	5,5	
		Ayam Wijen	2,7	
		Tahu Goreng	1,5	
	Tambahan VIP	Telur Orak Arik	0,3	
	Sore	Capjay (Wortel, Kembang Kol, Sawi, Bakso, Ayam Dadu)	6,6	
		Tempe Goreng	3,1	
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar	0,1	
Total			27,6	
11.	Menu 11			
	Pagi	Sapo Tahu (Tahu, Wortel, Kembang Kol, Bakso)	2.4	
		Tempe Goreng	0.2	
		Abon	0	
	Tambahan VIP	Telur Rebus	0.4	
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	1	
		Ayam Bakar	0.8	
		Bakwan Jagung	0.2	
	Tambahan VIP	Tahu Goreng	0	
	Sore	Semur (Ayam Fillet, Soun, Daun Bawang, Tomat)	0.5	
		Tahu Rempah	0.2	
		Abon	0	
	Tambahan VIP	Jamur Krispy	0	
Total			5.7	
Total Food Waste Menu			311,4	

2.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste pada Bulan Januari - Maret Tahun 2025

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)
1.	Januari 2025	726.2
2.	Februari 2025	667.04
3.	Maret 2025	926.5

2.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Januari - Maret Tahun 2025



Analisis :

1. Terdapat perubahan perhitungan sisa makanan pada Bulan Maret 2025, dimana perhitungan dipisahkan per menu dengan tujuan mengetahui menu makanan yang kurang diminati.
2. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa ada peningkatan sisa makanan pada Bulan Maret 2025, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
 - 3) Ada batasan diit yang dapat mempengaruhi rasa dan tampilan sehingga kurang menggugah selera.
 - 4) Tidak ada pantangan dari keluarga pasien, sehingga konsumsi makanan dari luar / dibawa dari rumah, komunikasi/edukasi Ahli Gizi kurang diperhatikan.
 - 5) Suasana lingkungan perawatan dan kondisi fisik pasien.
3. Tidak ada keterlambatan pengiriman makanan, jadwal makan sesuai.
4. Dari total sisa makanan pada Bulan Maret 2025 sebanyak 926.5kg, 67% berasal dari karbohidrat (nasi dan nasi tim).
5. Menu snack yang tidak diminati adalah, bubur sagu dan pudding.
6. Menu 5 adalah menu yang paling banyak sisa makanan, terdiri dari Menu Pagi (Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso dan Wortel), Opor Tahu), Menu Siang (Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah), Ayam Bombay, Bakwan Jagung, Tahu Krispy) dan Menu Sore (Sup Merah (Bakso, Ayam Dadu, Polong, Wortel), Tempe Goreng).

1. Melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien terkait pemberian diit dan pembatasan makanan dari luar.
2. Melakukan plating secara menarik.
3. Mengadakan cooking class.
4. Memperbaiki dari segi rasa, tampilan dan menu.
5. Mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian.
6. Mengganti menu snack yang tidak diminati.
7. Menimbang sisa makanan tanpa kuah.

[illegible]

2.4.5.8 Lampiran Rekap Dara Kehilangan Alat Makan

77

1.	01/02/2025	Abid Fadhul Abyan	B3C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	01/02/2025	Cholifah	B5C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	04/02/2025	Widya Dwi Anandita	D6A-11	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
4.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Makan			Sendok terbawa pulang
5.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Snack			Sendok terbawa pulang
6.	06/02/2025	Chabibatul Aziizah	B3C-1	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
7.	06/02/2025	Mimi Eka	D4C-7	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
8.	19/02/2025	Ni'matul Udhma Himza	D3B-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Maret 2025							
1.	11/03/2025	Muhammad Syifa	V3 (VIP)				Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	24/03/2025	Pranata Dimas Ariansyah	C3C-10				Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	25/03/2025	Mistianingsih	C3A-4				Sendok hilang pasien sudah pulang

Analisis :

1. Dari table diatas dapat diketahui bahwa ada 3 pasien yang menghilangkan/memecahkan alat makan, hal ini disebabkan kurangnya edukasi kepada pasien dan keluarga, ada peraturan yang tertulis dan tidak dijalankan, sehingga alat makan dianggap sebagai barang yang tidak memiliki nilai.
2. Tidak ada supervise dari Kepala Ruang terhadap SPO yang sudah dibuat.
3. Tidak ada kepedulian petugas terhadap pemeliharaan barang milik Rumah Sakit.
4. Tidak ada rasa kepemilikan perawat ruangan sehingga tidak dilakukan cek ketika pasien akan KRS.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Mencantumkan tata tertib menjaga fasilitas pada GC, sehingga petugas admisi dapat mengedukasi saat melakukan pendaftaran, jika pasien menghilangkan atau merusak fasilitas maka wajib mengganti. Sementara menggunakan catatan tertulis selama GC yang lama belum habis.
2. Melakukan supervisi “SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”, sebagai panduan petugas dalam pelayanan dimana terdapat kolaborasi antara Instalasi Gizi, Perawat Ruangan, CS Pantry dan Ruangan, dan Kasir.

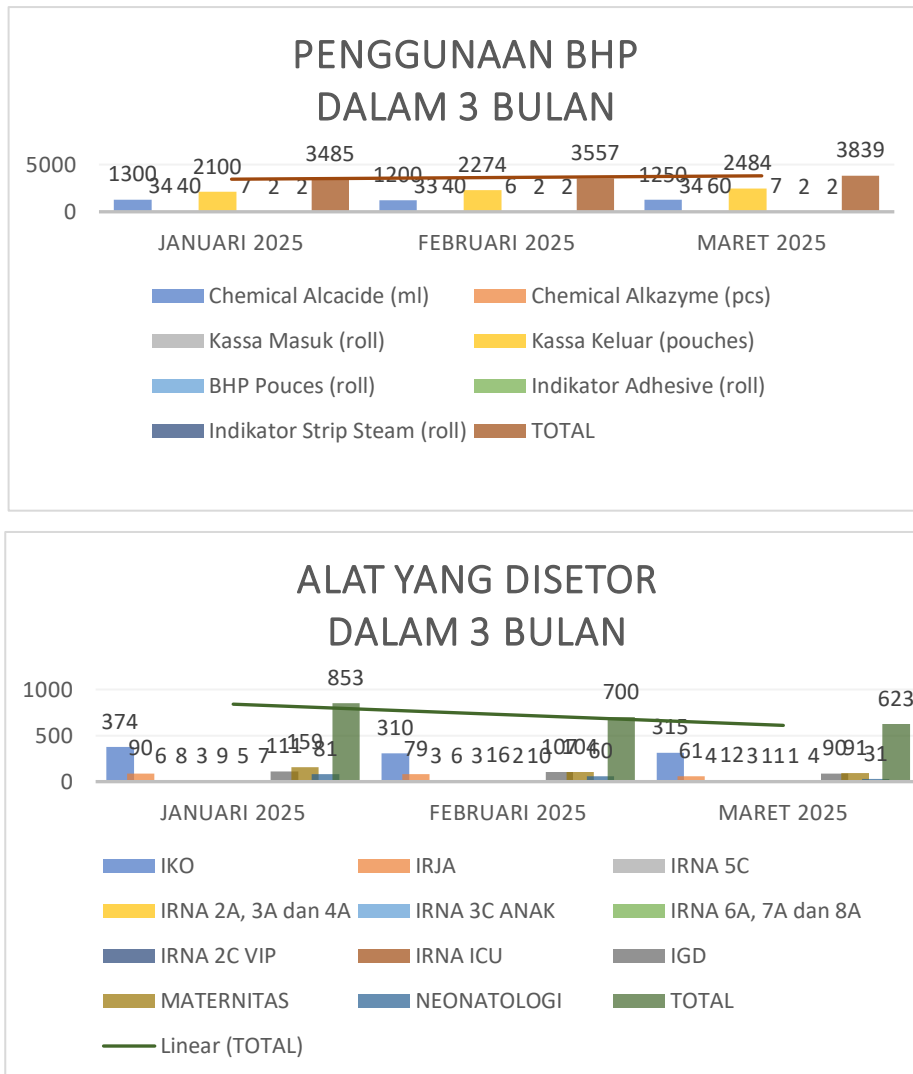
4.4.7 CSSD – Laundry

4.4.7.1 CSSD

4.4.7.2 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD Januari – Maret 2025

NO	HAL	BULAN TAHUN 2024		
		Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025
BHP				
1.	Chemical Alcacide (ml)	1300	1200	1250
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	34	33	34
3.	Kassa Masuk (roll)	40	40	60
4.	Kassa Keluar (pouches)	2100	2274	2484
5.	BHP Pouces (roll)	7	6	7
6.	Indikator Adhesive (roll)	2	2	2
7.	Indikator Strip Steam (roll)	2	2	2
Alat Yang Disetor				
8.	IKO	374	310	315
9.	IRJA	90	79	61
10.	IRNA 5C	6	3	4
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	8	6	12
12.	IRNA 3C ANAK	3	3	3
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	9	16	11
14.	IRNA 2C VIP	5	2	1
15.	IRNA ICU	7	10	4
16.	IGD	111	107	90
17.	MATERNITAS	159	104	91
18.	NEONATOLOGI	81	60	31
Jumlah		853	701	623

4.4.7.3 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSSD Bulan Januari – Maret 2025



Analisis :

1. Dari data diatas dapat diketahui bahwa, pengeluaran BHP dalam 3 bulan terakhir adalah stabil, ada peningkatan tetapi tidak signifikan. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan dan produktivitas CSSD membuat kassa steril meningkat.
2. Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat pada Bulan Maret 2025 yaitu sejumlah 315 set, diikuti dari Unit Maternitas 91 set dan IGD 90 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.
3. Unit Maternitas mengalami penurunan hal ini disebabkan karena penurunan jumlah kunjungan pasien rawat inap pada akhir bulan, dimana Dokter Spesialis Obgyn cuti lebaran.
4. Dengan perbaikan pencatatan menggunakan google spreadsheet data yang diambil valid, namun penggolongan kategori alat tidak seragam, seperti gunting talpus terhitung 1 alat dan

set partus juga terhitung 1 alat.

5. Penggunaan BHP meningkat tidak sebanding dengan jumlah alat yang disetor, hal ini disebabkan karena alat yang disetor terbanyak dari IKO dan Maternitas, dimana alat-alat tersebut kemungkinan besar terdapat noda membandel.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.
4. Melakukan orientasi petugas baru di CSSD.

4.4.7.4 Tabel Penggunaan Reuse Pada Bulan Maret Tahun 2025

Nama Alat	Reuse ke1
Junctionrees	-
Breathing circuit	-

Analisis :

Tidak ada permintaan alat reuse pada Bulan Maret 2025.

4.4.7.4 Tabel Hasil Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD

UNIT	BULAN			TOTAL 3 BULAN
	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	
Kejadian instrument kurang				
IKO	0	0	1	1
IGD	0	2	0	2
IRNA	0	0	0	0
IRJA	0	0	0	0
Kejadian Instrumen Hilang				
IKO	0	0	0	0
IGD	0	0	2	2
IRNA	0	0	0	0
IRJA	0	0	0	0

Analisis :

1. Ditemukan kejadian instrument kurang di IKO, sebanyak 1 kali, yaitu pinset anatomis. Hal ini ditemukan ketika perawat setor alat kotor dan langsung dicek oleh petugas CSSD, setelah ditelusur ditemukan di unit.
2. Ditemukan instrument hilang di IGD, sebanyak 2 kali, yaitu naldfulder dan pinset cirugis. Hal ini ditemukan ketika perawat setor alat kotor dan dicocokkan dengan serah terima alat bersih, setelah ditelusur instrument belum ditemukan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan pencatatan saat ada penemuan.
2. Melaporkan temuan kepada Kabid Keperawatan untuk dilakukan pendisiplinan petugas.
3. Melakukan penggantian alat hilang oleh unit yang bersangkutan.

4.4.7.5 Tabel Rekap Data Permintaan Instrumen Cito Selama Bulan Maret 2025

UNIT	JUMLAH PERMINTAAN CITO			KETERANGAN
	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025	
IKO	0	0	0	
IGD	0	0	0	
IRNA	0	0	0	
IRJA	0	0	0	

Analisis :

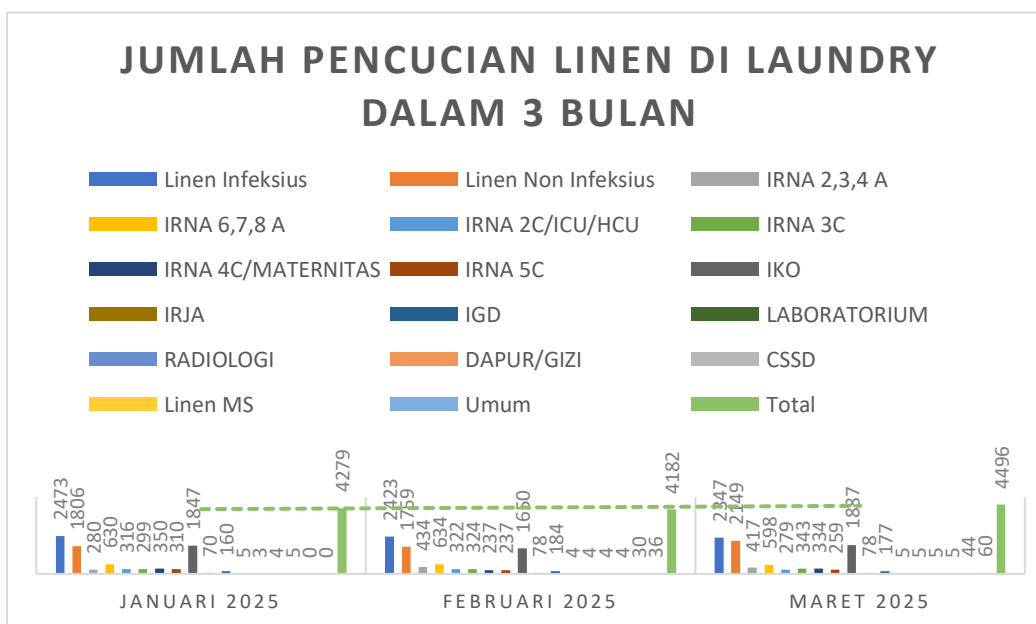
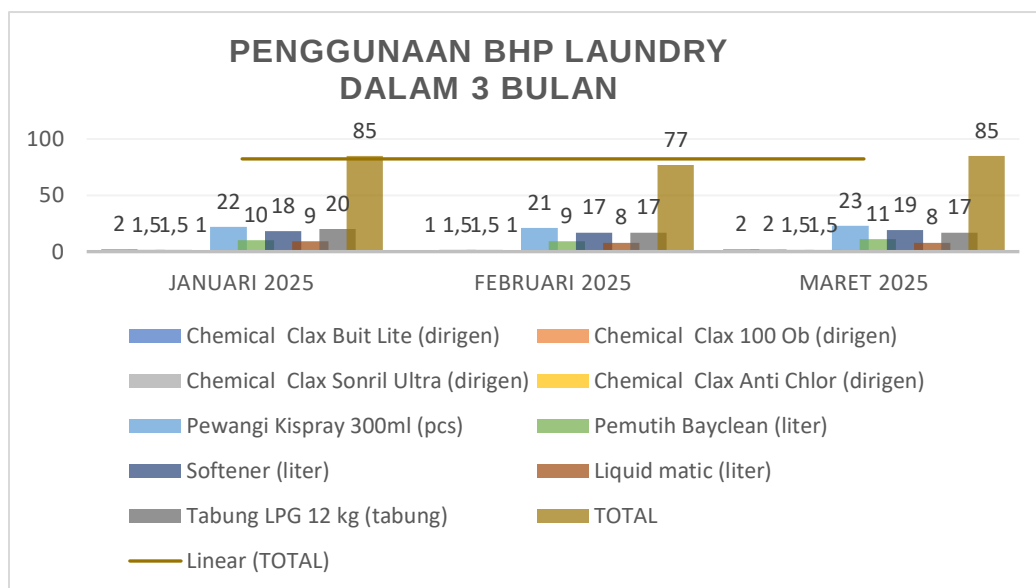
Tidak ada permintaan instrument cito selama 3 bulan terakhir, hal ini dipengaruhi ketertiban petugas dalam menyetorkan instrument kotor sehingga unit saat meminta alat selalu tersedia.

Rencana Tindak Lanjut : -**4.4.7.2 Laundry****4.4.7.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry pada Bulan Januari - Maret Tahun 2025**

NO	HAL	BULAN		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
BHP				
1.	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	2	1	2
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	1.5	1.5	2
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	1.5	1.5	1.5
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	1	1.5
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	22	21	23
6.	Pemutih Bayclean (liter)	10	9	11
7.	Softener (liter)	18	17	19
8.	Liquid matic (liter)	9	8	8
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	20	17	17
Total		85	77	85
LINEN (kg)				
1.	Linen Infeksius	2473	2423	2347
2.	Linen Non Infeksius	1806	1759	2149
3.	IRNA 2,3,4 A	280	434	417
4.	IRNA 6,7,8 A	630	634	598
5.	IRNA 2C/ICU/HCU	316	322	279
6.	IRNA 3C	299	324	343
7.	IRNA 4C/MATERNITAS	350	237	334
8.	IRNA 5C	310	237	259
9.	IKO	1847	1650	1887
10.	IRJA	70	78	78

11.	IGD	160	184	177
12.	LABORATORIUM	5	4	5
13.	RADIOLOGI	3	4	5
14.	DAPUR/GIZI	4	4	5
15.	CSSD	5	4	5
16.	Linen MS	-	30	44
17.	Umum	-	36	60
Total		4279	4182	4496

4.4.7.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Pada Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2025



Analisis :

1. Data diatas adalah jumlah pencucian linen pada Bulan Maret 2025 sebanyak 4496kg, mengalami peningkatan karena sebanding dengan peningkatan kunjungan pasien rawat inap.
2. Jumlah linen infeksius sebesar 2347kg, sebagian besar berasal dari IKO. Hal ini disebabkan produktivitas IKO pada Bulan Maret 2025 meningkat. Hal ini juga menyebabkan penggunaan BHP meningkat.
3. Perbandingan bisa dilakukan 3 bulan selanjutnya karena pada Bulan Januari 2025, jumlah linen umum dan MS tidak terdokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan breakdown pencatatan linen infeksius/non infeksiun per unit.
2. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan, yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2025.
3. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.
4. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
5. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
6. Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.

4.4.7.2.3 Tabel Inventarisasi Linen Laundry Pada Bulan Januari dan Februari 2025

No	Nama / Jenis Linen	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025
1.	Sprei	195	185	140
2.	Sarung bantal	290	275	250
3.	Selimut	225	216	209
4.	Baju tim IKO	118	118	117
5.	Baju ganti pasien	44	44	44
6.	Skort	162	160	154
7.	Perlak	21	19	35
8.	Baju ganti laundry	15	15	15
9.	Duk lubang besar	23	23	21
10.	Duk pembungkus	59	59	59
11.	Duk kecil 1 meter	58	58	58
12.	Duk ortho	20	20	18
13.	Duk lubang kecil	18	18	17
14.	Duk kaki	11	11	11
15.	Meja mayo	21	21	21
16.	Skort IKO	50	48	62
17.	Waslap	60	46	66
18.	Handuk CSSD	10	10	10
19.	Bantal	108	105	122

4.4.7.2.3 Tabel Rekap Kerusakan Linen dan Pemusnahan Pada Bulan Januari dan Februari 2025

No	Nama / Jenis Linen	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025
1.	Sprei	25	10	45
2.	Sarung bantal	24	15	25
3.	Selimut	14	10	7
4.	Duk Pembungkus	0	0	0
5.	Duk Lubang Kecil	0	0	1
6.	Celana Tim IKO	4	0	0
7.	Baju Tim IKO	5	0	0
8.	Baju Pasien	5	0	0
9.	Skort	0	2	4
10.	Perlak	6	2	0
11.	Baju Ganti Laundry	0	0	0
12.	Duk Kecil	2	0	0
13.	Waslap	2	14	5
14.	Handuk CSSD	0	0	0
15.	Bantal	12	3	3
16.	Kerudung	1	0	0
17.	Kantung L	6	0	0
18.	Meja Mayo	4	0	0
Pemusnahan (+)		Tanggal 27/01/2025	Dijadwalkan 6 bulan sekali	Dijadwalkan 6 bulan sekali

Analisis :

Petugas melakukan sortir setiap hari, linen tidak layak dijadikan satu dan diajukan untuk dilakukan pemusnahan, BA sudah dikirim ke PT sebagai lampiran untuk penambahan linen pengganti.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Follow up Pengadaan PT
2. Jadwal pemusnahan linen selanjutnya pada Bulan Juli 2025

4.4.7.2.4 Tabel Pelaporan Limbah atau Benda Asing Tercampur Linen Pada Bulan Januari - Maret Tahun 2025

No	Nama Benda	Jumlah		
		Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025
1.	Masker IKO	6	2	3
2.	Tissue	1	1	3
3.	Jarum	0	1	0
4.	Bumbu Dapur	0	0	0
5.	Uang	0	0	0
6.	Alat Tulis	1	0	0
7.	Benda lainnya	0	1	0

Analisis :

1. Masih ditemukan benda asing tercampur dengan linen, karena pemilahan seharusnya dilakukan di Unit sebelum linen dimasukkan kedalam tong linen kotor.
2. Ketidakterdisiplinan paling banyak dari Unit IKO.
3. Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi terhadap linen lainnya dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan sosialisasi kepada unit.
2. Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kemudian dilaporkan kepada Kabid Keperawatan dan SDM terkait hasil evaluasi.

4.4.7.5 Tabel Permintaan Linen Cito/Tidak Sesuai Jadwal Pada Bulan Maret 2025

UNIT	Tanggal	Jenis Linan	Jumlah	Alasan
-	-	-	-	-

Analisis :

Tidak ada permintaan linen cito dari unit, hal ini dikarenakan laundry memiliki jadwal permintaan linen sehari 2 kali, dan laundry standby 24 jam.

Rencana Tindak Lanjut : -

4.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan

4.5.7 SDM

4.5.7.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	39	13	6	7	0
		S1 Farmasi		1	0	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		20	12	8	0
		SMK		4	3	1	0
		S1 Akuntansi		0	0	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	1	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	6	6	0	0
		D3 Keperawatan		6	5	1	0
16	IGD	Profesi Ners	25	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRs	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0

		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	15	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	25	12	6	6	0
		D3 Keperawatan		13	8	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	1	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	10	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	4	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		4	4	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0

35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	46	17	8	9	0
		SMA		24	20	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	4	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			460				

Keterangan :
Terdapat penonaktifan sementara 2 staf TTK di unit farmasi dikarenakan magang pribadi, terdapat 1 penambahan dokter spesialis penyakit dalam.

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	dr. Iwan Donosepoetro, Sp.B FINACS	Dokter Spesialis Bedah	04 Maret 2025	SIP perpanjangan
2	dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	03 Maret 2025	SIP baru
3	dr. Annishafira Widyawardhani	Dokter Umum	05 Maret 2025	SIP baru
4	Yoga Eka Ramadani Ariwa, A.Md.AK	Analisis Laboratorium	07 Maret 2025	SIP perpanjangan
5	Pipin Purwa Ningrum, S.Farm.,Apt	Apoteker	19 Maret 2025	SIP perpanjangan
6	Ferianto Hendri Cahyono, A.Md.Kep	Perawat	17 Maret 2025	SIP perpanjangan
7	dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE	Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi dan Estetika	24 Maret 2025	SIP baru

Keterangan : Pada bulan Maret 2025 terdapat 2 SIP baru dan 5 SIP perpanjangan.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Sulit mencari Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
5	Fisioterapis	5	4	1	Belum mendapatkan kandidat yang cocok	Sedang proses pemenuhan
6	Perawat Gigi	2	1	1	Sudah ACC dari PT DPM	Open recruitment setelah hari raya
7	Terapis Wicara	2	1	1	On proses pengajuan ke PT DPM	On proses pengajuan ke PT DPM

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	5 Desember 2024	Orientasi Khusus	Renaldi Salsabila, A.Md.Rad	D3 Radiologi	Radiografer	5 Desember 2024	Bulan ke-3 orientasi khusus
2	16 Desember 2024	Orientasi Khusus	Miftakhul Khoiriyah, S.Ft	Profesi Fisioterapi	Fisioterapis	16 Desember 2024	Bulan ke-3 orientasi khusus
3	01 Maret 2025	Orientasi Khusus	dr. Annishafira Widyawardhani	Profesi Kedokteran	Dokter Umum	01 Maret 2025	Nulan ke-1 orientasi khusus

Keterangan :
Pada bulan Maret 2025 terdapat 3 staf yang menjalani orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS DIKLAT	JUDUL DIKLAT	SASARAN	KETERANGAN	RTL
1	03 s/d 15 Maret 2025	Magang	Magang BDRS PMI	Analisis Laboratorium	Diklat eksternal tidak berbayar	Dilakukan pemantauan dan <i>training of trainer</i> kepada petugas lab lainnya
2	11 s/d 12 Maret 2025	Inhouse Training	ESQ	Staf baru	Diklat berbayar oleh peserta tanpa ikatan dinas	-
3	17 Maret 2025	Internal	Diklat Kebijakan Umum Akreditasi	All staf	Diklat dilaksanakan secara online by zoom	-
4	19 Maret 2025	Internal	Diklat Kebijakan Umum Akreditasi	All staf	Diklat dilaksanakan secara online by zoom	-

Keterangan:
Pada bulan Maret 2025 terdapat pelaksanaan diklat yang dilaksanakan di RS Prima Husada Malang.

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

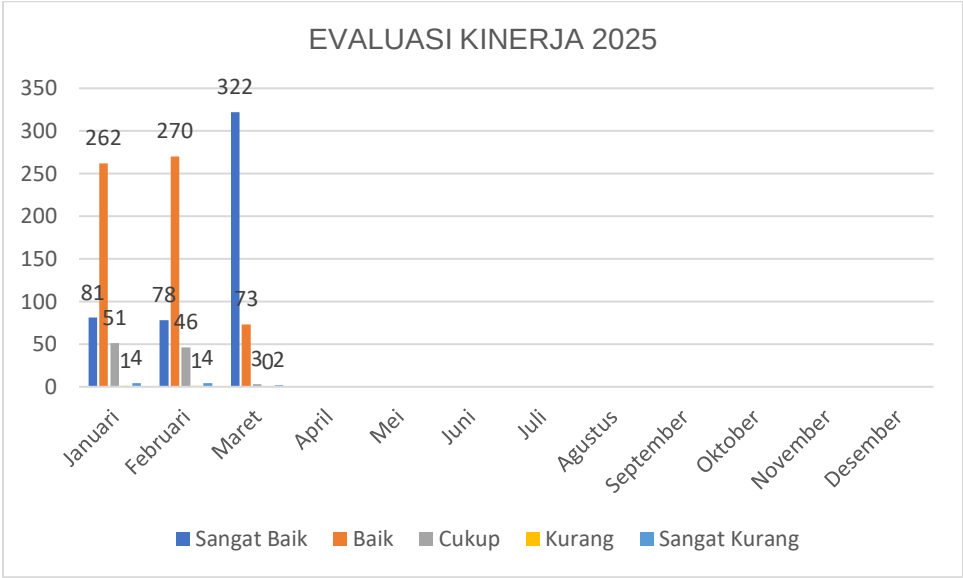
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayanan Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	Kabid Penunjang Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit KABid Penunjang Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
4	Kabid Keperawatan	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Keperawatan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum & Keuangan	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Satuan Pengawas Internal	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	40	2	22	18	2	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	10	0	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Umum	5	0	5	0	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	3	2	0	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	17	0	15	2	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	2	0	0	0	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	12	0	10	2	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	25	0	21	4	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	12	0	11	1	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
17	IPSRS	Umum	6	0	5	1	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Umum	27	0	23	4	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	8	0	7	1	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	18	0	15	3	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	15	0	13	2	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	9	0	7	2	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	24	0	21	3	0	0	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	12	0	9	3	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	9	0	8	1	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Umum	10	0	6	4	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	10	0	9	1	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	5	0	5	0	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	9	0	9	0	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	18	0	16	2	0	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	5	0	4	1	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	7	0	7	0	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Umum	2	0	2	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	2	1	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	45	1	32	12	1		Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	12	0	12	0	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	5	0	4	1	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	1	0	0	1	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
 Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Maret 2025.

3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



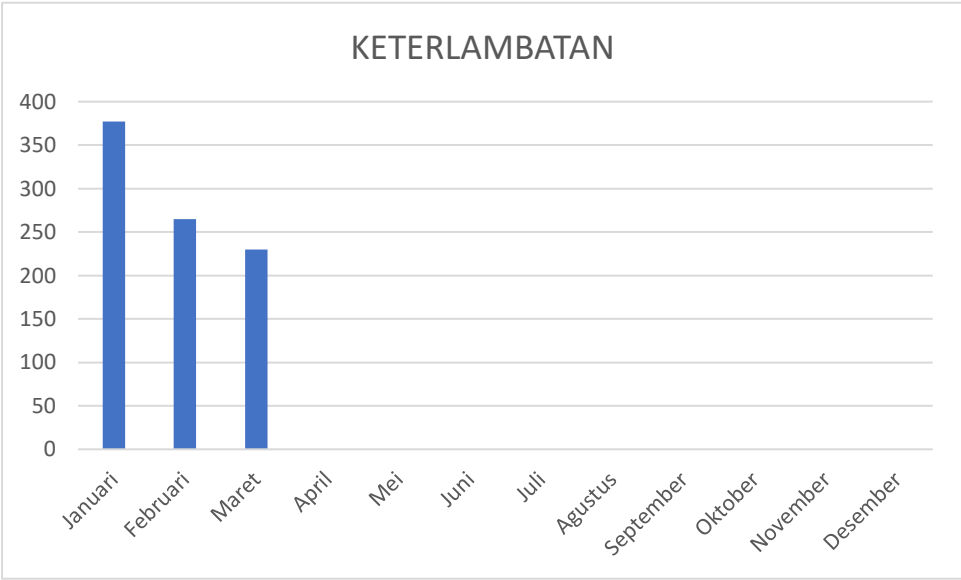
Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	81	78	322									
Baik	262	270	73									
Cukup	51	46	3									
Kurang	1	1	0									
Sangat Kurang	4	4	2									
TOTAL	399	399	400									

Analisa :
 secara umum terdapat peningkatan kinerja dari staf dilihat dari jumlah kategori cukup yang naik menjadi kategori diatasnya.

Rencana Tindaklanjut :

1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	377	265	230									



Analisa :
Secara umum terdapat penurunan keterlambatan karyawan. Hal ini dikaenakan SDM aktif menshare secara berkala keterlambatan karyawan ke Kepala Ruang

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling
3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2025

NO	JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Konseling	0	0	3								

Analisis :
Terdapat konseling terkait karir sejumlah 3 karyawan. Untuk ppermintaan konsleing dari unit melalui gform belum ada.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Supervisi (2x/bulan)	0	100%	50%									

3.5.2 IPSRS
3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintanance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruang	90%	84.61	66.6	92.3									

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	268	154	57.46%
Februari	270	135	50.00%
Maret	276	153	55.43%

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	21
Februari	22
Maret	21

Analisa :
 Pada bulan ini, capaian maintenance alat berdasarkan ruangan 92.3% dan jumlah alat 55.43%. Beberapa factor yang menyebabkan fluktuatif antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien, perbantuan perbaikan alat medis klinik Mutiara sehat serta beberapa kondisi alat servis yang membutuhkan waktu lebih lama.

Rencana Tindak Lanjut :
 Koordinasi dengan PT untuk ATEM sesuai ABK

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	MAINTENANCE / 1 BULAN	MAINTENANCE / 2 BULAN	MAINTENANCE / 3 BULAN	TOTAL	CAPAIAN
TARGET/BULAN	42	30	23	95	
JANUARI	11	6	16	33	35%
FEBRUARI	23	17	11	51	53.6%
MARET	14	41	6	61	64.21%
APRIL					
MEI					
JUNI					
JULI					
AGUSTUS					
SEPTEMBER					
OKTOBER					
NOVEMBER					
DESEMBER					

Analisa :
 Pada awal januari digunakan metode baru pencatatan kinerja terutama terkait sistem pencatatan dan target perbulan. Sudah dilakukan pencatatan metode baru, hasil evaluasi lebih baik dari tahun 2024. Capaian bulan ini meningkat menjadi 61%.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D,E dan LVMDP dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

Maret 2025							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/03/2025	2524	2393	131	MMHG			MMHG
02/03/2025	2393	2124	269	MMHG			MMHG
03/03/2025	2124	1928	196	MMHG			MMHG
04/03/2025	1928	1750	178	MMHG			MMHG
05/03/2025	1750	1622	128	MMHG			MMHG
06/03/2025	1622	1385	237	MMHG			MMHG
07/03/2025	1385	1050	335	MMHG	sebelum pengisian		MMHG
07/03/2025	1050	3021	0	MMHG	sesudah pengisian	1971	MMHG
08/03/2025	3021	2940	81	MMHG			MMHG

09/03/2025	2940	2660	280	MMHG			MMHG
10/03/2025	2660	2438	222	MMHG			MMHG
11/03/2025	2438	2332	106	MMHG			MMHG
12/03/2025	2332	2090	242	MMHG			MMHG
13/03/2025	2090	1782	308	MMHG			MMHG
14/03/2025	1782	1580	202	MMHG	sebelum pengisian		MMHG
14/03/2025	1580	3471	0	MMHG	sesudah pengisian	1891	MMHG
15/03/2025	3471	3341	130	MMHG			MMHG
16/03/2025	3341	3129	212	MMHG			MMHG
17/03/2025	3129	2909	220	MMHG			MMHG
18/03/2025	2909	2732	177	MMHG			MMHG
19/03/2025	2732	2535	197	MMHG			MMHG
20/03/2025	2535	2305	230	MMHG			MMHG
21/03/2025	2305	2055	250	MMHG			MMHG
22/03/2025	2055	1786	269	MMHG			MMHG
23/03/2025	1786	1504	282	MMHG			MMHG
24/03/2025	1504	1275	229	MMHG	sebelum pengisian		MMHG
24/03/2025	1275	3470	0	MMHG	sesudah pengisian	2195	MMHG
25/03/2025	3470	3311	159	MMHG			MMHG
26/03/2025	3311	3011	300	MMHG			MMHG
27/03/2025	3011	2669	342	MMHG			MMHG
28/03/2025	2669	2455	214	MMHG			MMHG
29/03/2025	2455	2214	241	MMHG			MMHG
30/03/2025	2214	1986	228	MMHG			MMHG
31/03/2025	1986	1773	213	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			6677	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						6057	MMHG
Rata-rata penggunaan okisgen per hari			425,7241379	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						3028,5	MMHG

Analisis :
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.7 Filter Air

3.5.2.2.7.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.9 UPS
1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

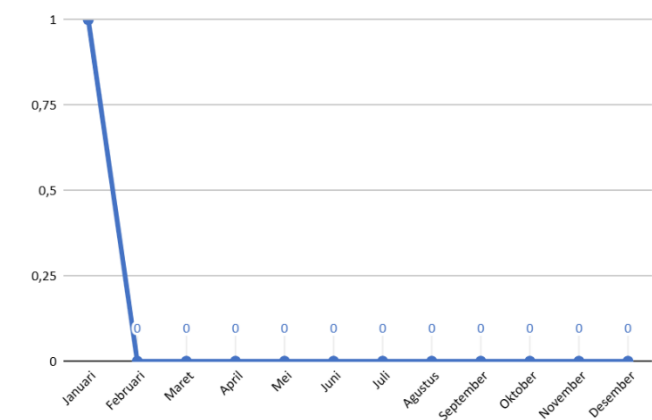
Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.3 Security
3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	1	0	0								

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



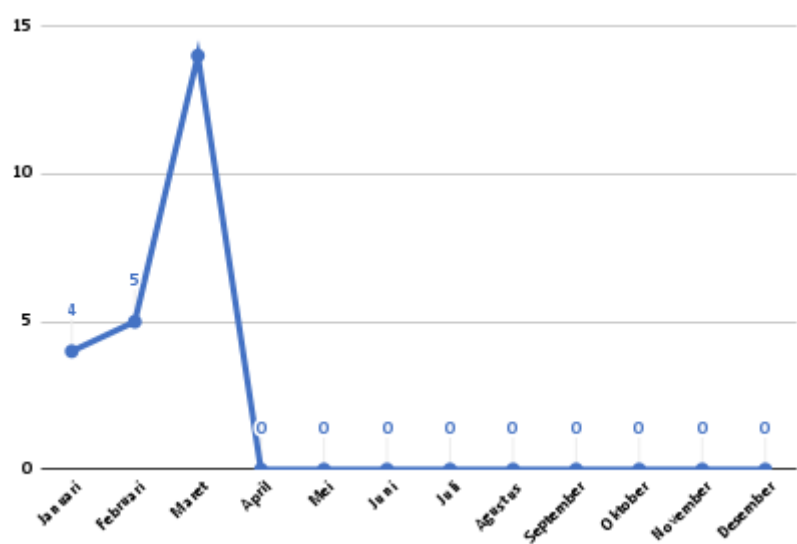
Analisa :
Tidak ada kejadian barang hilang di bulan Maret 2025

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	4	5	14								

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



ANGKA KEJADIAN BARANG BERPOTENSI HILANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
03 – 03 – 2025	Ditemukan kalung + bandung dibawah kursi ruang tunggu iko ,diamankan di pos IGD	Sudah diambil pemilik
06 – 03 – 2025	Ditemukan dompet tertinggal di area depan pendaftaran IGd , diamankan di pos IGD	Sudah diambil pemilik
11 – 03 – 2025	Ditemukan kunci kontak kendaraan R2 oleh rekan cs	Sudah diambil pemilik karyawan RSPH
11 – 03 – 2025	Ditemukan kontak motor milik pasien IGD rawat jalan , diamankan di pos IGD	Sudah diambil pemilik
13 – 03 – 2025	Ditemukan kontak motor tertinggal di parkir an karyawan lt 2 diamankan di pos poli	Sudah diambil pemilik
14 – 03 – 2025	Ditemukan topi anak di kursi tunggu pendaftaran poli central , diamankan di pendaftaran central	Sudah diambil pemilik
15 – 03 -2025	Ditemukan dompet keluarga pasien ditemukan di ruang tunggu farmasi ,diamankan di farmasi	Sudah diambil pemilik
16 – 03 – 2025	Telah ditemukan dompet keluarga pasien di area masjid berikut dengan isi dompet , diamankan di pos IGD	Sudah diambil pemilik

18 – 03 – 2025	Ditemukan kontak motor depan lift poli lantai 1	Sudah diambil pemilik
18 – 03 – 2025	Ditemukan sandang keluarga pasien ditemukan di depan IKO , terkondisikan di belakang poli	Sudah diambil pemilik
19 – 03 – 2025	Ditemukan kunci jatuh di area poli	Sudah diambil pemilik
21 – 03 - 2025	Ditemukan kunci motor pengunjung , diamankan di pos IGD	Sudah diambil pemilik
22 – 03 – 2025	Ditemukan kunci di area poli central	Sudah diambil pemilik
22 – 03 -2025	Ditemukan berkas pasien atas nama daffasyah , diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik

Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

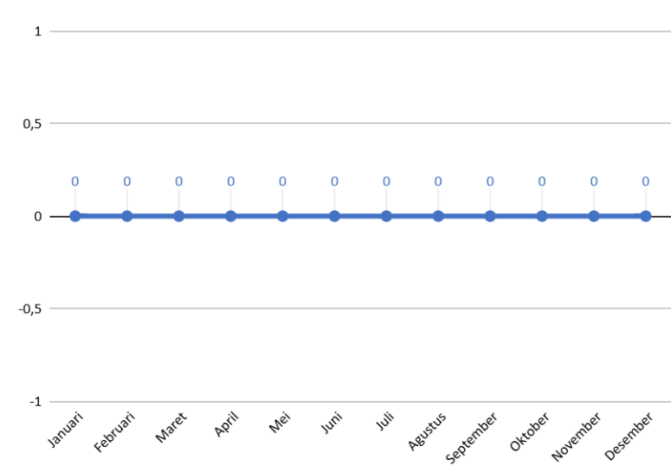
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0								

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan



Analisis :

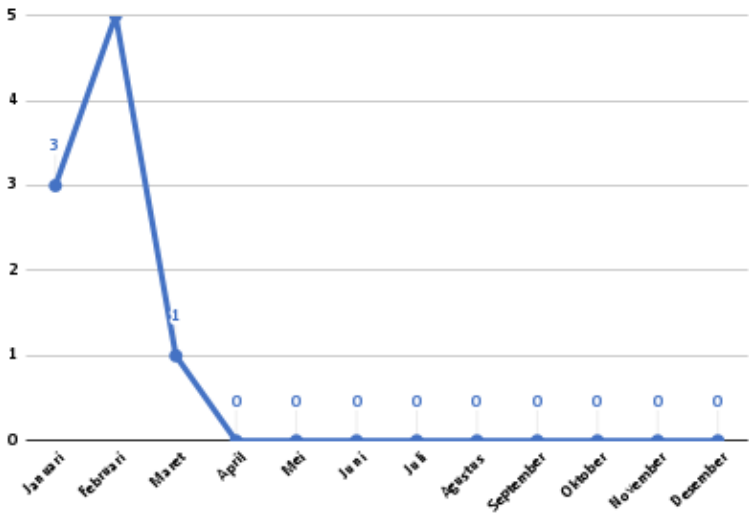
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	3	5	1									

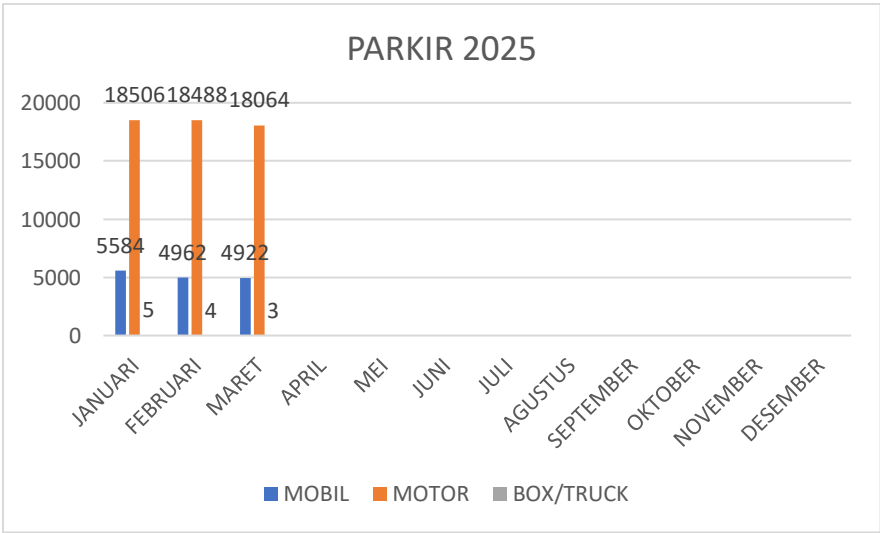


Analisis :
Angka ini relative kecil. Belum sepenuhnya tercatat. Yang tercatat adalah laporan security saat keliling saja.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :
Progres parkir bulan ini menurun akibat jumlah hari aktif yang lebih sedikit serta fluktuatif kunjungan pasien.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

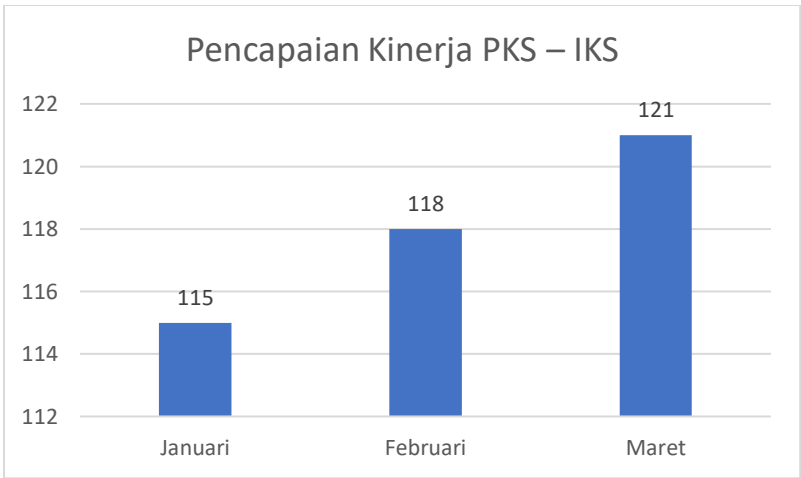
3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Februari 2025

No	Bulan	Target	Jumlah					Total Kurang
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru	Progres	
1	Januari 2025	1 IKS baru	115	6	0	0	2 (review pihak kedua) 1 (progres evaluasi) 1 (tdk diperpanjang)	4
2	Februari 2025	1 IKS baru	118	1	1	0	3 (Proses Tanda Tangan Pihak kedua)	3
3	Maret 2025	1 IKS baru	121	1	1	0	1 (Proses review)	1
Analisis ; - Pada bulan Maret 2025, PKS Expired dengan instansi lain masih dalam progres serta menindaklanjuti progres PKS yang belum selesai di tahun lalu. - Draft yang dikirim ke perusahaan masih dalam tahap TTD Rencana Tindak Lanjut : - Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua								

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Maret 2025

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
1	PT Nayaka Era Husada	Review pihak kedua	Selesai
2	Klinik Brawijaya Lawang	Review pihak kedua	Proses pihak klinik
3	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Review pihak kedua	Selesai
4	PT. Kasoem Hearing	Mengulang karena ada pergantian PIC dan Direktur	Proses Review dan Tanda Tangan
5	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
6	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Perpanjangan
7	PT BNI Life Insurance	Penambahan Addendum	Proses Pembuatan Addendum
8	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	Review	Proses pihak Dispenduk



3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Maret 2025

No	Bulan	Target	Jumlah Pasien
1	Januari	25	95
2	Februari	25	135
3	MARET	150	199
4	APRIL	150	
5	MEI	150	
6	JUNI	150	
7	JULI	150	
8	AGUSTUS	150	
9	SEPTEMBER	150	
10	OKTOBER	150	
11	NOVEMBER	150	
12	DESEMBER	150	
Analisis ; 1. Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan Maret meningkat 1.47% dari bulan Februari Rencana Tindak Lanjut : 1. Melakukan Promosi melalui Social Media 2. Kunjungan ke Perusahaan rekanan, menawarkan program MCU karyawan 3. Melakukan Follow Up ke Perusahaan yang sudah diberikan Surat Penawaran 4. Membuat Paket untuk pemeriksaan MCU			

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Jumlah Kunjungan	5	10	2								

Analisa :

Kunjungan eksternal mulai dilakukan Kembali untuk sosialisasi kebijakan yang berhubungan dengan rujukan pasien dan pengenalan staf baru. Terdapat peningkatan kunjungan pada bulan Februari karena telah direncanakand dan terjadwal.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala.

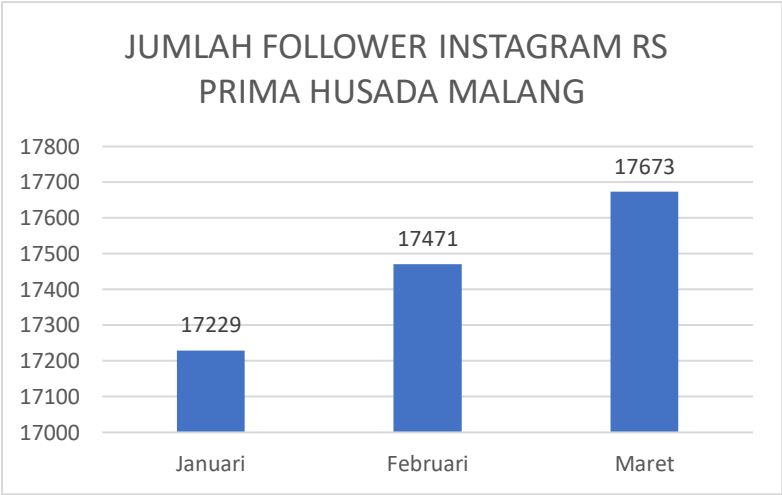
3.5.5.2.4 Digital Marketing

3.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

Platform Instagram

JUMLAH KONTEN BARU	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	3	7	9									
REELS	5	5	11									
STORY	6	10	14									
TOTAL	14	22	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	6	11	16									
FEED VIDEO	0	0	0									
REELS	3	4	5									
STORY	29	33	28									
TOTAL	38	48	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	17,229	17,471	17.673									
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	496	242	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

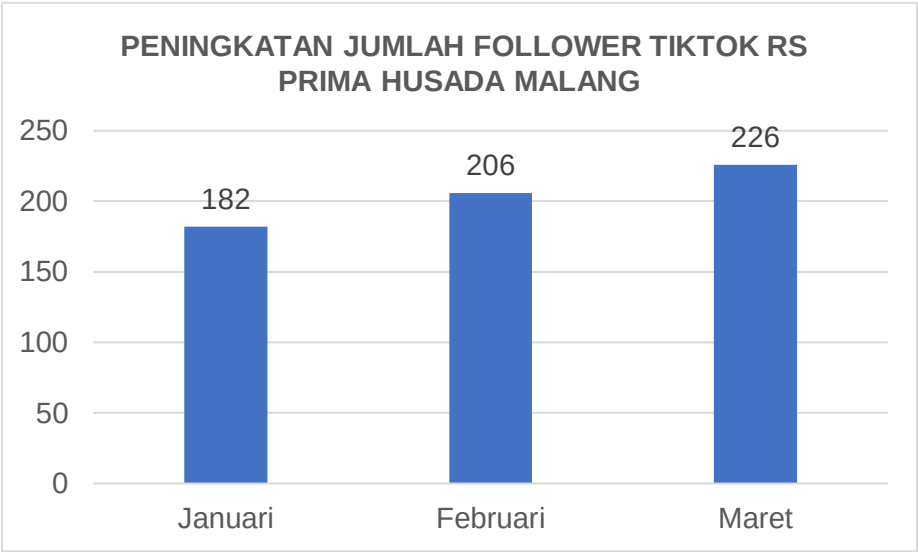


Analisa :
 Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1% dari bulan Maret

- Rencana Tindal Lanjut :**
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok												
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	2	3	4									
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	182	206	226									
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATA	16	24	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N FOLLOWER												
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH LIKE	45	72	1023									



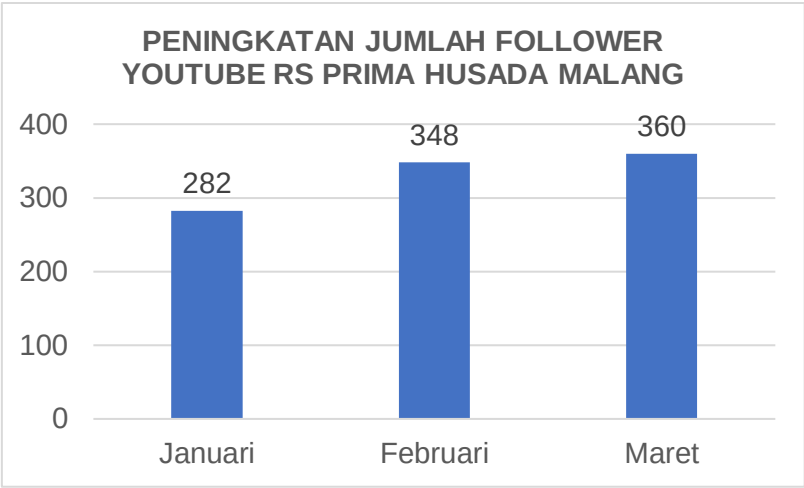
Analisa :
 Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1.1% dari bulan Februari

- Rencana Tindal Lanjut :**
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	0	2	0									
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH SUBS	282	348	360									
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	4	66	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



Analisa :
Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1.2% dari bulan Januari

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG																	
PERIODE 2025																	
											Y	Z	AA	AB	AC		
NC	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG						JUMLAH PIUTANG
		a	b	c	(a-b-c=d)	e	f	g	(e-f=g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total	
PERIODE JANUARI 2025 :																	
1	Asuransi	203.604.469	76.844.798	2.082.312	124.677.359	222.634.032	34.991.526	1.425.358	186.217.148	310.894.507	237.631.490	27.995.108	22.804.885	21.900.904	582.140	310.894.507	
2	Perusahaan	267.288.964	109.418.709	1	157.870.254	81.931.808	5.912.000	-	86.019.808	243.890.062	163.707.073	2.812.349	17.789.281	33.905.194	25.676.156	243.890.062	
3	Mandiri Inhealth	83.607.153	55.329.576	946.619	27.330.958	43.875.009	-	-	43.875.009	71.205.967	70.803.929	-	-	-	372.039	71.205.967	
4	Jasa Rahaaja	120.917.190	119.996.274	1	920.917	81.120.474	-	-	81.120.474	82.041.391	81.120.474	-	920.917	-	-	82.041.391	
5	BPJS Ketenagakerjaan	745.739.611	-	-	745.739.611	429.693.014	-	-	428.693.014	1.174.432.625	1.167.849.098	2.375.150	-	487.635	3.710.742	1.174.432.625	
										Total Saldo	1.882.464.553	1.721.122.062	33.182.607	41.515.073	56.303.734	30.341.078	1.882.464.553
PERIODE FEBRUARI 2025 :																	
1	Asuransi	310.890.496	195.143.500	3.453.339	112.293.656	288.168.610	27.204.170	1.021.818	259.942.622	372.236.278	335.510.635	13.873.869	-	22.270.234	582.140	372.236.278	
2	Perusahaan	243.890.062	54.574.387	0	189.315.676	127.967.748	-	-	127.967.748	317.283.424	195.790.549	42.760.383	3.403.421	34.334.061	40.994.011	317.283.425	
3	Mandiri Inhealth	71.205.967	33.691.344	552.929	36.961.695	17.686.913	-	-	17.686.913	54.648.608	54.276.568	-	-	-	372.039	54.648.607	
4	Jasa Rahaaja	82.041.391	81.120.474	1	920.918	230.199.405	591.728	-	229.607.677	230.528.595	229.607.677	-	-	920.917	-	230.528.594	
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.174.432.625	449.762.830	182	724.669.613	329.921.793	-	-	328.921.793	1.053.591.407	995.050.064	81.367.816	2.375.150	-	4.208.377	1.053.591.407	
										Total Saldo	2.028.288.312	1.810.694.385	107.892.068	5.778.571	67.625.812	2.028.288.311	
PERIODE MARET 2025 :																	
1	Asuransi	372.121.499	147.535.435	4.315.445	220.270.619	260.056.447	41.722.308	1.482.881	216.851.258	437.121.877	405.782.365	6.677.663	1.809.475	-	22.852.374	437.121.877	
2	Perusahaan	317.283.425	150.562.399	126.876	166.604.150	87.313.852	4.644.921	-	82.668.931	249.273.081	126.844.704	935,000	42.760.383	3.403.421	75.329.572	249.273.080	
3	Mandiri Inhealth	54.648.608	-	-	54.648.608	40.713.383	-	-	40.713.383	95.361.991	94.989.952	-	-	-	372.039	95.361.991	
4	Jasa Rahaaja	230.528.595	229.607.676	2	920.917	124.795.356	-	-	124.795.356	125.716.273	124.795.356	-	-	-	920.917	125.716.273	
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.053.591.407	1.040.744.420	604.006	12.242.891	640.446.733	-	-	640.446.733	652.689.624	648.229.193	538.803	338.100	2.375.150	4.208.377	652.689.624	
										Total Saldo	1.560.162.846	1.397.641.569	8.151.466	44.907.958	5.778.571	103.683.280	1.560.162.846

Keterangan :
Cut Off Piutang per 31 Maret 2025 saldo akhir Rp 1.560.162.845

3.5.5.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
RAWAT JALAN			
1.	Konsul internal jadi 1 episode kunjungan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Kunjungan Fragmentasi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Indikasi kunjungan rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Pasien kontrol gunakan kode Z sebagai du	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Tidak sesuai ketentuan perundangan pasien kontrol rutin rssa jika kunjungan hanya	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

	untuk minta rujukan maka tidak dijamin		
6	Kode gabung	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
RAWAT INAP			
1	Rujuk di hari yg sama, lampirkan CPPT	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Reseleksi kode du tf (dengan diagnosa df tf) sesuai dengan indikasi mrs dan penunjang	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Bayi lahir penolong persalinan dokter, tidak sesuai dengan jadwal DPJP	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Klinis pasien appendik prosedur lebih spesifik appendectomi, apakah semua appendek dengan prosedur explorasi lapartomi (dgn diagnosa akut peritonitis tindakan explorasi laparatomi)	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Penyebab Diagnosa hipo(hipokalemi, hiponatremia, hipokalsemia) sebagai diagnosa utama	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Kunjungan Readmisi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
7	ISK tanpa komplikasi tidaj ada indikasi RITL, klaim rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
8	Gea tidak ada indikasi RITL, klaim rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
9	Reseleksi diagnosa syok hipovolemik menjadi syok unspecified	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

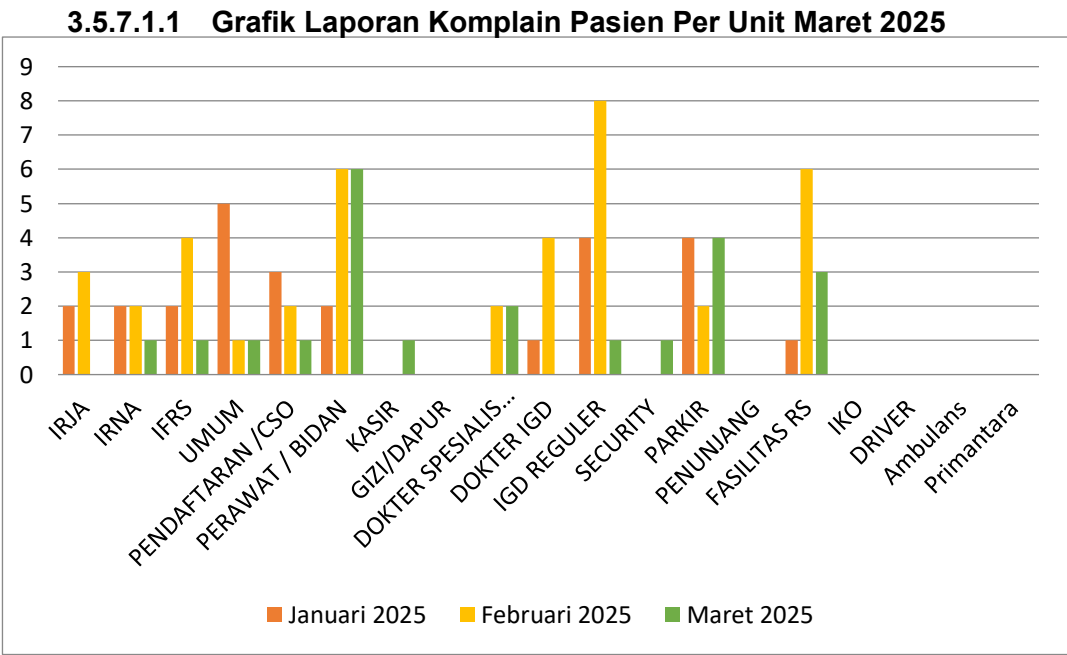
3.5.6 PIPP – MOD – MPP

3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Maret 2025

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1.	IRJA	2	3	0
2.	IRNA	2	2	1
3.	IFRS	2	4	1
4.	UMUM	5	1	1
5.	PENDAFTARAN /CSO	3	2	1
6.	PERAWAT / BIDAN	2	6	6
7.	KASIR	0	0	1
8.	GIZI/DAPUR	0	0	0
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	0	2	2
10.	DOKTER IGD	1	4	0
11.	IGD REGULER	4	8	1
12.	SECURITY	0	0	1
13.	PARKIR	4	2	4

14.	PENUNJANG	0	0	0
15.	FASILITAS RS	1	6	3
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	0	0	0
Total		26	40	22



- Analisis :**
- Jumlah pasien komplain selama Bulan Maret 2025 mengacu pada komplain pasien. Asal komplain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.
- Jumlah complain Pada bulan Maret 2025 Menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan Januari 2025 26 kasus complain, pada bulan februari 2025 sebanyak 40 kasus. Sedangkan pada bulan maret 2025 sebanyak 20 pasien
 - Komplain terbanyak pada bulan Maret 2025 yaitu dari bagian perawat/bidan sebanyak 6 kasus, parkir 4 kasus, fasilitas RS 3 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
 - Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 4 kasus complain dengan rincian :
 - Fasilitas RS sebanyak 1 kasus yaitu disediakanya fasilitas fotokopi agar tidak keluar RS untuk melakukan FC dokumen ketan ireng
 - Parkir sebanyak 3 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Maret 2025

NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1.	Langsung tatap muka	7	5	0
2.	Tidak Langsung :			

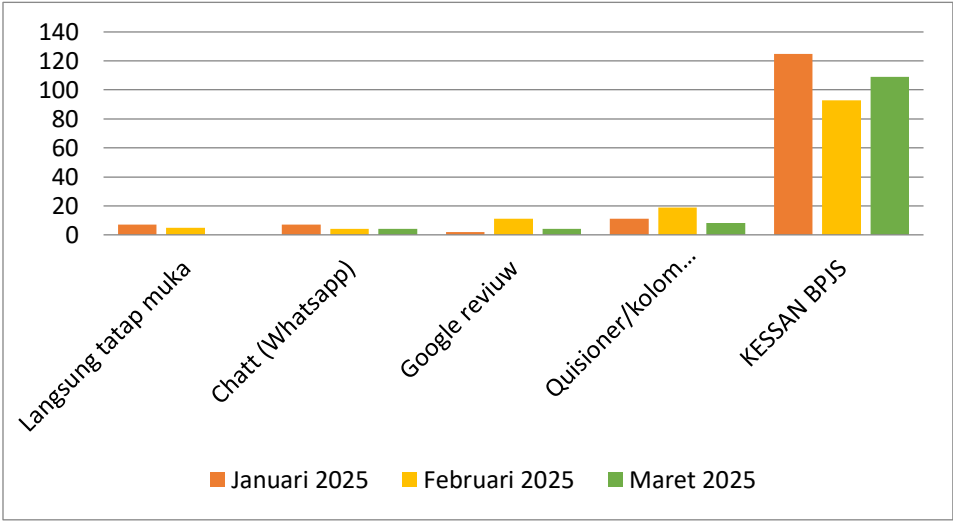
a	Chatt (Whatsapp)	7	4	4
b	Google reviuw	2	11	4
3.	Quisioner/kolom kritik saran	11	19	8
4.	KESSAN BPJS	125	93	109

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

NO	KETERANGAN	BINTANG 1	BINTANG 2	BINTANG 3	BINTANG 4	BINTANG 5
1.	KESSAN BPJS	0	0	3	27	79

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Maret 2025



Analisis :

Pada bulan Maret 2025 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 8 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari google riviuw dan WA sebanyak masing2 4 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Maret 2025

NO	Jenis pasien complain	Waktu tanggap		Waktu penyelesaian		< 3 hr Manajerial RS	7 hr ke PT
		Standard < 5 ‘	Pencapaian (dari waktu total dibagi jml komplain atau rata2 waktu tanggap)	Standard < 60 ‘	Pencapaian		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google review	100%	100%	100%	100%	0	0
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	3	4	0
					50%	60%	
5.	KESSAN	100%	0	100%	100%	0	0

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Maret 2025 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 60% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 4 kasus complain dengan rincian :

- 1) Fasilitas RS sebanyak 1 kasus
Disediakan mesin fotokopi untuk pasien di RS agar pasien tidak keluar RS
- 2) Parkir sebanyak 3 kasus
Terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,

Rencana Tindak Lanjut :

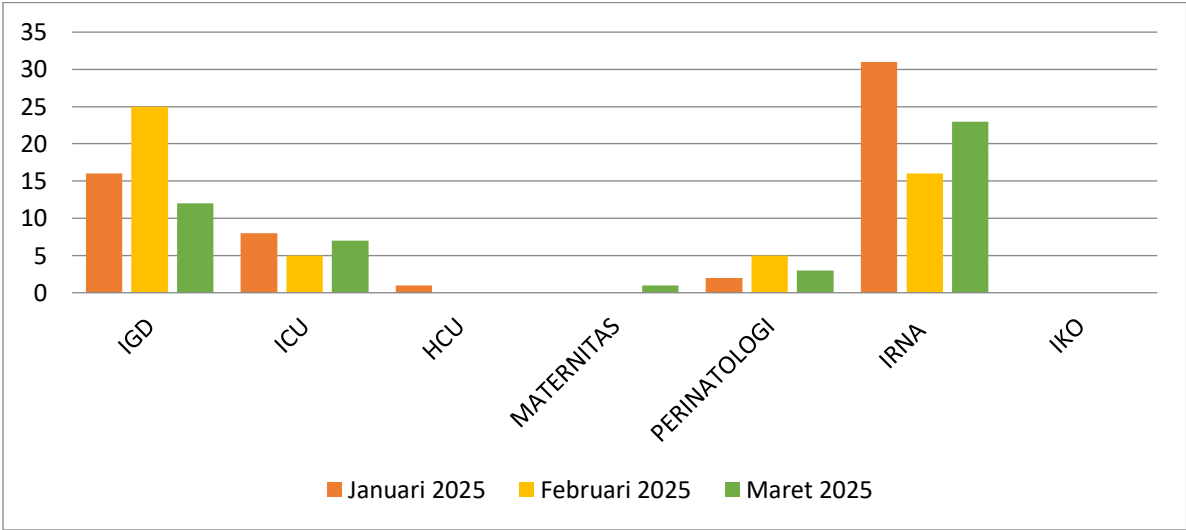
Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Maret 2025

NO	UNIT PERUJUK	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1.	IGD	16	25	12
2.	ICU	8	5	7
3.	HCU	1	0	0

4.	MATERNITAS	0	0	1
5.	NEONATOLOGI	2	5	3
6	IRNA	31	16	23
7	IKO	0	0	0
Total		48	58	46

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Maret 2025



3.5.7.5.3 Tabel Rincian Pasien Rujuk Maret 2025

NO	Nama Pasien	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	Ny. Tukiyah	ICU	CVA ICH, HT EMERGENCY	DR FARID SP S	RSSA	PRO EVAKUASI ICH	4	TIDAK
2	Ny. Ngatini	IRNA	hyperglycemia in critical ill, bisitopenia susp MSS dd anemia Aplastik, DM nefropathy, NSTEMI	DR ARDHI SP PD	RS LAVALETE	PRO PERAWATAN LEBIH LANJUT	4	TIDAK
3	Ny. Jati	IGD	STEMI Posterior, Shock Cardiogenik	-	RST. Soepraon	PRO PCI	1	TIDAK
4	Ny. Suni	IRNA	Hernia Femoralis Incaserata, Anemia	dr. Anton Sp. B	RSSA	PRO PERAWATAN LEBIH LANJUT	2	TIDAK
5	Ny. Ngatipah	IRNA	Susp. CVA, AF RVR. CKD	dr. Farid Sp. N konsul dr Ira Sp. Jp	RS. Lavalatte	PRO HD	2	TIDAK
6	Sdra. Rudi Saka	IRNA	AKI, Asidosis Metabolik, HT, Bacterial Infection, Hiponatremi	dr Ardhandy, Sp PD	RSUD Lawang	Pro HD	5	Tarif rs : 3.975.726 Plafon : 3.012.000 Minus : 963.726
7	TN. NURALI	IGD	STEMI	dr Miryanti Sp JP	RS UMM	Pro PCI	1	Tidak
8	Tn. Tain	IRNA	Necrotizing fascitis digiti 1 pedis S, DM Hiperglikemi	dr. Anton Sp.B	RSSA	PRO PERAWATAN LEBIH LANJUT	2	Tidak
9	Ny. Sudarti	ICU	ADHF, HHD, CAR, CKD	dr. Yoga Sp JP	RS LAVALETE	Pro HD	1	Tidak
10	TN. IMBING CAHYONO	IRNA	STEMI ANTERIOR, ADHF, EF	dr Ira Sp JP	RS UMM	PRO PCI	2	Tidak
11	TN. AHMAD SUWANDI	IGD	NSTEACS, HHD, DM type 2	dr Miryanti Sp JP	RS UMM	PRO PCI	1	Tidak
12	TN. SEGAF	IRNA	Geriatric Syndrome, CHF, Hiponatremi, Imobilisasi, Dimensia	dr Ardhandy Sp PD	RSJ Lawang	Pro Geriatric Unit	2	Tidak
13	Ny.	IRNA	Ileus Obstruktif + Adhesive	dr Zaki, SP.B raber	RSSA	Pro Perawatan	5	TIDAK

	Suhartatik		Ileum Ileus post Explorasi Laparatomy, B20 Reaktiv	dr Ardhi, Sp.PD		Lebih Lanjut dan Tata Laksana B20		
14	Tn Ahmad Hadi Purnomo	IRNA	Colic Renal Persistent, Batu Staghorn D	dr Pradana, Sp.U	RSSA	Pro Bivalve k/p Nefrectomy	3	TIDAK
15	BY NY. IFADATUL LAILY	NEO	RDS ok Neonatal Bronchopneumonia dd TTNB	dr. Fiona Sp. A	RS Lavalette	Perawatan lama	3	TIDAK
16	Tn Samsul	IRNA	Hematemesis Melena	dr. Ard hany, Sp.PD-KGH konsul dr Farid, Sp.S	RS Karsa Husada Batu	Pro Endoscopy	3	TIDAK
17	TN. ABDUL SYUKUR	IGD	CVA ICH Temporal Dextra susp. Edema?	dr. Farid Sp. N	RST. Soepraon	pro evakuasi hematome	1	Tidak
18	Ny. Rokemi	ICU	DOC, CVA emboli 2an attack	dr. Farid Sp. N	RS LAVALETE	pro stroke unit	1	Tidak
19	Ny. Desi Maulidya	MTS	G1P0000 Ab000 UK 28-30 mgg dg ALO + Asites Permagna	dr Humaira Sp OG	RSSA	pro Perawatan intensif	1	Tidak
20	tn. toha	IGD	DOC dt Intracranial dd Extracranial, ACKD	DR FARID SP S	Lavalete	Pro Stroke Unit	2	TIDAK
21	Ny.Djumaiah	ICU	Syok kardiogenik,	dr.Miryanti.,Sp.Jp	RSSA	Pro perawatan lebih lanjut	4	Tidak
22	Tn. Moelyo HARIYANTO	IRNA	paraparase inferior	DR FARID SP S	RSSA	Pro MRI	2	Tidak
23	Ny. Waginah	IRNA	paraparase inferior, Transferase myelitis	dr. Farid Sp S	RS Karsa Husada Batu	Pro MRI	3	Tidak
24	Tn Subekti Wiryatmoko	IRNA	Disfonia dt Susp Tumor Laring (Susp. Malignancy)	dr Farid, Sp.N	RSSA	Pro Penatalaksanaan Lebih Lanjut THT (Tracheostomy)	2	TIDAK
25	Ny. Rukinah	IRNA	Geriatric Problem, Hiponatremi, Hipokalemia	dr. Ard hany, Sp.PD-KGH	RSJ Lawang	Pro Geriatric Unit	4	TIDAK
26	Tn. Atim	IGD	Heniparase Sin ec CVA Infark, AF RVR, Efusi Pleura Dex	dr. Dewi Sp. S	RS Lavalette	pro stroke unit	1	TIDAK
27	Tn Wahib	IRNA	CKD st III-IV ec Hydronefrosis grade IV	dr. Aji, Sp.PD	RSSA	Pro HD	3	TIDAK
28	Tn Lantas	IRNA	CVA ICH	dr. Farid, Sp.S	RST. Soepraon	Pro Unit Stroke dan Evakuasi Hematome	4	TIDAK
29	Tn Agus Wahyu Utomo	IRNA	Hematemesis Melena	dr. Ard hany, Sp.PD-KGH	RSSA	Pro perawatan SpPD- KGEH dan pertimbangan endoskop	3	TIDAK
30	Ny. Devi Yuliasari	IGD	Dispnea dt Pneumonia, B20	Dr. ANDY, SP. P	RS Lavalette	Pro Penanganan lebih lanjut	2	TIDAK
31	Ny. Sulami	IRNA	Post Hematoskezia	dr. Ardhi, Sp. PD	RSSA	Pro Penatalaksanaan Lebih Lanjut di Bidang Hematologi + Trombopheresis	3	TIDAK
32	Tn Soeyono	IRNA	CKD st V	dr. Zoraida Sp.PD	RSSA	Pro Pertimbangan HD	5	TIDAK
33	Ny. Supilah	IRNA	Anemia, hematemesis melena, AKI	dr Aji, Sp.PD	RSSA	Pertimbangan Endoskopi dan Penanganan lebih lanjut	3	TIDAK
34	Tn. Khoirul Anam	ICU	ARDS	dr Andi, Sp.P	RS Lavalete	Pro Penatalaksanaan Lebih Lanjut di Bidang Hematologi + Trombopheresis	6	TIDAK
35	Tn. Moch Chalim	IGD	Burn Injury Grade 2B 28% Luas 30-32%	dr. Sigit Sp. Bp	RSSA	Pro Penanganan lebih lanjut	1	TIDAK
36	Tn. Lantas	IGD	CVA ICH Post Trepanasi	dr. Farid Sp. N	RS. Karsa Husada Batu	Pro COILING	1	TIDAK
37	Ny. Sri Rahyau	IGD	STEMI Anteroseptal	dr. Ira Sp. Jp	RS UMM	Pro PCI	1	TIDAK
38	Tn. Kibanan	IRNA	Acure on CKD dt Urate	dr. Ardhi Sp. PD	RSSA	Pro HD	3	TIDAK

			Nefropaty, Acure on Chronic gout arthirits, HF					
39	Tn. Soleh	IGD	CVA Emboli Luas	dr. Farid Sp. N	RS. Karsa Husada Batu	Pro Penanganan lebih lanjut	1	TIDAK
40	By. Ny. Sofia	NEO	Prematur, Afiksia, Hiperglikemia Refrakter	dr. Dicky Sp. A	RSSA	Pro Ventilator	1	TIDAK
41	Ny. Artitis Undari	IGD	Susp. CVA Infark, Hemiparase Dex	dr. Syahrir, Sp. S	RSSA	pro stroke unit	2	TIDAK
42	By Ny. Sherlina	NEO	Pneumonia, RDS, Susp. NEC	dr. Dicky Sp. A	RSSA	Pro Ventilator	2	TIDAK
43	Nn. Alberto Petronela Kato	IRNA	Paralisis Hipokalemi Perbaikan, Lukositosis, Anemia	dr. Farid Sp. N	RSSA	Pro BMP	4	TIDAK
44	An. M Akbar Nurdaffah	IRNA	Bisitopeni Susp ALL dd AML, Leukositosis	dr. Dicky Sp. A	RSUD Sidoarjo	Pro Penanganan lebih lanjut	3	TIDAK
45	Tn. Hantono	ICU	STEMI anterior extensive succesfull fibrinolytic, PVC Begimini, HHD, Riwyat: CVA Infark	dr Mira Sp. Jp	RS UMM	Po PCI	1	TIDAK
46	Tn. Dani	ICU	CVA ICH + IVH	dr. Syahrir, Sp. S	RS. Karsa Husada Batu	Pro Trepanasi Hematom	2	TIDAK

Analisis :

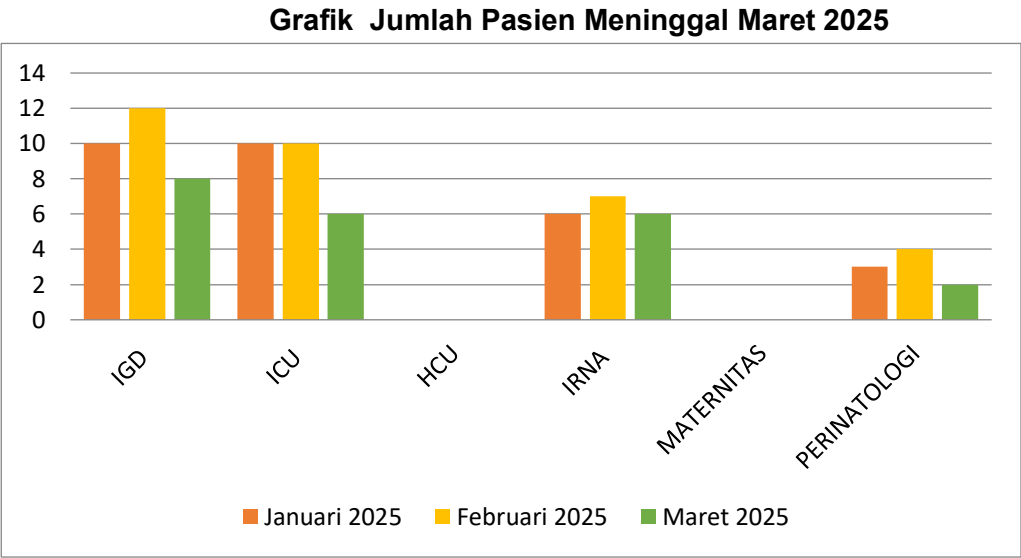
1. Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan Maret 2025, pada bulan Jauari 2025 sebanyak 58 pasien pada bulan Februari 2025 sebanyak 46 pasien Sedangkan pada bulan Maret 2025 sebanyak 46 pasien.
2. Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - a) Pro PCI
 - b) Pro CVCU
 - c) Pro stroke unit
 - d) Pro HD
 - e) Pro Bedah digestif
 - f) MRI
 - g) Pro bedah saraf lanjutan
 - h) Membutuhkan alat khusus
 - i) Membutuhkan pengobatan ARV
3. Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya bulan Pada bulan februari 2025 sebanyak Rp. 3.926.387 sedangkan pada bulan Maret 2025 sebanyak Rp. 963.726

Rencana Tindak Lanjut:

1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Maret 2025

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1.	IGD	10	12	8
2.	ICU	10	10	6
3	HCU	0	0	0
4.	IRNA	6	7	6
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	3	4	2
Total		17	29	33



Tabel Rincian Pasien Meninggal Maret 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP
1	Ny. Lik Anatus	IGD	CVA Infark	dr. Farid Sp. N
2	NY. ELLY SUSANA	IGD	DOC ec susp uremic encephalopathy, ACKD	dr Ardhany Sp PD
3	Ny.Siti Saidah	ICU	.Syock Cardiogenic dd non cardiogenic	dr.Miryanti.,Sp.JP
4	Tn Anam Jumadi	IRNA	Doc dt Sepsis encephalopathy, tetanus ardt gr 3, Aki,	dr Aji Sp PD
5	By Ny Santi Dewi	NEO	RDS ok neonatal pneumonia	dr Fiona Sp A
6	Tn. Joni Harianto	IRNA	BPH, anemia, post TURP	dr Edi Sp U
7	Tn. Nur Fakhri	IRNA	anemia hemoragic	dr Heri, Sp.PD
8	Tn FATKHUR ROHMAN	IGD	DOA	dr Sofia
9	Tn. Syaiful Huda	IGD	Edema Cerebri, Midline Shift dan Obliterasi Ventrikel Lateral	dr. Anton Sp. B
10	Ngali	IGD	DOS	dr. ANDIRA
11	By. Fiola	IGD	Dypsnea	dr Yeni
12	Ny. Martini	IRNA	NSTEMI + HT	dr. Yoga Sp. Jp
13	Tn. Slamet suprianto	ICU	adhf	dr. Yoga Sp. Jp
14	Ny. Mistutik	IRNA	Diabeticfoot post debridemen amputasi pedis (D), sepsis	dr Zaki, Sp.B
15	Tn. ABD Cholik	IRNA	Serosis Hepatis	dr Ardhany Sp PD
16	TN. AGUS SUWANDONO	IGD	SVT dengan aberrant onduction	dr. Yoga Sp. Jp
17	NY SIU	ICU	ARDS	dr. Aji Sp.PD Raber dr. Mira Sp. JP KOnsul dr. Heru Sp. An
18	Ny. Nur Istiqomah	ICU	CVA Trombosis, Epilepsi, Anemia, DM JL. ROGONOTO TIMUR NO 33 RT. 005 RW. 004 KEL. TAMANHARJO Kec. SINGOSARI KAB MALANG JAWA TIMUR	
19	By. Ny Putri Amalia	NEO	BBLASR, RDS	dr. Dicky Sp. A
20	Ny. Sulikah	ICU	Acute Respiratory Failure, Susp. TB, AF	
21	Tn. Sumid	ICU	STEMI	dr. Mira Sp. Jp
22	Ny. Wartini	IGD	Susp. Massa Paru Dex, ADHF, dt HHD	dr. Andy Sp. P

Analisa :

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Maret 2025 sebanyak 22 pasien
2. Jumlah terbanyak yaitu dari IGD : 8 pasien, ICU : 6 pasien, IRNA 6 pasien, dan Neonatologi sebanyak 2 pasien.

3. Pada bulan Maret 2025 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 1 kasus.
4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

3.5.7.6.1 Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	Usia lanjut	-	-	-
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastropik	-	-	-
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	-	-	-
4	Perkiraan biaya tinggi	-	-	-
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	-	-	-
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	-	-	-
7	Potensial komplain tinggi	-	-	-
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	-	-	-
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya	-	-	-
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	-	-	-
11	Berpotensi masalah hukum	-	-	-
12	Naik kelas pelayanan	-	-	-
13	Lain - lain	-	-	-

3.5.7.6.2 Tabel Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	Habis PKS	-	-	-
2	BPJS status Denda	-	-	-
3	BPJS status Premi	-	-	-
4	BPJS status Denda dan Premi	-	-	-
5	BPJS staus Usia lebih dari 21 tahun	-	-	-
6	BPJS status keluar atas kemauan sendiri	-	-	-
7	BPJS status penangguhan pembayaran	-	-	-
8	Rencana pengurusan BPJS	-	-	-
9	BPJS status tidak ditanggung	-	-	-
10	BPJS tidak aktif akhir bulan	-	-	-
11	BPJS peralihan Mandiri ke PBI	-	-	-

3.5.8 *Cleaning Service*

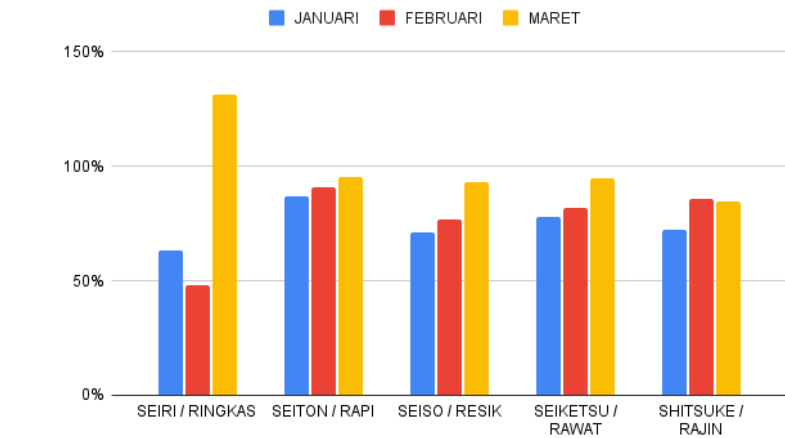
3.5.8.1 Indikator Kerja *Cleaning Service*

KATEGORI	DESKRIPSI
SEIRI	Penempatan Alat Kebersihan di Janitor/ trolley
	Penempatan Alat Kebersihan di Janitor/ trolley
SEITON	Kerapian baju dan kebersihan, penampilan petugas CS
	Kerapian baju dan kebersihan, penampilan petugas CS
SEISO	Membersihkan area kerja secara rutin sesuai jadwal
	Membersihkan area kerja secara rutin sesuai jadwal
SEIKETSU	Mematuhi SOP kebersihan

	Mematuhi SOP kebersihan
SHIKETSU	Konsistensi dalam menjalankan 5S secara mandiri tanpa pengawasan
	Konsistensi dalam menjalankan 5S secara mandiri tanpa pengawasan
	Konsistensi dalam menjalankan 5S secara mandiri tanpa pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas *Cleaning Service*

NO	JENIS SPV	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	SEIRI / RINGKAS	63%	48%	50%
2	SEITON / RAPI	87%	91%	91%
3	SEISO / RESIK	71%	77%	76%
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	82%	76%
5	SHITSUKE / RAJIN	72%	86%	86%



Analisa :
 Produktifitas Unit CS dalam penilaian ini masih dalam moneyv karena memakai instrument supervise yang baru.Terdapat peningkatan kinerja dari 4 poin pada bulan februari 2025.

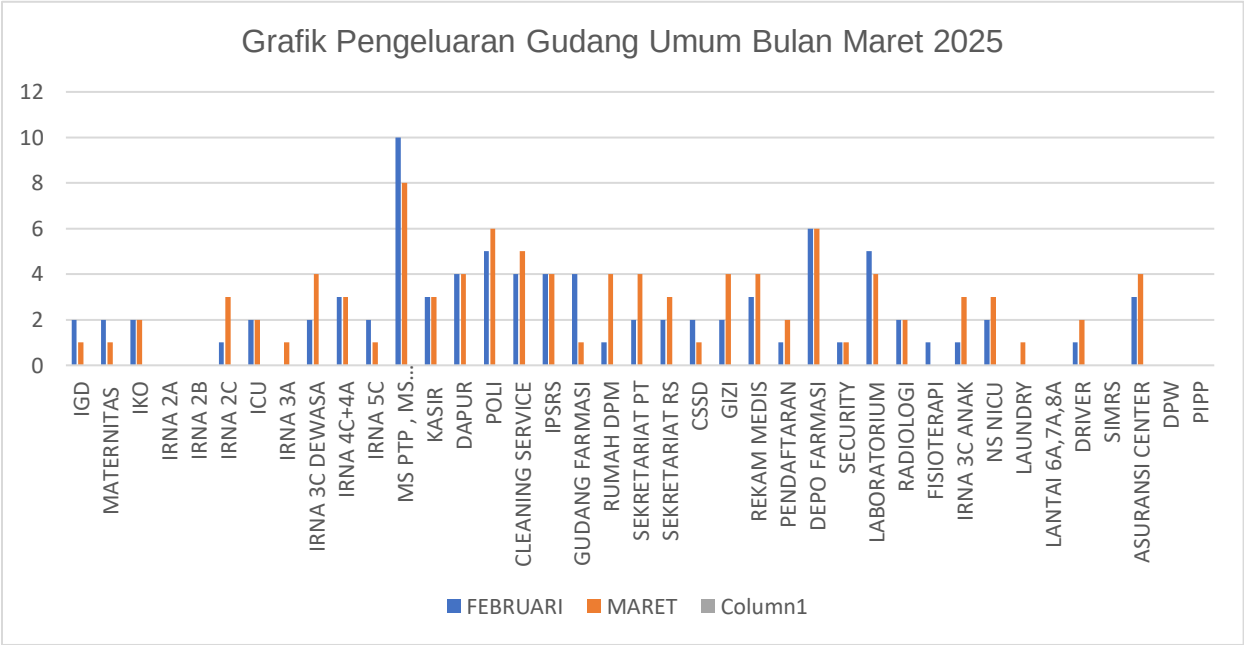
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		FEBRUARI	MARET	
1	IGD	2	1	↓-100%
2	MATERNITAS	2	1	↓-100%
3	IKO	2	2	↑0%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	1	3	↓66,66%
7	ICU	2	2	↓0%
8	IRNA 3A	0	1	↓100%
9	IRNA 3C DEWASA	2	4	↑50%
10	IRNA 4C+4A	3	3	↑0%
11	IRNA 5C	2	1	↓50%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	10	8	↓-25%
13	KASIR	3	3	↓0%
14	DAPUR	4	4	↓ 0%
15	POLI	5	6	↓16,66%

16	CLEANING SERVICE	4	5	↓20%
17	IPSRS	4	4	↓0%
18	GUDANG FARMASI	4	1	↓-100%
19	RUMAH DPM	1	4	↓75%
20	SEKRETARIAT PT	2	4	↓50%
21	SEKRETARIAT RS	2	3	↓33,33%
22	CSSD	2	1	↓-100%
23	GIZI	2	4	↓50%
24	REKAM MEDIS	3	4	↓25%
25	PENDAFTARAN	1	2	↓-100%
26	DEPO FARMASI	6	6	↓0%
27	SECURITY	1	1	↑0%
28	LABORATORIUM	5	4	↓-25%
29	RADIOLOGI	2	2	↑0%
30	FISIOTERAPI	1	0	↓0%
31	IRNA 3C ANAK	1	3	↓66,66%
32	NS NICU	2	3	↑100%
33	LAUNDRY	0	1	↑0%
34	LANTAI 6A,7A,8A	0	0	↓0%
35	DRIVER	1	2	↓50%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	3	4	↓25%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :

Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat dan,Depo Farmasi

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
- 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
- 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.6 Komite dan Tim

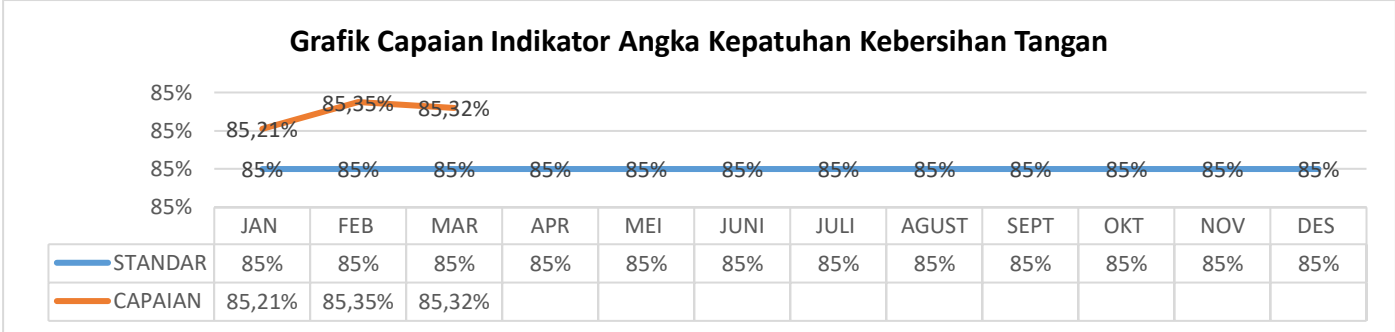
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,21%	85,35%	85,32%										85,29%
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,01%	93,06%	93,1%										93,05%
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%										99,74%
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%										100%
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89,16%	89,38%	99,1%										92,54%
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%										0%
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	75,9%	76,21%	74,93%										75,68%
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%										98,07%
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%										100%
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	100%	100%	100%										100%
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	99,75%	98,64%	99,1%										99,16%
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	99,92%	100%										99,97%
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%										99,86%

3.6.1.1Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



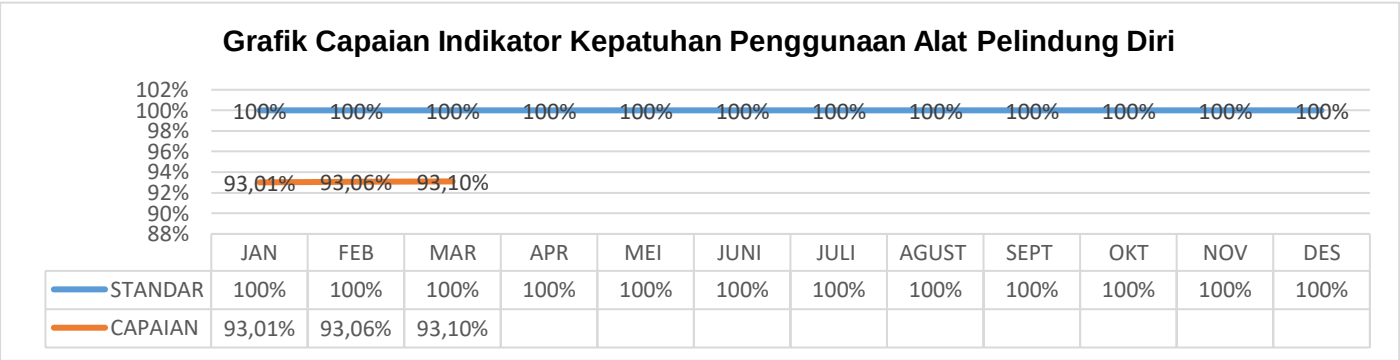
Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35% dan capian di bulan Maret yaitu 85,32%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.				
DO	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.				
STUDY	Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35% dan capian di bulan Maret yaitu 85,32%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	- Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin.	- Perawat /Bidan	Satu bulan

			- Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. - Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. - Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	- Dokter - Karu - IPCLN/PCN	
--	--	--	--	---	--

3.6.1.1.1 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.6.1.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



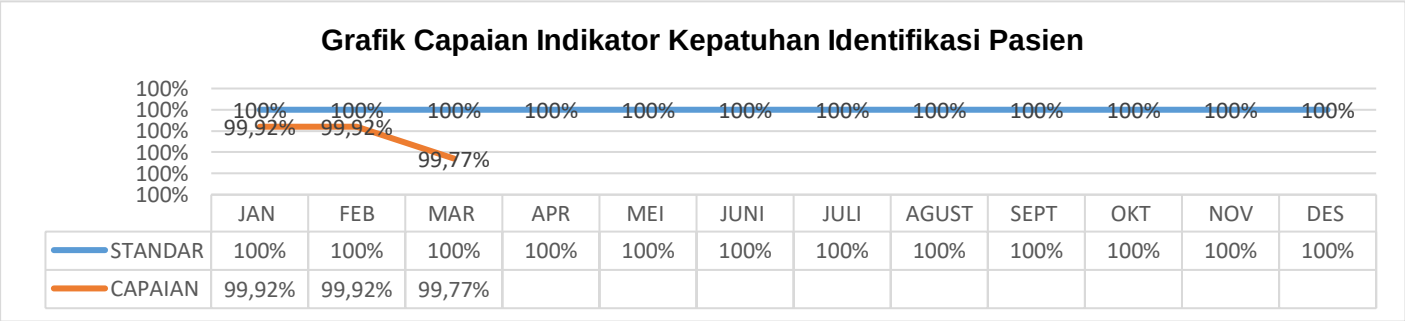
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung alat pelindung diri pada bulan Januari hingga MaretTahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.
DO	- Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. - Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. - Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. - Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). - Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter. - Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01%, dibulan Februari sebesar 93,06% dan capaian di bulan Maret yaitu 93,1%. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat

	yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan. Untuk petugas CS ditemukan masih menggunakan handscon medis untuk mengepel yang seharusnya menggunakan handscoon kerja.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	- Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. - Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. - Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. - Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. - Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. - Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.6.1.1.2 Kepatuhan Identifikasi Pasien

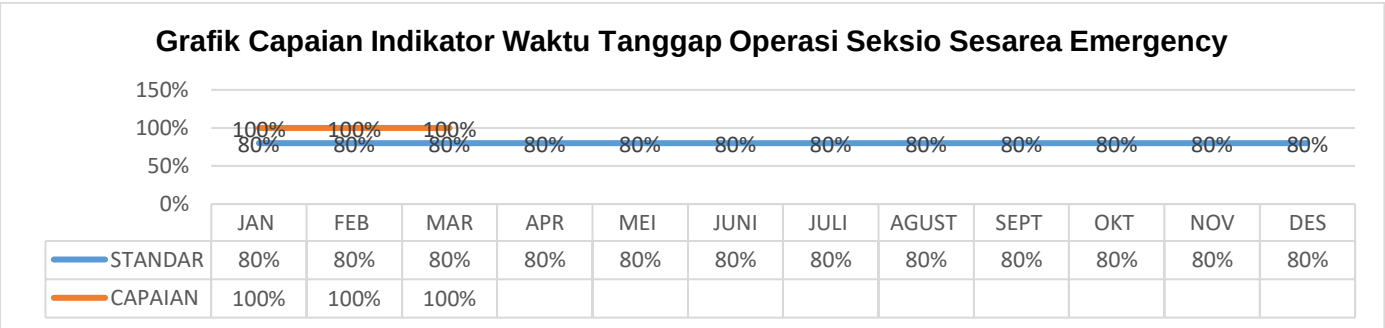
3.6.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pas



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Maret Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,92 %, pada bulan Februari sebesar 99,92% dan capaian di bulan Maret sebesar 99,77%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Terus melakukan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

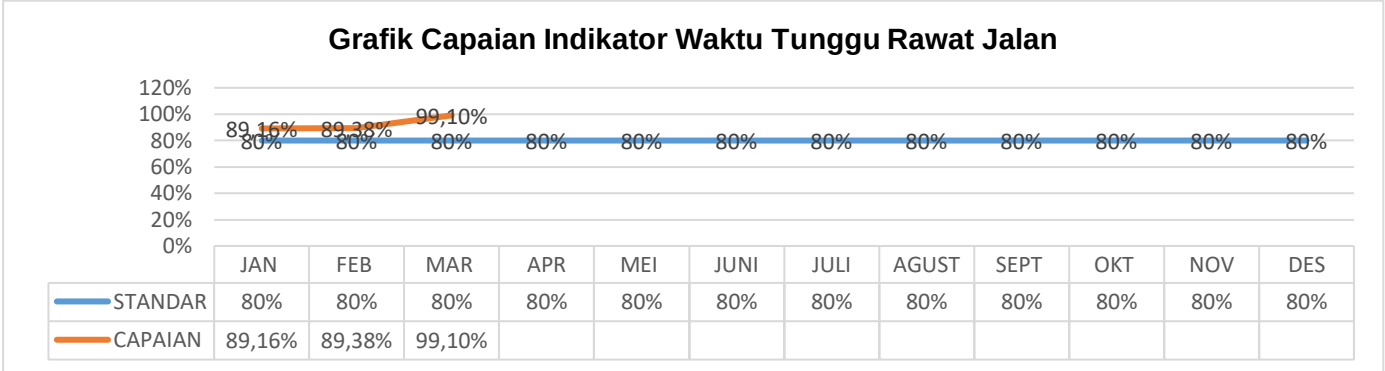
3.6.1.1.3 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari hingga Maret tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan

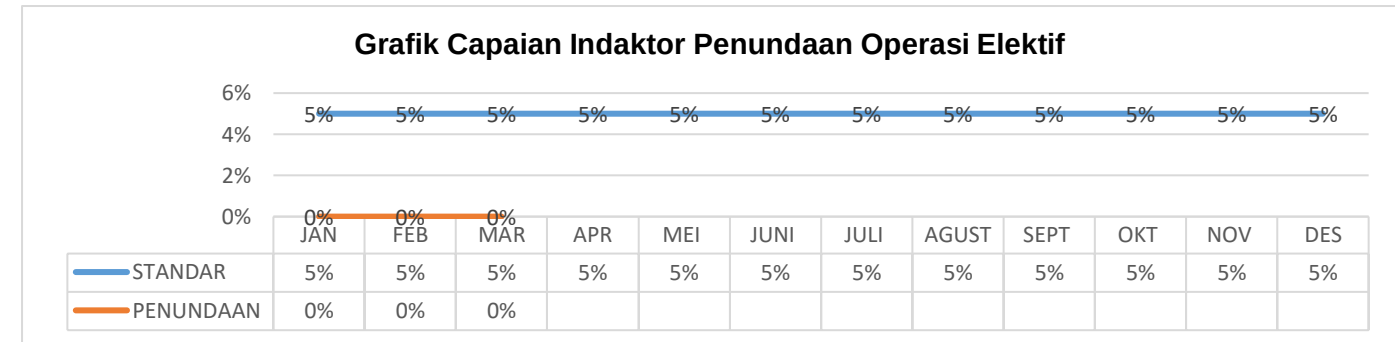
3.6.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian di bulan februari yaitu 89,16%, di bulan Februari 89,38% dan di bulan Maret 99,1%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dibulan berikutnya.

3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

3.6.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

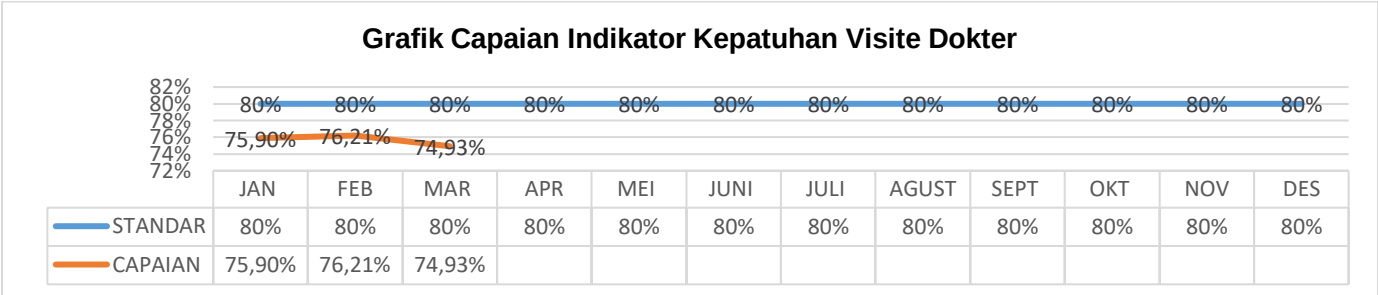


Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari hingga Maret tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 0%, hal ini kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.3 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

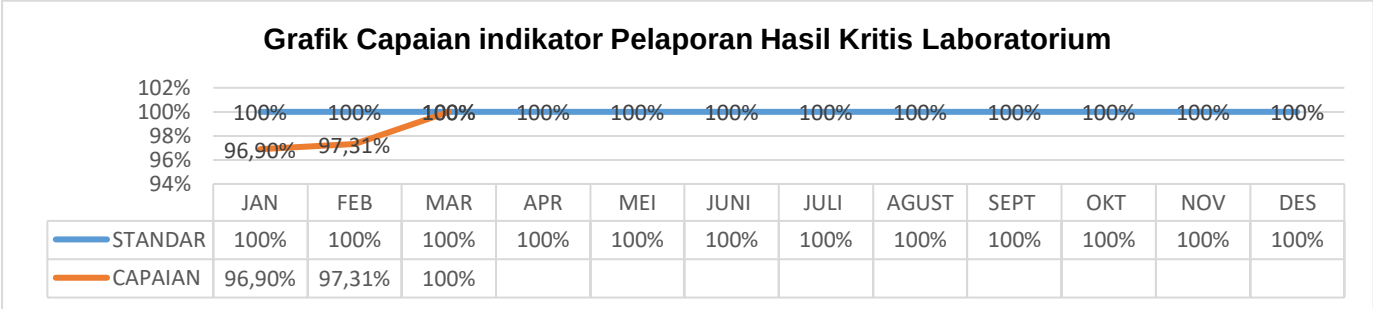


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari hingga Maret Tahun 2025 belum mencapai standart, hal ini disebabkan karena Seluruh dokter Klinisi di Rumah Sakit Prima Husada adalah dokter tamu dari luar, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9%, di bulan february 76,21% dan di bulan Maret sedikit menurun menjadi 74,93%. Dari hasil supervisi didapatkan nya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS asal karena RS Prima Husada belum memiliki dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr, dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr, dr. Aji, Sp.PD. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu), dr. Ardani, Sp.DP (tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Melakukan KIE dan komunikasi dengan DPJP terkait waktu visite dokter, hal ini menjadi PR yang cukup besar bagi tim mutu dan manajemen karena sebagian besar DPJP tidak hanya bertugas di RS Prima Husada.	Manajemen RS	Satu Bulan

3.6.1.1.7.2 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

3.6.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

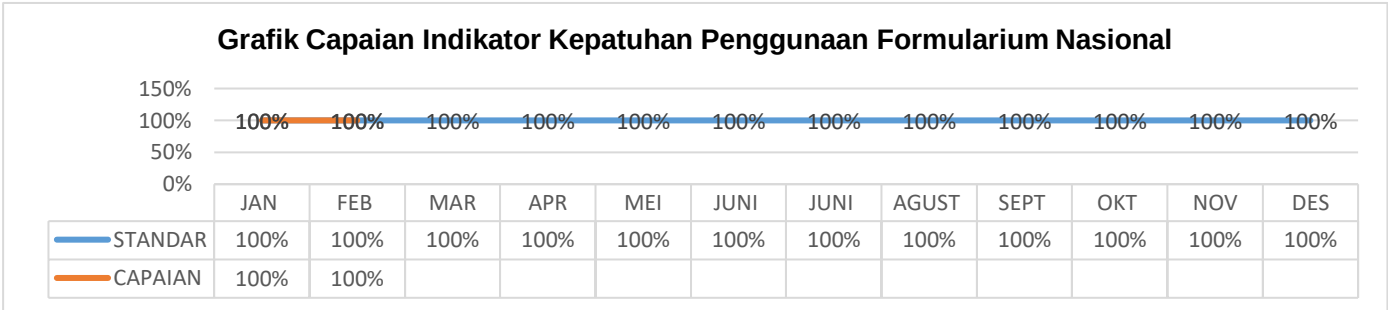


Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari dan Februari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart. Capaian meningkat pada bulan Maret yang telah mencapai standart 100%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 96,9% dan bulan Februari 97,31%. Capaian meningkat pada bulan Maret yang telah mencapai standart 100%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	- Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor - Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	- Komite mutu - Kepala instalasi laboratorium	Satu Tahun

3.6.1.1.4 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

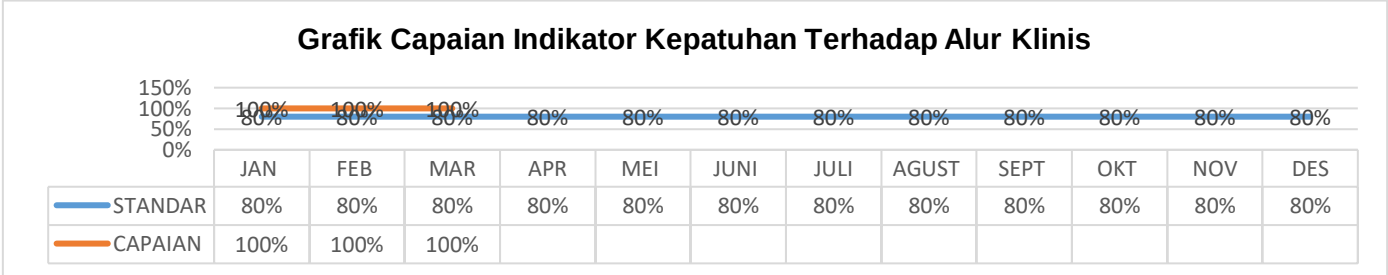
3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari hingga Maret tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.6.1.1.5 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

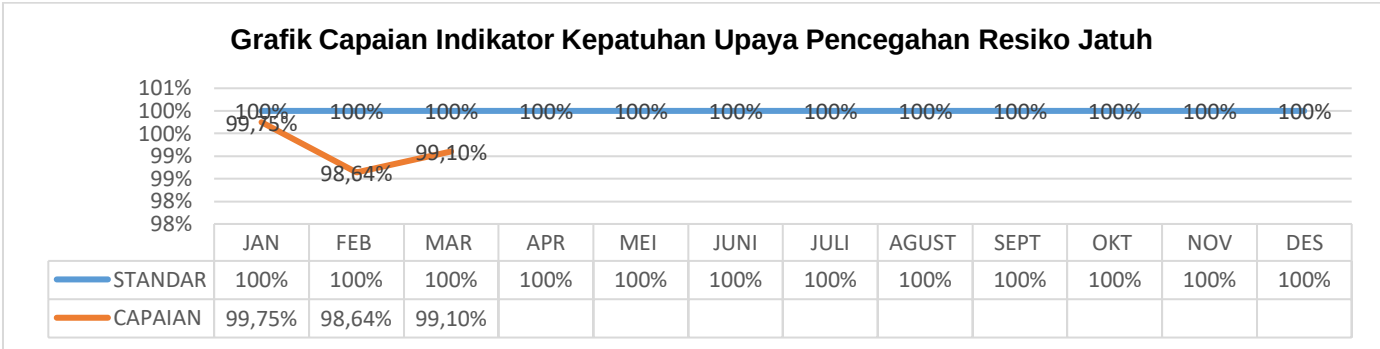
3.6.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari hingga Maret tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.6 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

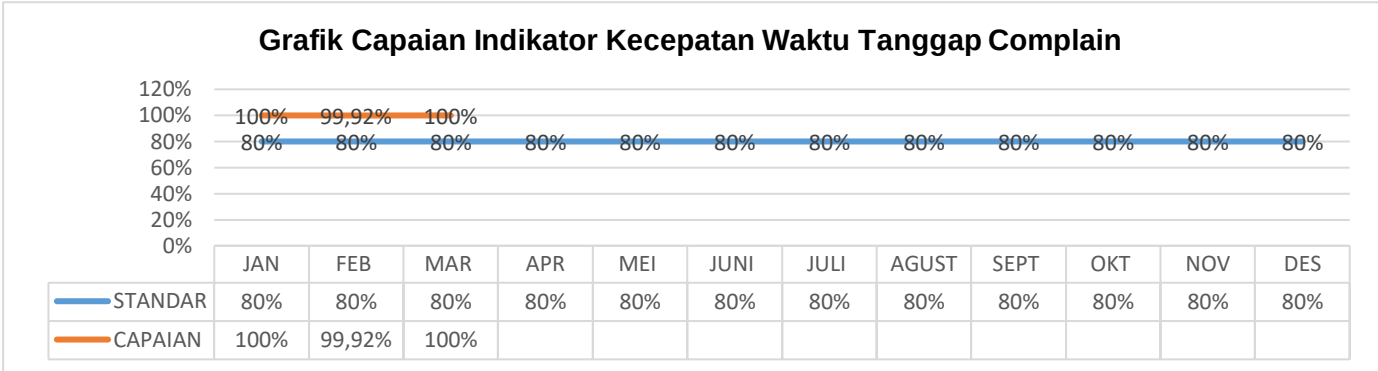


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Maret Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 99,75%, begitupun capaian di bulan Februari 98,64%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Melakukan supervisi berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu Bulan

3.6.1.1.7 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

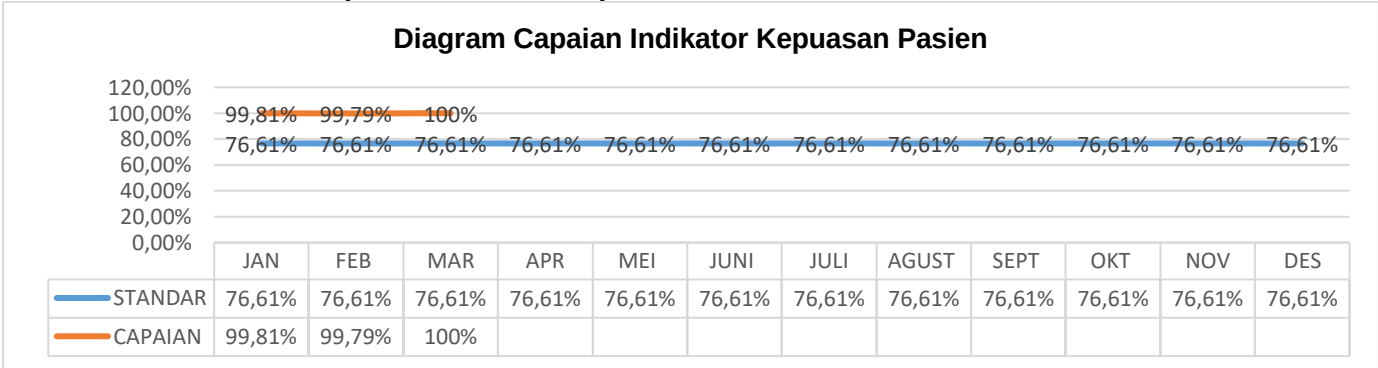
3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Dari grafik indikator waktu tanggap kompalian bulan Januari hingga Maret tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 80%, hal ini kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.12.2 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.12.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari hingga Maret tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepuasan pasien . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%										99,74%
2.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	100%	99,55%	99,92%	99,73%										99,73%
3.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi (IRNA,IGD,IKO)	100%	100%	100%	100%										100%
4.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										100%
5.	Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	0	0	0	0										0
6.	Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu di Waspadai / High Alert (Farmasi)	100%	100%	100%	100%										100%
7.	Kepatuhan penyiapan, pengelolaan, pemberian sesuai standar obat elektrolit pekat (Farmasi)	100%	100%	100%	100%										100%
8.	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur (IGD,IRNA,IKO)	100%	100%	100%	99,57%										99,85%
9.	Kepatuhan Pengisian Daftar Tilik Keselamatan Pasien Operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%										100%
10.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan) (IRNA,IRJA,IGD,IKO)	100%	98,64%	98,64%	99,32%										98,86%
11.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh	100%	98,64%	98,65%	98%										98,43
12.	Kepatuhan kebersihan tangan	85%	85,21%	85,35%	85,32%										85,29%

3.6.1.1.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis akut	100%	100%	100%	100%										100%
2.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%										100%

3.6.1.1.3 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%										

2.6.1.14 Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kesesuaiaan Penarikan Data SIMRS Dengan Data Manual Pada Laporan Unit	100%	80,39%	81,69%	82,73%										

1.6.1.2.5 Mutu Unit

1.6.1.2.5.1 Instalasi Gawat Darurat

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Batas waktu pasien menunggu tempat tidur kurang dari 6 jam (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	99,71%										
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,2%	98,36%	98,37%										
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%										
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%										
5.	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%										
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%										
7.	Kepuasan pasien	85%	97,36%	97,29%	100%										
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
9.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										
10.	Kepatuhan pelaporan pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										
11.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
12.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis di IGD	100%	100%	100%	100%										
13.	Angka tindak lanjut screening nyeri pasien di IGD	100%	100%	100%	100%										
14.	Angka kepatuhan triage untuk penyakit menular di IGD	100%	100%	100%	100%										
15.	Respon time IGD kurang dari 5 menit	100%	100%	100%	100%										
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	4,65%	3,7%	2,38%										
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%										

18.	Kepatuhan pemasangan gelang identitas pasien kurang dari 30 menit setelah pasien terdaftar rawat inap	100%	73,21%	73,32%	75,11%										
19.	Kejadian merujuk pasien berdasarkan aspek pilihan pasien	0	0	0	0										
20.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%										
21.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, anak, remaja, risiko bunuh diri)	100%	100%	100%	100%										
22.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%										
23.	Kegiatan merujuk pasien (horizontal)	0	1	4	3										

1.6.1.2.5.2 IRNA 2A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	-	-	-								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-								
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	6.	-	-								
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	-										
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	-	-	-								
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-								
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	-	-	-								
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	-	-	-								
9.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-								

10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	-	-	-								
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	-	-	-								
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	-	-	-								
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	-	-	-								
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	-	-	-								
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	-	-	-								
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	-	-	-								
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	-	-	-								
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	-	-	-								
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-								
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-								
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	-	-	-								
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	-	-	-								

3.6.1.2.6.3 IRNA 3A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	92,8%	94,7%	95,23%										
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	93,7%	94,5%	94,61%										
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%										
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	90,6%	89,82%	92,22%										
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-										
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	88,98%	100%	100%										
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	88,98%	100%	100%										
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%										
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	96,04%										
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%										
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajenen nyeri	100%	100%	100%	100%										

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%										
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	0										
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	0										
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%										
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	95,31%										
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0										
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%										
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.4 IRNA 4A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25		
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,72%	96,88%	97,12%										
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,6%	96,9%	96,7%										
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%										
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	88,98%	95,17%	96,38%										
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-										

7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	97,14%	100%	89,11%										
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	97,14%	100%	100%										
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%										
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%										
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%										
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%										
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-										
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-										
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%										
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	98,06%										

22.	Kejadian merujuk pasien (Hirizontal)	0	0	0	0										
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%										
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.5 IRNA 2C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,9%	97,5%	99,2%										
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	95,8%	97,3%	97,8%										
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%										
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	82,47%										
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-										
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	94,07%										
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	100%										
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%										
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										

13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%										
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%										
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%										
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-										
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-										
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%										
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%										
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0										
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%										
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.6 IRNA 3C ANAK

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,7%	97,1%	97,54%										
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,8%	96,1%	96,19%										
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%										
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	80,72%	100%										
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-										
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	88,1%	100%										
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	88,1%	100%										
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%										
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%										
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajenen nyeri	100%	100%	100%	100%										

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%										
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%										
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-										
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%										
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%										
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0										
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%										
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.7 IRNA 5C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	92,11%										
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,6%	99,8%	99,7%										
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,7%	99,1%	99,5%										
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%										
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	80,68%										

6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-										
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	100%										
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	97,27%										
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%										
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	98,71%										
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	88,24%										
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%										
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	75%										
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	92,64%										
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%										
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0,97%	1,06%	0,43%										
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%										
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%										

21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%										
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0										
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%										
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.8 IRNA 6A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,2%	90,3%	93,3%										
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,1%	97,3%	97,1%										
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%										
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	82,14%	78,72%	82,02%										
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-										
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%										
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%										
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%										
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										

12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%										
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%										
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%										
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,75%	0%	0,32%										
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%										
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%										
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%										
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0										
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%										
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.9 IRNA 7A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,98%	93,4%	96,12%										
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	87,24%	89,22%	92,33%										
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%										
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	80,58%	63,95%										
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-										
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%										
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%										
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%										
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%										
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajenen nyeri	100%	100%	100%	100%										

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%										
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,23%	0%	0,64%										
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%										
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%										
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%										
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	1	1										
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%										
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6. 10 IRNA 8A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agt'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	97,8%	99,8%	99,62%										
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	92,1%	95,6%	95,71%										
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%										
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	72,79%	82,52%										
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-										

7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%										
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%										
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%										
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%										
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%										
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%										
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%										
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%										
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%										
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%										

22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0										
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%										
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.11 ICU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89.9%	95,5%	97,7%										
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,2%	99,8%	99,6%										
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,64%	97,81%	100%										
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,72%	96,89%	100%										
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	92%	93,2%	88,2%										
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%										
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-										
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										

12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%										
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%										
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0										
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-										
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%										
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	93,33%										
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%										
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	92,37%										
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%										
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0										
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.12. HCU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	88,99%	96,22%	97,61%										
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,5%	99,2%	99,36%										
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,71%	98,92%	100%										
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,21%	96,71%	95,32%										
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	94%	97,1%	82,18%										
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%										
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-										
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%										
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%										

16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0										
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-										
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%										
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	100%										
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%										
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%										
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%										
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0										
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.13 IRJA

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian medis rawat jalan (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,2%	98,72%	99,02%										
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,35	98,71%	99,24%										
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,11%										

5.	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	89,16%	89,3%	99,11%										
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%										
7.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%										
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
9.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										
10.	Angka kelengkapan pengkajian keperawatan rawat jalan	100%	100%	100%	100%										
11.	Ketepatan waktu jam praktek dokter	100%	78,92%	77,8%	72,59%										
12.	Kejadian merujuk pasien	0	0	0	48										
13.	Angka kelengkapan inform concent	100%	100%	100%	100%										
14.	Angka kelengkapan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%										
15.	Kelengkapan profil pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.14 MATERNITAS

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kematian ibu (mutu prioritas unit)	0%	0%	0%	0%										
2.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%										
3.	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%										

4.	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	25,95%	24,56%	34,51%										
5.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%										
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%										
7.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%										
8.	Kejadian keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%										
9.	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%										
10.	Kejadian perdarahan post partum	0	0	2	5										
11.	Kejadian partus macet	0	0	0	13										
12.	Kejadian eklamsi	0	1	0	0										
13.	Kejadian pre eklamsi	0	5	2	4										
14.	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0										
15.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	13,6%	12,5%	18,75%										
16.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	13,6%	12,5%	18,75%										
17.	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	108	77	86										
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%										
19.	Kepuasan pasien	≥ 76,61	100%	100%	100%										
20.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
21.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										

22.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										
23.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%										
24.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
25.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%										
26.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										
27.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%										
28.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%										
29.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%										
30.	Angka kelengkapan pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%										
31.	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0	0	0	0										
32.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%										
33.	Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir	0	0	0	0										

3.6.1.2.6.15 NICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian kematian bayi (mutu prioritas unit)	0	0	1	2										
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	98,31%	99,02%	99,45%										
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,98%	99,79%	99,71%										

4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%										
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	85,11%	85,51%	81,18%										
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%										
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%										
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%										
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%										
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%										
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%										
17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%										
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%										
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%										

20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-										
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%										
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk NICU	100%	100%	100%	100%										
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	100%	100%	100%	100%										
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%										
25.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (neonatus)	100%	100%	100%	100%										
26.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0										

5.6.1.2.6.16 PICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (Anak) (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,23%	99,44%	99,44%										
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,11%	98,79%	98,79%										
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%										
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	100%	100%										
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%										
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%										

8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%										
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%										
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%										
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%										
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										
16.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%										
17.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%										
18.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-										
19.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%										
20.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk PICU	100%	100%	100%	100%										
21.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	0%	-	-	-										
22.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%										
23.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0										

3.6.1.2.6.17 IKO

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian tidak dilakukannya skiren pada pasien operasi yg seharusnya diskiren (mutu prioritas unit)	0	0	0	0										
2.	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%										
3.	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%										
4.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%										
5.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%										
6.	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	0	0										
7.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0										
8.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0										
9.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengkajian pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0										
10.	Kejadian diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0										
11.	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0										
12.	Kejadian tidak lengkapnya pengkajian pra bedah	0	0	0	0										
13.	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0										
14.	Kejadian ketidaklengkapan form daftar tilik pasien operasi	0	0	0	0										
15.	Kejadian Ketidakpatuhan Prosedur Pasien Yang Menggunakan Implan	0	0	0	0										

16.	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	00	0										
17.	Ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC	0	0	0	81,98%										
18.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan inform consent	100%	100%	100%	100%										
19.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis	100%	100%	100%	100%										
20.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%										
21.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%										
22.	Kepatuhan pencatatan pesan lewat telepon	100%	100%	100%	100%										
23.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%										
24.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%										
25.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%										
26.	Kepatuhan pelaksanaan asesmen nyeri	100%	100%	100%	100%										
27.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%										

28.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%										
29.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%										
30.	Kelengkapan Asesmen pra sedasi dan pra anastesi	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.18 Laboratorium

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian ketidaktersediaan Reagen esensial di laboratorium (mutu prioritas unit)	0	0	0	3										
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%										
3.	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%										
4.	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan	100%	100%	100%	100%										
5.	Survilen harian hemofiglen	100%	100%	100%	100%										
6.	Angka kepatuhan Prosedur penggunaan produk darah	100%	100%	100%	100%										
7.	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0										
8.	Waktu tunggu hasil laboratorium >140 menit	0%	0%	0%	0%										
9.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%										
10.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%										
11.	Kepatuhan Pelaporan Kritis Gula Darah	100%	100%	100%	100%										

12.	Angka kepatuhan pengelolaan POCT (proses pelaporan nilai kritis, kualifikasi)	100%	100%	100%	100%										
13.	Waktu tunggu hasil laborat cito <30 menit	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.19 Radiologi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,88%	100%	100%										
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	2,12%	3,54	5,5%										
3	Kepatuhan pelaporan nilai kritis hasil radiologi <30 menit	0	0	0	0%										
4.	Kepatuhan edukasi pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%										
5.	Angka kelengkapan inform consen pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%										
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%										
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.20 Gizi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian pasien baru tidak mendapatkan makan (mutu prioritas unit)	0	0	0	0										
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%										
3.	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0	0	4										
4.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0										
5.	Kelengkapan pengkajian gizi (awal dam lanjut)	100%	100%	100%	100%										

6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,44%	99,67%	99,21%										
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,01%	99,23%	98,92%										

3.6.1.2.6.21 Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketersediaan obat obatan emergency (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%										
3.	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%										
4.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0	0	1										
5.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0										
6.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,85%	61,98%	74,45%										
7.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	48,68%	44,17%	59,59%										
8.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	1										
9.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	2										
10.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0										
11.	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	2										
12.	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0										
13.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	20										
14.	Kejadian obat pasien rawat jalan yang tidak diambil	0	0	0	29										

15.	Kepatuhan penggunaan panduan antibiotik dan efektifitas jangka panjang dan jangka pendek	100%	100%	100%	100%										
16.	Kepatuhan penyimpanan obat obatan emergency disimpan secara seragam	100%	100%	100%	100%										
17.	Kepatuhan proses pengelolaan obat recal hingga pengembalian atau pemusnahan	100%	100%	100%	100%										
18.	Angka Kepatuhan pengelolaan obat kedaluwarsa	100%	100%	100%	100%										
19.	Angka Kepatuhan penyimpanan dan pengelolaan obat yang perlu di waspada	100%	100%	100%	100%										
20.	Kepatuhan penyimpanan, pengelolaan dan pemberian obat elektrolit pekat	100%	100%	100%	100%										
21.	Angka Kepatuhan peresepan dan interuksi medis	100%	100%	100%	100%										
22.	Angka kepatuhan dispensing	100%	100%	100%	100%										
23.	Angka kepatuhan pemberian obat	100%	100%	100%	100%										
24.	Angka kelengkapan pencatatan efek samping obat	100%	100%	100%	100%										
25.	Angka Kepatuhan Pelaporan Medication Error	100%	100%	100%	100%										
26.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%										
27.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	93,10%										
28.	Kepatuhan pelaksanaan panduan penggunaan single dose vial	100%	100%	100%	100%										
29.	Kepatuhan penggunaan risk based approach monitoring penggunaan obat	100%	100%	100%	100%										

30.	Angka kepatuhan pengkajian risiko penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah	100%	100%	100%	100%										
-----	---	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.6.22 Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0%	0%	0,42%										
2	Angka kepatuhan kolaborasi tim pengadaan obat	0%	0%	0%	100%										

3.6.1.2.6.23 PPI

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%	0,29%										
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰										
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 %	0‰	0‰	0‰										
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 %	0‰	0‰	0‰										
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%	0,23%										
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%										
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%	85,35%	85,32%										
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%	93,06%	93,1%										
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%	93,21%	93,27%										
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0										

3.6.1.2.6.24 PIPP

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%										

2.	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%										
3.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	100%	100%										
4.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	1005	100%										
5.	Kepuasan Pasien	76,61%	99,81%	99,79%	100%										
6.	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	14,12	18,94%	16,09%%										
7.	Angka Kepuasan Pasien BPJS	100%	99,9%	99,89	100%										
8.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%										
9.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.25 SDM

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	0										
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	78%	98,51%	98,69%										
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	37%	2,39%	1,91%										
4.	Angka pemenuhan kompetensi sesuai dengan unit	100%	100%	100%	100%										
5.	Angka kelengkapan file kepegawaian dimasing masing unit	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.26 Rekam Medis

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap (mutu prioritas unit)	100%	91,86%	29,3%	35,83%										

2.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0%	0,14%	0,23%	0,35%										
3.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat jalan	100%	91,86%	70,8%%	98,04%										
4.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien IGD	100%	100%	100%	90,25%										
5.	Kejadian Kendala Pada SIMRS Dalam Upaya Menunjang Pelayanan Rekam Medis Elektronik	0	0	0	0										
6.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien Di SIMRS	100%	100%	100%	100%										
7.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	7,56%	7,89%	9,56%										
8.	Angka keterbacaan dokumen rekam medis	100%	100%	100%	98,17%										

3.6.1.2.6.27 K3RS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%										
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	0	0										
3	Kejadian tenaga Kesehatan sakit akibat kerja	0	0	0	0										

3.6.1.2.6.28 Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim	0	0	0	0										
2.	Angka pending klaim BPJS	0%	3,05%	2,54%	3,23%										
3.	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	0,91%	1,9%	2,22%										
4.	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	98,99%	98,96%	99,26%										

5.	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	1	2	0										
----	------------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.6.29 IPSRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	46%	65%	78%										
2.	Angka keterlambatan respon dan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam (alat medis)	0%	97%	92%	94%										

3.6.1.2.6.30 UMUM

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	7	8	7										
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	10	8	2										

3.6.1.2.6.31 Cleaning Service

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	47,5%	59,26%	23,53%										
2.	Kejadian komplain Kebersihan Kamar Mandi	0%	0	0	0										
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	88,72%	91,33%	92,47										

4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	92%	94,07%	94,28										
----	--	------	-----	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.6.32 KESEKRETARIATAN

	No	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 4 setiap bulannya	0%	50%	40,48%											
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	27,27%	23,08%											
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	29,41%	29,41%											

3.6.1.2.6.33 Laundry

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	2,14%	1,78%	2,23%										
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0										
3.	Kejadian Tercampur Benda Asing	0	0	0	1										
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	98,82%	99,32%	99,04%										
5.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	97,23%	96,22%	96,48%										

3.6.1.2.6.34 CSSD

No	Judul	Stan	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0	0	0										
2	Kejadian instrument kurang	0	0	1	1										
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%										
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96,77%	97,11%	97,88%										

3.6.1.2.6.35 Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kunjungan rawat inap >90 pasien perhari	100%	98,71%	98,71%	99,86%										
2	Angka kunjungan rawat jalan >350 pasien perhari	100%	86,69%	93,82%	93,82%										
3.	Angka kunjungan pasien rencana operasi 15 pasien perhari	100%	92,34%	91,22%	92,46%										
4.	Angka kunjungan MCU dan vaksin 150 perbulan	100%	100%	98,82%	97,92%										

1.6.1.2.6.36 IT

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian downtime	0	0	0	0										
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%										
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.37 Kamar Jenazah

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%										
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-										
3.	Kepatuhan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.38 PKRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pelaksanaan edukasi kelompok	100	53,26%	68,38%	78,88%										

3.6.1.2.6.38 DRIVER

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Resptime Panggilan Driver < 10 menit On Side	100%	99,2%	99,68%	99,88%										
2	Resptime Panggilan Driver < 30 menit On Call	100%	100%	99,92%	99,82%										
3	Kepatuhan pemeliharaan alat transportasi	100%	100%	100%	100%										
4	Angka kelengkapan alat emergency untuk ambulance emergency	100%	100%	100%	100%										
5	Kepatuhan pelaksanaan decontaminasi pasca transport pasien menular pada ambulance	100%	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.39 SECURITY

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya merokok, puntung rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit)	0	6	11	7										
2	Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit	0	0	0	0										
3	Kejadian potensial barang hilang	0	7	9	13										
4	Kejadian kekerasan di lingkungan RS	0	0	0	0										

1.6.2 Komite PPI

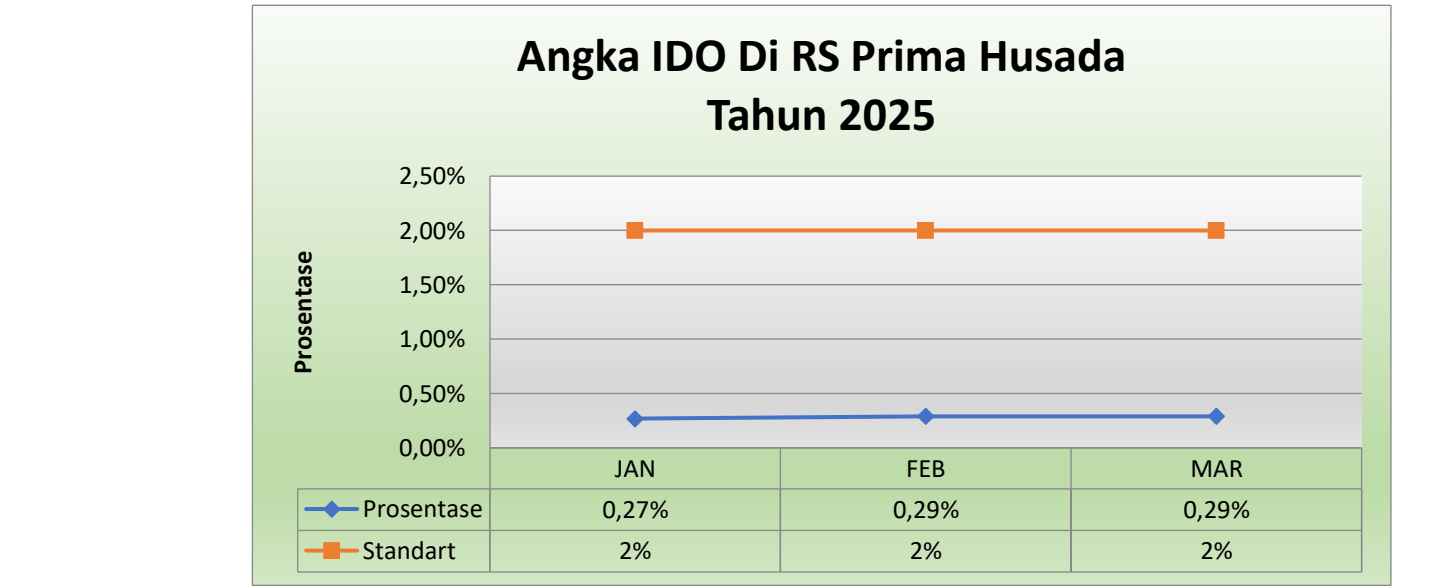
1.6.2.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.2.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Jenis Tindakan Operasi di RS	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Tindakan Operasi	Insiden (%)
Bedah Orthopedi	0	60	0%
Seksio Sesaria	1	51	1,96%
Apendiktomi	0	3	0%
Herniotomi	0	12	0%
Katarak	0	43	0%
CABG	-	-	-
Tumor Payudara	0	14	0%
Semua Operasi	1	341	0,29%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	Dari grafik diatas diperoleh data terdapat kejadian IDO pada 1 orang pasien yang menjalani operasi laparatomy. Dari hasil assesmen pasien diperoleh data bahwa pasien berusia 37 tahun. Saat kontrol hari 1, ditemukan kondisi luka basah dan keluar darah bercampur puss. Pasien belum sempat melakukan perawatan luka sebelumnya dan luka tidak dibuka sama sekali setelah operasi. Dari hasil assesmen diperoleh data bahwa pasien sudah melakukan mandi sebelum operasi (3 jam sebelum op). Selain itu, dari hasil laboratorium tidak menunjukkan adanya kondisi anemia maupun leukositosis, justru leukosit membaik dari yang awalnya 11.530 menjadi 10.160. Pasien saat operasi berada pada urutan ke 3 penggunaan IKO 1 setelah pasien bedah plastik, dengan jeda proses pembersihan 30 menit. Dari hasil assesmen pasien juga diperoleh data bahwa pasien terek makan dan hanya memakan makanan yang rendah protein dan lebih percaya pada tetangganya yang melarang makanan kaya protein seperti telur, ayam, dll.				
Masalah saat ini	1. Belum adekuatnya edukasi perawatan pasien pasca operasi terutama perawatan saat dirumah termasuk nutrisi yang harus dipenuhi untuk mempercepat penyembuhan luka.				
Permasalahan sebelumnya	2. Masih belum berjalannya secara rutin terkait anjuran pasien untuk melakukan mandi sebelum operasi baik itu operasi elektif maupun cyto.				
Tindakan yang dilakukan	3. Monitoring proses edukasi pasien pasca operasi terutama pemahaman pasien dan keluarga terhadap nutrisi tubuh yang harus dipenuhi. 4. Koordinasi dengan ahli gizi untuk memastikan pasien dan keluarga paham terkait diet pasien operasi dan tidak menghiraukan pernyataan-pernyataan mitos diluar terkait terek makan. 5. Monitoring proses edukasi tambahan pada pasien yang terjadi IDO, untuk tidak khawatir jika terdapat penyakit penyerta dan konsultasi dengan DPJP untuk mendapatkan terapi yang sesuai untuk membantu mempercepat pemulihan. 6. Mengajukan petugas IKO untuk menjadwalkan penggunaan kamar operasi dan mendahulukan pasien dengan kategori operasi bersih terlebih dahulu dan memperhatikan jeda waktunya. 7. Mengajukan petugas unit untuk tetap melakukan edukasi/tindakan memandikan pasien (diseka) dengan sabun antiseptic sebelum pasien dilakukan operasi. 8. Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai di ruang perawatan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Lanjutkan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan pasien di rumah	Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	Pasien post operasi.	1. Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. 2. Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-pesan-media-feed back)	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/PCN	Satu bulan

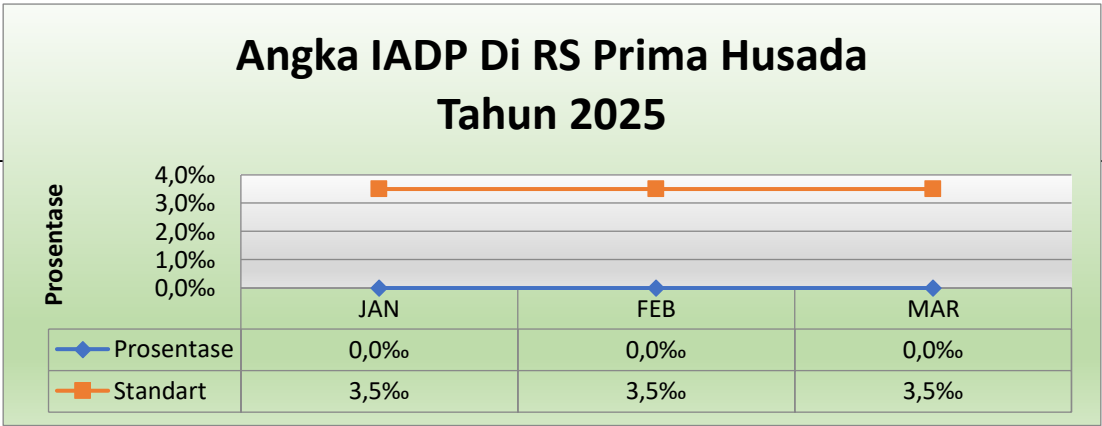
			3. Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. 4. Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.		
Memastikan bundle IDO berjalan dengan baik.	Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	Pasien operasi	1. Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi. 2. Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. 3. Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik)	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes

Ruang	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian CVC	Insiden (%)
ICU	0	37	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.2.2 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



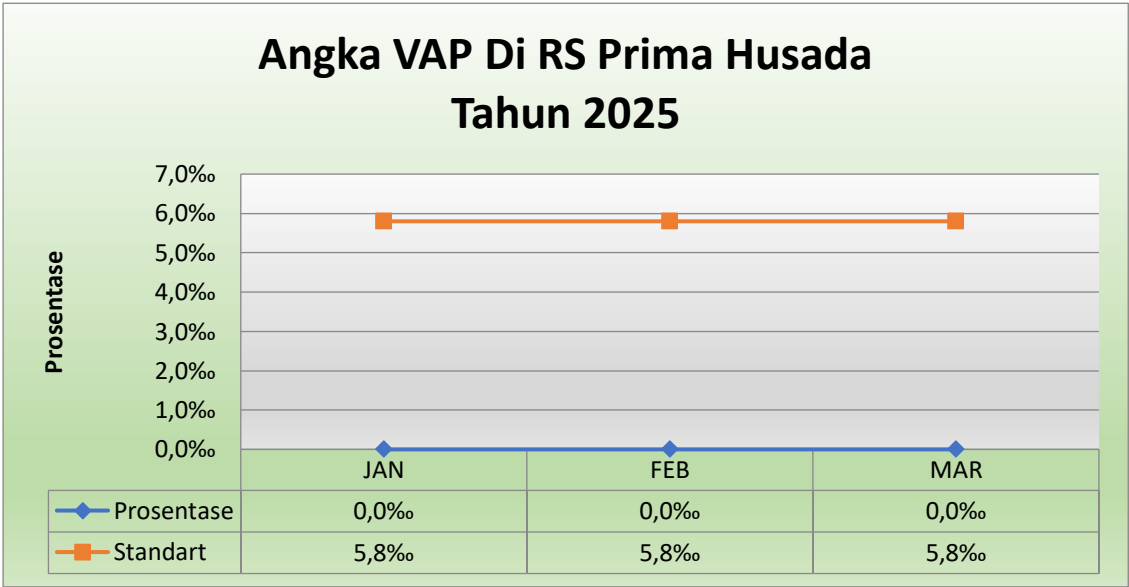
Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 6 hari total lama pemasangan CVC pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. 2. Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Melakukan monitoring 5. perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.3 VAP

3.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	VAP		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (%)
ICU	0	59	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 2 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. 2. Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. 3. Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. 4. Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. 5. Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

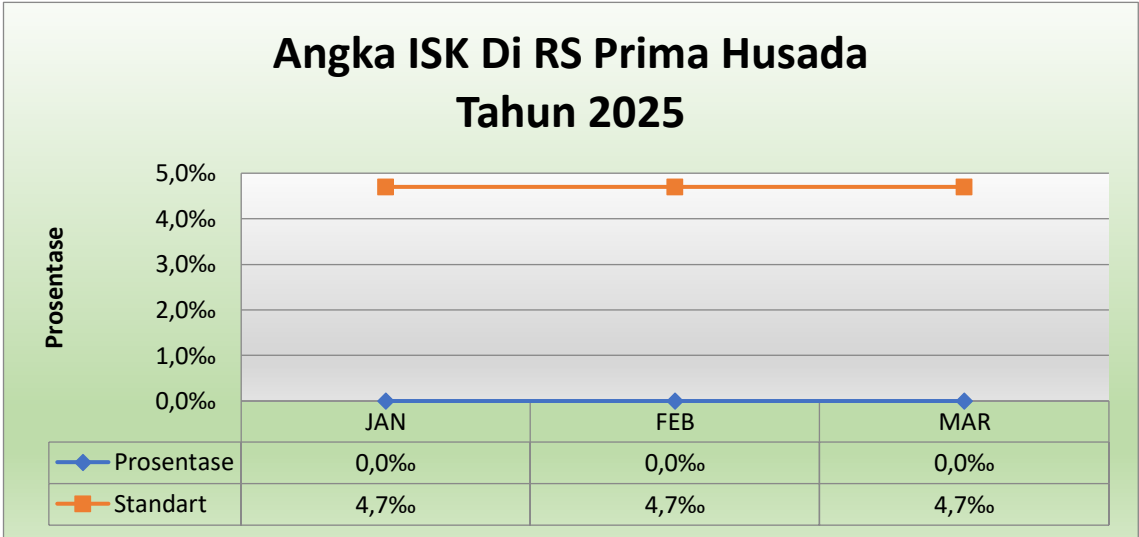
			5. Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. 6. Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.4 ISK

3.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR
 ((Pelaporan INM dan HAI^s Kemenkes)

Ruang	ISK		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (‰)
ICU	0	281	0‰
HCU	0	37	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.4.2 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)

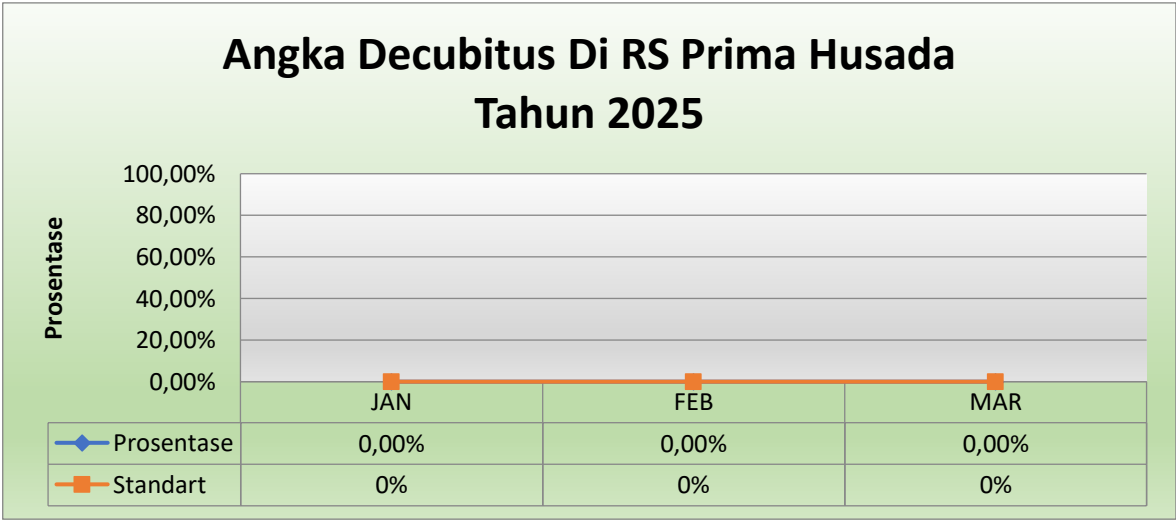


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1038 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan
-----------------------------------	--	-------------------------------	---	---	------------

3.6.1.1.5 Decubitus

3.1.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus

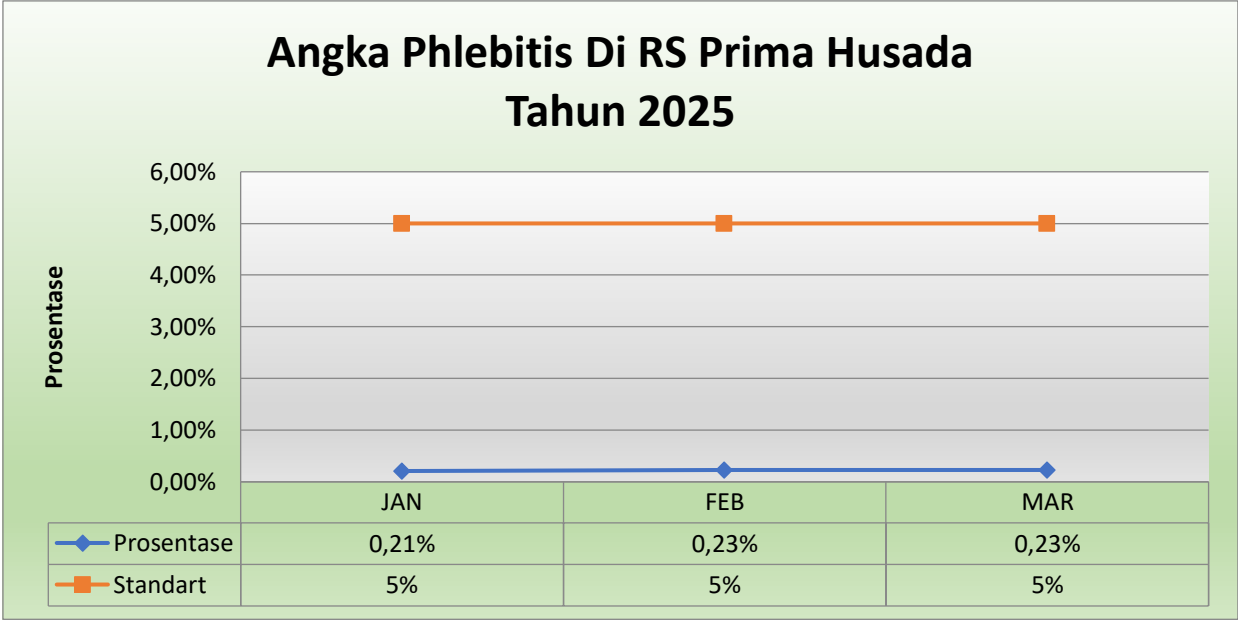


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 9 pasien tirah baring lama.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi decubitus				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi decubitus				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 4. Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
---	--	--	--	--	------------

3.6.1.1.6 Phlebitis

3.6.1.1.6.1 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

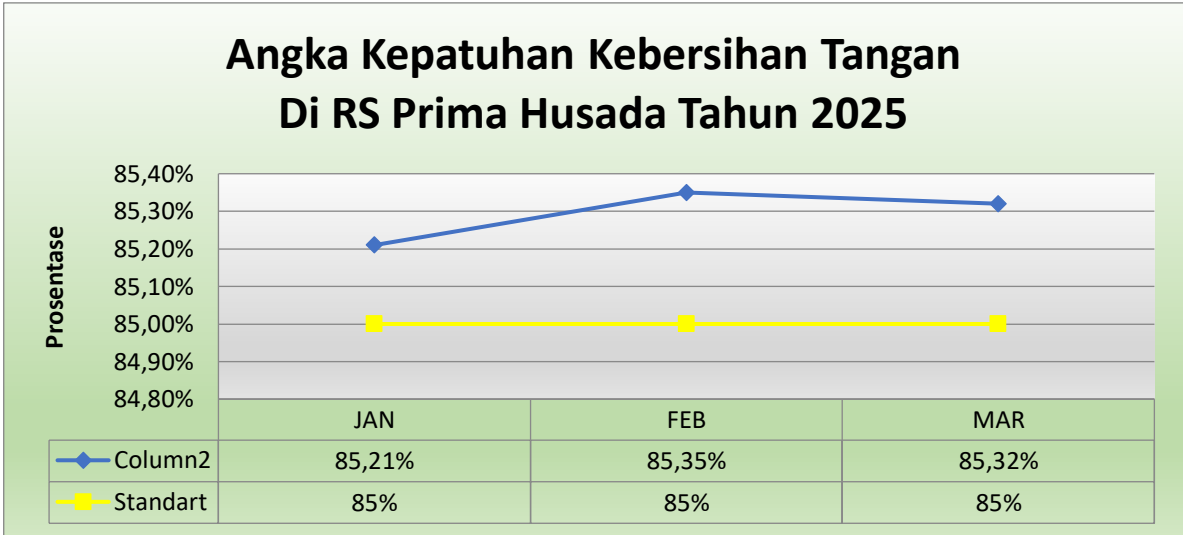


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2654 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,23%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh, 6 pasien yang mengalami phlebitis, 4 diantaranya merupakan pasien berusia 50 tahun lebih dan 1 pasien batita dengan kondisi pembuluh darah sangat beresiko pecah. 2 diantara keenam pasien tersebut mengalami phlebitis karena mendapatkan cairan pekat KCL dan 1 pasien dengan transfuse PRC 2 labu dengan 1 jalur infus saja, selain itu pasien juga masih mendapatkan obat-obatan injeksi lainnya seperti antibiotic. Kebanyakan kejadian phlebitis terjadi di ruang perawatan 1 hari setelah pemasangan (OB) dari IGD dan setelah mendapatkan cairan pekat tersebut. Dari 5 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
Masalah saat ini	Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian produk darah.				
Permasalahan sebelumnya	Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, seperti D5% dan D10% yang memang rutin diberikan melalui infus.				
Tindakan yang dilakukan	1. Menganjurkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. 2. Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan transfuse darah pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. 3. Menganjurkan perawat untuk memilih iv canula yang sesuai dengan kebutuhan pasien (lihat besarnya pembuluh darah & rencana pengobatan yang akan diberikan, usahakan menggunakan iv canula ukuran besar).				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

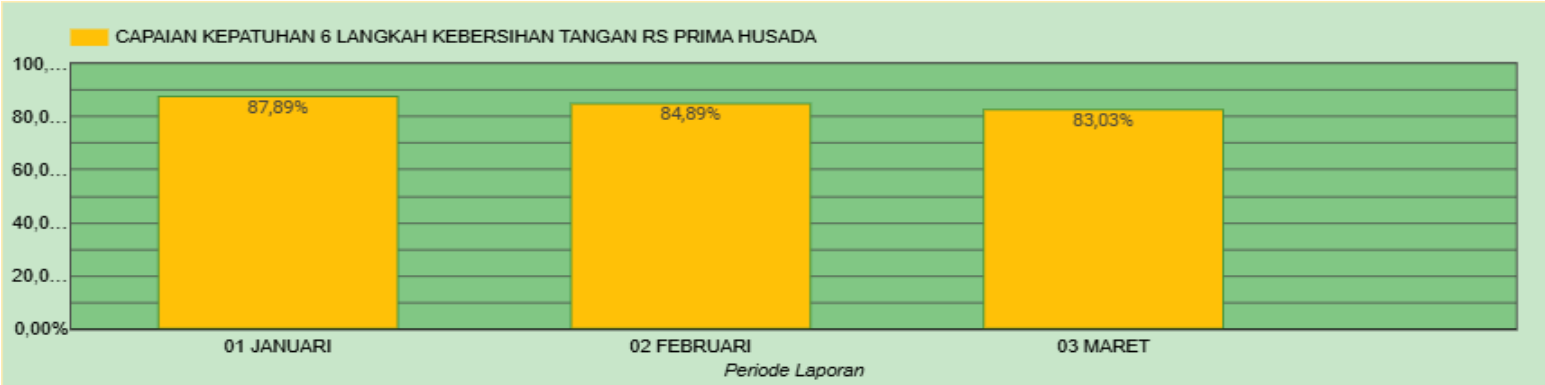
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	1. Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. 2. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. 3. Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. 4. Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. 5. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. 6. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. 7. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 8. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan
---------------------------------------	---	-----------------------------	--	---	------------

3.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

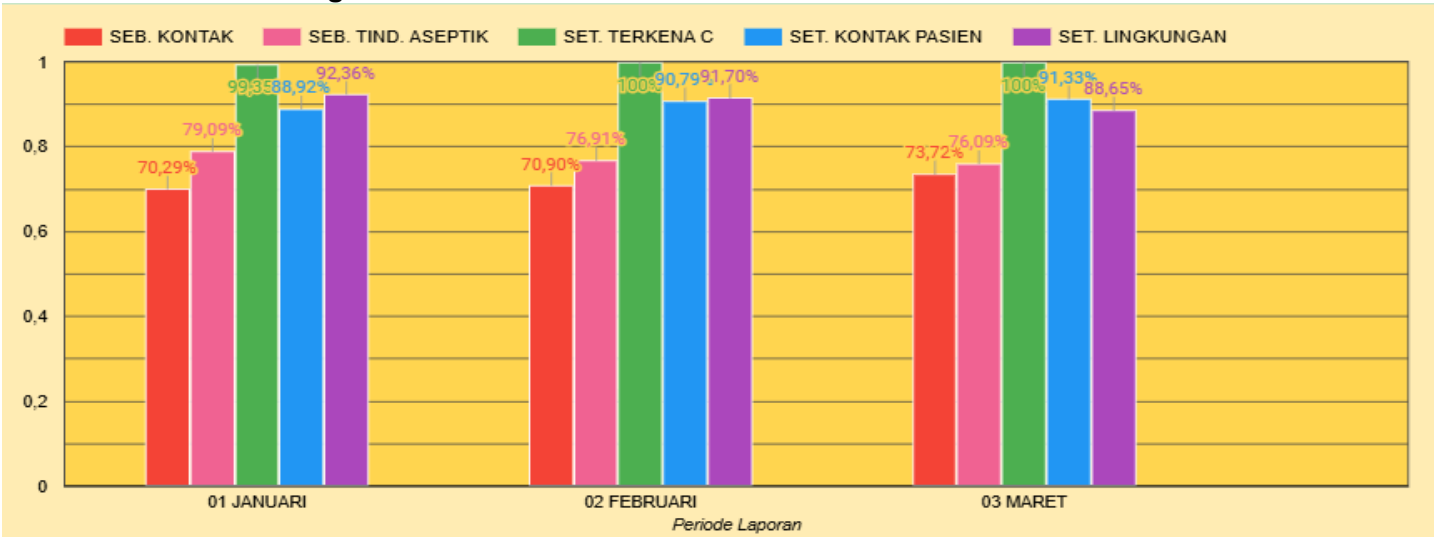
3.6.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan

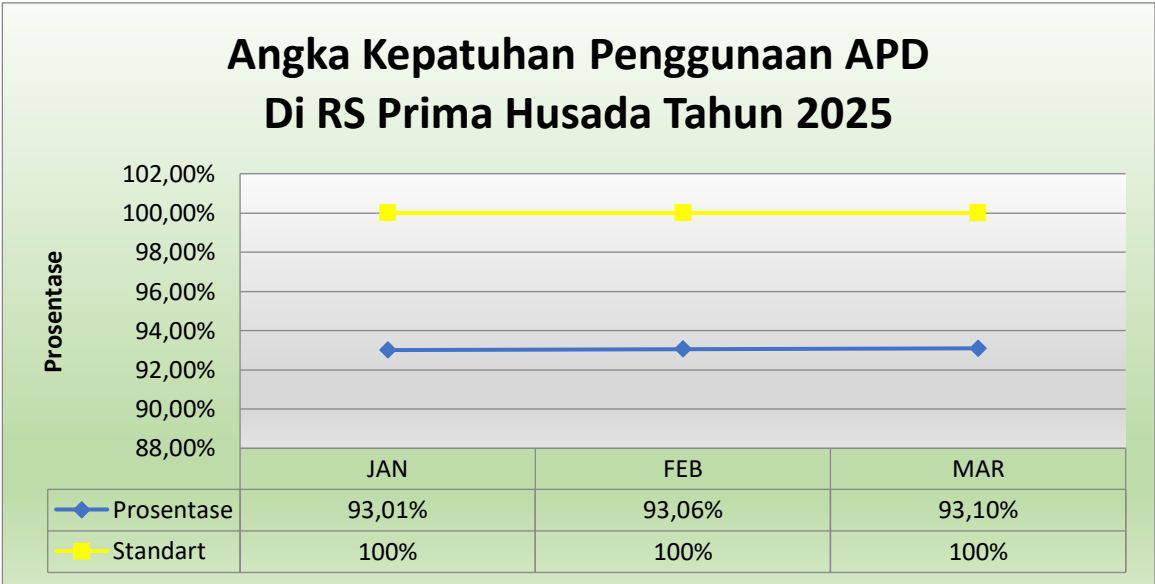


Analisa	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,32%. Masih belum bisa mencapai target 100% karena memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan cuci tangan terutama pada momen sebelum kontak pasien (73,72%) dan sebelum melakukan tindakan aseptik (76,09%). Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Dilihat dari segi kepatuhan 6 langkah cuci tangan, 83,03% dari petugas dapat melakukan 6 langkah cuci tangan dengan baik. Namun memang karena belum menjadi kebiasaan dari petugas sehingga masih ada yang tidak urut melaksanakan 6 langkah cuci tangannya.				
Masalah saat ini	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa).				
Permasalahan sebelumnya	Kurangnya kesadaran petugas terhadap pentingnya cuci tangan dan persepsi kebersihan tangan yang salah.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. 3. Memberikan proses pembelajaran dengan membuat video pendek edukasi cuci tangan supaya lebih mudah untuk mengingat. 4. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
---------------------------------	---	----------------------------------	--	--	------------

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas

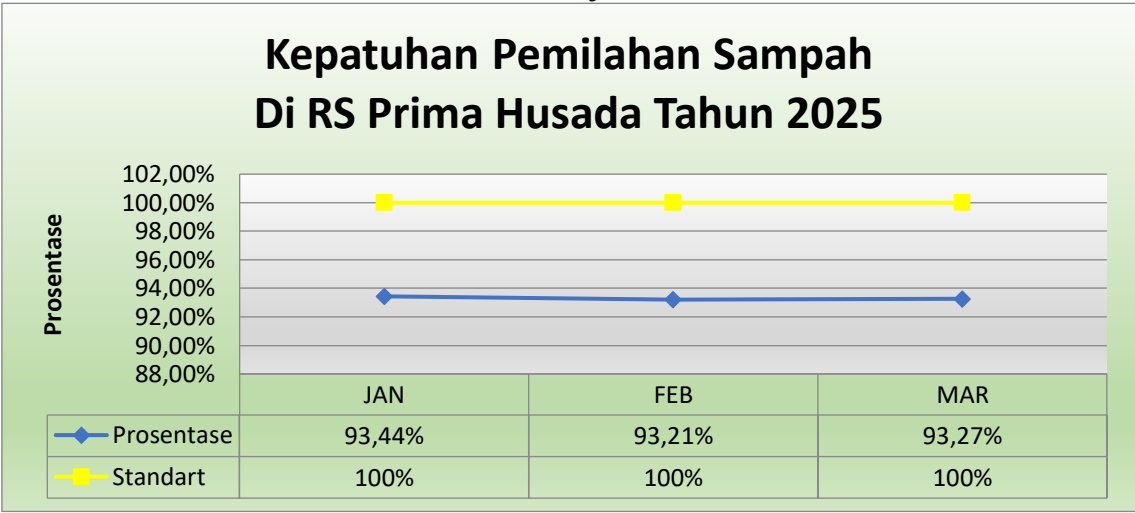


Analisa	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,1%. Dari hasil monitoring dan supervise, terjadi sedikit peningkatan kepatuhan pemakaian APD, kepatuhan petugas nakes dalam pemakaian APD sudah baik, namun tidak pada dokter DPJP yang sering berlebihan memakai APD, seperti visite saja namun memakai APD lengkap mulai skort masker, nurse cap, dan sarung tangan. Selain itu, terdapat peningkatan pada petugas CS yang biasanya masih memakai handscoon untuk bersih-bersih, saat ini sudah menggunakan sarung tangan kerja. Penggunaan APD pada petugas penjamah makanan juga mengalami peningkatan semenjak dilakukannya resosialisasi terkait hygiene penjamah makanan.
Masalah saat ini	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi dengan mementingkan keuntungan pemakaian APD pribadi dan tidak melihat kerugiannya pada orang lain.
Permasalahan sebelumnya	Petugas masih belum bisa membiasakan dengan kebiasaan baru yang benar dan lebih memilih diam-diam menjalankan kebiasaan yang salah.
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM).

	5. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 6. Melarang perawat untuk memberikan handscoon jika ada CS yang meminta untuk membersihkan ruangan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidak disiplin petugas dalam pemakaian APD. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 5. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.9 Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

3.6.1.1.9.1 Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan

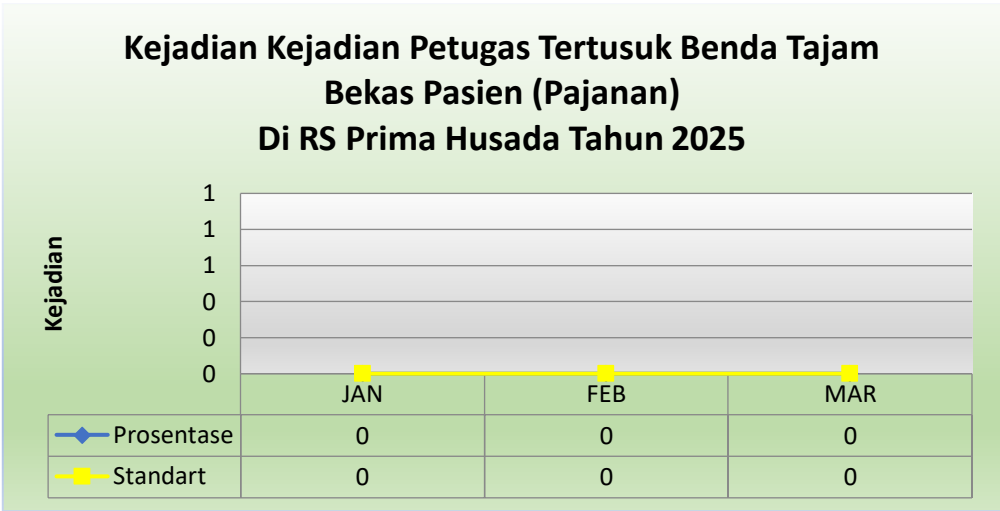


Analisa	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,27%. Dari hasil monitoring dan supervise, memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan pemilahan dengan baik saat terutama pembuangan bungkus sput, bungkus alkohol swab dan pembuangan tissue pada safety box baik di unit IGD, IRJA, maupun IRNA.
Masalah saat ini	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius.
Permasalahan sebelumnya	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius.
Tindakan yang dilakukan	1. Menganjurkan menyiapkan kresek hitam dan kresek kuning pada saat akan melakukan tindakan yang sekiranya akan menghasilkan banyak sampah non infeksius dan infeksius atau bengkok.

	- Memberikan proses pembelajaran langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar. - Melakukan monitoring pemilahan sampah saat melakukan tindakan. - Melakukan supervisi pada tempat sampah yang ada di unit-unit. - Menjelaskan terkait proses pembayaran saat membuang sampah infeksius pada pihak ke-3 tergantung dari berat timbangan sampah, untuk menyadarkan bahwa kesalahan pembuangan sampahnya dapat merugikan rumah sakit.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	- Lakukan edukasi ulang pada staf tentang pemilahan sampah. - Berikan proses pembelajaran pada petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan. - Sampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun grup WA (untuk menciptakan efek jera).	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Tidak ditemukan kejadian pajanan.				
Masalah saat ini	Tidak ada kejadian pajanan.				
Permasalahan sebelumnya	Safety box tidak standar, tembus tusukan jarum.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pemilahan sampah khususnya benda tajam pada saat melakukan tindakan. 2. Melakukan monitoring kerapian dan kebersihan troli tindakan untuk segera dibersihkan setelah tindakan dan tidak meninggalkan jarum/benda tajam terbuka di troli tindakan. 3. Melakukan monitoring teknik recapping saat menutup jarum saat menyiapkan obat pasien. 4. Sudah diajukan telaah penggantian safety box, dengan melampirkan kejadian pajanan namun tidak ada penggantian safety box.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan proses pemilahan sampah yang benar dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. 2. Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. 3. Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

			APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. 5. Monitoring teknik recapping tutup jarum.		
--	--	--	--	--	--

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

NO	UNIT	TARGET	DES	JAN	FEB	MAR	%	MANDOK	KETERANGAN
1	IRNA 2C	8x/Bulan	100%	100%	50%	100%	Menurun	Ada	
2	ICU HCU	8x/Bulan	0%	0%	0%	50%	Menurun	Ada	
3	IRNA 3C	8x/Bulan	100%	100%	50%	100%	Menurun	Ada	
4	MATERNITAS	8x/Bulan	100%	100%	75%	100%	Menurun	Ada	
5	PERINATOLOGI	8x/Bulan	100%	100%	75%	100%	Menurun	Ada	
6	IRNA 5C	8x/Bulan	100%	100%	50%	100%	Menurun	Ada	
7	IRNA 2A,3A,4A	8x/Bulan	75%	75%	25%	100%	Menurun	Ada	
8	IRNA 6A,7A,8A	8x/Bulan	100%	100%	75%	50%	Menurun	Ada	
9	IGD	8x/Bulan	25%	0%	100%	100%	Tercapai	Ada	
10	FARMASI	8x/Bulan	100%	100%	25%	100%	Menurun	Ada	
11	GIZI	8x/Bulan	75%	50%	100%	100%	Tercapai	Ada	
12	IRJA	8x/Bulan	100%	100%	50%	100%	Menurun	Ada	
13	PPI		100%	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	

- Analisis**
 : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Maret Petugas PKRS tiap unit sudah melakukan kegiatan dengan baik , dari data tersebut Unit ICU/HCU mulai melaksanakan Edukasi Kelompok dengan peresentasi 50%, untuk Unit IRNA 6A,7A,8A, mengalami penurunan di bulan Maret 2025.
- Rencana Tindak Lanjut**
 : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan Maret.

3.6.3.2 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	%	MANDOK	KET
Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	Dilaksanakan 1x, karena dibulan puasa dan diganti dgn senam diabet dan seminar
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	50%	100%	0%	Tidak Tercapai	Ada	Libur Puasa
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	100%	Ada	
General Meeting	1x/2Bulan		0%	100%	0%	Tidak Tercapai	Terlaksana	

Karyawan								
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.3 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

NO	UNIT	TARGET	JAN	FEB	MAR	%	MANDOK	KETERANGAN
1	PONEK	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
2	HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
3	STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
4	KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
5	TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	

Analisis

: Bulan Maret PROGNAS TB DOTS tercapai, tetapi untuk lain masih belum terlaksana.

Rencana Tindak Lanjut

: Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

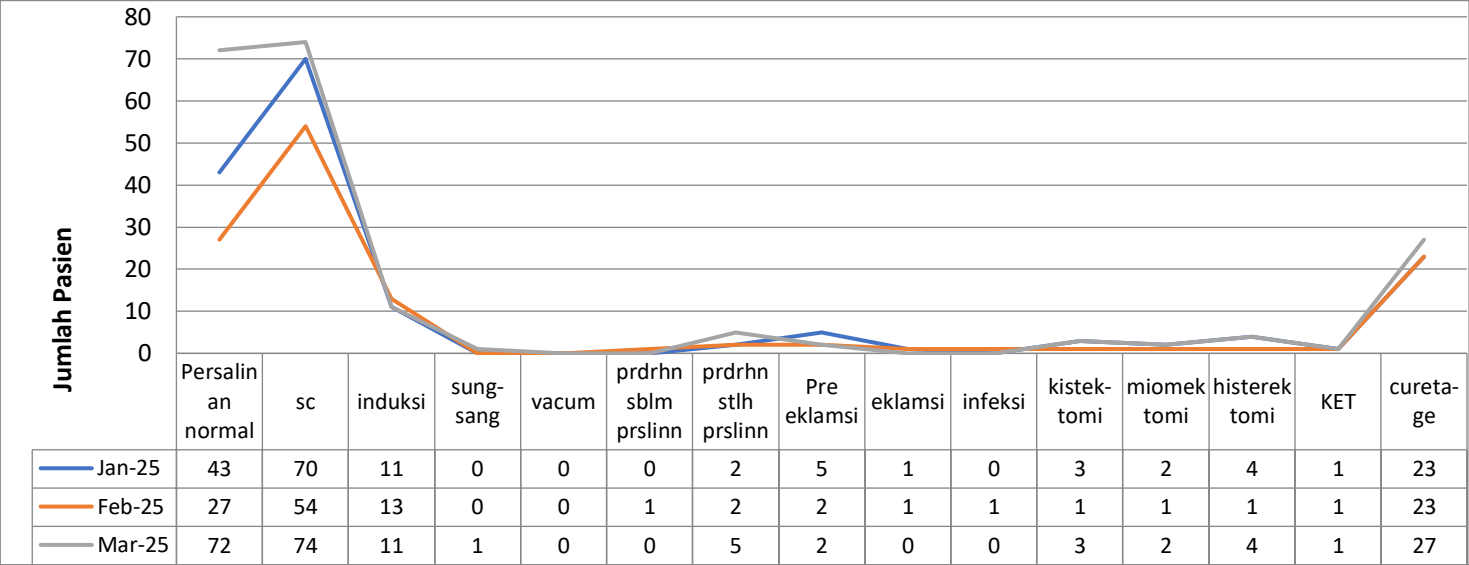
3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Maret 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	43	27	72
	b. <i>SectioCaesaria</i>	73	54	74
2				
	a. Induksi / Drip	11	13	11
	b. Sungsang	0	0	1
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	1	11
	b. Perdarahan setelah Persalinan	2	2	1
	c. Pre Eklamsi	5	2	0
	d. Eklamsi	1	1	11
	e. Infeksi	0	1	1
4				
	a. Curretage	23	23	27
	b. Kistektomi	3	1	3
	c. Miomektomi	2	1	2
	d. Histerectomy	4	1	4
	e. KET	1	1	1

1.6.2.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Maret 2025



- Analisis :**
1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Maret 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 74 pasien. Dan untuk persalinan normal pada bulan Maret 2025 juga mengalami peningkatan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 72 persalinan. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
 2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
 3. Persalinan dengan sungsang pada bulan Maret sebanyak 1 pasien, dan tidak ada persalinan dengan sungsang pada bulan Januari dan Februari 2025. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Maret 2025 dan 2 bulan sebelumnya.
 4. Induksi Persalinan pada bulan Maret mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 11 pasien
 5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Maret 2025 sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Maret 2025, sedangkan pada 2 bulan sebelumnya ada 1 kejadian.
 6. Jenis pelayanan curretage di bulan Maret 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 27 pasien. *Curetage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynecology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
 2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.

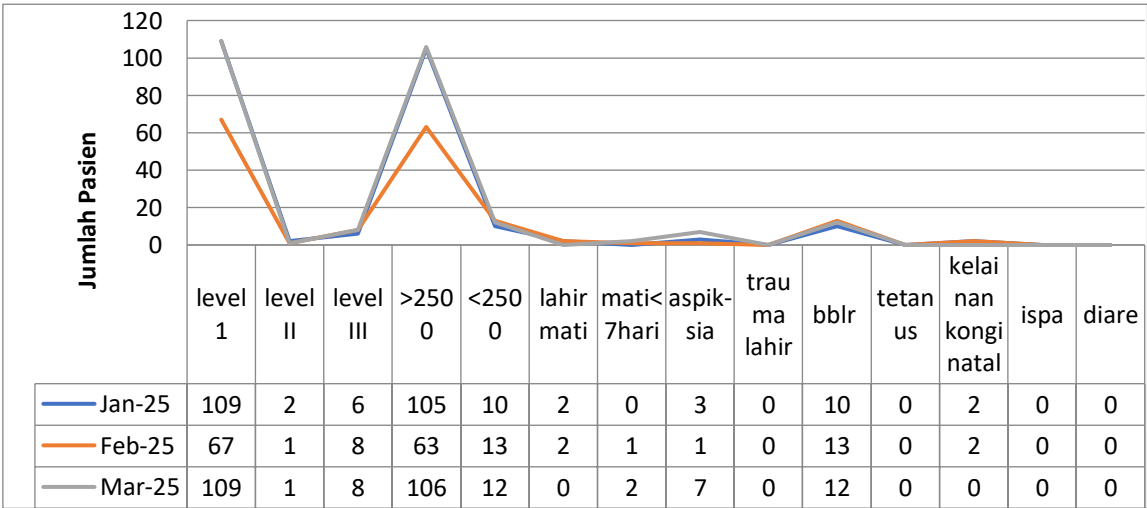
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.6.4.1.2 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.2.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponpek Maret 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1				
	a. Level 1	109	67	109
	b. Level II	2	1	1
	c. Level III	6	8	8
2				
	a. ≥ 2500 gram	105	63	106
	b. ≤ 2500 gram	10	13	12
3				
	a. Kelahiran Mati	2	2	0
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	0	1	2
4				
	a. Asphyxia	3	1	7
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	10	13	12
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	2	2	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

1.6.2.1.2.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Maret 2025



Analisis :

- 1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Maret 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 109 bayi. Dan pada level 2 sama dengan bulan sebelumnya yaitu 1 bayi. Dan pada level 3 juga sama dengan bulan sebelumnya yaitu 8 bayi.

- 2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Maret 2025 mengalami peningkatan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 106 bayi.
- 3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Maret 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 12 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
- 4. Kasus BBLR pada bulan maret 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 12 bayi.
- 5. Tidak ada kasus kelahiran mati pada bulan Maret 2025, sedangkan pada 2 bulan sebelumnya sebanyak 2 kasus
- 6. Ada 2 kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Maret 2025, sedangkan pada bulan Februari sebanyak 1 kasus, dan tidak ada kasus kematian bayi pada bulan Januari 2025

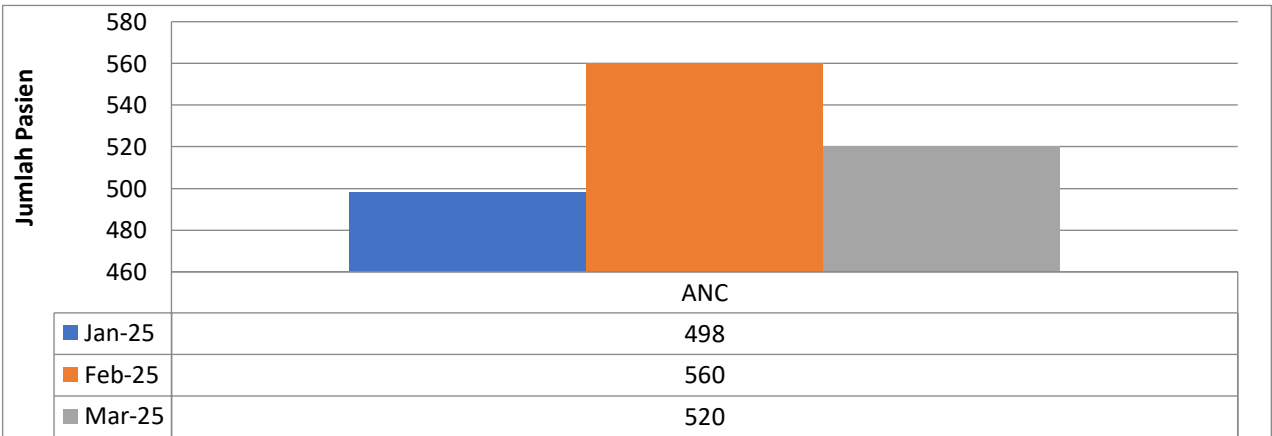
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

3.6.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek Maret 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	ANC	498	560	520

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Maret 2025



Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan Maret 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 520 kunjungan.

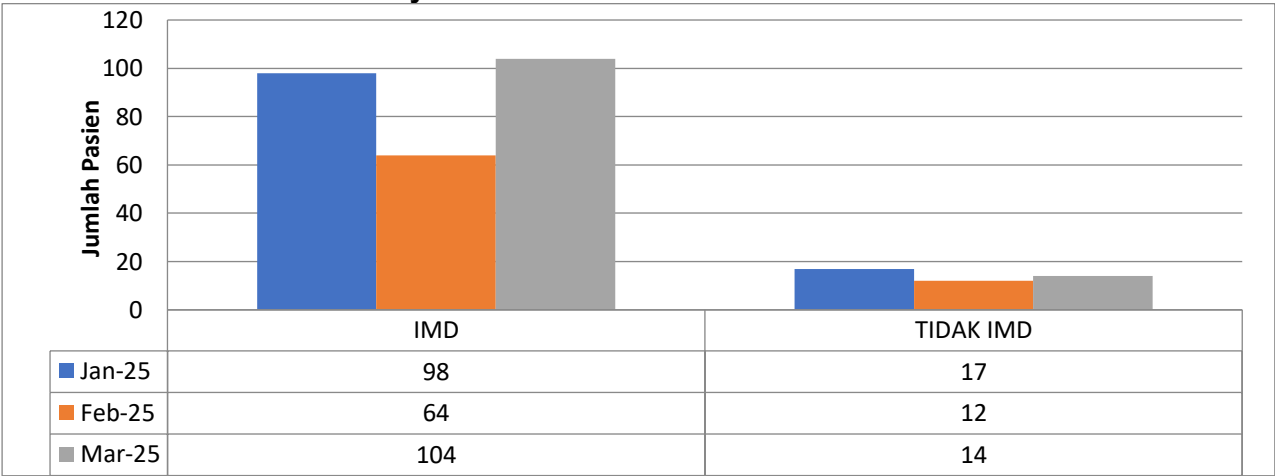
Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi

serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.6.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Maret 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	IMD	98	64	104
2	Tidak IMD	17	12	14

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Maret 2025



Analisis :

- 1) Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Maret 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 104 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- 2) Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Maret sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 14 bayi, Sedangkan pada bulan Februari 12 bayi, dan januari sebanyak 17 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3) Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

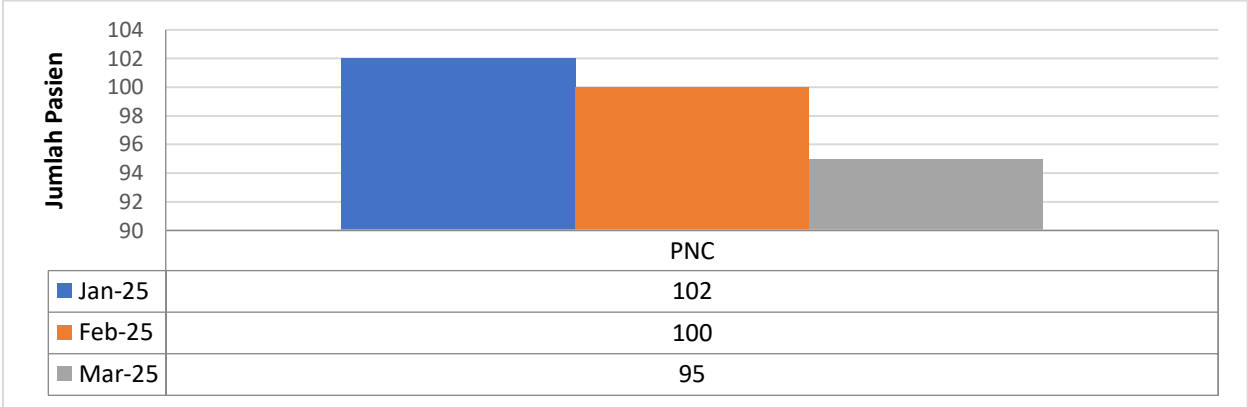
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

3.6.1.2.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Maret 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	PNC	102	100	95

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Maret 2025



Analisis :
Pelayanan PNC pada bulan Maret 2025 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 95 kunjungan.

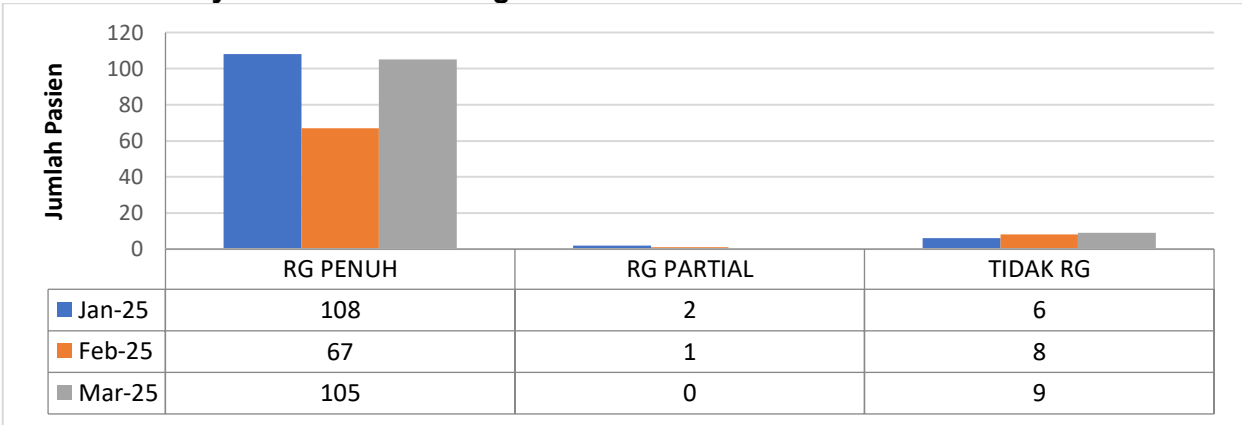
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek Maret 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	Rawat gabung penuh	108	67	105
2	Rawat gabung partial	2	1	0
3	Tidak Rawat gabung	6	8	9

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2025



Analisis :

- 1) Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Maret 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 105 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2) Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Maret 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 9 bayi.
Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan

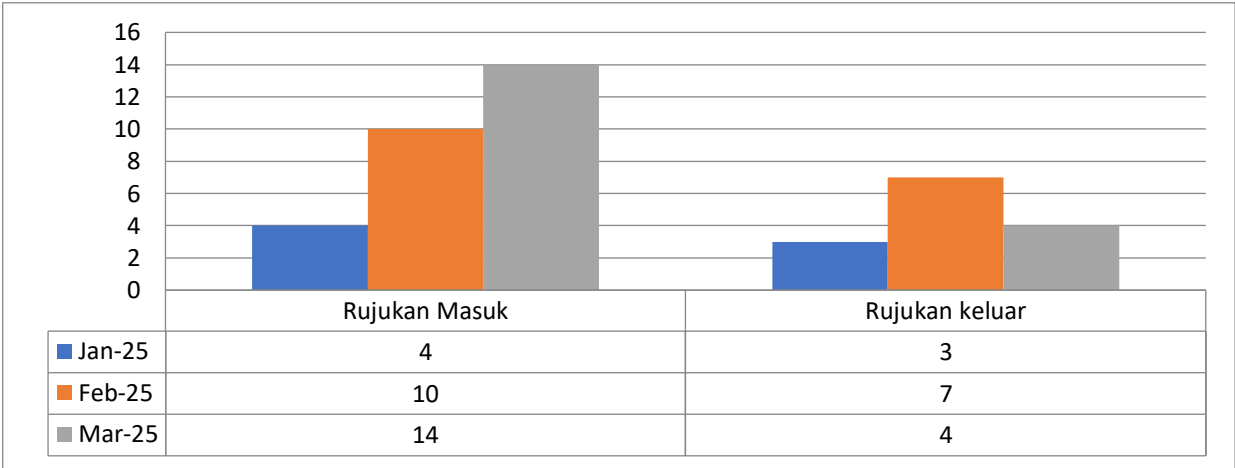
alat bantu pernafasan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponek maret 2025

NO	RUJUKAN	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	Rujukan Masuk	4	10	14
2	Rujukan keluar	3	7	4

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Maret 2025

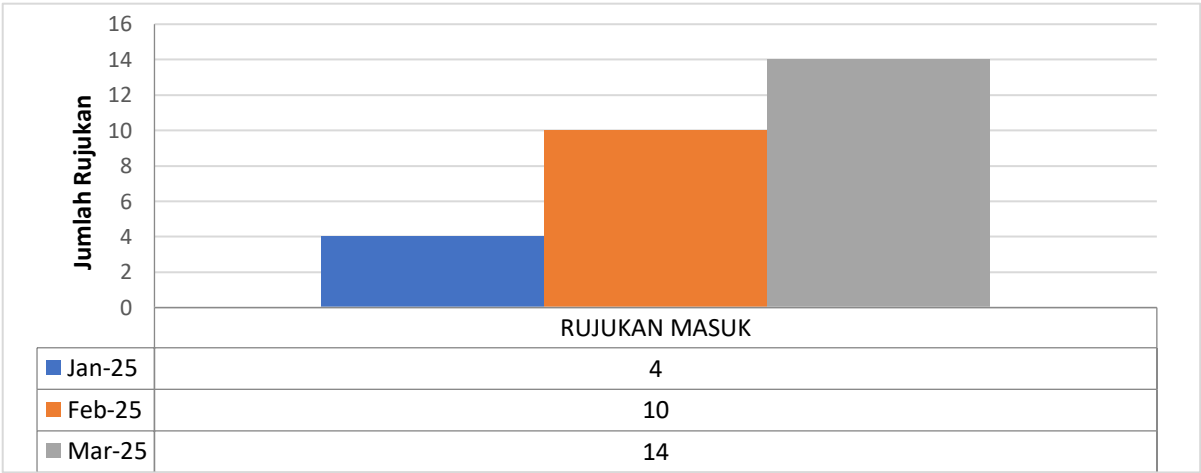


3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponek Maret 2025

Bulan Januari 2025		
1	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 mgg dg BSC + Prolong KIFL	BPM Lilik Agustina
2	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 mgg dg KPD	BPM Titik Sunariyati
3	G3 P1001 Ab100 UK 10-12 mgg dg HEG	Klinik Mutiara Sehat
4	G3 P2002 Ab000 UK 37-38 mgg dg KPD +KIFL	PKM Singosari
Bulan Februari 2025		
1	G2 P1001 Ab000 uk 30-32 mgg dg PPI	BPS Lilik Agustina
2	G3 p0201 Ab000 uk 32-34 mgg dg KIFA	Klinik Putra Husada
3	G1 P0000 Ab000 uk 37-38 mgg dg KPD	BPS Subaedah I
4	G1 P0000 Ab000 uk 39-40 mgg dg Prolong KIFA	BPM Titik Sunaryati
5	G1 P0000 Ab000 uk 39-40 mgg dg IUFD + Letli + High miopi	Klinik Kartini
6	G2 P1001 Ab000 uk 10-12 mgg dg Abortus Inkomplit	Klinik Putra Husada
7	P2002 Ab000 dg kala 3 + Retensio Plasenta	PKM Singosari
8	G2 P1001 Ab000 uk 30-32 mgg dg PPI	BPM Tri
9	Anemia Grafis + Massa IntraAbdominal susp CA Ovari + Prolaps Uteri grade 4	PKM Pakis
10	Anemia +Susp CA Serviks	Klinik Nayaka

Bulan Maret 2025		
1	G2 P1001 Ab000 UK 6-8 dg abortus inkomplit + Syok Hipovolemik	PMB Tri Widiyawati
2	G1 P0000 Ab000 UK 2-4 Mgg dg KET	KRI Idaman Hati
3	G2 P0101 Ab000 UK 28-30 mgg dg PPI	PMB Tri Widiyawati
4	G3 P2002 Ab000 UK 8-10 mgg dg abortus Inkomplit dan Anemia	PKM Ardimulyo
5	G3 P2002 Ab000 UK 36-37 mgg dg KPD + KIFL	PMB Nuri Afanti
6	Anemia Grafis + Kista Endometriosis	Klinik Tirto Husada
7	G2 P1001 Ab000 UK 38-39 mgg dg KIFL + Autoimum + HT	PKM Singosari
8	G1 P0000 Ab000 UK 40 mgg dg KIFL + KPD	PMB Titik
9	G1 P0000 Ab000 UK 39 – 40 mgg dg prolong kala 1 fase aktif	PKM Ardimulyo
10	G3 P2002 Ab000 UK 38 - 39 mgg dg letak lintang + HT gestasional	PMB titik
11	P1001 Ab000 dg post partum normal dan rupture perineum D3	PMB Heni Budiasih
12	G1 P0000 Ab000 UK 32-34 mgg dg Gemeli, letsu, anemia grafis	RS Sahabat
13	G3 P1001 AB100 UK 39-40 mgg dg KIFA	PMB Titik Sunaryati
14	Asfiksia berat + BBLR + NKB	RSUD Lawang

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Maret 2025



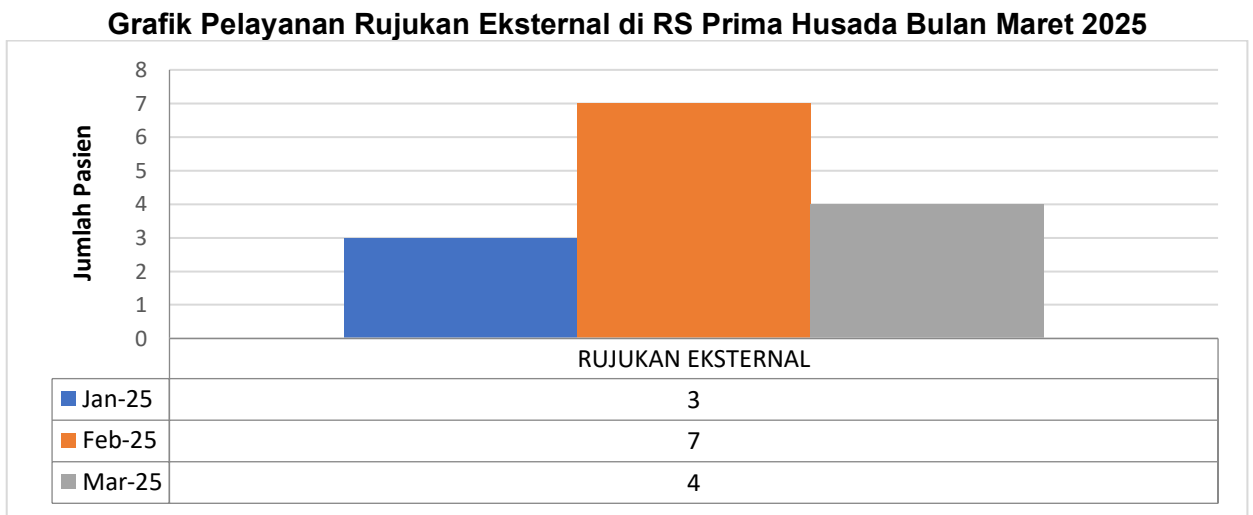
Analisis :
 Jumlah rujukan masuk pada bulan Maret 2025 meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 14 rujukan, sedangkan pada bulan Februari sebanyak 10rujukan, dan pada bulan Januari sebanyak 4 rujukan masuk.

Rencana dan Tindak Lanjut
 Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
 Tabel Rujukan Keluar Ponek Maret 2025

Bulan Januari 2025		
1	BBLR + Asfiksia	RS Saiful Anwar
2	RDS ok Neonatal pneumonia dd TTNB + Makrosefali	RS Soepraon
3	Post curettage + Sub Involusi Uteri + syok hipovolemi	RS Saiful anwar

Bulan Februari 2025		
1	P1001 Ab000 dg Eklamsia	RS saiful Anwar
2	P1001 Ab000 dg post SC h+9 dg late HPP ec Sub Involusi Uteri	RS Saiful Anwar
3	RDS +NKB	RS Saiful Anwar
4	RDS + BBLSR	RS Soepraoen
5	RDS + NKB + BBLSR	RS Soepraoen
6	RDS + BBLR	RS Soepraoen
7	RDS + BBLR	RS Saiful Anwar
Bulan Maret 2025		
1	NKB + RDS + Susp NEC, Pneumonia	RS Saiful Anwar
2	NKB + BBLSR + RDS	RS Saiful Anwar
3	RDS ok Neonatal	RS Lavalette
4	G1 P0000 Ab000 UK 28-30 mgg dg PEB + ALO	RS Saiful Anwar



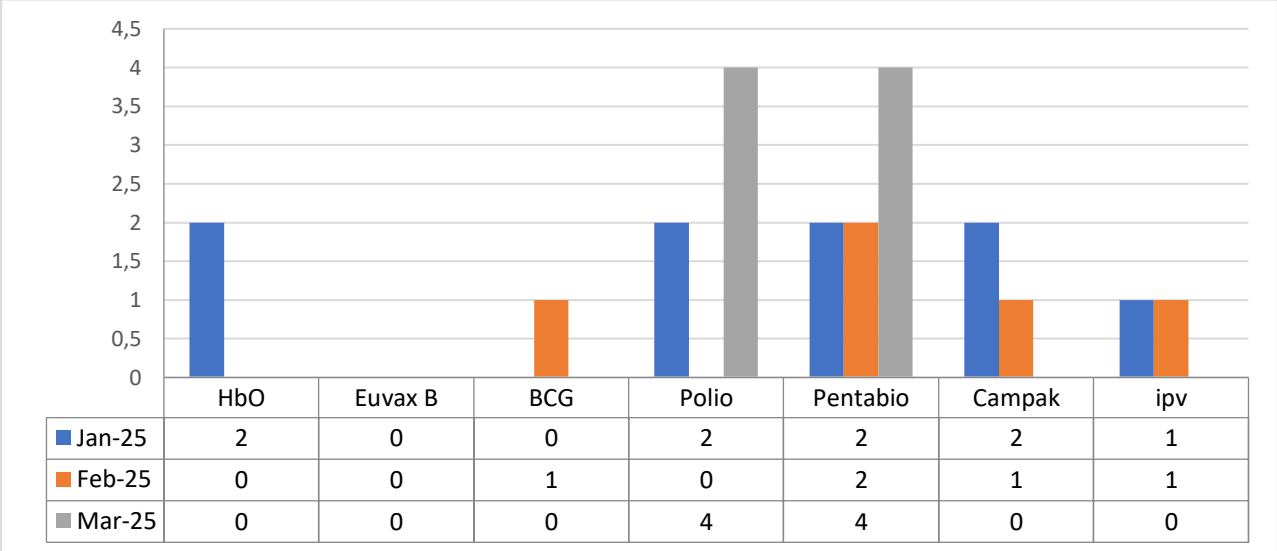
Analisis :
 Pada bulan Maret 2025 jumlah rujukan eksternal menurun, yaitu 4 pasien dirujuk, sedangkan pada bulan Februari 2025 ada 7 pasien, dan 3 pasien pada bulan Januari 2025.

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponpek Maret 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	HbO	2	0	0
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	0	1	0
3	Polio	2	0	4
4	Pentabio	2	2	4
5	Campak	2	1	0
6	IPV	1	1	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2025



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Maret 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
2. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Maret dan Februari 2025, sedangkan pada Januari 2025 sebanyak 2 bayi. Hal ini dikarenakan ketidaktersedianya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas belum bisa memeberikan ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Maret 2025, sedangkan pada bulan Februari 2025 dan bulan sebelumnya sebanyak 1 bayi
4. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Maret dan Januari 2025, sedangkan pada bulan Februari 2025 sebanyak 1 bayi
5. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi campak pada bulan Maret 2025, sedangkan pada bulan Februari 2025 sebanyak 1 bayi dan 2 bayi pada bulan Januari 2025.
6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Maret 2025 sebanyak 4 bayi, sedangkan pada bulan Februari 2025 tidak ada, dan pada bulan Januari 2025 sebanyak 2 bayi.
7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Maret sebanyak 4 bayi, sedangkan pada bulan Januari dan Februari 2025 sama, yaitu 2 bayi, imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

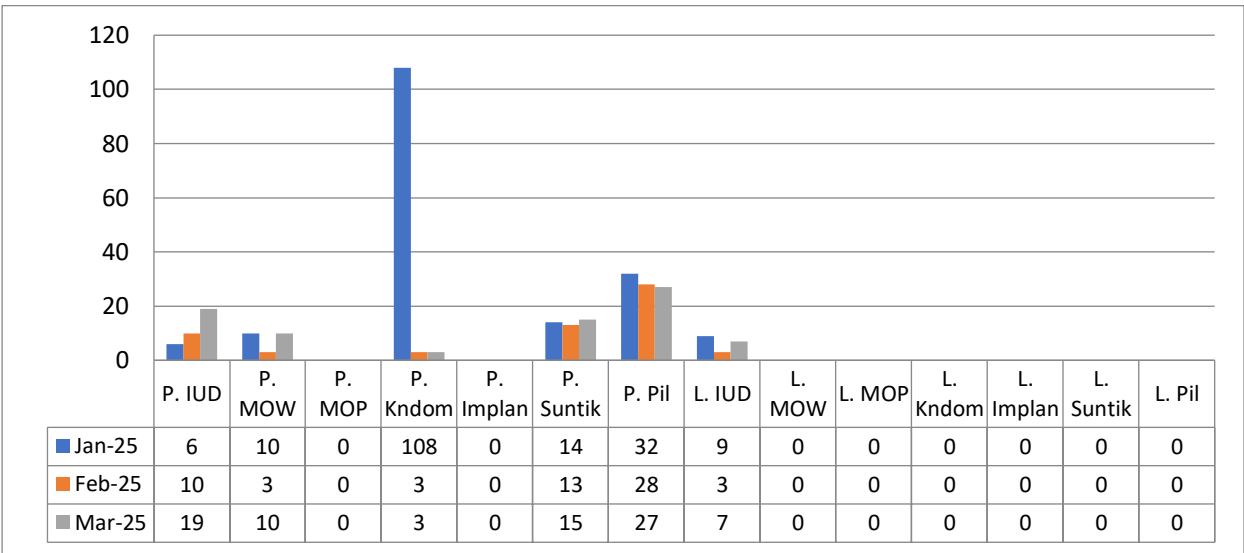
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponek Maret 2025

No	Jenis	Jumlah Pasang			Jumlah Lepas		
		Bulan Januari 2025	Bulan Februari 2025	Bulan Maret 2025	Bulan Januari 2025	Bulan Februari 2025	Bulan Maret 2025
1	IUD	6	10	19	9	3	7
2	MOW	10	3	10	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	108	3	3	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	14	13	15	0	0	0
7	Pil	32	28	24	0	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2025



Aanalisis :

- 1) Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Maret 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 19 akseptor yang terdiri dari 7 akseptor IUD Nova T dan 12 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
- 2) Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Maret 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3) Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Maret dan Februari sama yaitu 3 pengguna, sedangkan pada bulan Januari 2025, yaitu 108 pengguna
- 4) Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan maret 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 27 pengguna
- 5) Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Maret 2025 sebanyak 15 dan pada bulan Februari 2025 sebanyak 13 pengguna, sedangkan pada bulan Januari sebanyak 14 pengguna.

Rencana dan Tindak Lanjut :

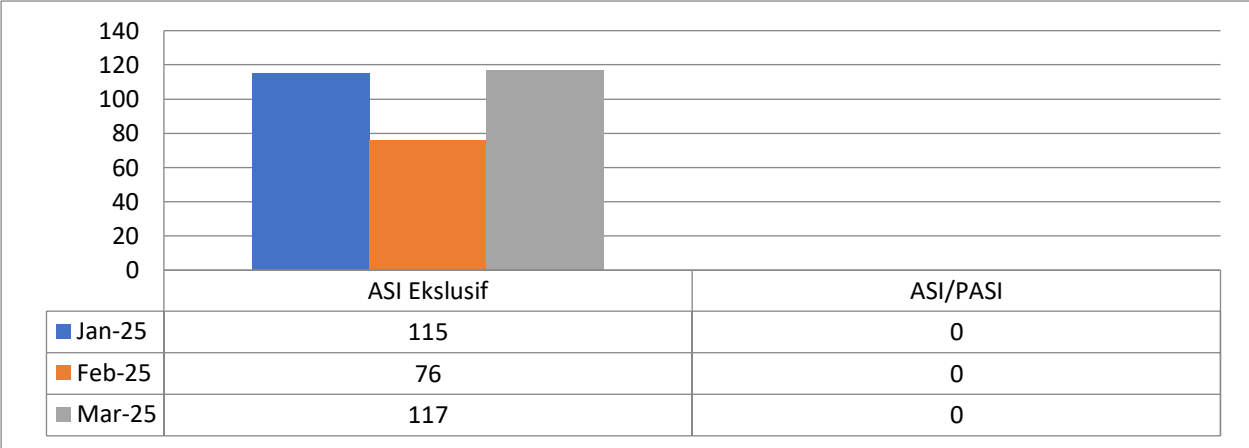
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Maret 2025

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	Asi eksklusif	115	76	117
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Maret 2025



- Analisis :**
- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Maret 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 117 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
 - 2. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :

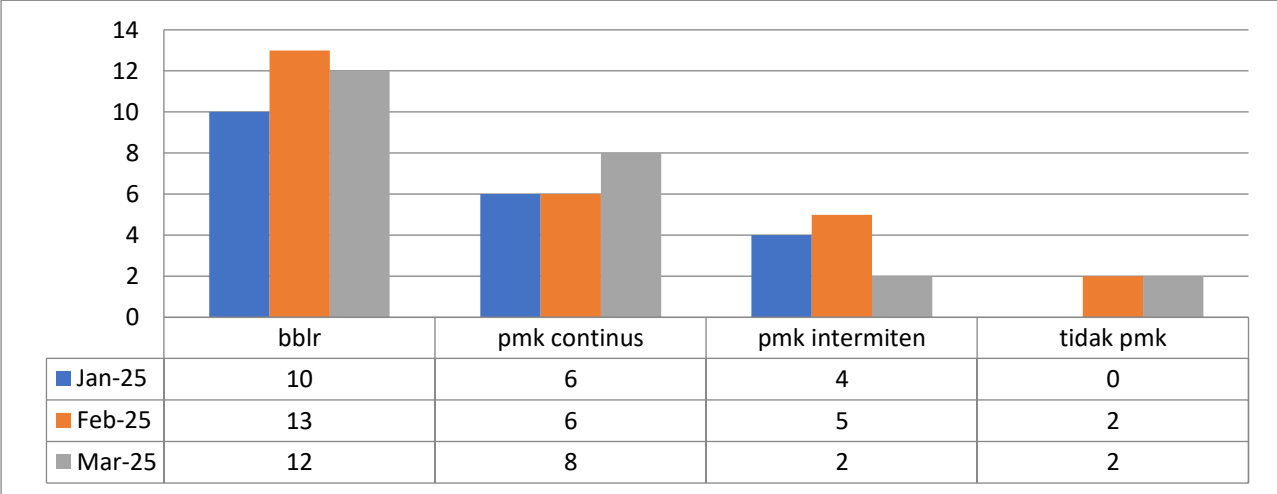
Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel Pelayanan Perawatan metode kanguru (PMK) Pada BBLR di Ponek Februari 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	Bayi BBLR	10	13	12
2	PMK continuos	6	6	8
3	PMK Intermiten	4	5	2
4	Tidak PMK	0	2	2

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Maret 2025



Analisis :

- 1) Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2) Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Maret 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi, sedangkan pada bulan Maret sebanyak 5 bayi, dan Januari 2025 sebanyak 4 bayi
- 3) Sedangkan metode PMK continus pada bulan Maret 2025 sebanyak 8 bayi, sedangkan pada bulan Januari dan Februari 2025 sebanyak 6 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4) Ada 2 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Maret dan Februari 2025, dan tidak ada yang tidak PMK pada bulan Januari 2025. Hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK karena terpasang alat C-pep dan bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

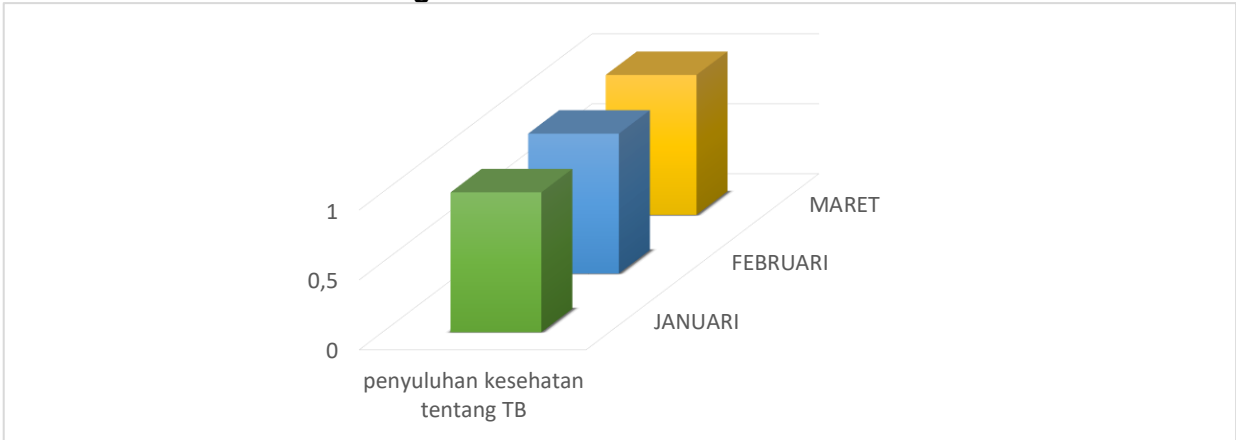
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1	1	1

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



Analisis:

Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

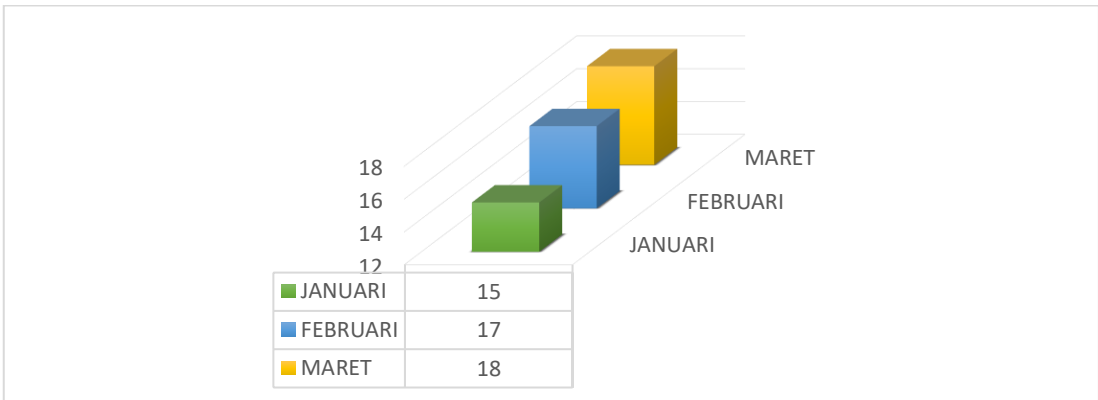
Rencana dan Tindak Lanjut:

Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian Masker	15	17	18

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Januari 2025 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

- 2. Pada bulan februari 2025 terdapat 17 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 3. Pada bulan maret 2025 terdapat 18 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standar

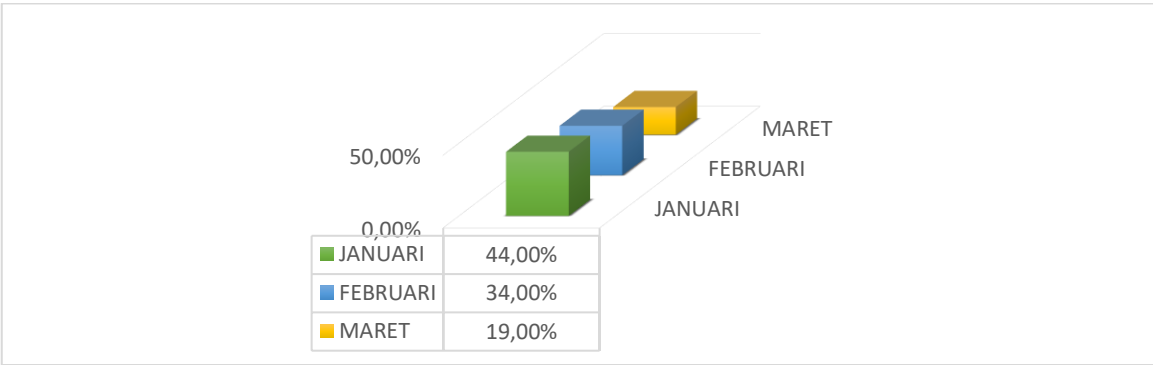
Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	44	34	19

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Januari 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 44
- 2. Pada bulan Februari 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 34
- 3. Pada bulan Maret 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 19

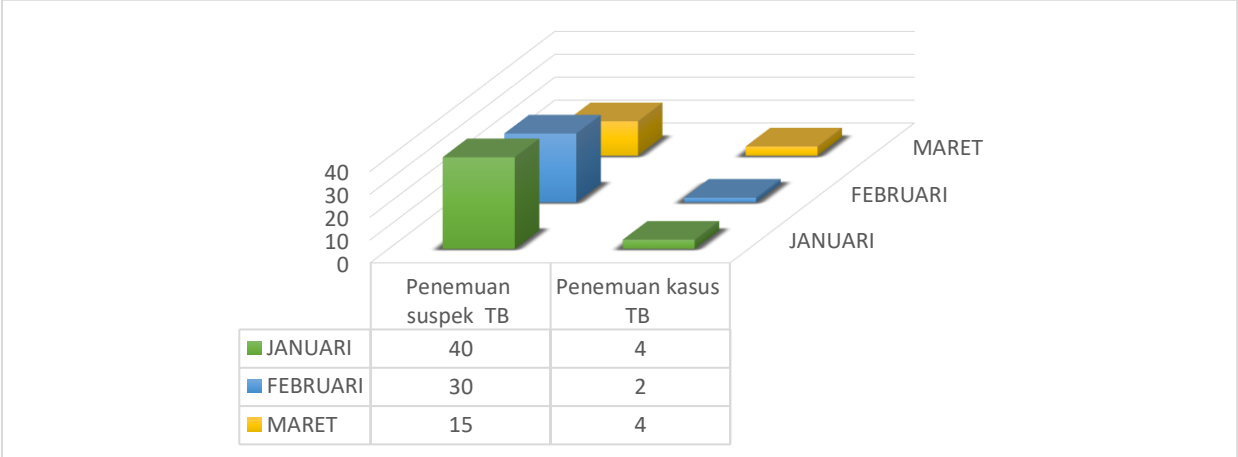
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Penemuan suspek TB	40	32	15
2	Penemuan kasus TB	4	2	4

Grafik Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan januari 2025 terdapat 40 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 4 pasien
- 2. Pada bulan Februari 2025 terdapat 32 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 2 pasien
- 3. Pada bulan maret 2025 terdapat 15 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 4 pasien

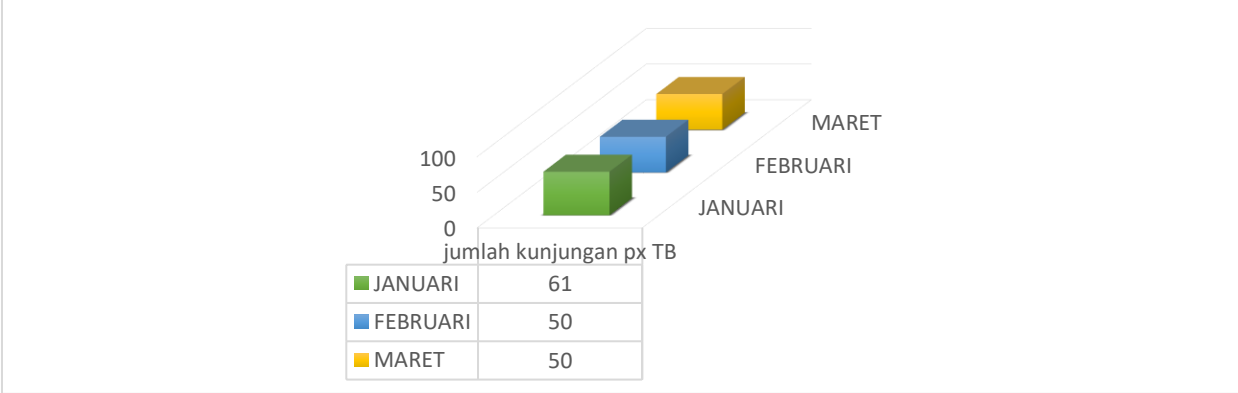
Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	61	50	50

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis:

- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Januari 2025 di poli pasien TBC mencapai 61 pasien.
- 2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Februari 2025 di poli pasien TBC mencapai 50 pasien.

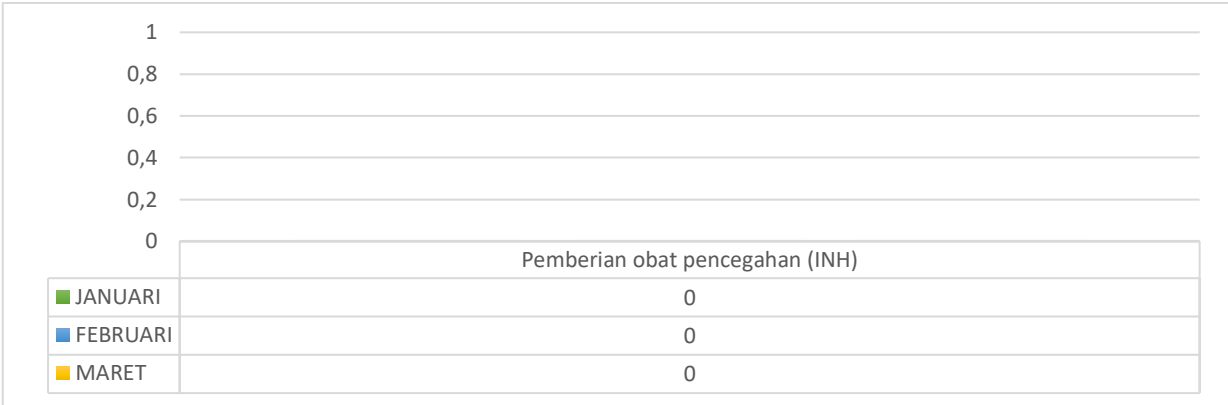
3. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Maret 2025 di poli pasien TBC mencapai 50 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	0

Grafik Pemberian Obat Pencegahan di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

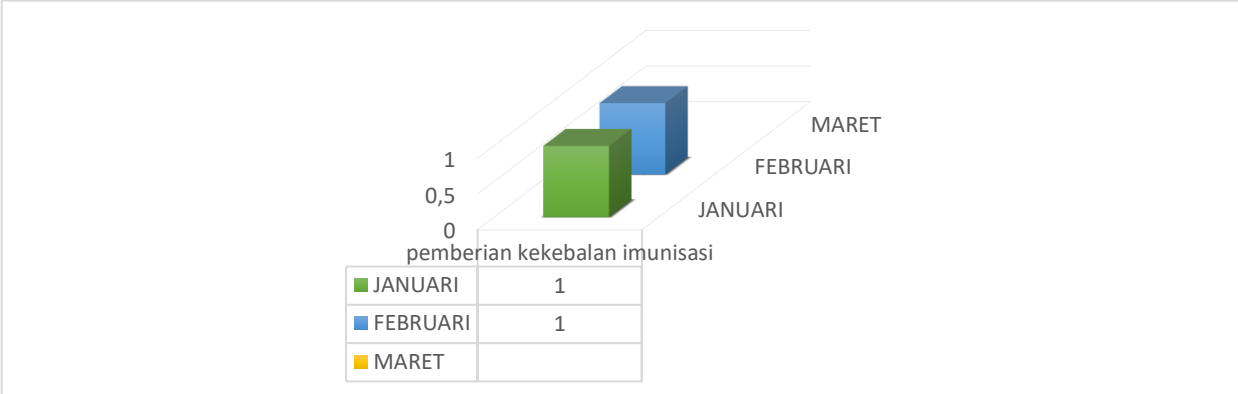
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian imunisasi BCG	1	1	0

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan Januari
- 2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan Februari
- 3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 0 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan Maret

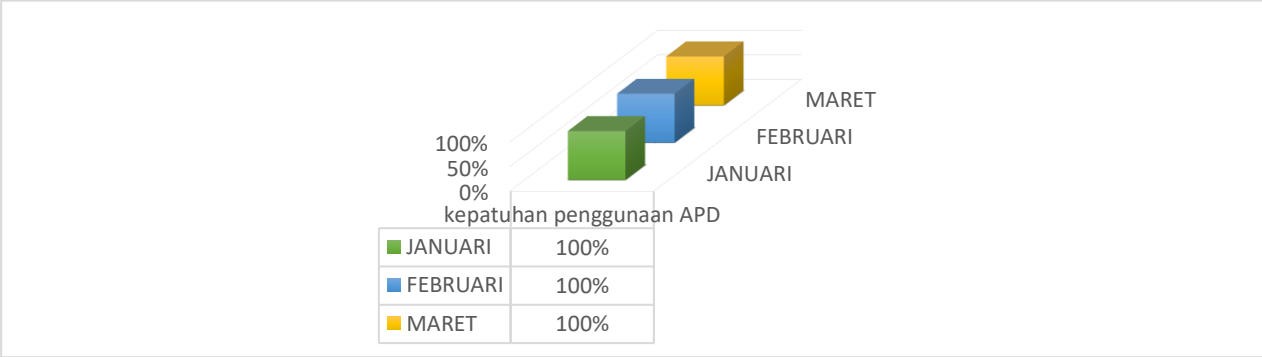
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	100%

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



Analisis :

Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

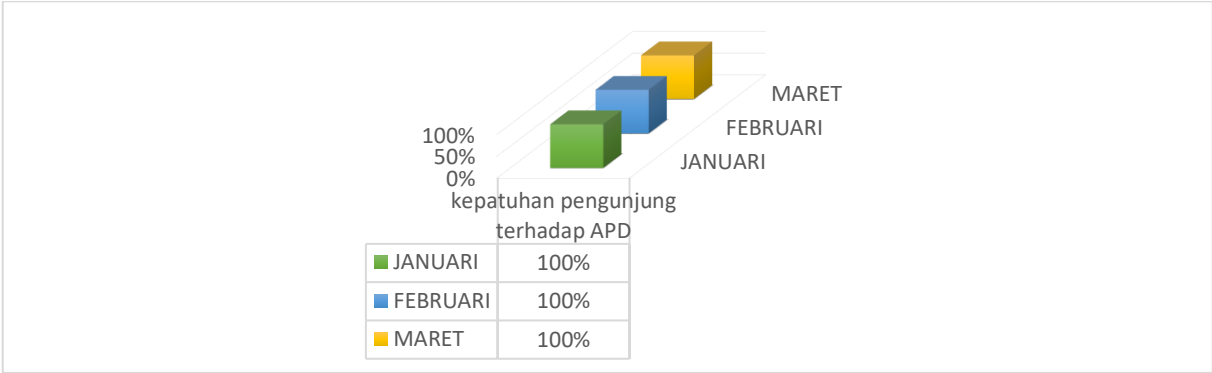
Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	100%

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD di RS Prima Husada



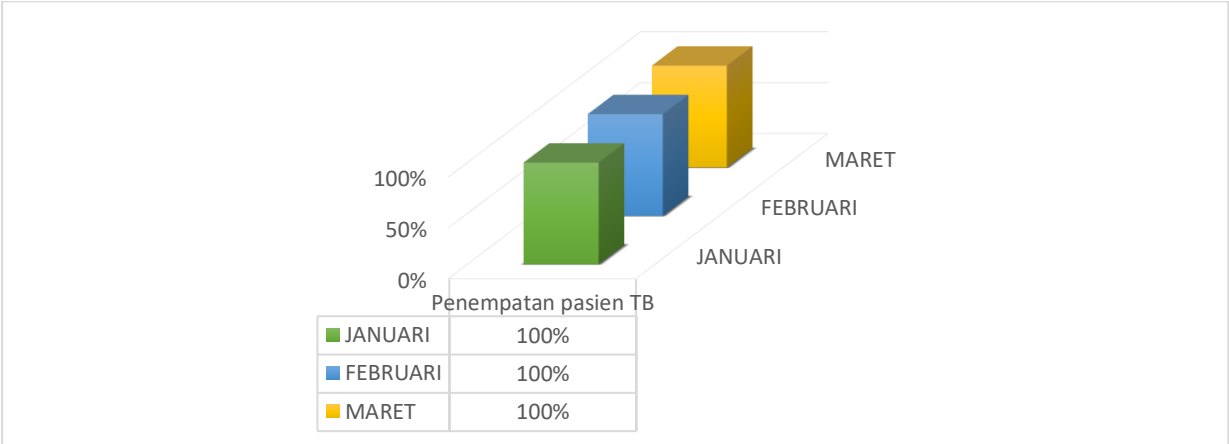
Analisis:
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Penempatan pasien TB	100%	100%	100%

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



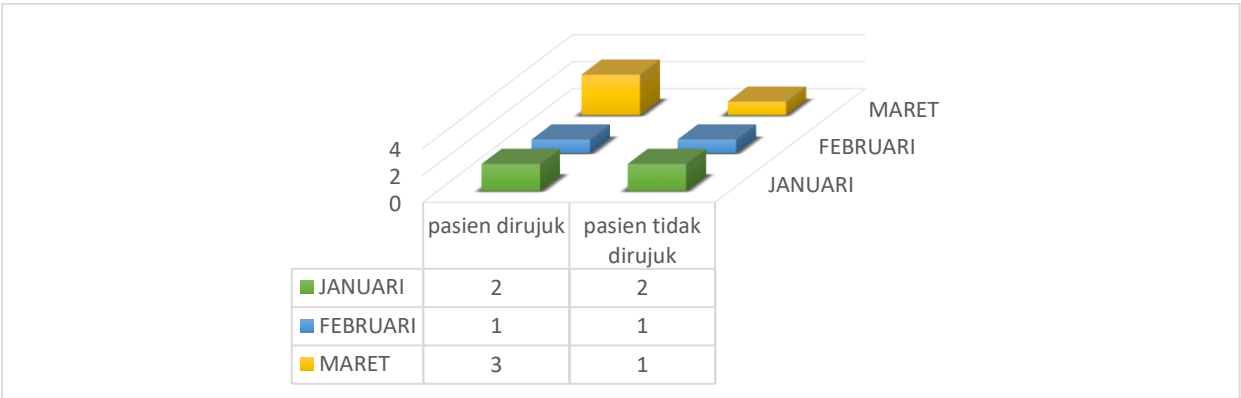
Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien TB yang dirujuk	2	1	1
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	2	1	3

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

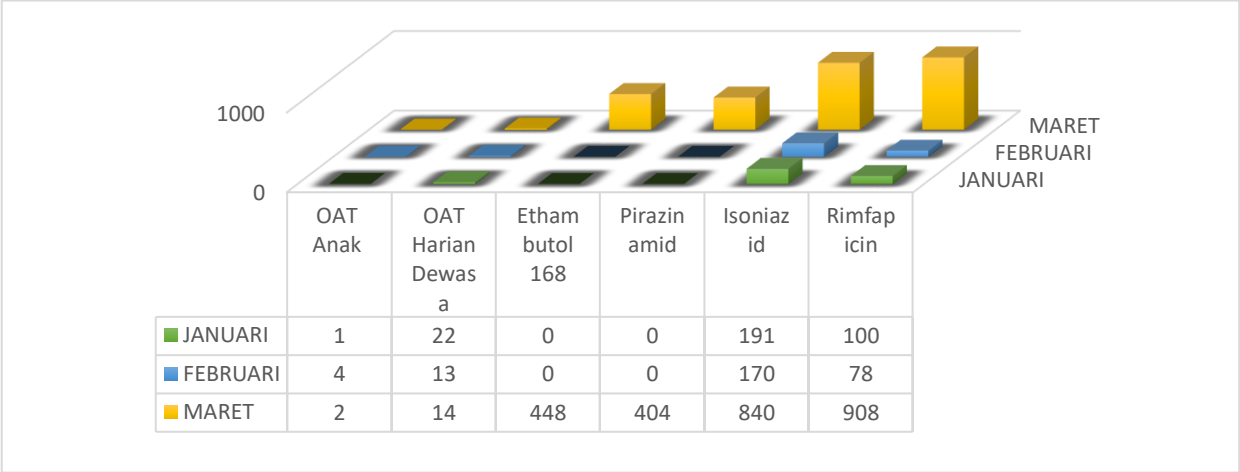
- 1) Pada bulan Januari 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 2) Pada bulan Februari 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 3) Pada bulan Maret 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	OAT Anak	1	4	2
2.	OAT Harian Dewasa	22	13	14
3.	Ethambutol	0	0	448
4.	Pirazinamid	0	0	404
5.	Isoniazid	191	170	840
6.	Rimfapicin	100	78	908

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



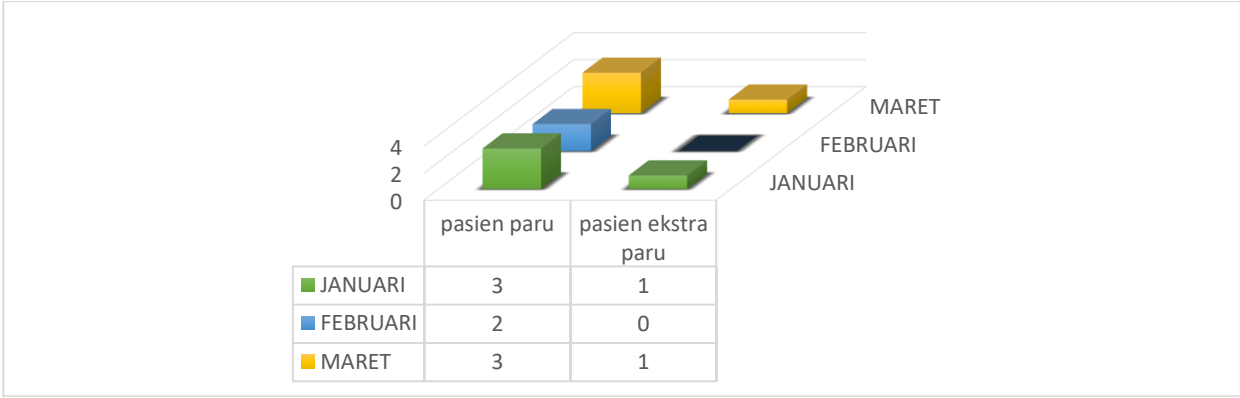
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien paru	3	2	3
2.	Pasien Ekstra paru	1	0	1

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

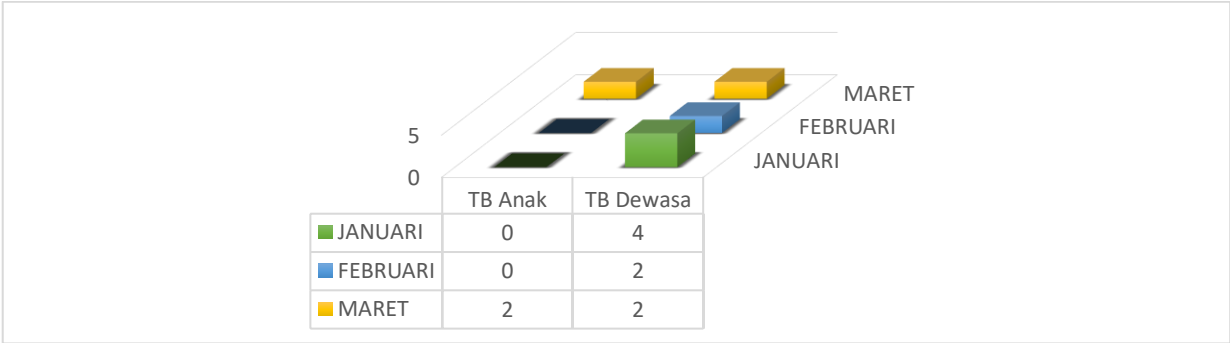
1. Pada bulan Januari 2025 terdapat 1 pasien ekstra paru
2. Pada bulan Februari 2025 terdapat 0 pasien ekstra paru
3. Pada bulan Maret 2025 terdapat 1 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien Anak	0	0	2
2.	Pasien Dewasa	4	2	2

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



Analisis :

- 1. Pada bulan Januari terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 4 pasien
- 2. Pada bulan Februari terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien
- 3. Pada bulan Maret terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P	Tn. P	V		
3.	dr. Yunita, Sp. P	Ny. S	V		

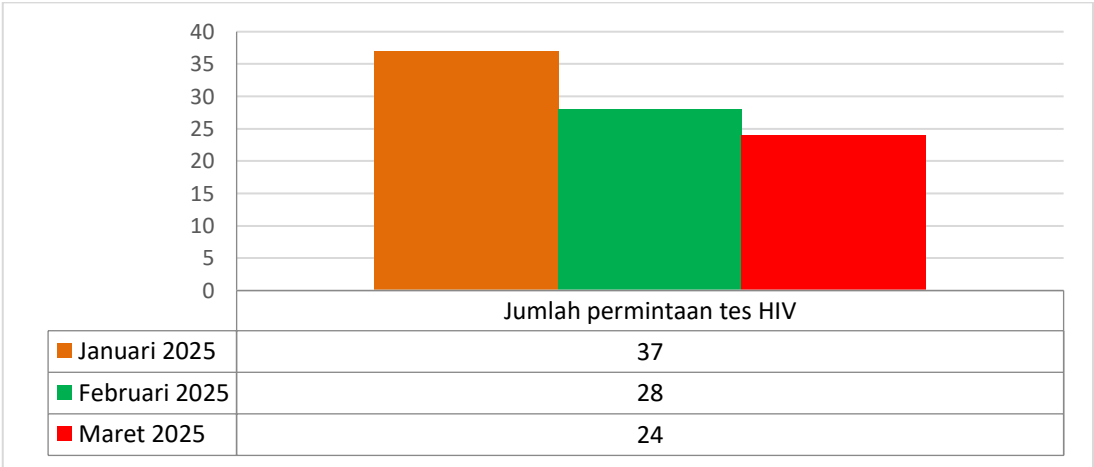
Analisis :
 Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	Permintaan Test HIV	37	28	24

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret 2025



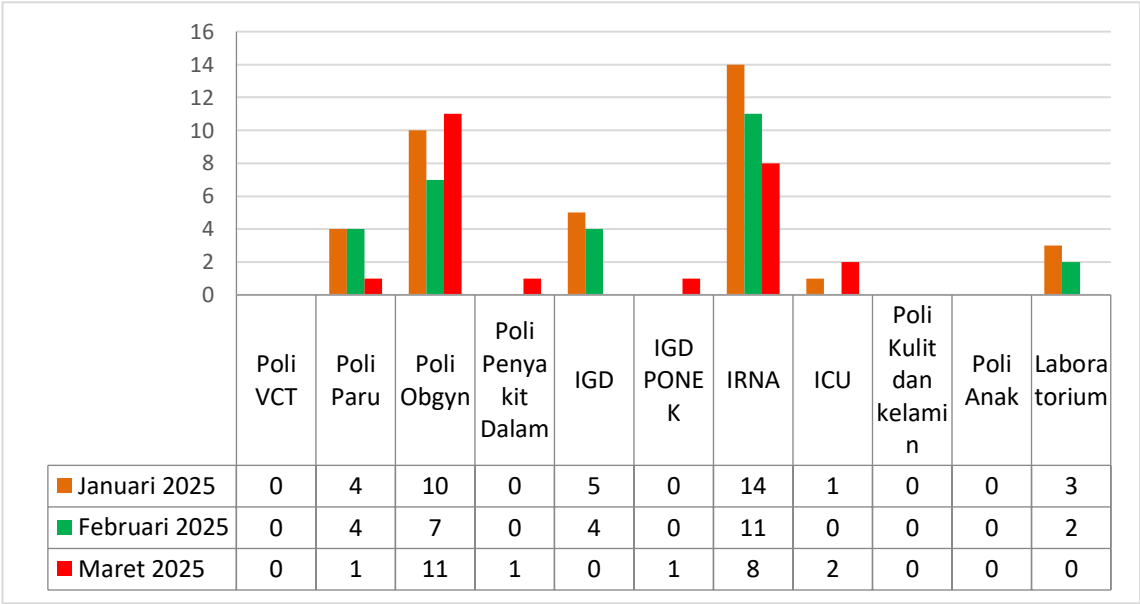
Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Januari 2025 sebanyak 37 pemeriksaan, pada bulan februari 2025 sebanyak 28 pemeriksaan, sedangkan pada bulan maret 2025 turun menjadi 24 pemeriksaan. Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :
 Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	4	4	1
3	Poli Obgyn	10	7	11
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	1
5	IGD	5	4	0
6	IGD PONEK	0	0	1
7	IRNA	14	11	8
8	ICU	1	0	2
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	3	2	0

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV Maret 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan januari 2025 sebanyak 10 pasien pada bulan februari 2025 sebanyak 7 pasien Sedangkan pada bulan Maret 2025 sebanyak 11 pasien.

Hal ini dikarenakan sudah tersedianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

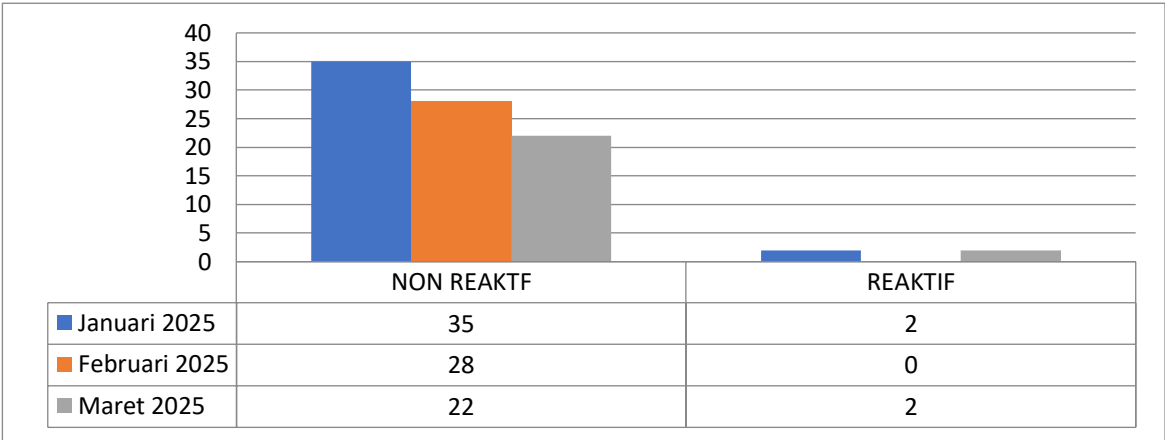
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	Non Reaktif	35	28	22
2	Reaktif	1	2	0

Grafik Status HIV Maret 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan maret 2025 sebanyak 2 pasien sama dengan temuan dibulan januari 2025.

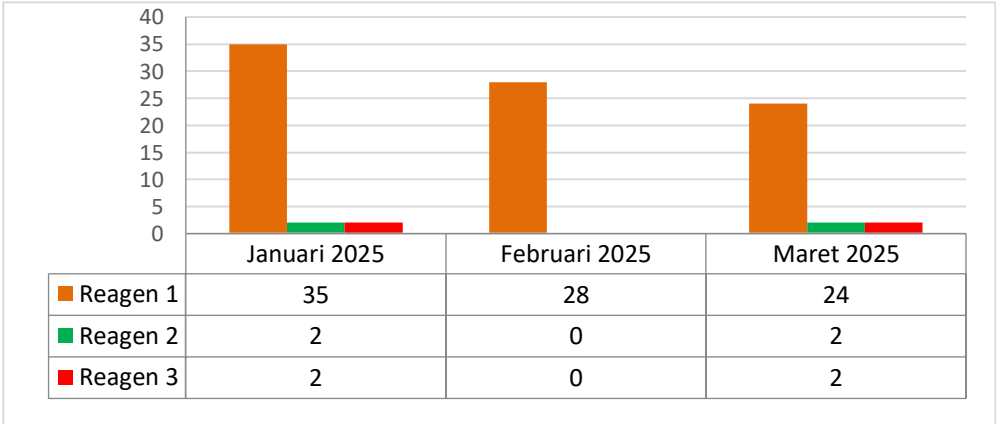
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	Reagen 1	35	28	24
2	Reagen 2	2	0	2
3	Reagen 3	2	0	2

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Maret 2025



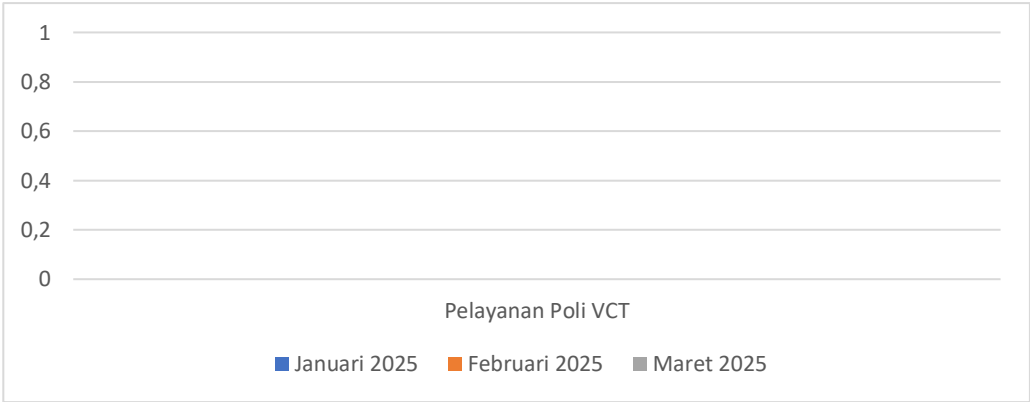
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Maret 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 2 pasien , pada bulan Februari 2025 hanya memakai reagen 1 karena tidak ada pasien dengan hasil positif. Pada bulan Januari memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien hasil reaktif sebanyak 2 pasien. Pada bulan Desember 2024 memakai reagen 3 Dikarenakan ada pasien dengan hasil reaktif sebeanyak 1 pasien,

Rencana Tindak Lanjut :
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Maret 2025



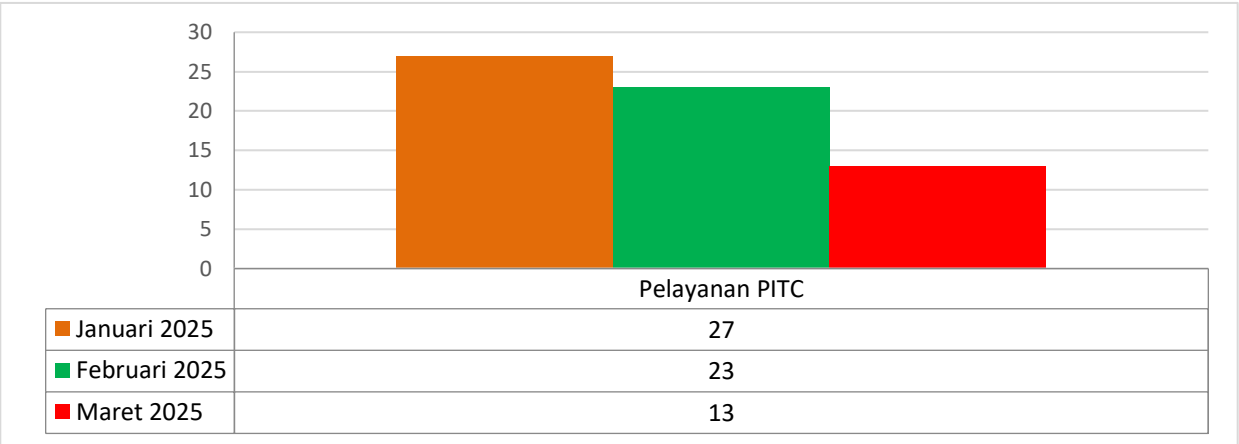
Analisis pelayanan Poli VCT
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

Rencana Tindak Lanjut
Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.1.2.3.5 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	Pelayanan PITC	27	23	13

Grafik Pelayanan PITC Maret 2025



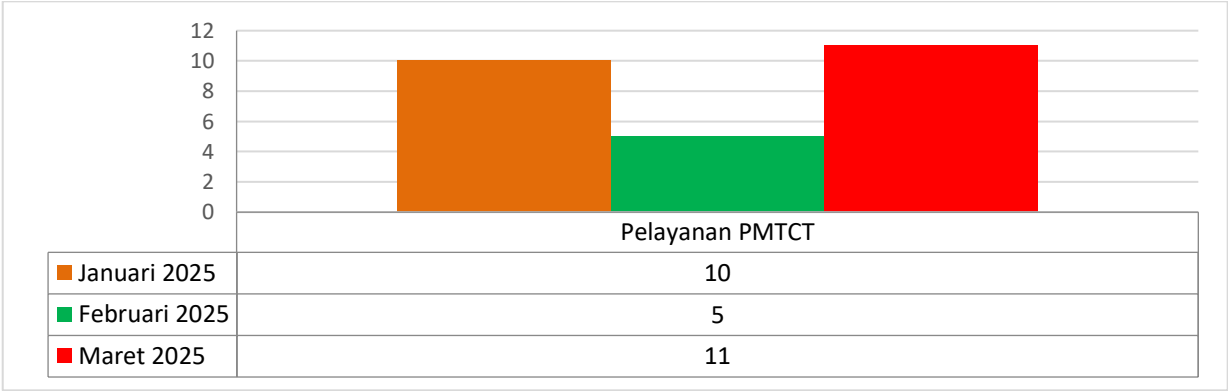
Analisis :
Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan januari 2025 sebanyak 27 pasien. pada bulan februari sebanyak 23 pasien. Sedangkan pada bulan Maret 2025 turun menjadi 13 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan peningkatan terkait penjangrian pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	Pelayanan PMTCT	10	5	11

Grafik Pelayanan PMTCT Maret 2025



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan januari 2025 sebnayak 10 pasien. pada bulan februari 2025 sebanyak 5 pasien. Sedangkan pada bulan maret 2025 sebanyak 11 pasien.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

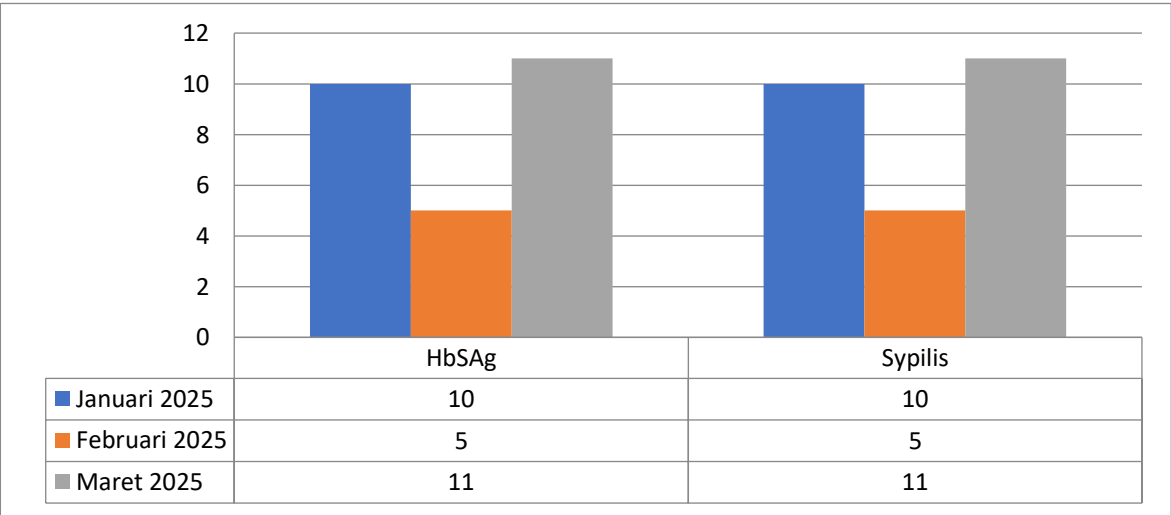
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmission bias dilakukan.

3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	HbSAg	10	5	11
2	Sypilis	10	5	11

**Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Maret 2025**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan Januari 2025 sebanyak 10 pasien, pada bulan Februari 2025 sebanyak 5 pasien Sedangkan pada bulan maret 2025 sebanyak 11 pasien Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

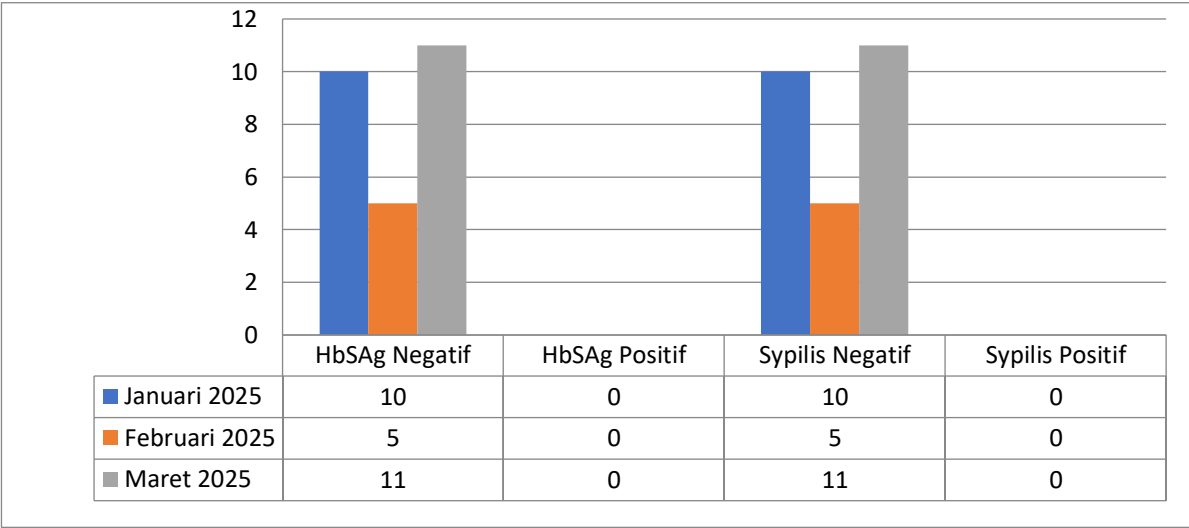
Rencana Tindak lanjut :

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	HbSAg			
	Negatif	10	5	11
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	10	5	11
	Positif	0	0	0

**Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Maret 2025**



Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan Januari, Februari dan Maret 2025 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif.

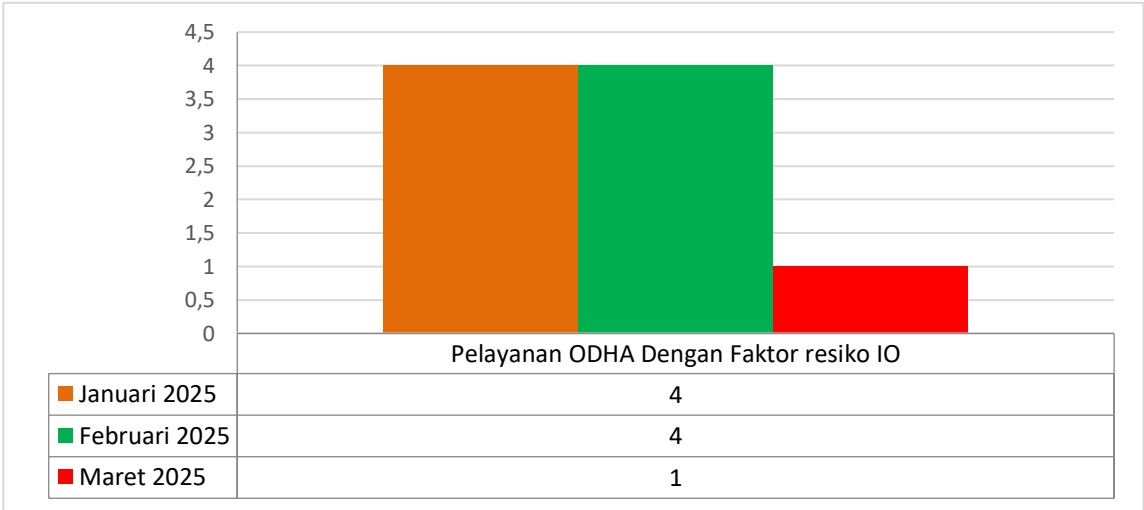
Rencana Tindak Lanjut :

- Pada pasien HbSAg
 Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
- Pada pasien Sypilis
 Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	4	4	1

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Maret 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan Januari dan februari 2025 sebanyak 4 pasien, Sedangkan pada bulan Maret 2025 didapatkan 1 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

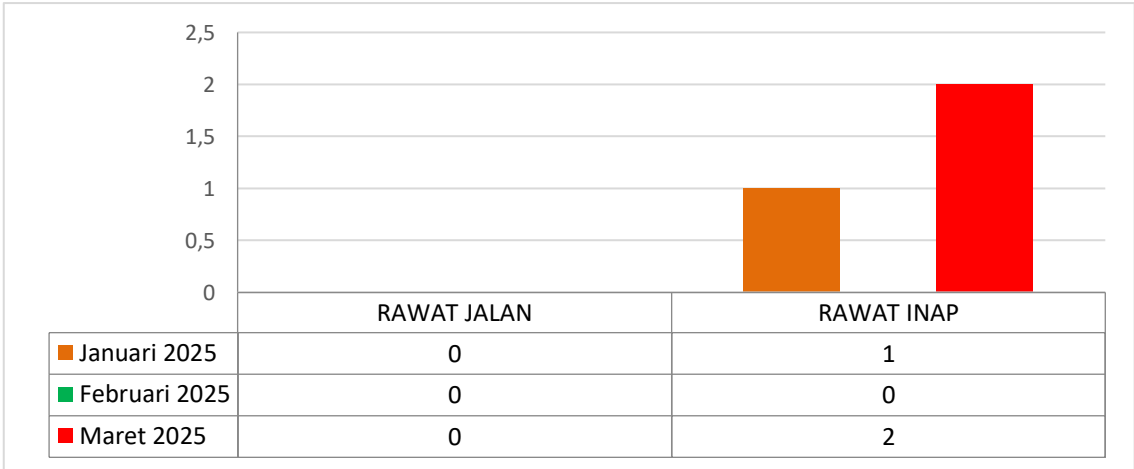
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
1	Rawat Jalan	2	0	0
2	Rawat Inap	1	1	2

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS Maret 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan pada bulan januari terdapat 1 pasien yang dirujuk dari rawat inap, pada bulan februari 2025 tidak ada pasien dengan HIV yang dirujuk Sedangkan pada bulan maret 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk dari rawat inap
Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Januari 2025

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.

2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas
Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	0
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	-	1	1	1

Pemantaua n pertumbuha n (Pelayan an Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaa n imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberika n PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersdiaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	1
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

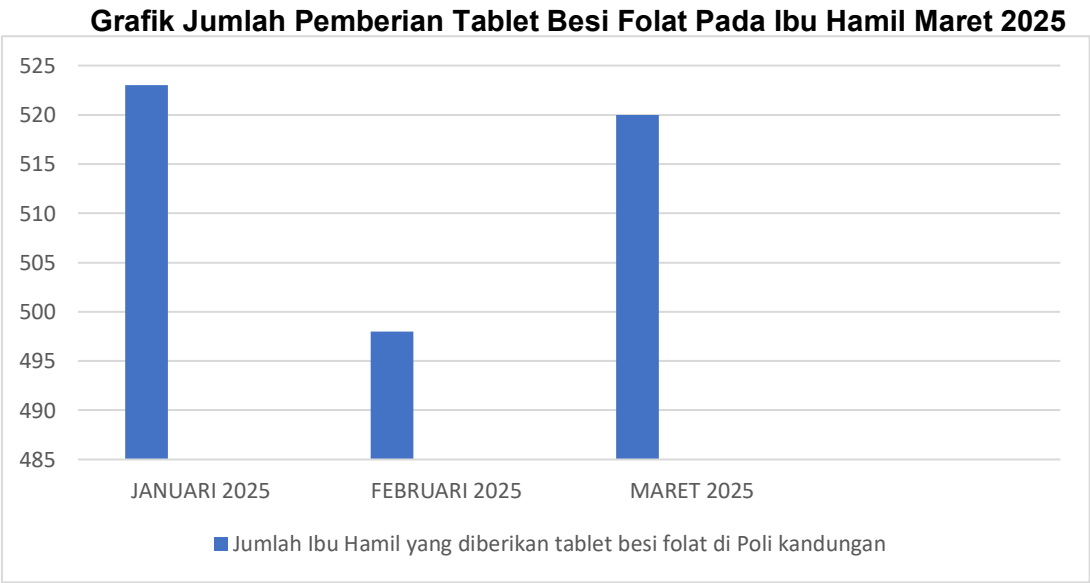
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
--------------------------------------	---	-----------	----------------------------	---	---	---

Analisis :
Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	523	498	520



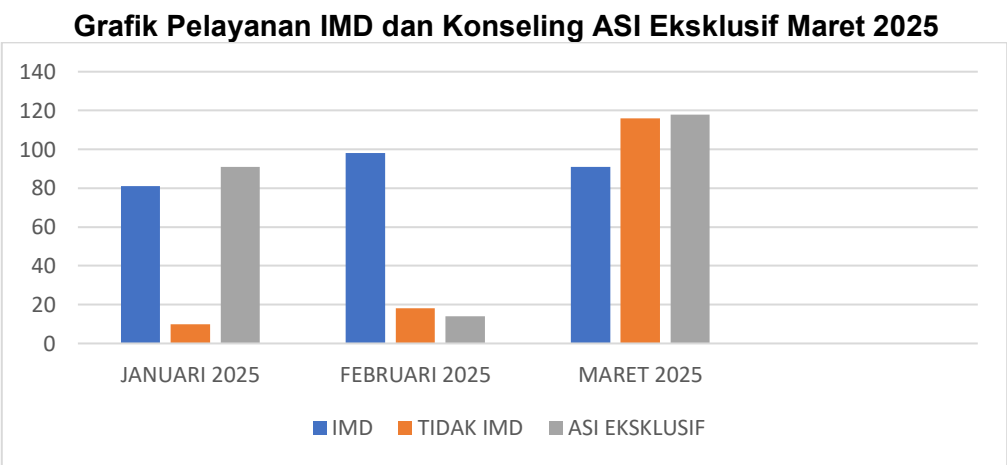
Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat naik dari sebelumnya 498 di bulan Februari menjadi 520 pada bulan Maret yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

- Rencana Tindak Lanjut:**
- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 - 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	IMD	81	98	104
2	Tidak IMD	10	18	14
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	91	116	118



- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Maret 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 104 bayi.
 - 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Maret 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 14 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
 - 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
 - 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Maret 2025 yaitu sebanyak 118 pasien.

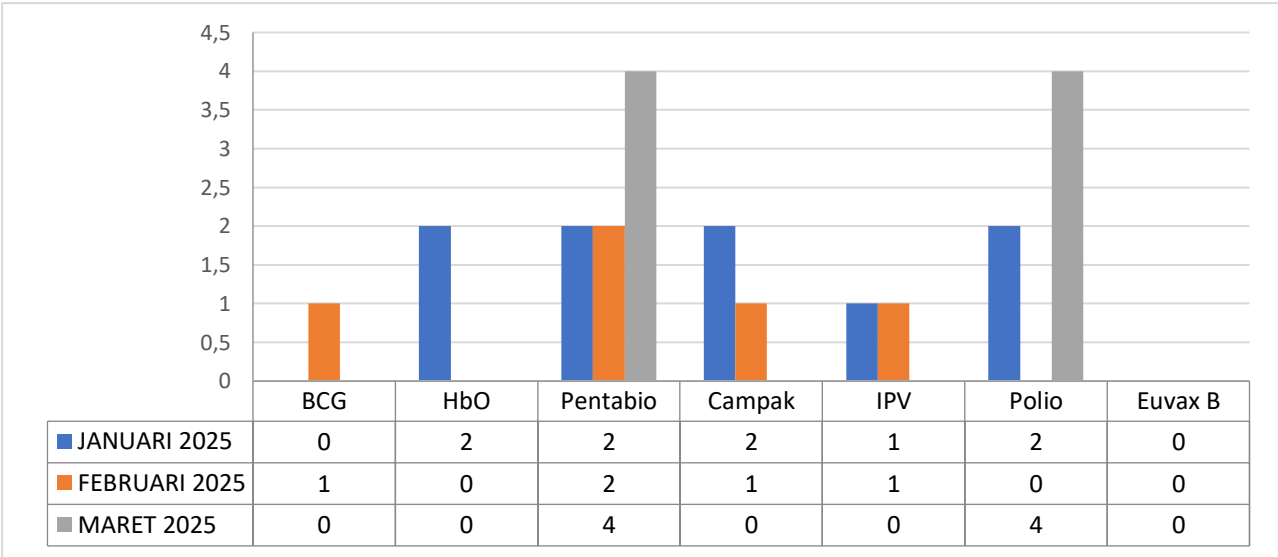
Rencana Tindak Lanjut:
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	BCG	0	1	0
2	DPT 1	2	0	0
3	DPT 2	2	2	4
3	DPT 3	2	1	0
4	DPT 4	1	1	0
5	Campak	2	0	4
6	IPV	0	0	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Maret 2025



Analisis:

- 1. Terdapat 4 balita yang melakukan imunisasi Pentabio di bulan Maret 2025.
- 2. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi BCG, IPV, HbO, campak, dan euvax B pada bulan Maret 2025.
- 3. Pada periode Maret 2025 terdapat 4 bayi yang melakukan Imunisasi Polio.

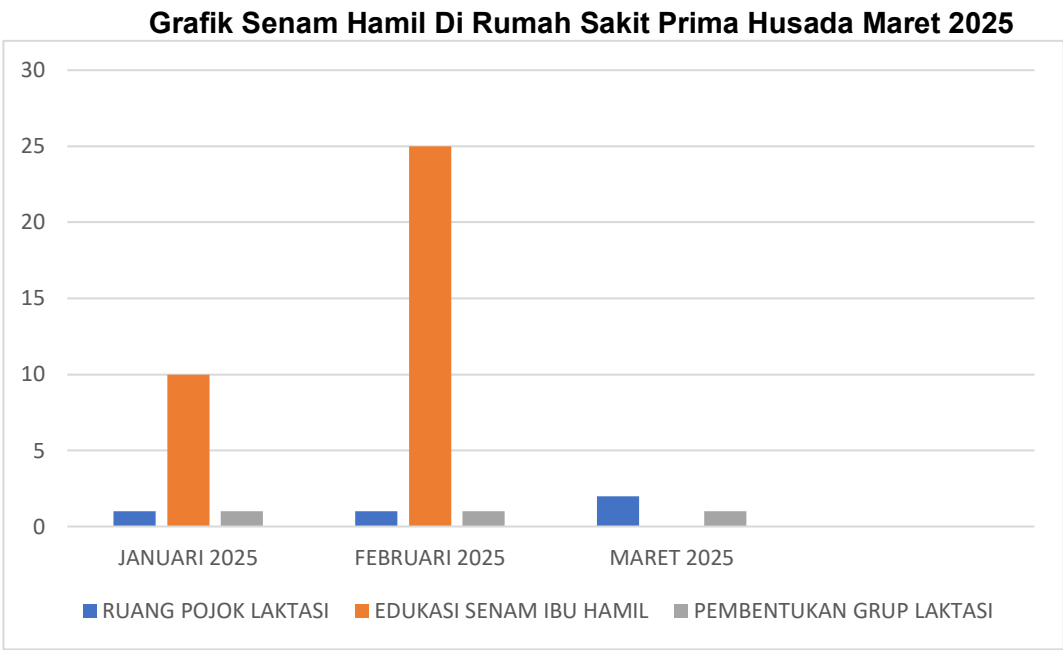
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
Ruang Pojok Laktasi	1	1	2
Senam Hamil	10	25	0
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1



Analisis :

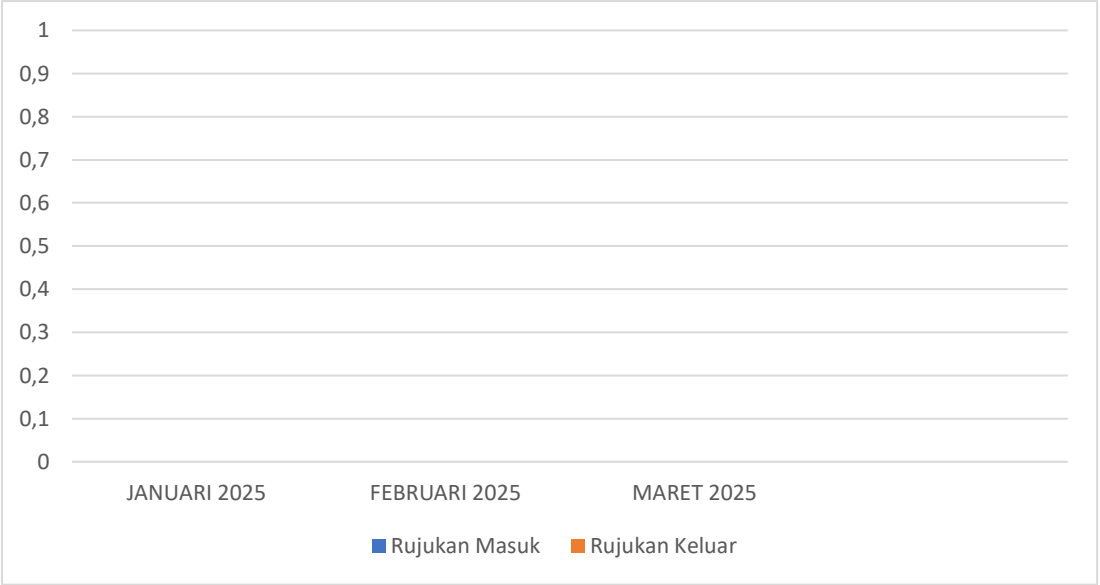
- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Pada bulan Maret edukasi pada senam ibu hamil ditiadakan, bertepatan dengan bulan Ramadhan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

**3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi**

RUJUKAN MASUK				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-



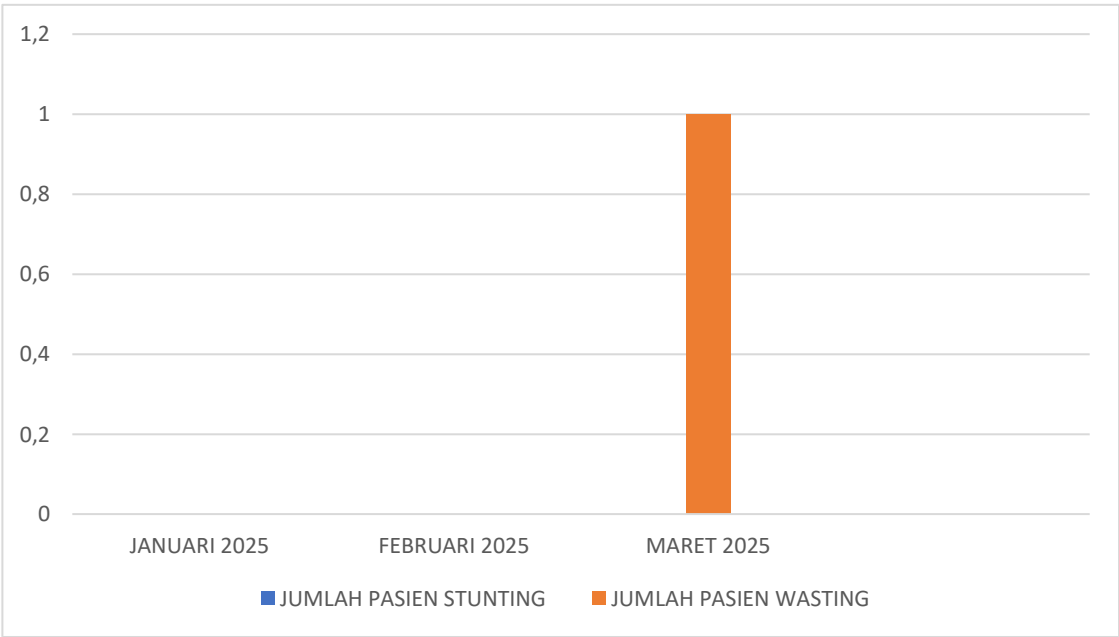
Analisis :
Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan
Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	MARET 2025
Jumlah Pasien Stunting	0	0	0
Jumlah Pasien Wasting	0	0	1

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :

Terdapat 1 pasien *wasting* pada bulan Maret 2025. Hal tersebut berkaitan dengan kebiasaan makan yang salah pada pasien. Ibu pasien mengatakan anak hanya suka makan dengan nasi dan kecap saja sehari-harinya. Di mana kebutuhan energi anak defisit tingkat berat, makanan yang dimakan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Sehingga berdasarkan berat badan menurut umur pasien termasuk *wasting*.

Rencana Tindak Lanjut :

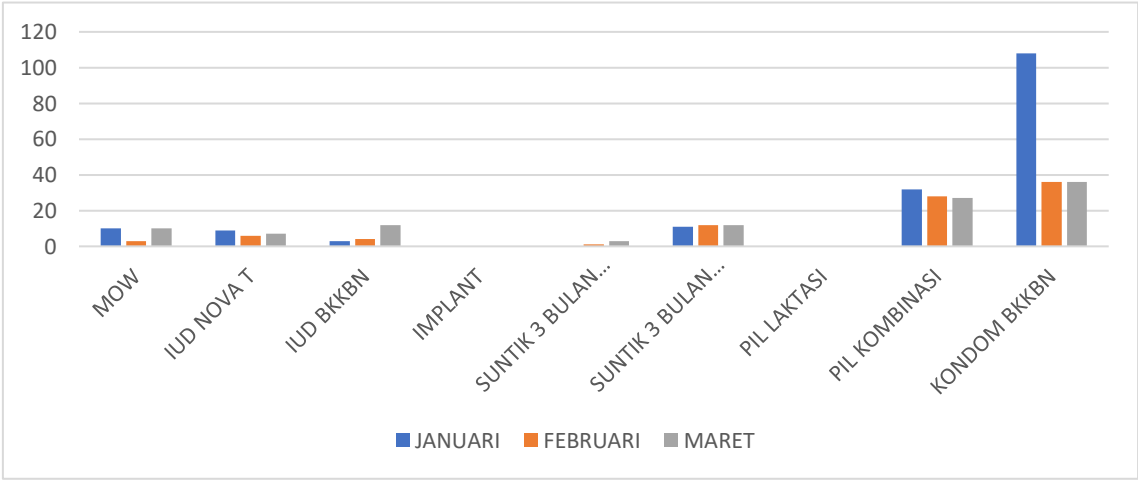
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita *wasting* tersebut pada bulan April.

3.1.2.5 KBRS

3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	MOW	10	3	10
2	IUD Nova T	9	6	7
3	IUD BKKBN	3	4	12
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	3	1	3
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	11	12	12
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	32	28	27
9	PIL LAKTASI	0	0	0
10	KONDOM BKKBN	108	36	36

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

- 1. Peserta MOW pada bulan Januari (10) Februari (3) naik Maret (10)
- 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Januari (9) Februari (6) Maret (7)
- 3. Peserta IUD BKKBN Januari (3) naik Februari (4) Maret (12)
- 4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Januari (3) turun Februari (1) naik Maret (3)
- 5. Peserta KB suntik progestin Januari (11) naik Februari (12) Maret tetap (12)
- 6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Januari (32) turun Februari (28) Maret (27)
- 7. Peserta KB Kondom pada bulan Januari (108) menurun Februari (36) Maret tetap (36)

Analisis :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

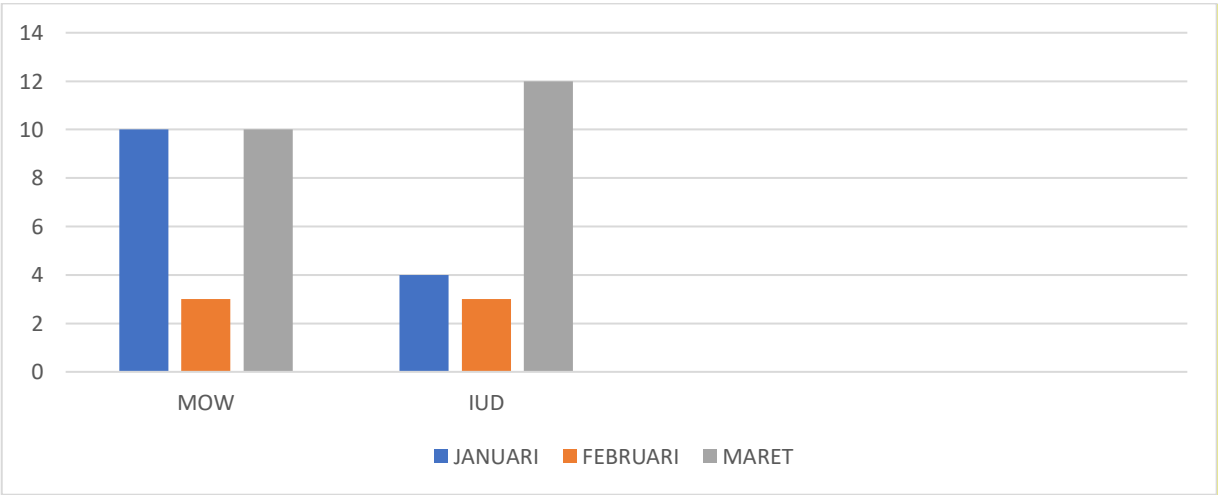
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Persalinan

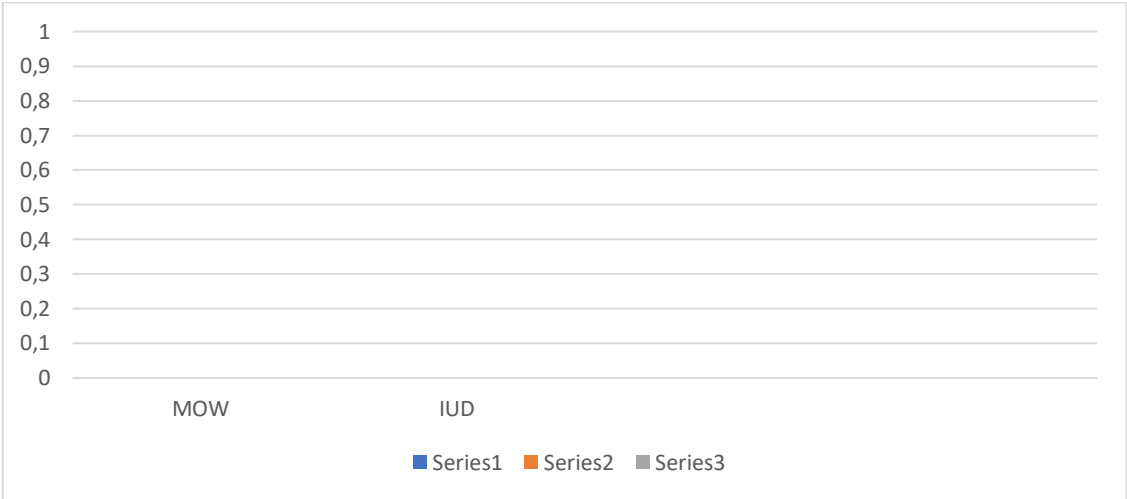
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2024	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	MOW	10	3	10
2	IUD	4	3	12

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN MARET 2025
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Januari-Februari-Maret meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Januari-Februari-Maret menetap.

Analisis :

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2025

1.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Januari 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Evani Sanchia	P/35	dr. Humaira, Sp.OG	216894	Pre Eklamsia Ringan	31/12/2024	02/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
2	Rifa Kumala	P/48	dr. Pradana, Sp. U	194596	Cystoscopy	02/01/2025	04/01/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
3	Badariyah	P/55	dr. Ardhi, Sp.Pd	220134	DM type 2	02/01/2025	06/01/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Levofloxacin po		1x0.5	1,5	0,5	3
4	Robanah	P/64	dr. Zora, Sp.PD	224961	DM Hiperglikemi	04/01/2025	08/01/2025	5	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	1,4	0,8	1,75
									Asam Pipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2,5
5	Muliani	P/68	dr. Yoga, Sp.JP	149322	Dyspnea	05/01/2025	10/01/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Ciprofloxacin po		2x0,5	4,5	1	4,5
6	Wahyu Aris	L/27	dr. Zaki, Sp.B	225127	Hemoroid	06/01/2025	09/01/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
7	Supiani	P/44	dr. Aida, Sp.OG	223418	PRM	07/01/2025	09/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
8	Supriyadi	L/46	dr. Anton, Sp.B	212029	Necrotizing fasciitis	07/01/2025	09/01/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftizoxime		3x1	6	4	1,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
9	Suliana	P/34	dr. Anton, Sp.B	199917	Necrotizing fasciitis	14/01/2025	16/01/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3.5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
10	Rara Ayu	P/29	dr. Aida, Sp.OG	156799	SC	16/01/2025	18/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67

									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11	Musringatun	P/46	dr. Zaki, Sp.B	095948	Susp appendicitis acute	16/01/2025	19/01/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
12	Paeri	L/63	dr. Ardhany, Sp. Pd	225648	Systemic inflamatory	16/01/2025	19/01/2025	4	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3
13	Desi Ayu	P/29	dr. Humaira, Sp. OG	217065	SC	17/01/2025	19/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
14	Sulasmini	P/57	dr. Ira, Sp.JP	225708	Angina Pectoris	17/01/2025	24/01/2025	8	Azitromycin	2	1x1	1,5	0,3	5
									Levofloxacin inf		1x0.75	3	0,5	6
15	Paini	P/58	dr. Zaki, Sp.B	213310	Cholangitis ikterik	18/01/2025	19/01/2025	2	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	0,8	0,8	1
									Metronidazole inf		3x0,5	3	1,5	2
16	Suryanto	L/61	dr. Farid, Sp. U	201834	CVA	18/01/2025	21/01/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
17	Tjong Sui Lan	P/69	dr. Ardhiij, Sp.Pd	174685	Colic Abdomen	19/01/2025	26/01/2025	8	Ceftiaxone	2	2x1	4	2	2
									Cefoperazone		2x1	10	4	2,5
18	Atim	P/63	dr. Zaky, Sp.B	064323	Gangren daibeticum	22/01/2025	25/01/2025	4	Ceftriaxone	3	2x1	7	2	3,5
									Cefoperazone		1x2	2	4	0,5
									Metronidazole inf		3x0,5	5	1,5	3,33
19	Ngadi	L/72	dr. Elvi, Sp.P	225992	Dyspnea	22/01/2025	25/01/2025	4	Ceftriaxone	3	2x1	4	2	2
									Levofloxacin inf		1x0,75	1,5	0,5	3
									Asam Ppipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2,5
20	Kustinah D	P/50	dr. Heri, Sp.Pd	225997	DM type 2	22/01/2025	26/01/2025	5	Ceftiaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	3,6	0,8	4,5

1.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Februari 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Santoso	L/59	dr. Yoga, Sp.JP	226229	Syok Kardiogenik	27/01/2025	02/02/2025	7	Ceftriaxone	2	2x1	14	2	7
									Levofloxacin po		1x0,5	3,5	0,5	7
2	Muslica	P/64	dr. Zaki, Sp. B	226256	Necrotizing facitis	28/01/2025	02/02/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Metronidazole inf		3x0,5	7,5	1,5	5
3	M Ifham C	L/66	dr. Anton, Sp.B	226468	Ganggren Diabetic	01/02/2025	03/02/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
4	Mudjayanah	P/61	dr. Heri, Sp.Pd	226249	DM type 2	01/02/2025	05/02/2025	5	Ceftiaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2,4	0,8	3
5	Ani Ati	P/63	dr. Heri, Sp.Pd	217025	OF	02/02/2025	05/02/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Metronidazole inf		2x0,5	3,5	1,5	2,33
6	Munjiono	L/45	dr. Anton, Sp.B	226500	Necrotizing fasciitis	03/02/2025	05/02/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	6	2	3
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
7	Tasu'in	L/67	dr. Ardhany, Sp. Pd	226683	Malaise and fatigue	05/02/2025	07/02/2025	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3
8	Ponimi	P/68	dr. Zaki, Sp.Pd	226831	Post of Amputasi	07/02/2025	10/02/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Metronidazole inf		3x0,5	4,5	1,5	3
9	Nabilla I	P/25	dr. Ardhany, Sp.Pd	221471	Diarrhoea	07/02/2025	10/02/2025	4	Asam Pipemidat	2	2x0,4	2	8	2,5
									Metronidazole po		3x0,5	3	1,5	2
10	Sukardi	L/74	dr. Andy, Sp. P	200612	COPD, HT	08/02/2025	13/02/2025	6	Azitromycin po	1	1x0,5	2,5	0,3	8,3
11	Wahyu Saskya	P/23	dr. Aida, Sp.OG	227002	SC	10/02/2025	12/02/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67

									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
12	Shofi'i K	L/64	dr. Zaki, Sp.B	227077	Gangrene	11/02/2025	13/02/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
13	Chrismi Ismawati	P/24	dr. Humaira, Sp.OG	227058	Preamture repture	11/02/2025	13/02/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
14	Wiwik Indrayani	P/32	dr. Andi, Sp.B	226390	Abses Mamae Dextra	13/02/2025	16/02/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Metronidazole inf		3x0,5	4,5	1,5	3
15	Wartani	L/65	dr. Anton, Sp.B	186975	Appendicitis pedis	19/02/2025	22/02/2025	4	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3.5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
16	Sri Mardiana	P/59	dr. Ira, Sp. Jp	113462	ADHF, Susp Pneumoni	20/02/2025	24/02/2025	5	Azitromycin po	1	1x0,5	1,5	0,3	5
17	Yossy Dwi	P/28	dr. Heri, Sp.Pd	227564	TF	22/02/2025	28/02/2025	7	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2,4	0,8	3
18	Ratnawati	P/40	dr. Humaira, Sp.OG	227676	PEB	24/02/2025	26/02/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
19	Tumiasih	P/46	dr. Zaki, Sp.B	211797	Hemoroid	24/02/2025	27/02/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
20	Rosati	P/51	dr. Pradana, Sp. U	067107	Observation for susp malignant	25/02/2025	28/02/2025	4	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5

1.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Maret 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	M Sueb	L/57	dr. Heri, Sp.Pd	227934	OF H-8	01/03/2025	07/03/2025	7	Levofloxacin po	2	1x0,75	5,25	0,5	10,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
2	Sanusi	L/72	dr. Andy, Sp.P	197323	Dyspnea	03/03/2025	07/03/2025	3	Azitromycin po	3	1x0,5	1	0,3	3,33
									Meropenem		2x1	6	3	2
									Levofloxacin inf		3x0,25	1,5	0,5	3
3	Anam Jumadi	L/44	dr. Aji, Sp.Pd	123986	Enchelophathy	09/03/2025	10/03/2025	2	Metronidazole inf	2	4x0,5	3,5	1,5	2,33
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
4	David Adi	L/23	dr. Zaki, Sp.B	093671	COS 345	10/03/2025	13/03/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
5	Friska Mey	P/27	dr. Humaira, Sp.OG	225378	Gravida SC	11/03/2025	13/03/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
6	Edis Adelia	P/16	dr. Aida, Sp.OG	228456	SC	11/03/2025	13/03/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Revalino T	L/26	dr. Arianto, Sp.OT	103388	CF Patela	11/03/2025	14/03/2025	4	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
8	Muhammad Noer	L/21	dr. Farid, Sp. N	049242	Chronic intractable pain	11/03/2025	15/03/2025	5	Clindamycin	1	4x0,6	7,2	1,2	6
9	Siti Mukhayana	P/55	dr. Ard hany, Sp. Pd	222081	Vomiting ec urenia	12/03/2025	15/03/2025	4	Levofloxacin	1	1x0,5	0,5	0,5	1
10	Silviana C	P/29	dr. Humaira, Sp.OG	228119	Floating Head	14/03/2025	16/03/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11	Yohana S	P/46	dr. Ard hany, Sp. Pd	228595	CKD stage 2	14/03/2025	16/03/2025	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3
12	Irwan Rahman	L/38	dr. Anton, Sp.B	150624	Hidrocel testis	14/03/2025	16/03/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5

13	Kasnawi	L/70	dr. Ardhi, Sp.Pd	024214	DM + Hidronefrosis renal	15/03/2025	19/03/2025	5	Ceftriaxone Asam Pipemidat	2	2x1	8	2	4
14	Nisviyatul Amri	P/46	dr. Oka, Sp.OT	093688	Flexor Tenosynovitis	16/03/2025	18/03/2025	3	Ceftriaxone Ceftriaxone	2	2x0.4	1,6	0,8	2,5
15	Ruminah	P/64	dr. Arianto, Sp.OT	228665	Ruptur tendon flexor	16/03/2025	18/03/2025	3	Ceftriaxone Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
16	M Mukhlis	L/62	dr. Aji, Sp. Pd	228666	Chronic diarrhea	16/03/2025	20/03/2025	5	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	3,5	1	3,5
17	M Firmansyah	L/25	dr. Pradana, Sp. U	045530	Stricture Uretra	18/03/2025	20/03/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
18	Sudarsih	L/75	dr. Pradana, Sp. U	088276	Susp Nefroliasis	26/03/2025	29/03/2025	4	Gentamycin	1	2x0,04	0,28	0,24	1,167
19	Nurul Yaqin	L/58	dr. Anton, Sp.B	166085	Gangren anogenital	28/03/2025	30/03/2025	3	Ceftriaxone Ceftriaxone Metronidazole po	3	1x1 2x1 3x0,25	1 4 1,5	2 2 2	0.5 2 7,5
20	Anggelina K	P/20	dr. Sigit, Sp. BP	229132	Injury of unspecified	28/03/2025	30/03/2025	3	Cefazolin	1	2x1	6	3	2

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

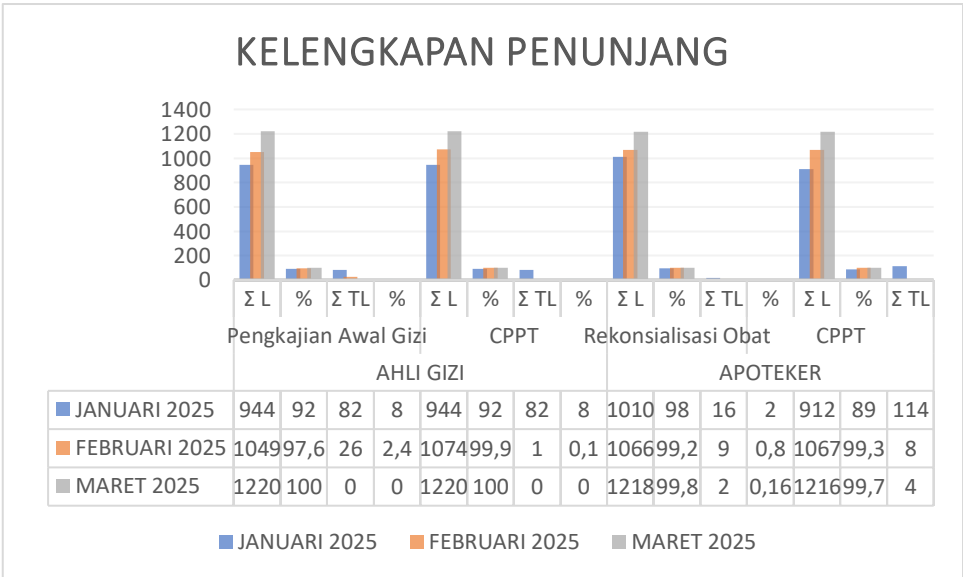
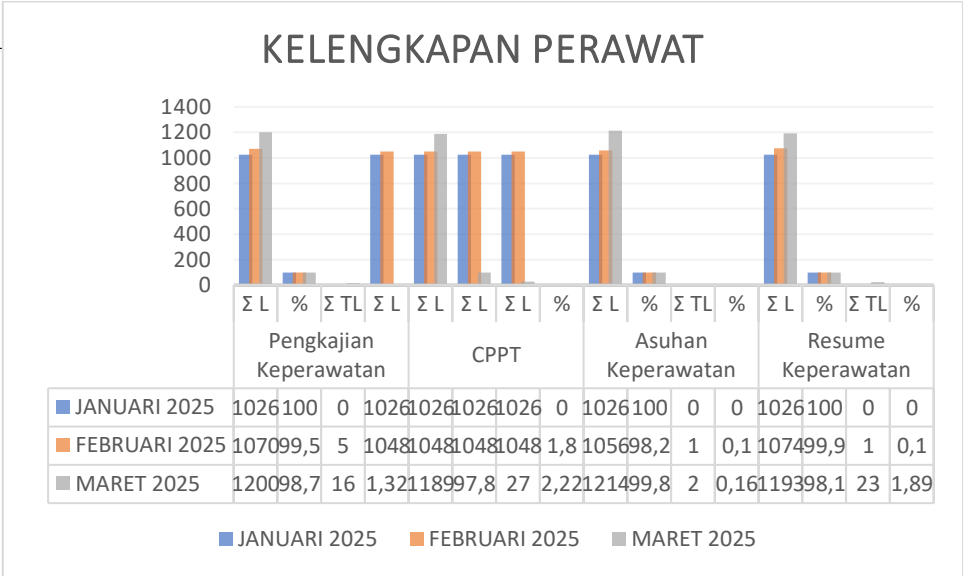
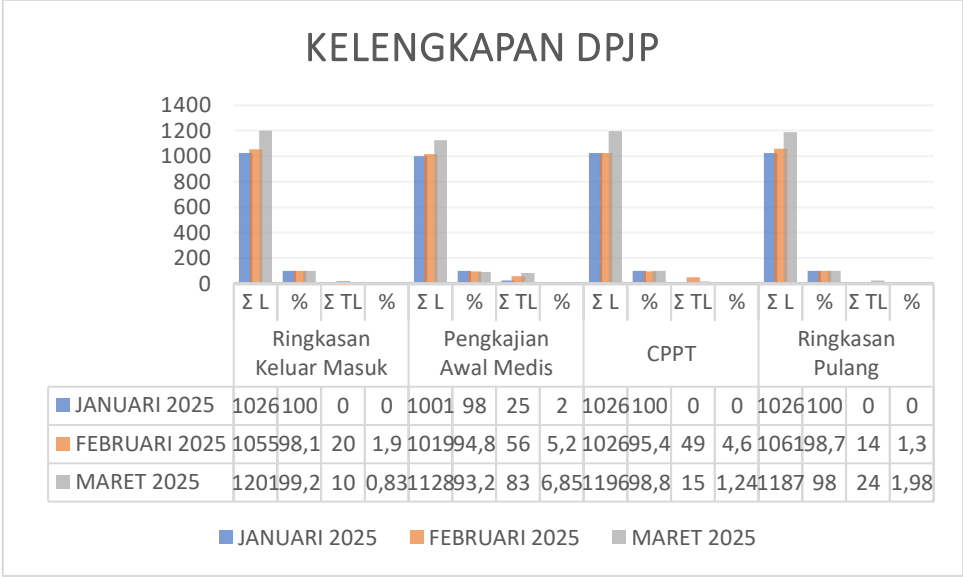
3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Maret Tahun 2025

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1026	100	0	0	1001	98	25	2	1026	100	0	0	1026	100	0	0
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	Σ L	Σ L	Σ L	Σ L	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1026	100	0	1026	1026	1026	1026	0	1026	100	0	0	1026	100	0	0
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Februari	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
Maret	1220	100	0	0	1220	100	0	0	1218	99.84	2	0.16	1216	99.67	4	0.33

3.6.6.2 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Januari – Maret Tahun 2025



Analisis :

1. Kelengkapan DRM rawat inap DPJP dan Perawat mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena perubahan alur analisa rekam medis, perawat melakukan setor terlebih dahulu ke petugas rekam medis sehingga data yang didapatkan valid.
2. Kelengkapan DRM penunjang mengalami peningkatan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
2. Melakukan supervise secara berkala.
3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
4. Membuat rapot ketidaklengkapan dan kolaborasi dengan Kabid Keperawatan.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.1 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Kurang disiplinnya penginputan BMHP /obat di IKO membuat selisih SO positif	P	Memberikan sosialisasi kepada petugas IKO tentang pentingnya penginputan obat yang akurat dan disiplin Memantau dan mengevaluasi penginputan obat di IKO untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan standart
		D	Melakukan sosialisasi penginputan obat kepada petugas IKO
		S	Mengevaluasi penginputan obat di IKO untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan standart
		A	Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisa data
2	Skiren dari unit irna masih kurang bersih	P	Berkoordinasi dengan unit irna terkait dengan skiren sebelum operasi
		D	Sosialisasi ke semua unit untuk skiren sebelum menurunkan operasi
		S	Menemukan beberapa pasien sudah di skiren tetapi masih belum bersih
		A	Menjalankan skiren yang bersih sebelum pasien di transfer ke IKO
3	Petugas RR kurang paham dalam advice dpjp yang di tulis di CPPT pada saat operan ke petugas IRNA	P	Mensosialisasikan petugas RR tentang cara operan yang baik terhadap perawat rawat inap dan advice yang di berikan DPJP dengan lengkap
		D	Mengawasi dan mengevaluasi kinerja petugas RR saat mengoperi anak IRNA
		S	Mengevaluasi kinerja petugas RR saat mengoperi anak IRNA untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan standart
		A	Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisa data

3.7.2 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Alur IGD dengan Kains lama yang lebih ribet/lama	P	Identifikasi masalah: Waktu tunggu pasien di IGD terlalu lama Tujuan: Mengurangi waktu tunggu pasien di IGD Rencana:Meningkatkan efisiensi proses penerimaan pasien dan pengkajian
		D	Implementasi rencana: Meningkatkan jumlah petugas penerimaan pasien dan pengkajian Pemantauan waktu tunggu pasien
		S	Analisis data: Menganalisis data waktu tunggu pasien sebelum dan setelah implementasi rencana. Identifikasi kesulitan: Mengidentifikasi kesulitan yang di hadapi dalam implementasi rencana
		A	Tindakan: Mengambil tindakan dengan merubah alur yang sekarang Evaluasi: Mengevaluasi efektivitas dengan alur yang baru
2	Pelayanan di IGD yang masih sering ada komplain terkait komunikasi pasien	P	1. Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi kebutuhan komunikasi pasien dan keluarga pasien di IGD 2.Pelatihan petugas:Memberikan pelatihan kepada petugas IGD tentang teknik komunikasi 3.Pengembangan protokol komunikasi: Mengembangkan protokol komunikasi yang jelas dan standart untuk digunakan di IGD
		D	1.Implementasi pelatihan: Melakukan pelatihan kepada petugas IGD tentang teknik komunikasi yang efektif 2.Penggunaan protokol komunikasi: Menggunakan protokol komunikasi yang telah dikembangkan di IGD
		S	1.Evaluasi kualitas komunikasi: Mengevaluasi kualitas komunikasi di IGD melalui survei pasien dan keluarga pasien 2.Analisa Data: Menganalisis data yang diperoleh dari survei untuk mengetahui apakah kualitas komunikasi di IGD telah meningkat
		A	1.Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisa data
3	Dokter IGD masih tergantung bidan jika ada masalah obgyn di IGD	P	1.Memberikan pelatihan kepada dokter IGD tentang penanganan pasien OBGYN 2.Meningkatkan kerja sama antara dokter IGD dan bidan dalam menangani pasien OBGYN
		D	Melakukan pelatihan kepada dokter IGD tentang penanganan pasien OBGYN Melakukan pelatihan menggunakan alat bantu diagnostik seperti USG dan laboratorium di IGD
		S	1. Mengevaluasi kemampuan dokter IGD dalam menangani pasien OBGYN sebelum dan sesudah pelatihan

		A	1.Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisi data 2.Meningkatkan kerja sama antara dokter IGD dan bidan dalam menangani pasien OBGYN
4	Penulisan SBAR masih belum sesuai	P	Memberikan sosialisasi kepada dokter dan perawat yang membantu menulis SBAR di IGD. Memantau dan mengevaluasi penulisan SBAR di IGD untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan standart
		D	Mensosialisasi kembali penulisan SBAR sesuai dengan SPO dan panduan
		S	Mengevaluasi penulisan SBAR apakah ada perubahan
		A	Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis data Meningkatkan pelatihan SBAR untuk tim medis

3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Terkait MUTU unit ada perubahan semua IRNA	P	1.Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas perubahan MUTU di IRNA 2.Memberikan staf pelatihan mutu terbaru di IRNA
		D	1. Melakukan implementasi rencana aksi untuk meningkatkan mutu unit 2. mengawasi dan mengevaluasi proses perubahan MUTU IRNA
		S	1. Mengevaluasi proses perubahan MUTU IRNA untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan standart
		A	1. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi proses perubahan IRNA untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan standart
2	Komunikasi kurang efektif antara farmasi dan gudang farmasi terkait stok BMHP breathing	P	1.Mengidentifikasi kebutuhan komunikasi yang efektif terkait farmasi dan gudang farmasi
		D	1.Berkoordinasi antara unit farmasi dan gudang farmasi sehingga stok BMHP di irna selalu ada
		S	1.Mengevaluasi komunikasi antara farmasi dan gudang farmasi untuk memastikan bahwa telah efektif
		A	1.Berkoordinasi dengan kains farmasi ,gudang dan IRNA

3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Kurang patuhnya DPJP mencentang ITER pada resep perlu di evaluasi	P	Mensosialisasikan kepada DPJP tentang pentingnya mencentang ITER pada resep. Memberikan umpan balik kepada DPJP tentang ketaatan mereka dalam mencentang ITER
		D	Melakukan sosialisasi DPJP tentang pentingnya mencentang ITER resep Mengawasi dan mengevaluasi ketaatan DPJP dalam mencentang ITER pada resep
		S	Mengevaluasi ketaatan DPJP dalam mencentang

2	Fasilitas USG 4D poli OBGYN sakura mengalami kerusakan		ITER pada resep untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan standart
		A	Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisa data
		P	1.Mengidentifikasi penyebab kerusakan fasilitas USG 4D 2.Mengajukan permintaan perbaikan kepada pihak PT 3.Menggunakan fasilitas USG 4D alternatif jika memungkinkan
		D	Melakukan identifikasi penyebab kerusakan fasilitas USG 4D Mengajukan permintaan perbaikan kepada pihak ATEM
		S	Menganalisis data yang diperoleh dari evaluasi untuk mengetahui apakah proses perbaikan telah efektif
		A	Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisa data

3.7.5
Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Retur barang dari rawat inap : - Obat tak bertuan → gudang retur (secara sistem), namun fisiknya dikembalikan ke rak barang retur di depo farmasi → setelah diretur ke gudang, kains akan order obat dengan jumlah sesuai yang ada di gudang retur agar dapat dimasukkan kembali menjadi stok depo. - Obat bertuan → depo farmasi melalui fitur Retur Penjualan. - Retur barang dari rawat jalan → depo farmasi melalui fitur Retur Penjualan.	P	Penambahan fitur oleh progamer
		D	1. Penentuan alur retur obat untuk meminimalkan selisih stok 2. Koordinasi dengan progamer untuk penambahan fitur
		S	Tidak perlu ada gudang retur karena menambah rantai proses retur yang tidak Diperlukan. Untuk efisiensi, seluruh obat dari unit baik bertuan atau tidak harus dikembalikan melalui depo farmasi.
		A	1. Obat bertuan dikembalikan melalui fitur Retur Penjualan. 2. Obat tidak bertuan dikembalikan melalui fitur sesuai dengan kondisinya. Maka diperlukan penambahan fitur : - Penerimaan Barang Konsinyasi - Penerimaan Obat yang Dibeli Antar RS - Penerimaan Obat Tidak Bertuan 3. Fitur penerimaan farmasi lainnya dibuat berjenjang : diajukan oleh Kains Farmasi (dengan adanya fitur keterangan untuk menjelaskan alasan penerimaan obat lainnya) → diapprove oleh PT → baru bisa menambah ke stok depo. Berita Acara tetap dilampirkan sebagai arsip RS. 4. Buat PJ retur tiap shift di depo yang bertanggung jawab terhadap proses retur mulai dari penerimaan barang fisik, penginputan ke sistem, penilaian obat layak/tidak, pengembalian obat retur di Rak Obat Depo.

2.	Temuan pada tanggal 17-18 maret 2025 : Fitur Penerimaan Farmasi Lain tidak bisa digunakan untuk input barang konsinyasi sehingga memperlambat pelayanan untuk release stok ke IKO. Fitur Penerimaan Barang Farmasi tidak bisa menambah stok meskipun sudah di release menyebabkan selisih stok.	P	Perbaiki fitur oleh Progamer.
		D	1. Koordinasi dengan Progamer 2. Progamer update fitur di SIMRS
		S	1. Fitur Penerimaan Farmasi Lain untuk input barang konsinyasi khususnya implan karna belum ada master barang sehingga stok belum ada di sistem. 2. Fitur Penerimaan Barang Farmasi untuk input faktur agar menambah stok di sistem.
3.	Beberapa DPJP input 2 resep berbeda di Poli Rawat Jalan yaitu : - Resep obat nebul (Vellutin, Pulmicort, Combivent) dan masker nebul tiap DPJP berbeda ada yang centang Obat Paket sehingga tarif tidak muncul dan ada tidak centang Obat Paket tarif muncul di Tim Asuransi Center. - Resep obat minum Hal ini menyebabkan perbedaan tarif tiap pasien dan farmasi tidak bisa tracking total resep pasien karena diinputkan 2 resep.	A	1. Follow up ke progamer. 2. Monitoring dan evaluasi SIMRS.
		P	Perubahan alur resep obat dan BMHP tindakan nebul di Poli Rawat Jalan.
		D	1. Koordinasi dengan Karu Asuransi Center. 2. Perhitungan tarif jasa dokter, jasa tindakan dan plafon obat rawat jalan sebesar Rp 338.300.
		S	Resep obat dan BMHP nebul masuk tarif rawat jalan sehingga tidak boleh di centang Obat Paket.
4.	Perubahan alur permintaan SPB (Surat Permintaan Barang) ke gudang farmasi menjadi 3 kali dalam seminggu.	A	Resep obat nebul dan BMHP serta obat rawat jalan total plafon obat Rp 150.000 (Tidak dicentang Obat Paket).
		P	Permintaan SPB (Surat Permintaan Barang) ke gudang farmasi menjadi 3 kali dalam seminggu.
		D	Direktur RS dan Kabid Penunjang Medis melakukan koordinasi dengan Kains Farmasi
		S	Perubahan alur permintaan SPB (Surat Permintaan Barang) ke gudang farmasi menjadi 3 kali dalam seminggu. Tujuannya agar tidak ada serah terima pada jam ramai pasien, tidak ada tambahan barang diluar jam gudang farmasi dan plottingan jaga gudang farmasi ke depannya 2 orang.
5.	Alur permintaan Breathing Circuit Bubble Cpap; Breating Circuit	A	1. Tanggal 5 Maret 2025 Kains Farmasi koordinasi dengan PT untuk penataan ruang dan penambahan lemari buffer stok. 2. Tanggal 6 Maret 2025 Ruang buffer sudah tersedia di ruang sebelah depo farmasi maka ruangan sebelah harus tetap terkunci. 3. Perubahan alur input SPB pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari serah terima barang tiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. 4. Pengawasan external dengan penambahan cctv dan pengajuan smart door lock. 5. Evaluasi sistem ROP.
		P	Perubahan alur permintaan bmhp breathing CPAP dan bmhp breathing ventilator untuk pasien umum

	Double Heated Wire Neonatal; Breathing Circuit Ventilator Adult; Breathing Circuit Ventilator Child untuk pasien umum diinput BMHP ke gudang farmasi. Hal ini menyebabkan sering selisih stok dikarenakan perawat tidak ada stok breathing di ruangan. Jika ada permintaan pada malam hari dan gudang tutup jadi perawat ambil barangnya ke depo dan utang barang ke depo namun operan farmasi tidak jalan sehingga lupa tidak follow up ke perawat.	D	Melakukan koordinasi dengan Kabid Penunjang Medis, Kabid Keperawatan, dan Karu
		S	1. Breathing Circuit Bubble Cpap; Breathing Circuit Double Heated Wire Neonatal; Breathing Circuit Ventilator Adult; Breathing Circuit Ventilator Child tarif BMHP sudah termasuk jasa tindakan CPAP dan Ventilator.
		A	Perubahan alur permintaan Breathing Circuit Bubble Cpap; Breathing Circuit Double Heated Wire Neonatal; Breathing Circuit Ventilator Adult; Breathing Circuit Ventilator Child khusus penjamin UMUM : 1. Perawat input Breathing Circuit CPAP atau Breathing Ventilator pada fitur resep "Tambah Paket" di biling perawat artinya input resep tanpa tarif. 2. Farmasi cek resep sudah tercentang obat paket dan simpan resep. Tujuan : tidak ada tambahan tarif. 3. Perawat ambil barang ke depo farmasi 4. Permintaan BMHP ke Gudang Farmasi khusus Breathing Circuit Bubble Cpap; Breathing Circuit Double Heated Wire Neonatal; Breathing Circuit Ventilator Adult; Breathing Circuit Ventilator Child ditiadakan.
6.	Alur paket kuret ODC di Rawat Jalan yang semula diinput perawat rawat jalan namun salah input resep di Tambah Paket sehingga tarif tidak muncul di keuangan.	P	Evaluasi alur peresepan paket kuret ODC Rawat Jalan.
		D	Melakukan koordinasi dengan Kabid Pelayanan Medis dan Verifikator.
		S	Resep paket kuret ODC rawat jalan tarif harus muncul di keuangan untuk di klaim.
		A	Alur peresepan paket kuret ODC RJ disepakati diinput oleh bidan maternitas. Alurnya: 1. Apabila pasien berkunjung ke poli → advice tindakan kuret → paket di ambil oleh maternitas → bidan input resep paket kuret sesuai yg terpakai. 2. Apabila pasien dijadwalkan kuret → pasien ke igd → paket diambil bidan ponek igd → bidan input resep paket kuret sesuai yg terpakai. 3. Farmasi mengambil paket kuret dan menyiapkan tambahan sesuai list. 4. Farmasi cek inputan resep sesuai yg terpakai dan cek resep tanpa centang obat paket (agar tagihan tetap masuk dikeuangan).
7.	Hasil stok opname farmasi yang sudah stabil pada akhir tahun 2024 dan belum mencapai target selisih 0.	1	Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname
		D	1. Berdasarkan Surat Edaran dari RS Nomor 218/I-SE/DIR/III/2025 tentang Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname Farmasi disampaikan beberapa kebijakan
		S	Evaluasi hasil stok opname belum mencapai target 0

		A	1. Penyesuaian / Adjustment stock (akibat dari adanya selisih hasil stock opname) dengan acuan selisih wajar sebesar 1% dari total persediaan TIDAK LAGI DIBERLAKUKAN per 1 Januari 2025. 2. Acuan selisih hasil SO sesuai dengan BA (Berita Acara) hasil SO. 3. Selisih Kurang (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO < jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu dan menentukan unit yang terlibat kemudian hitung beban 60% kepada Manajemen Rumah Sakit (Direktur Rumah Sakit, Kabid Penunjang, Kabid Pelayanan Medis, Kabid Keperawatan, Kabid Umum & keuangan, Kains. Farmasi). Penanggung jawab rak dan unit terlibat sebesar 40% dari jumlah selisih SO. Pembebanan langsung pada periode berjalan. 4. Selisih Lebih (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO > jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu, jika selisih lebih masih dalam selisih wajar tidak dibebankan, jika terdapat selisih lebih yang mengalami peningkatan ekstrim, maka diberlakukan pembebanan selisih lebih hasil SO berupa teguran tertulis dari direktur rumah sakit kepada unit penyebab selisih SO dan penanggung jawab rak. 5. Hasil dari perhitungan selisih akan disesuaikan dalam penggajian setiap bulan
8.	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif. Januari 2025 : +226.818 Februari 2025 : +5.439.289 Maret 2025 : +1.009.675 Belum berjalan scan barcode menunggu antrian Programmer PT.	P	Perencanaan scan barcode.
		D	1. Mengajukan proposal scan barcode dan mengajukan kebutuhan alat yang menunjang pelayanan. 2. Melakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya.
		S	1. Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien.
		A	Pengajuan software aplikasi barcode ke progamer dan pengajuan alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper ke Pengadaan Umum PT. DPM.
9.	Pelaksanaan Stok Opname Bulan Maret 2025	P	Perubahan alur SO dari PT agar perhitungan SO didampingi oleh PT
		D	Membuat alur pelayanan obat berjalan saat stok opname.

		S	1. Petugas input konfirmasi ke petugas hitung yang terkadang tetap menulis di kertas/ data pengeluaran barang sehingga menimbulkan selisih saat perhitungan SO. 2. Terdapat beberapa pengeluaran obat untuk Poli Rawat Jalan, Rawat Inap, dan IGD dengan waktu perhitungan.
		A	a. Alur : 1. SO dimulai pukul 19:00 WIB setiap minggu terakhir / bulan, Kains Farmasi memastikan layanan berhenti pukul 19:00 WIB pada hari Sabtu. 2. Tim Auditor datang pukul 19:00 WIB untuk open periode SO, dipastikan tidak ada pelayanan resep melalui SIMRS dan fisik, jika pun ada emergency maka menggunakan resep manual, dan pengurangan pada kertas kerja. 3. Perhitungan ulang saat verifikasi SO setiap rak terdiri atas pendampingan 1 tim auditor dan 1 staff unit farmasi. 4. Input SO pada SIMRS bisa dilakukan oleh auditor dan staff unit farmasi. 5. Verifikator dilakukan oleh tim SO, dan closing dilakukan pada hari Minggu setelah rak SO dengan status close. 6. Programmer memastikan semua fitur yang dapat menampilkan stock sistem pada saat periode SO di NON AKTIFKAN. 7. Programmer menonaktifkan monitoring stock 2 hari sebelum jadwal SO. 8. Petugas Gudang farmasi memastikan H-1 sebelum pelaksanaan SO semua permintaan barang telah direlease dan tidak ada transaksi saat pelaksanaan SO. 9. Kabid Penunjang RS diperlukan untuk pendampingan dalam proses SO.
10.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 74.45% dan waktu tunggu obat racikan 59.59%	P	Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur KPO digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. 1. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	1. Follow up ke Programmer. 2. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. 3. KPO tertinggal ada 133 KPO.
11.	Obat tertinggal 2x24 jam	P	Perbaikan kebijakan obat tertinggal.
		D	Membuat rekapan pasien yang sudah mendapat pengantaran gratis.

		S	1. Obat tertinggal bulan maret sudah mengalami penurunan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam. 2. Primantara sudah menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi.
		A	1. Pasien yang obatnya tertinggal dimintai data agar mudah diidentifikasi. 2. Pengantaran gratis membantu farmasi agar tidak terjadi penumpukan obat tertinggal, terkadang pasien memang ada yang tidak mau tapi tetap di edukasi untuk obat diantar.
12.	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.
		D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi deathmoving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1. Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2. Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan. 3. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur obat near ED kepada distributor.
13.	Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan standar, ditemukan indikator vaksin pemerintah yang berubah warna sehingga tidak layak digunakan.	P	Mengadakan VR di Depo Farmasi sesuai dengan standar penyimpanan vaksin.
		D	1. Memperbaiki VR yang ada supaya bisa digunakan kembali. 2. Mengedukasi perawat dan petugas farmasi terkait penyimpanan yang benar.
		S	1. Vaksin yang tidak layak diberikan kepada pasien bisa dikembalikan ke Puskesmas 2. Wilayah, tetapi RS harus memikirkan bagaimana vaksin tidak sampai diretur.
		A	1. Vaksin pemerintah disimpan di VR Gudang Farmasi. 2. Perubahan alur pengambilan vaksin oleh perawat poli.
14.	Fitur retur barang rusak tidak bisa mengeluarkan stok di monitoring stok.	P	Perbaiki fitur retur barang rusak.
		D	Koordinasi dengan Programmer PT.
		S	1. Barang expired date perlu dikeluarkan stoknya dari SIMRS menggunakan fitur retur barang rusak kemudian dilalukan pemusnahan obat namun fitur tersebut tidak dapat mengeluarkan stok dari sistem.

			2. Sudah dilakukan receive retur namun stok masih muncul di monitoring stok, tapi di pengeluaran barang dan mutasi barang sudah 0.
		A	Follow up progamer.
15.	Floorstok IKO	P	Mendisiplinkan perawat untuk menjalankan SPO.
		D	Koordinasi dengan Kabid Keperawatan.
		S	Kendala di FS IKO dimana perawat anestesi belum menjalankan inputan resep terlebih dahulu kemudian disiapkan oleh farmasi dikarenakan tidak menyanggupi jika operasi berlangsung berturut-turut. Dan informasi SPO sudah diedarkan dan dijelaskan namun perawat belum menjalankan sesuai SPO.
		A	Monitoring dan evaluasi.
16.	Pasien yang mendapatkan pelayanan obat kronis dengan diagnosa P RB.	P	Perbaikan alur pelayanan obat kronis dengan diagnosa PRB.
		D	Pengajuan fitur surat pengantar PRB dari poli ke IFRS di SIMRS sehingga tidak ada lagi kelolosan pasien tidak di PRB di V-Claim
		S	1. Pasien dengan pelayanan obat kronis yang sama selama 3 bulan berturut-turut otomatis masuk ke dalam Program Rujuk Balik (PRB). 2. Pasien dapat berkunjung ke FKRTL dalam kondisi kegawatdaruratan dan/atau untuk kasus sesuai indikasi medis dan ketentuan yang berlaku. Masih banyak pasien yang dirujuk internal dan di lakukan PRB namun DPJP utama tidak dilakukan PRB. 3. Jika pasien PRB dan obat ditinggal maka farmasi kesulitan konfirmasi ke pasien apakah ada surkon ke dokter lain.
		A	1. Pasien PRB : - Jika prb rujukan utama namun masih ada surkon (surat kontrol) internal maka surkon internal di tarik, pasien diarahkan untuk mengambil obat ke FKTP dan kontrol lebih lanjut disana, nanti FKTP yang memutuskan apakah lanjut kontrol ke rs atau tidak. - Jika prb rujukan internal namun rujukan utama belum prb maka koordinasi dengan karu poli untuk dikoordinasikan dengan DPJP agar rujukan utama dijadwalkan PRB. 2. Primantara wajib menanyakan dulu ke pasien apakah pasien ada surkon ke dokter lain. Jika pasien ambil obat yang ditinggal maka farmasi konfirmasi terlebih dahulu saat ambil obat.

3.7.6 Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortorium RSPH Malang.
		D	Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikan dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.
		A	Follow up berkala ke Programmer.
2.	Petugas belum kompeten dalam pelaksanaan crossmatch labu darah	P	Mendaftarkan pelatihan/magang secara bergilir.
		D	1) Melakukan pendampingan terhadap petugas yang melakukan crossmatch. 2) Melakukan pelatihan dengan vendor.
		S	Hasil crossmatch menentukan apakah labu darah bisa diberikan kepada pasien atau tidak, jika hasil aglutinasi positif maka tidak bisa diberikan.
		A	1) Melakukan pencatatan pengulangan kegiatan crossmatch. 2) Permintaan labu darah cito ketika malam hari sementara permintaan ke PMI Lawang terlebih dulu. 3) Petugas magang secara bergilir setiap 2 minggu sekali.
3.	Tidak ada fitur nilai normal pada Billing SIMRS sehingga petugas melakukan klik manual.	P	Mengajukan fitur pengisian nilai normal kepada Programmer PT.
		D	Membuat surat pengajuan fitur batas atas dan batas bawah nilai normal untuk dilakukan pengisian oleh petugas laboratorium.
		S	Dengan adanya batas atas dan batas bawah yang ditentukan, system akan membaca hasil laboratorium setiap pasien apakah berada pada nilai normal atau tidak.
		A	Follow up ke Programmer PT.
4.	Reagen kadaluarsa dan datang terlambat.	P	Memperbaiki pengadaan reagen di Laboratorium.
		D	Melakukan analisa keterlambatan. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan..
		S	Terdapat reagen yang kosong nasional seperti CKMB, DPJP memutuskan untuk menggunakan pemeriksaan Troponin.
		A	1. Melakukan perbaikan penataan FIFO FEFO pada kulkas Laboratorium. 2. Menjalankan kartu stok dan perencanaan SO. 3. Menentukan stok minimal untuk order reagen.
5.	Pengadaan rectal swab di Lab RS Prima Husada Malang	P	Mengajukan TOR pelayanan rectal swab.
		D	Diskusi dengan Kains Laboratorium RS, dr Ari Putri, Sp.PA
		S	Utilitas jarang tidak direkomendasikan, kecuali jika bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk MCU.
		A	Proses perhitungan unit cost, jika sudah maka akan diajukan TOR.

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Layanan Poli yang belum masuk kedalam E-RM -Poli KIA -Poli Gizi	P	Melakukan permintaan fitur kepada Programmer PT.
		D	Membuat flow chart alur pelayanan pada Poli KIA dan Poli Gizi untuk diterapkan pada E-RM.
		S	Kekurangan jika kunjungan Poli KIA dan Poli Gizi dilakukan pencatatan secara manual maka hasil konseling tidak terekap dengan baik dan tidak bisa diakses oleh DPJP, sehingga tidak bisa dilakukan tindakan lanjutan yang terintegrasi. Pencatatan manual resiko hilangnya sangat tinggi.
		A	Follow up ke Programmer PT. Hasil konseling disampaikan kepada asisten setiap DPJP.
2.	Kebijakan baru dari BPJS Kesehatan tentang Kunjungan Kontrol Poli Rawat Jalan	P	Menjalankan kebijakan baru dengan meminimalisir complain.
		D	Melakukan pemberitahuan melalui social media sebelum kebijakan dijalankan. Kolaborasi dengan Programmer PT untuk menambahkan fitur surat control fisioterapi.
		S	Perawat fisioterapi masih belum bisa menginput surat kontrol pasien bpjs yg berasal dari surat rujukan utama, sehingga masih pasien masih diarahkan ke pendaftaran untuk mencetak surat kontrol
		A	1. Menertibkan pasien control sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2. Follow up ke Programmer PT.
3.	Pendaftaran masih mendaftarkan pasien pada waktu jam praktik dokter sudah selesai.	P	Membuat kebijakan terkait pendaftaran pasien.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Dokter spesialis Gigi Anak drg. Ajeng, Sp.KGA komplain karena ada 1 pasien yang didaftar oleh pendaftaran pada waktu jam prakteknya sudah selesai.
		A	1. Menutup pendaftaran poli spesialis di H-10menit sebelum jam praktik selesai. 2. Konfirmasi DPJP jika ada tambahan pasien yang mendekati jam praktik selesai.
4.	ERM Rawat Inap belum terlaksana, ERM rawat jalan masih ditemukan kendala.	P	Merealisasikan pelaksanaan ERM rawat Inap dan rawat Jalan pada tahun 2025.
		D	Kolaborasi dengan Programmer PT.
		S	ERM Rawat jalan sudah terlaksana, tetapi masih banyak ketidaklengkapan dalam penginputan ERM.
		A	1. Follow up terus menerus ke programer dengan cara screenshot permasalahan dan dikirimkan via whatsapp guna menindaklanjuti permasalahan tersebut agar proses validasi ERM berjalan lancar. 2. Trial ERM Rawat Inap Bulan Maret 2025.

5.	Pasien BPJS TK dari IGD tidak diberikan pengantar rujukan ke Poli Spesialis.	P	Perbaiki alur rujukan pasien.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Ada 1 pasien dari IGD yg tidak diberikan pengantar rujukan untuk ke poli spesialis bedah plastik dan tidak diarahkan ke pendaftaran untuk informasi jadwal praktek dokter tersebut. Pasien ke pendaftaran pada hari H tidak membawa surat rujukan dan datang pada hari yang tidak ada jadwal dokter tersebut.
		A	Mengingatkan ke KARU IGD terkait alur pasien BPJS TK dan selalu mengarahkan pasien ke pendaftaran untuk informasi jadwal dokter apabila pasien ada kontrol Lanjutan.
6.	Ketidak lengkapan pengisian form rekam medis oleh PPA.	P	Mengajukan sosialisasi ke PPA terkait pengisian DRM yang baik dan benar.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO. Koordinasi dengan Kabid Keperawatan.
		S	Ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis oleh semua PPA. Mengecek ulang setiap DRM yang akan di setor ke RM dan melengkapi yang kurang sehingga DRM sudah lengkap waktu di setor ke RM.
		A	Sosialisasi ke semua PPA tentang ketepatan dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sehingga tidak ada lagi DRM yang tidak lengkap.
7.	Keterlambatan perawat poli untuk mengupload e-casemix	P	Mengingatkan ke perawat poli untuk segera mengupload di link.
		D	Karu koordinasi dengan Kepala Ruang IRJA.
		S	Keterlambatan upload dapat menyebabkan keterlambatan klaim.
		A	1. Bila praktek dokter telah selesai bisa langsung upload e-casemix di link. 2. Mengingatkan ke KARU Poli bila dokter sudah selesai praktek agar segera mengupload e casemix pada link yang sudah disediakan.
8.	Surat Rujukan penuh masih manual belum SIMRS	P	1. Mengidentifikasi kebutuhan dan spesifikasi sistem digital untuk surat rujukan penuh. 2. Mengembangkan rencana untuk mengimplementasikan sistem digital. 3. Mengadakan pelatihan untuk tim administrasi dan tim medis tentang penggunaan sistem digital. 4. Mengajukan ke Programmer PT.
		D	1. Mengimplementasikan sistem digital untuk surat rujukan penuh. 2. Mengadakan pelatihan untuk tim administrasi dan tim medis tentang penggunaan sistem digital. 3. Menguji coba sistem digital untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik.

		S	1. Peningkatan efisiensi dalam membuat surat rujukan penuh. 2. Identifikasi masalah yang masih ada dan perlu diperbaiki.
		A	1. Mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi sistem digital 2. Follow up ke Programmer PT

3.7.8 Permasalahan CSSD

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Kebutuhan mesin steam plasma belum terpenuhi.	P	Mengajukan kebutuhan mesin ke PT.
		D	Koordinasi dengan Vendor dan DPJP terkait kebutuhan mesin steam plasma.
		S	Instrument bedah saraf memerlukan perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya.
		A	1) Membuat telaah terkait mesin yang saat ini digunakan dan yang dianjurkan. 2) Koordinasi dengan DPJP (dr Fachri, Sp.BS) bahwa sterilisasi alat bedah saraf menggunakan autoclave dengan cara alat dikemas satu persatu.

3.7.9 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil pencucian membuat kain terkena bercak putih.	P	Memperbaiki alur pencucian.
		D	Menerapkan alur baru.
		S	Monitoring dan evaluasi alur baru, mencari penyebab kerusakan.
		A	1. Melakukan pemilahan baju dan linen dari unit menggunakan handscoon baru (tidak terkena zak kimia). 2. Melakukan pemisahan pencucian antara linen dan baju IKO.
2.	Pencatatan jumlah linen tidak valid.	P	Memperbaiki pencacatan menggunakan digital.
		D	Pencatatan jumlah linen menggunakan google spreadsheet.
		S	Pencatatan manual beresiko angka tidak terbaca dengan baik sehingga jumlah linen tidak valid.
		A	Pencatatan digital akan dimulai pada awal Bulan Januari 2025, sebelumnya akan dilakukan SO. Rencana dilakukan stok opname setiap bulan. Pencatatan real per lantai.

3.7.10 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Respon Time Pelayanan Radiologi	P	Memperbaiki respon time pelayanan radiologi.
		D	Kolaborasi antara perawat dan radiographer dengan DS Radiologi.
		S	Pencatatan dapat diketahui respon time pelayanan radiologi dari selesai periksa sampai dengan selesai hasil.

		A	Melakukan pencatatan waktu permintaan dan selesai hasil di Google Spreadsheet.
2.	Menerima permintaan pemeriksaan pasien IGD tanpa ada inputan di SIMRS.	P	Perbaikan alur pelayanan pemeriksaan radiologi dari unit.
		D	Mendisiplinkan petugas menjalankan sesuai SPO.
		S	Petugas IGD sering kali meminta pemeriksaan sebelum dilakukan input untuk menegakan diagnosis. Perawat juga menghapus inputan tanpa konfirmasi petugas radiologi setelah selesai pemeriksaan dan hasil sudah dicetak.
		A	Pemeriksaan dilakukan jika sudah ada inputan di SIMRS. Pemeriksaan yang dihapus tanpa konfirmasi maka menjadi beban petugas yang menghapus.
3.	Pemeriksaan Cito Bed tidak sesuai dengan kriteria	P	1. Mengidentifikasi kriteria pemeriksaan cito bed yang sesuai. 2. Melakukan analisis akar masalah untuk mengetahui penyebab pemeriksaan cito bed tidak sesuai dengan kriteria. 3. Mengembangkan rencana untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan cito bed.
		D	1. Mengadakan pelatihan untuk tim medis dan tim keperawatan tentang kriteria pemeriksaan cito bed yang sesuai. 2. Mengembangkan checklist untuk memastikan pemeriksaan cito bed sesuai dengan kriteria. 3. Mengimplementasikan sistem pelaporan untuk memantau kualitas pemeriksaan cito bed.
		S	1. Peningkatan kualitas pemeriksaan cito bed sesuai dengan kriteria. 2. Identifikasi masalah yang masih ada dan perlu diperbaiki.
		A	1. Menyusun SPO pemeriksaan cito bed berdasarkan kriteria. 2. Mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan cito bed. 3. Mengembangkan rencana untuk memantau dan mempertahankan kualitas pemeriksaan cito bed. 4. Mengadakan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas pemeriksaan cito bed tetap sesuai dengan kriteria.

3.7.11 Permasalahan Instalasi Gizi dan Dapur

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Pendistribusian alat makan tidak tercatat dengan baik	P	Memperbaiki alur pengecekan fasilitas RS sebelum pasien KRS.
		D	Kolaborasi Ahli Gizi dengan Pendaftaran IGD, Perawat, CS Pantry, CS Ruang dan Kasir.
		S	Fasilitas RS resiko hilang karena pasien

			jika tidak dibuatkan alur yang jelas. Petugas wajib memberikan edukasi untuk meminimalisir kehilangan/kerusakan.
		A	Membuat SPO “Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”. Sosialisasi kepada Unit Terkait
2.	Selisih antara jumlah barang pada kartu stok dan jumlah fisik bahan makanan	P	Pendisiplinan pengisian kartu stok.
		D	Kolaborasi dengan tim pengolahan dan penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan.
		S	Risiko kehabisan stok bahan makanan apabila tidak teratur mengisi kartu stok bahan makanan.
		A	Sosialisasi ulang kepada tim pengolahan dan tim penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan.

3.8 Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	39	13	6	7	0
		S1 Farmasi		1	0	1	0
		D3 Analisis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		20	12	8	0
		SMK		4	3	1	0
		S1 Akuntansi		0	0	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	1	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0

14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	6	6	0	0
		D3 Keperawatan		6	5	1	0
16	IGD	Profesi Ners	25	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRs	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	15	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	25	12	6	6	0
		D3 Keperawatan		13	8	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	1	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	10	0	0

32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	4	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		4	4	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	46	17	8	9	0
		SMA		24	20	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	4	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0

60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			460				

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan April 2025 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan Maret 2025, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 Maret 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E- PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E- PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E- PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I- PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E- PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya)	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS/RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUNAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/I/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/II/VI/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025